

Buku Ajar
**KELUARGA BERENCANA
DAN KESEHATAN
REPRODUKSI**
METODE, KONSELING, DAN EFEK SAMPING

Lely Khulafa'ur Rosidah • Wiwiek Elsada Nainggolan • Herlina Puji Angesti
Rizki Amalia • Sri Musfiroh • Devi Elfita Sari • Erma Puspita Sari

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.



BUKU AJAR: KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI: METODE, KONSELING, DAN EFEK SAMPING

Penulis:

Lely Khulafa'ur Rosidah, S.ST., M.Kes.
Wiwiek Elsada Nainggolan, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb
Herlina Puji Angesti S.Tr.Keb., M.Kes.
Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes.
Sri Musfiroh, S. Si.T., M.Kes.
Devi Elfita Sari, SST., Bd., M.Keb.
Erma Puspita Sari, SST., Bdn., M.Kes.

Editor:

Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Buku Ajar: Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi: Metode, Konseling, dan Efek Samping

Penulis:

Lely Khulafa'ur Rosidah, S.ST., M.Kes.
Wiwiek Elsada Nainggolan, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb
Herlina Puji Angesti S.Tr.Keb., M.Kes.
Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes.
Sri Musfiroh, S. Si.T., M.Kes.
Devi Elfita Sari, SST., Bdn., M.Keb.
Erma Puspita Sari, SST., Bdn., M.Kes.

Editor:

Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7927-21-7

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar berjudul “Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi: Metode, Konseling, dan Efek Samping” dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, tenaga pendidik, serta praktisi kesehatan yang memerlukan pemahaman komprehensif mengenai pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam praktik kebidanan.

Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu, keluarga, dan masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada pemilihan metode kontrasepsi, tetapi juga mencakup pemenuhan hak reproduksi, pemberian informasi yang benar, konseling yang berpusat pada klien, serta penatalaksanaan efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan kontrasepsi. Oleh karena itu, bidan sebagai tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu, etis, dan sesuai kebutuhan klien.

Buku ajar ini membahas berbagai materi pokok yang disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan kebidanan, anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, serta dasar regulasi fertilitas. Pembahasan dilanjutkan dengan kebutuhan dan hak kesehatan reproduksi melalui pendekatan berpusat pada klien, konseling keluarga berencana yang efektif, komunikasi terapeutik, informed choice, serta skrining kelayakan metode kontrasepsi.

Selain itu, buku ini juga menguraikan berbagai metode kontrasepsi, meliputi metode kontrasepsi alamiah dan barrier, kontrasepsi hormonal kombinasi seperti pil, patch, dan cincin, serta kontrasepsi progestin saja seperti suntik, pil, dan implan. Setiap metode dibahas berdasarkan indikasi, cara penggunaan, kelebihan, keterbatasan, jadwal pemakaian, serta penatalaksanaan keluhan dan efek samping yang dapat terjadi. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, menerapkan keterampilan konseling, serta memberikan asuhan kebidanan yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhan klien.

Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran yang aktif, aplikatif, dan berorientasi pada capaian kompetensi. Materi yang disajikan tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pengetahuan teoretis, tetapi juga membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, pengambilan keputusan klinis, serta sikap profesional dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan isi buku pada edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v

BAB 1 KONSEP DASAR KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN

REPRODUKSI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN	1
A. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi	5
B. Konsep Dasar Keluarga Berencana	6
C. Ruang Lingkup Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	8
D. Permasalahan dalam Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	9
E. Peran Bidan dalam Pelayanan KB dan Kespro	10
F. Aktivitas 1 — <i>Knows How Mini-Case</i>	12
G. Rangkuman Materi	23
H. Referensi	26

BAB 2 ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM REPRODUKSI SERTA DASAR

REGULASI FERTILITAS	29
A. Definisi Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi serta Dasar Regulasi Fertilitas	31
B. Konsep Dasar Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi serta Dasar Regulasi Fertilitas	32
C. Kebutuhan untuk Pemeliharaan Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi serta Dasar Regulasi Fertilitas	52
D. Tanda Normal Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi serta Dasar Regulasi Fertilitas	54
E. Tanda Bahaya Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi serta Dasar Regulasi Fertilitas	56
F. Asuhan Kebidanan	58
G. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	61
H. Dokumentasi	62
I. Aktivitas 1	63
J. Concept Map	70
K. Aktivitas 2 — <i>Knows How</i>	72
L. Portofolio	87
M. Ringkasan Materi	90
N. Alur asuhan singkat	91
O. Tabel Red Flags & Eskalasi	92
P. Referensi	94

BAB 3 KEBUTUHAN DAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI: PENDEKATAN BERPUSAT PADA KLIEN	98
A. Konsep Kebutuhan Kesehatan Reproduksi Sepanjang Daur Kehidupan	101
B. Hak Kesehatan Reproduksi dalam Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	104
C. Pendekatan Berpusat pada Klien (Client-Centered Care)	107
D. Analisis Faktor Penentu Akses dan Kerentanan dalam Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	109
E. Integrasi Hak dan Kebutuhan dalam Perencanaan Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi	112
F. Aktivitas 2 — Knows How Mini-Case	115
G. Rangkuman Materi	128
H. Tabel Red Flags & Eskalasi	129
I. Referensi	131

BAB 4 KONSELING KB YANG EFEKTIF: KOMUNIKASI, INFORMED CHOICE, DAN SKRINING KELAYAKAN METODE	132
A. Konseling KB Sebagai Prosedur Klinis	133
B. Mini Case	136
C. OSCE Konseling KB	136
D. Ringkasan BAB	136
E. Red Flags	136
F. Referensi	137

BAB 5 METODE KONTRASEPSI ALAMIAH DAN BARIER: INDIKASI, CARA PAKAI, DAN KELEBIHAN–KETERBATASAN	139
A. Konsep Dasar Kontrasepsi	148
B. Metode Kontrasepsi Alamiah	148
C. Metode Kontrasepsi Barrier	149
D. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	150
E. Ringkasan Materi	168
F. Alur asuhan singkat	170
G. Tabel Red Flags & Eskalasi	170
H. Referensi	173

Bab 6 KONTRASEPSI HORMONAL KOMBINASI: PIL, PATCH/CINCIN, JADWAL, DAN PENATALAKSANAAN KELUHAN	175
A. Konsep Dasar Kontrasepsi Hormonal Kombinasi	184
B. Jenis Kontrasepsi Hormonal Kombinasi	186
C. Skrining dan Kelayakan Medis	192
D. Jadwal Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Kombinasi	196
E. Tata Laksana Lupa Pakai	199

F. Penatalaksanaan Keluhan dan Efek Samping	201
G. Identifikasi Tanda Bahaya (ACHES) dan Rujukan	205
H. Latihan Soal:	206
I. Rangkuman Materi	217
J. Glosarium	217
K. Referensi	219

BAB 7 KONTRASEPSI PROGESTIN SAJA: SUNTIK, PIL, DAN IMPLAN

SERTA TATALAKSANA EFEK SAMPING..... 222

A. Konsep Dasar Kontrasepsi Progestin Saja	226
B. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Progestin.....	227
C. Pil Progestin Saja	229
D. Kontrasepsi Suntik Progestin	232
E. Kontrasepsi Implan	235
F. Efek Samping dan Tatalaksana Kontrasepsi Progestin	237
G. Aktivitas 1 — Knows How	242
H. Rangkuman Materi	254
I. Tabel Red Flags & Eskalasi	256
J. Referensi	258

PROFIL PENULIS..... 259

BAB 1

KONSEP DASAR KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Bab ini mendukung pencapaian CPL sebagai berikut:

- CPL-1: Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- CPL-2: Menerapkan komunikasi terapeutik dan pendekatan berpusat pada klien/keluarga dalam pelayanan kebidanan.
- CPL-6: Mengelola pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana secara sistematis dan berkelanjutan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK Utama:

- CPMK-1: Menganalisis konsep, tujuan, kebijakan, serta aspek etika dan legal keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan kebidanan.

CPMK Pendukung:

- CPMK-3: Mengevaluasi kebutuhan, preferensi, dan hak kesehatan reproduksi klien dengan pendekatan berpusat pada klien.
- CPMK-7: Mengelola pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi berbasis sistem, termasuk pencatatan, pelaporan, dan evaluasi mutu layanan.

Sub-CPMK

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menganalisis konsep, tujuan, dan manfaat keluarga berencana serta kesehatan reproduksi dalam pelayanan kebidanan.
- Menjelaskan ruang lingkup pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.

- Menganalisis aspek etika, legal, dan hak reproduksi dalam pelayanan kebidanan.
- Mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan sistem pelayanan yang mempengaruhi pemanfaatan layanan KB dan kesehatan reproduksi.
- Menganalisis permasalahan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta peran bidan dalam mengatasinya.

Indikator Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar KB dan kesehatan reproduksi secara tepat
- Menguraikan tujuan dan manfaat pelayanan KB
- Mengaitkan pelayanan KB dengan aspek etika dan hak reproduksi
- Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi
- Menganalisis masalah dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
- Menjelaskan peran bidan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

Uraian Materi

Keluarga Berencana (KB) bersama dengan kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dalam pelayanan kebidanan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, dan keluarga. KB tidak hanya dipahami sebagai upaya pengaturan jumlah dan jarak kelahiran, tetapi juga sebagai implementasi dari konsep kesehatan reproduksi yang menempatkan hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan reproduksinya secara sadar, bertanggung jawab, dan bermartabat (World Health Organization, 2021). Dalam konteks nasional, kebijakan yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menegaskan bahwa program KB berperan dalam membangun keluarga berkualitas melalui pengendalian kelahiran, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan fungsi keluarga (BKKBN, 2022). Selain itu, peran KB dalam menekan angka kematian ibu, mencegah kehamilan berisiko, serta mengendalikan tingkat fertilitas didukung oleh pendekatan promotif dan preventif dalam kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Hal tersebut sejalan dengan capaian pembelajaran pada Bab 1, khususnya CPMK-1, yang menekankan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menganalisis konsep, tujuan, kebijakan, serta aspek etika dan legal dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, KB tidak hanya dipandang sebagai tindakan medis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kesehatan yang dipengaruhi oleh regulasi, kebijakan, serta faktor sosial dan budaya.

Dalam praktik kebidanan, pelayanan KB dilaksanakan dengan pendekatan *continuity of care*, yaitu pemberian asuhan secara berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Pendekatan ini meliputi masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, masa nifas, hingga periode antara kehamilan (Saifuddin, 2020). Konsep ini memperlihatkan bahwa pelayanan KB merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan reproduksi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penerapan asuhan yang terintegrasi ini juga mendukung pencapaian CPMK-7, terutama dalam aspek pengelolaan layanan KB yang sistematis melalui pencatatan, pelaporan, serta tindak lanjut yang berkesinambungan.

Pelayanan KB juga harus mengedepankan pendekatan yang berpusat pada klien (*client-centered care*). Teori yang dikemukakan oleh Carl Rogers menekankan pentingnya empati, penghargaan terhadap individu, serta pengakuan terhadap otonomi klien dalam pengambilan keputusan (Rogers, 1961). Dalam konteks pelayanan KB, pendekatan ini diwujudkan melalui proses konseling yang memungkinkan klien memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisinya. Konsep *shared decision making* memperkuat hal tersebut dengan melibatkan klien

secara aktif dalam setiap keputusan berdasarkan informasi yang lengkap dan objektif (Elwyn et al., 2012). Pendekatan ini berkaitan erat dengan CPMK-3, yaitu kemampuan dalam menilai kebutuhan dan preferensi klien secara komprehensif.

Selain pendekatan berbasis klien, pelayanan KB juga dilandasi oleh pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh informasi yang akurat, akses layanan yang adil tanpa diskriminasi, serta pelayanan yang aman dan berkualitas (WHO, 2021). Dalam praktiknya, prinsip tersebut harus diintegrasikan dengan etika profesi yang mencakup otonomi, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice* (Beauchamp & Childress, 2019). Penerapan prinsip etika ini mencerminkan pencapaian CPL-1, yaitu profesionalisme dalam menjalankan praktik kebidanan sesuai standar etika dan regulasi yang berlaku.

Pelayanan KB juga tidak terlepas dari peran keluarga sebagai lingkungan utama dalam pengambilan keputusan kesehatan reproduksi. Pendekatan *family-centered care* menempatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perencanaan asuhan (Friedman, Bowden, & Jones, 2003). Keputusan terkait penggunaan kontrasepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai budaya, dukungan pasangan, serta kondisi sosial ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori ekologi sosial dari Bronfenbrenner yang menyatakan bahwa perilaku individu merupakan hasil interaksi antara faktor individu, keluarga, komunitas, dan kebijakan (Bronfenbrenner, 1979). Oleh karena itu, pelayanan KB harus mempertimbangkan berbagai aspek tersebut secara menyeluruh.

Di samping itu, penyelenggaraan pelayanan KB memerlukan pengelolaan yang baik dalam sistem pelayanan kesehatan. Teori manajemen kesehatan menekankan pentingnya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menjamin efektivitas layanan (Green & Kreuter, 2005). Implementasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, dan praktik mandiri bidan membutuhkan sistem pencatatan yang akurat, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, serta sistem rujukan yang berjalan dengan baik. Hal ini memperkuat peran bidan dalam mendukung pencapaian CPMK-7 melalui pengelolaan layanan berbasis sistem dan data.

Keberhasilan program KB tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif seperti peningkatan penggunaan kontrasepsi atau penurunan angka kelahiran, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diberikan. Teori mutu pelayanan kesehatan menekankan pentingnya aspek struktur, proses, dan hasil (*outcome*) sebagai indikator kualitas layanan (Donabedian, 1988). Kualitas konseling, ketepatan pemilihan metode, efektivitas pemantauan, serta kepuasan klien menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program KB (BKKBN, 2022).

Dengan demikian, Bab 1 ini disusun untuk mendukung pencapaian CPMK-1 dengan penguatan pada CPMK-3 dan CPMK-7, melalui integrasi berbagai teori yang relevan, mulai dari kesehatan reproduksi, asuhan berkesinambungan, pendekatan berpusat pada klien, hingga manajemen pelayanan kesehatan. Integrasi tersebut diharapkan mampu membangun pemahaman yang komprehensif serta kemampuan analitis mahasiswa dalam mengimplementasikan pelayanan KB yang profesional, etis, berorientasi pada klien, dan berkelanjutan di tingkat komunitas.

A. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia serta fungsi dan prosesnya (Simaibang et al., 2024). Konsep ini menekankan bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya terbatas pada ketiadaan penyakit, tetapi mencakup kesejahteraan secara menyeluruh dalam kehidupan reproduksi individu. Pelayanan kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan *life cycle approach*, yaitu pelayanan yang diberikan secara berkelanjutan mulai dari masa remaja hingga usia lanjut (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, kesehatan reproduksi juga berkaitan dengan upaya pencegahan berbagai masalah kesehatan yang dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan manusia. Status kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, yaitu (Glasier et al., 2006):

1. Faktor sosial (pendidikan, norma masyarakat)
2. Faktor ekonomi (pendapatan, akses layanan)
3. Faktor budaya (kepercayaan dan nilai)
4. Akses terhadap pelayanan kesehatan

Kesehatan reproduksi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, memilih pelayanan kesehatan secara bebas, serta mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas tanpa diskriminasi. Prinsip ini dikenal sebagai pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan (Starrs et al., 2018).

Dalam praktik kebidanan, pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan melalui pendekatan *continuity of care*. Pelayanan ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Promotif (edukasi kesehatan reproduksi)
2. Preventif (pencegahan penyakit dan komplikasi)

3. Kuratif (penanganan masalah kesehatan)

4. Rehabilitatif (pemulihan kesehatan)

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan serta mencegah terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi (Kementerian Kesehatan RI, 2020; Afulani et al., 2019).

Kesehatan reproduksi merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan hak individu. Oleh karena itu, diperlukan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara luas.

Bagian ini mendukung pencapaian CPMK-1, khususnya dalam menganalisis konsep dasar kesehatan reproduksi sebagai landasan pelayanan kebidanan. Pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi serta pendekatan *life cycle* juga memperkuat CPMK-3, yaitu kemampuan mengevaluasi kebutuhan dan hak kesehatan reproduksi klien secara komprehensif. Selain itu, pendekatan berbasis hak yang menekankan keadilan, akses, dan non-diskriminasi selaras dengan CPL-1 dalam penerapan profesionalisme dan etika dalam pelayanan. Pelayanan yang berkelanjutan dan sistematis juga berkontribusi pada CPMK-7, khususnya dalam pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi secara terintegrasi.

B. Konsep Dasar Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak guna mencapai kesejahteraan keluarga (Simaibang et al., 2024). Program KB tidak hanya berfokus pada pengendalian kelahiran, tetapi juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dan pembangunan kesehatan reproduksi. Dalam konteks pelayanan kesehatan, KB berperan penting dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta menurunkan risiko kesehatan ibu dan bayi (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, KB dipandang sebagai bentuk pencegahan primer terhadap berbagai risiko kehamilan, seperti kehamilan terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jaraknya, dan terlalu banyak jumlahnya (4T). Kondisi tersebut merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, program KB menjadi salah satu intervensi strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Cleland et al., 2012). Selain itu, teori determinan kesehatan menjelaskan bahwa keberhasilan program KB dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perilaku individu, lingkungan sosial, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta kebijakan pemerintah (Green & Kreuter, 2005).

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi modern secara signifikan dapat menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan serta

mengurangi risiko komplikasi kehamilan (Darroch et al., 2016). Selain itu, KB juga memberikan dampak positif terhadap aspek sosial dan ekonomi, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan pendidikan anak, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan (Ahmed et al., 2012). Hal ini menunjukkan bahwa KB tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

Pendekatan dalam pelayanan KB tidak terlepas dari konsep *family-centered care* dan pendekatan ekologi sosial. Teori *family-centered care* menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam pengambilan keputusan kesehatan, sehingga pelayanan KB harus mempertimbangkan kondisi kesehatan, nilai budaya, serta dukungan pasangan (Friedman et al., 2003). Sementara itu, pendekatan ekologi sosial menjelaskan bahwa perilaku penggunaan kontrasepsi dipengaruhi oleh interaksi antara individu, keluarga, komunitas, dan sistem pelayanan kesehatan (Bronfenbrenner, 1979).

Pelayanan KB dilaksanakan dengan prinsip yang berorientasi pada kebutuhan klien dan berbasis hak, antara lain:

1. Berbasis keluarga, yaitu mempertimbangkan kondisi kesehatan, sosial, dan psikologis keluarga
2. Berpusat pada klien, dengan menghormati pilihan dan otonomi individu
3. Berkelanjutan (*continuity of care*), melalui pelayanan sepanjang siklus kehidupan perempuan
4. Menghormati hak reproduksi, termasuk akses informasi, keamanan pelayanan, dan kebebasan memilih metode

Pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh informasi yang lengkap dan tidak bias, serta memilih metode kontrasepsi secara sukarela tanpa adanya paksaan. Prinsip ini sejalan dengan etika kesehatan yang menekankan pentingnya otonomi, keadilan, dan *informed choice* dalam setiap pelayanan kesehatan (Beauchamp & Childress, 2019; Starrs et al., 2018).

Materi ini mendukung CPMK-1 dalam memahami konsep, tujuan, dan manfaat keluarga berencana dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Analisis faktor sosial, budaya, dan perilaku dalam penggunaan kontrasepsi memperkuat CPMK-3, terutama dalam mengevaluasi kebutuhan dan preferensi klien. Selain itu, prinsip pelayanan KB berbasis hak dan berpusat pada klien mencerminkan penerapan CPL-2, yaitu komunikasi terapeutik dan pendekatan client-centered dalam pengambilan keputusan kontrasepsi. Dari aspek sistem pelayanan, materi ini juga berkontribusi pada CPMK-7 dalam memahami peran KB dalam pengelolaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

C. Ruang Lingkup Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Ruang lingkup keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mencakup berbagai pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan individu secara menyeluruh sepanjang siklus kehidupan. Pelayanan ini tidak hanya terbatas pada penggunaan kontrasepsi, tetapi juga meliputi edukasi, pencegahan penyakit, serta pelayanan kebidanan yang berkelanjutan. Secara umum, ruang lingkup tersebut meliputi pelayanan kontrasepsi, konseling keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi, serta pencegahan penyakit menular seksual (Simaibang et al., 2024).

Dalam implementasinya, pelayanan kesehatan reproduksi harus dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pendekatan promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan, serta menurunkan risiko terjadinya gangguan kesehatan reproduksi. Pelayanan yang berbasis bukti ilmiah juga diperlukan agar intervensi yang diberikan sesuai dengan standar dan efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat (Starbird et al., 2016).

Adapun komponen utama dalam ruang lingkup pelayanan KB dan kesehatan reproduksi meliputi:

1. Pelayanan kontrasepsi, yaitu penyediaan dan pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien
2. Konseling KB, berupa komunikasi dua arah yang membantu klien memahami pilihan metode serta efek sampingnya
3. Pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, serta kesehatan reproduksi remaja
4. Pencegahan penyakit menular seksual, melalui edukasi, skrining, dan penanganan dini
5. Pelayanan kebidanan berkesinambungan, yang diberikan secara terus-menerus sepanjang siklus kehidupan perempuan

Selain itu, pelayanan KB dan kesehatan reproduksi juga harus memperhatikan prinsip pelayanan yang berpusat pada klien serta menghormati hak reproduksi individu. Setiap individu berhak mendapatkan informasi yang jelas, memilih metode pelayanan secara bebas, serta memperoleh pelayanan yang aman dan berkualitas tanpa diskriminasi (WHO, 2021). Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien dan dilakukan secara profesional.

Ruang lingkup keluarga berencana dan kesehatan reproduksi merupakan suatu sistem pelayanan yang luas dan terintegrasi. Pelaksanaan pelayanan yang

komprehensif, berkesinambungan, dan berbasis bukti ilmiah menjadi kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan reproduksi serta kesejahteraan masyarakat.

Bagian ini berkontribusi terhadap CPMK-1 dalam memahami cakupan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi secara komprehensif. Penjelasan mengenai berbagai jenis pelayanan serta pendekatan berbasis bukti memperkuat CPMK-7, khususnya dalam pengelolaan layanan kesehatan yang terintegrasi, termasuk aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu, penerapan pelayanan berpusat pada klien dan penghormatan terhadap hak reproduksi mendukung CPMK-3 dalam mengevaluasi kebutuhan dan preferensi klien. Hal ini juga sejalan dengan CPL-6, yaitu kemampuan dalam mengelola layanan kesehatan berbasis sistem dan mutu.

D. Permasalahan dalam Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

Permasalahan dalam pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi masih menjadi tantangan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu masalah utama adalah tingginya angka *unmet need*, yaitu kondisi di mana pasangan usia subur ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi. Selain itu, efek samping kontrasepsi yang dirasakan oleh akseptor serta kurangnya edukasi yang memadai juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan dan keberlanjutan kontrasepsi (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Dari perspektif sosial, faktor budaya dan norma masyarakat turut berperan dalam mempengaruhi perilaku penggunaan kontrasepsi. Dalam beberapa masyarakat, masih terdapat anggapan bahwa penggunaan KB merupakan tanggung jawab perempuan semata, sehingga partisipasi laki-laki dalam program KB masih rendah. Ketidaksetaraan gender ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi (Blackstone et al., 2017). Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya akses informasi juga menyebabkan masyarakat kurang memahami manfaat dan pentingnya KB.

Permasalahan lain yang sering ditemukan adalah kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, terutama dalam hal konseling. Konseling yang kurang efektif dapat menyebabkan kesalahan dalam pemilihan metode kontrasepsi, sehingga meningkatkan risiko ketidakcocokan dan akhirnya menyebabkan putus pakai (*drop out*). Penelitian menunjukkan bahwa kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan klien sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan kontrasepsi (Afulani et al., 2019).

Secara lebih rinci, beberapa permasalahan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi meliputi:

1. Tingginya angka *unmet need* dan rendahnya cakupan penggunaan kontrasepsi
2. Efek samping dan ketidaknyamanan dalam penggunaan kontrasepsi
3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi
4. Ketimpangan gender dalam pengambilan keputusan reproduksi
5. Keterbatasan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Selain itu, faktor sistem pelayanan seperti ketersediaan alat kontrasepsi, distribusi layanan yang belum merata, serta keterbatasan tenaga kesehatan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program KB. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan KB dan kesehatan reproduksi tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem pelayanan dan kebijakan kesehatan (Starbird et al., 2016).

Permasalahan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bersifat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif, mulai dari peningkatan edukasi masyarakat, penguatan peran tenaga kesehatan, hingga perbaikan sistem pelayanan kesehatan, guna meningkatkan keberhasilan program KB dan kesehatan reproduksi secara berkelanjutan.

Materi ini mendukung CPMK-1, khususnya dalam kemampuan menganalisis berbagai permasalahan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Pembahasan mengenai faktor sosial budaya, ketimpangan gender, dan akses layanan memperkuat CPMK-3 dalam memahami konteks dan kebutuhan klien secara menyeluruh. Selain itu, identifikasi permasalahan dalam sistem pelayanan seperti kualitas layanan dan ketersediaan fasilitas berkontribusi pada CPMK-7, terutama dalam evaluasi dan pengelolaan layanan kesehatan. Dari sisi profesionalisme, analisis masalah ini juga mendukung CPL-1 dalam meningkatkan kualitas praktik kebidanan yang etis dan bertanggung jawab.

E. Peran Bidan dalam Pelayanan KB dan Kespro

Bidan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan masyarakat. Peran ini tidak hanya terbatas pada pemberian layanan klinis, tetapi juga mencakup aspek promotif dan preventif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan reproduksi. Dalam hal ini, bidan berfungsi sebagai edukator, konselor, serta penyedia layanan kontrasepsi yang berkontribusi terhadap keberhasilan program KB (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Dalam menjalankan perannya sebagai edukator, bidan bertanggung jawab memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami mengenai kesehatan reproduksi dan metode kontrasepsi. Edukasi yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat serta membentuk sikap positif terhadap penggunaan kontrasepsi. Selain itu, sebagai konselor, bidan harus mampu melakukan komunikasi interpersonal yang baik agar klien dapat memahami pilihan metode yang tersedia dan menentukan keputusan secara mandiri. Kualitas konseling yang baik terbukti berpengaruh terhadap kepuasan klien dan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi (Afulani et al., 2019; Solo et al., 2019).

Selain itu, bidan juga berperan sebagai pemberi layanan (*service provider*) yang melaksanakan tindakan medis sesuai dengan kompetensi dan standar praktik kebidanan. Pelayanan ini mencakup pemasangan, pemantauan, serta penanganan efek samping kontrasepsi. Dalam memberikan pelayanan, bidan harus mengedepankan prinsip keselamatan pasien, standar prosedur operasional, serta pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice*) untuk menjamin kualitas layanan yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Peran bidan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Edukator, memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan KB
2. Konselor, membantu klien dalam pengambilan keputusan yang tepat
3. Pelaksana layanan, menyediakan dan melakukan tindakan kontrasepsi
4. Advokat, mendukung hak reproduksi dan akses pelayanan kesehatan
5. Motivator, mendorong partisipasi masyarakat dalam program KB

Di samping itu, bidan juga berperan dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui pendekatan komunitas. Bidan dapat bekerja sama dengan kader kesehatan, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan penerimaan program KB. Pendekatan ini penting karena keberhasilan program KB tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi juga oleh dukungan lingkungan sosial (Starbird et al., 2016).

Peran bidan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sangat menentukan keberhasilan program. Pelaksanaan peran yang optimal, didukung oleh kompetensi profesional dan pendekatan yang berpusat pada klien, akan meningkatkan kualitas pelayanan serta keberlanjutan penggunaan kontrasepsi di masyarakat.

Bagian ini mendukung CPMK-1 dalam memahami peran strategis bidan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Peran bidan dalam konseling, edukasi, dan pelayanan kontrasepsi memperkuat CPMK-3, khususnya dalam mengevaluasi kebutuhan dan preferensi klien melalui pendekatan berpusat pada klien. Selain itu,

peran bidan dalam pengelolaan pelayanan, pencatatan, dan koordinasi sistem kesehatan mendukung CPMK-7 dalam aspek manajemen layanan berbasis data. Hal ini juga selaras dengan CPL-2 dalam penerapan komunikasi terapeutik serta CPL-6 dalam pengelolaan layanan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan.

F. Aktivitas 1 — *Knows How Mini-Case*

Topik: Konsep Dasar Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam Pelayanan Kebidanan

Skenario Kasus (Mini-Case)

Seorang perempuan usia 27 tahun, P1A0, datang ke bidan desa untuk berkonsultasi mengenai kesehatan reproduksi dan penggunaan kontrasepsi. Ibu memiliki anak usia 1 tahun dan belum menggunakan KB sejak melahirkan.

Hasil pengkajian awal:

1. Ibu ingin menunda kehamilan, tetapi belum menentukan pilihan kontrasepsi
2. Ibu merasa takut efek samping KB hormonal karena pengalaman orang lain
3. Pengetahuan ibu tentang kesehatan reproduksi masih terbatas
4. Suami menyerahkan keputusan kepada ibu
5. Jarak ke Puskesmas ± 10 km
6. Ibu jarang mengikuti kegiatan Posyandu

Tugas Mahasiswa (Level Knows How)

Mahasiswa diminta untuk menjelaskan dan merencanakan (bukan melakukan tindakan langsung) terkait kasus di atas:

1. Analisis masalah kebidanan dan faktor yang mempengaruhi keputusan KB
2. Jelaskan konsep kesehatan reproduksi dan peran KB
3. Jelaskan pendekatan konseling berbasis hak (*rights-based & client-centered care*)
4. Tentukan pilihan metode kontrasepsi yang sesuai dan rasional
5. Jelaskan peran jejaring pelayanan (kader, bidan, Puskesmas)
6. Rancang rencana tindak lanjut (*follow-up*) berbasis komunitas
7. Identifikasi potensi risiko (*drop out, unmet need, kehamilan tidak direncanakan*)

Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Penerapan Konsep Dasar KB dan Kesehatan Reproduksi dalam Konseling Kebidanan
3	Kasus	Konseling kesehatan reproduksi dan perencanaan KB pada wanita usia subur
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta mampu memahami dan menerapkan konsep dasar KB dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan kebidanan melalui konseling berbasis klien
5	Kompetensi	1. Anamnesis kesehatan reproduksi 2. Pemahaman konsep dasar KB dan kespro 3. Identifikasi masalah kebidanan 4. Perencanaan pelayanan KB 5. KIE/konseling berbasis hak 6. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 25 tahun, P1A0, datang ke Posyandu untuk berkonsultasi mengenai kesehatan reproduksi. Ibu memiliki anak usia 1 tahun dan belum menggunakan kontrasepsi sejak melahirkan. Hasil anamnesis: a. Ibu ingin menunda kehamilan b. Ibu kurang memahami tentang KB c. Ibu takut efek samping kontrasepsi d. Suami menyerahkan keputusan kepada ibu e. Tidak ada riwayat penyakit kronis f. Keadaan umum baik, tanda vital normal TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah terkait kesehatan reproduksi 2. Identifikasi masalah/kebutuhan KB 3. Jelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi dan peran KB 4. Tentukan pilihan metode kontrasepsi yang sesuai 5. Berikan KIE/konseling berbasis hak dan client-centered care 6. Jelaskan rencana tindak lanjut (follow up)
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta sesuai 2. Penilaian berdasarkan checklist (0–3) dan global rating (1–4) 3. Tidak memberikan bantuan 4. Penilaian objektif INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta anamnesis → PS menjawab sesuai skenario 2. Tidak ada kontraindikasi medis

		3. Diagnosis yang diharapkan: - PUS dengan kebutuhan KB 4. Tindakan yang diharapkan: a. Konseling KB berbasis hak b. Menjelaskan konsep dasar kespro c. Menawarkan metode sesuai kondisi 5. Edukasi yang diharapkan: a. Menjelaskan manfaat KB b. Meluruskan ketakutan efek samping 6. Tindak lanjut: a. Jadwal kunjungan ulang b. Edukasi lanjutan
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. Berperan sebagai ibu yang belum memahami KB 2. Tampak ragu dan kurang pengetahuan 3. Fokus masalah: a. takut efek samping b. kurang informasi 4. Jika dijelaskan → mulai memahami 5. Akan bertanya: "KB itu aman tidak ya, Bu?"
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi, Bu PS: Pagi, Bu Peserta: Apa yang bisa saya bantu? PS: Saya ingin tanya soal KB Peserta: Apa yang ibu ketahui tentang KB? PS: Saya belum terlalu paham, Bu Peserta: Apakah ada kekhawatiran? PS: Saya takut efek samping Peserta: Baik Bu, saya akan jelaskan PS: Iya Bu
10	Kebutuhan manikin	Tidak wajib (roleplay konseling)
11	Kebutuhan laboran	1. Menyiapkan ruang OSCE 2. Menyiapkan lembar penilaian 3. Mengatur alur peserta
12	Kebutuhan alat	1. Meja dan kursi 2. Lembar status pasien 3. Lembar penilaian 4. Alat tulis 5. Leaflet KB
13	Penulis	(Isi sesuai penulis)
14	Referensi	1. World Health Organization. (2021). <i>Family planning/contraception</i>. 2. Kementerian Kesehatan RI. (2023). <i>Pedoman pelayanan kontrasepsi</i>. 3. BKKBN. (2022). <i>Pedoman pelayanan KB</i>.

		4. Saifuddin, A. B. (2020). <i>Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi</i> . 5. Rogers, C. (1961). <i>On becoming a person</i> . 6. Elwyn, G., et al. (2012). <i>Shared decision making</i> . 7. Beauchamp & Childress. (2019). <i>Principles of biomedical ethics</i> .
--	--	--

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Konsep Dasar Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam Pelayanan Kebidanan

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif (Anamnesis Dasar KB dan Kesehatan Reproduksi)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama / kebutuhan KB		
2. Status reproduksi / menyusui		
3. Riwayat penggunaan kontrasepsi		
4. Riwayat obstetri (GPA, persalinan terakhir)		
5. Riwayat kesehatan reproduksi		
6. Faktor sosial / keluarga		
7. Pengetahuan & persepsi tentang KB		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Melakukan semua 7 langkah dengan benar
- 2= Melakukan 4–6 langkah dengan benar
- 1= Melakukan 1–3 langkah dengan benar
- 0= Tidak melakukan

KOMPETENSI 2. Prosedur dan Perencanaan Pelayanan KB

1. Persiapan

Komponen	Skoring	Skor
a. Menyapa klien dengan sopan		
b. Memperkenalkan diri		
c. Menjelaskan tujuan konseling		
d. Meminta persetujuan		
e. Menjaga privasi		
f. Hand hygiene		
g. Menyiapkan media/alat edukasi		

2. Langkah-langkah

Komponen	Skoring	Skor
a. Mengkaji kondisi umum klien		
b. Mengidentifikasi kebutuhan KB		
c. Melakukan skrining kelayakan		
d. Mengidentifikasi risiko kesehatan reproduksi		
e. Menentukan pilihan metode KB		
f. Memberikan KIE berbasis hak		
g. Menghargai pilihan klien		
h. Menyesuaikan metode dengan kondisi		
i. Menjelaskan cara penggunaan		
j. Menjelaskan efek samping		
k. Menjelaskan tanda bahaya		
L. Menyusun rencana tindak lanjut		

3. Pasca Tindakan

Komponen	Skoring	Skor
a. Menyimpulkan hasil konseling		
b. Dokumentasi		
c. Merapikan alat / lingkungan		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Melakukan 15–20 langkah dengan tepat & sistematis
- 2= Melakukan 10–14 langkah cukup tepat
- 1= Melakukan 1–9 langkah
- 0= Tidak melakukan / tidak tepat

KOMPETENSI 3. KIE / Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan kondisi klien		
3. Menjelaskan konsep dasar KB		
4. Menjelaskan pilihan metode		
5. Memberi kesempatan bertanya		
6. Menjawab dengan jelas dan empatik		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Semua 6 langkah benar
- 2= 4–5 langkah benar
- 1= 1–3 langkah benar
- 0= Tidak melakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sistematis		
2. Menjaga privasi		
3. Empati terhadap klien		
4. Komunikasi jelas & tenang		
5. Percaya diri		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= 5 langkah benar
- 2= 4 langkah benar
- 1= 1–3 langkah benar
- 0= Tidak melakukan

$$\text{TOTAL SKOR} = (K1 + K2 + K3 + K4) / 3$$

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota),.....

.....

Penguji :

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Topik: Konsep Dasar Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam Pelayanan Kebidanan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus KB Komunitas
Metode penilaian	DOPS adalah metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan mahasiswa dalam praktik pelayanan kebidanan. Penilai mengamati tindakan nyata mahasiswa, kemudian memberi umpan balik segera. Domain yang dinilai: komunikasi, informed consent, persiapan, keterampilan, keselamatan pasien, profesionalisme.	Pembimbing mengamati mahasiswa saat melakukan konseling KB di Posyandu, melakukan skrining kelayakan, membantu klien memilih metode sesuai kebutuhan dan hak reproduksi, serta merencanakan tindak lanjut.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam memberikan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang aman, efektif, dan berpusat pada klien.	Mahasiswa dinilai dari kemampuan melakukan konseling, menjelaskan konsep dasar KB, membantu pengambilan keputusan, dan menyusun rencana tindak lanjut.
Kasus klinik	Kasus berbasis komunitas yang memungkinkan mahasiswa menunjukkan keterampilan klinik dan komunikasi.	Seorang ibu usia 30 tahun, P2A1, datang ke Posyandu untuk konsultasi KB. Ibu ingin menunda kehamilan, masih ragu menggunakan KB karena takut efek samping, dan ingin berdiskusi bersama suami.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Observasi dilakukan saat mahasiswa melakukan tindakan nyata dalam pelayanan.	Mahasiswa melakukan anamnesis, mengidentifikasi kebutuhan KB, memberikan konseling berbasis hak, menjelaskan pilihan metode, serta menyusun rencana tindak lanjut.
Aspek yang dinilai	Meliputi kemampuan klinis dan non-klinis dalam pelayanan kebidanan.	Pembimbing menilai kemampuan anamnesis, skrining kelayakan, pemilihan metode, komunikasi, serta kemampuan menghargai keputusan klien.
Fokus observasi pembimbing	Menilai performa mahasiswa secara menyeluruh dan sistematis.	Pembimbing mengamati apakah mahasiswa melakukan konseling dengan baik, menjelaskan metode KB secara jelas, melibatkan pasangan, dan menjaga privasi klien.

Umpan balik	Diberikan segera setelah observasi, bersifat spesifik dan konstruktif.	Mahasiswa dinilai sudah baik dalam komunikasi dan empati, namun perlu meningkatkan ketelitian dalam skrining dan perencanaan tindak lanjut.
Keputusan penilaian	Kategori: kompeten, perlu supervisi, atau remedial.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan konseling, menentukan metode sesuai kondisi klien, dan menyusun tindak lanjut dengan benar.
Makna dalam OBE	Menunjukkan capaian pembelajaran pada level “does” (Miller).	Mahasiswa mampu menerapkan konsep KB dan kesehatan reproduksi dalam praktik nyata, tidak hanya memahami teori.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 1.1
Portofolio pada Pelayanan KB Berbasis Komunitas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pelayanan KB Berbasis Komunitas
Hakikat portofolio	Kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan.	Memuat bukti mahasiswa mampu memahami konsep dasar KB, melakukan asesmen kebutuhan, serta memberikan konseling kesehatan reproduksi secara tepat
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan perbaikan berkelanjutan.	Mahasiswa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menjelaskan konsep KB, memilih metode sesuai kondisi

		klien, dan memberikan edukasi yang tepat.
OSCE dan DOPS	Memberikan bukti keterampilan di laboratorium (OSCE) dan praktik nyata (DOPS).	OSCE berisi hasil ujian konseling KB, DOPS berisi observasi langsung saat mahasiswa melakukan konseling dan skrining di komunitas.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus klien meliputi data, masalah, tindakan, dan hasil.	Mahasiswa mencatat kasus ibu usia subur yang membutuhkan KB, termasuk kondisi reproduksi, pilihan metode, dan rencana tindak lanjut.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mengenali dan mencegah risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya skrining kontraindikasi, edukasi efek samping, dan informed choice dalam pelayanan KB.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari pembimbing sebagai dasar perbaikan kompetensi.	CI menilai mahasiswa baik dalam komunikasi, namun perlu meningkatkan ketepatan dalam skrining dan pemilihan metode.
Karakteristik penilaian	Dilakukan berulang dan berkelanjutan, bukan sekali penilaian.	Mahasiswa dinilai dari beberapa praktik pelayanan KB sehingga terlihat perkembangan kemampuan.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mempertahankan performa pada berbagai kesempatan.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, dan refleksi terlihat mahasiswa konsisten dalam konseling dan edukasi KB.
Makna dalam OBE	Bukti autentik capaian pembelajaran pada level performa nyata.	Mahasiswa mampu menerapkan konsep KB dan kesehatan reproduksi secara konsisten, aman, dan sesuai kebutuhan klien.

Tabel 1.2
Case Report pada Pelayanan KB Berbasis Komunitas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pelayanan KB Berbasis Komunitas
Hakikat case report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus klien yang ditangani mahasiswa dalam pelayanan kebidanan	Mahasiswa menyusun laporan tentang pasangan usia subur di komunitas yang membutuhkan KB dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan reproduksi, sosial, dan preferensi klien.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengintegrasikan data, analisis masalah, perencanaan, dan evaluasi.	Mahasiswa menjelaskan alasan pemilihan metode KB, memberikan edukasi yang sesuai, dan merancang tindak lanjut berbasis kebutuhan klien.
Isi laporan	Identitas klien, data subjektif dan objektif, analisis, diagnosis, tindakan, dan evaluasi.	Data: ibu usia 30 tahun, ingin menunda kehamilan, khawatir efek samping KB → analisis kebutuhan → pemilihan metode KB sesuai kondisi → edukasi → rencana kontrol ulang.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, analisis, dan pengambilan keputusan.	Pembimbing menilai kesesuaian metode KB dengan kondisi klien serta ketepatan edukasi yang diberikan.
Nilai edukatif	Mengembangkan kemampuan clinical reasoning dan dokumentasi.	Mahasiswa memahami bahwa pelayanan KB harus berbasis bukti, mempertimbangkan konteks sosial, dan komunikasi efektif.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori ke dalam praktik nyata secara sistematis.	Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar KB dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan kebidanan secara tepat dan adaptif.

Tabel 1.3
Refleksi Patient Safety pada Pelayanan KB Berbasis Komunitas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pelayanan KB Berbasis Komunitas
Hakikat refleksi	Tulisan yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko serta mencegah kesalahan dalam pelayanan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memastikan metode KB yang dipilih aman, sesuai kondisi klien, serta mempertimbangkan aspek budaya dan sosial.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran keselamatan klien dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan dalam konseling atau pemilihan metode KB dapat berdampak pada kesehatan dan keberlanjutan penggunaan KB.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, penyebab, upaya pencegahan, dan pembelajaran.	Risiko: kurangnya pemahaman klien, efek samping, pengaruh budaya. Pencegahan: edukasi jelas, konseling berulang, dan monitoring berkelanjutan.
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang berpotensi membahayakan klien.	Salah pemilihan metode KB, efek samping yang tidak dijelaskan, serta mitos yang mempengaruhi keputusan klien.
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk meminimalkan risiko.	Melakukan skrining kelayakan, memberikan edukasi yang tepat, melibatkan keluarga, dan melakukan tindak lanjut.
Pembelajaran mahasiswa	Hal yang dipelajari dan rencana perbaikan ke depan.	Mahasiswa belajar pentingnya komunikasi efektif, konseling berbasis hak, dan pemantauan penggunaan KB secara berkelanjutan.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan kemampuan berpikir kritis.	Mahasiswa mampu meningkatkan kualitas pelayanan KB secara aman, tepat, dan berpusat pada klien.

G. Rangkuman Materi

Bab ini membahas secara komprehensif konsep dasar Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan kebidanan sebagai landasan dalam pemberian asuhan yang berkualitas, aman, dan berpusat pada klien. Rangkuman berikut menyajikan poin-poin inti yang merepresentasikan keseluruhan materi:

1. Konsep Dasar Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan upaya pengaturan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. KB tidak hanya berfokus pada penggunaan kontrasepsi, tetapi juga mencakup edukasi, konseling, serta pengambilan keputusan secara sadar dan sukarela oleh pasangan usia subur.

2. Konsep Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Pelayanan kesehatan reproduksi mencakup seluruh siklus kehidupan perempuan, mulai dari remaja, usia reproduksi, kehamilan, persalinan, hingga menopause, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

3. Ruang Lingkup Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dalam Kebidanan

Pelayanan meliputi pengkajian kebutuhan klien, konseling KB, pemilihan metode kontrasepsi, pelayanan kesehatan ibu, pencegahan penyakit menular seksual, serta edukasi kesehatan reproduksi. Bidan berperan penting dalam memberikan asuhan yang komprehensif dan berkesinambungan.

4. Prinsip Pelayanan Berbasis Hak Reproduksi

Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi harus menghormati hak klien, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, memilih metode kontrasepsi, mendapatkan pelayanan yang aman, serta bebas dari diskriminasi dan paksaan. Pendekatan ini menekankan client-centered care dan informed choice.

5. Peran Bidan dalam Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

Bidan berperan sebagai pemberi asuhan, konselor, edukator, dan advokat kesehatan perempuan. Bidan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mendukung pengambilan keputusan keluarga, serta menjamin kesinambungan pelayanan melalui tindak lanjut dan rujukan.

6. Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan KB

Pemanfaatan KB dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, sikap, budaya, dukungan pasangan, akses pelayanan, serta persepsi terhadap efek samping. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan psikologis klien.

7. Relevansi terhadap Capaian Pembelajaran

Materi ini mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa dalam memahami konsep dasar KB dan kesehatan reproduksi (CPMK pengetahuan), melakukan analisis masalah dan kebutuhan klien (CPMK keterampilan), serta memberikan konseling berbasis hak (CPMK sikap dan profesionalisme).

Secara keseluruhan, konsep dasar KB dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan kebidanan merupakan pondasi penting dalam memberikan asuhan yang holistik, berkelanjutan, dan berpusat pada klien, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan ibu, anak, dan keluarga.

Tabel 1.4
Red Flags & Eskalasi

Pelayanan KB Berbasis Komunitas

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perdarahan pervaginam banyak atau berkepanjangan setelah penggunaan kontrasepsi	Kemungkinan efek samping berat atau gangguan hormonal yang memerlukan evaluasi lebih lanjut	Lapor ke pembimbing/dokter, evaluasi kondisi umum klien, pertimbangkan penghentian metode dan rujukan
Tidak haid disertai tanda kehamilan (mual, payudara tegang)	Kemungkinan kegagalan kontrasepsi dan kehamilan	Lakukan tes kehamilan, hentikan kontrasepsi sementara, rujuk untuk evaluasi
Nyeri hebat pada perut bawah	Dapat mengarah pada kehamilan ektopik atau komplikasi lain	Segera evaluasi, lakukan rujukan emergensi
Tanda infeksi pada alat kontrasepsi (misal implan, IUD) di rumah klien (kemerahan, nyeri, bengkak, keluar cairan)	Infeksi lokal akibat prosedur	Lapor ke petugas kesehatan, lakukan perawatan luka sesuai SOP, pertimbangkan rujukan jika berat
Sakit kepala berat atau gangguan penglihatan	Kemungkinan efek samping serius atau kondisi neurologis	Hentikan sementara penggunaan kontrasepsi, evaluasi media segera
Peningkatan berat badan yang signifikan dan cepat	Efek samping hormonal atau faktor lain yang perlu dikaji	Edukasi pola hidup, evaluasi penyebab, pertimbangkan ganti metode KB sesuai kebutuhan
Klien tidak patuh penggunaan (lupa minum pil, terlambat suntik)	Risiko kegagalan kontrasepsi meningkat	Edukasi ulang, pilih metode yang lebih sesuai (misal implan atau suntik), lakukan konseling tambahan
Klien ingin menghentikan kontrasepsi karena efek samping atau mitos	Risiko drop out KB	Konseling ulang, tawarkan alternatif metode, lakukan informed choice dan follow-up

Ditemukan kontraindikasi baru selama penggunaan KB	Risiko keselamatan klien	Hentikan metode, lakukan evaluasi medis, rujuk ke fasilitas kesehatan jika diperlukan
Reaksi alergi atau hipersensitivitas setelah vaksin atau suntikan KB (misal ruam, sesak nafas ringan)	Efek samping serius yang memerlukan perhatian	Hentikan prosedur, berikan pertolongan awal, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab : Konsep Dasar KB dan Kesehatan Reproduksi
 Nama Mahasiswa : _____
 NIM : _____
 Tanggal : _____
 Tempat Praktek/Lapangan Komunitas : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan pelayanan KB	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan asesmen kebutuhan KB pada klien	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi pasangan usia subur yang memerlukan KB	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menanyakan riwayat penggunaan kontrasepsi sebelumnya	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menanyakan riwayat menstruasi, kehamilan, dan keluhan terkait KB	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menanyakan riwayat penyakit kronis atau obat yang sedang digunakan	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menanyakan preferensi dan kekhawatiran klien terkait KB	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa melakukan skrining kelayakan metode KB hormonal dan non-hormonal	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa mengidentifikasi kontraindikasi penggunaan metode KB tertentu	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menentukan metode KB yang sesuai dengan kondisi dan preferensi klien	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa memberikan edukasi mengenai cara kerja, penggunaan, kelebihan dan kekurangan metode KB	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan efek samping yang mungkin terjadi dan langkah pencegahannya	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya/red flags yang memerlukan evaluasi atau rujukan	☐	☐	_____

14	Saya sudah bisa menyesuaikan metode KB dan edukasi sesuai konteks sosial, budaya, dan preferensi klien	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menyusun rencana tindak lanjut dan monitoring penggunaan KB	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa mendokumentasikan jenis KB, edukasi, dan rencana tindak lanjut secara ringkas dan jelas	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama pelayanan KB	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Referensi

- Afulani, P. A., Buback, L., Essandoh, F., et al. (2019). Quality of antenatal care and associated factors in a rural county in Kenya: An assessment of service provision and experience dimensions. *BMC Health Services Research*, 19, 684. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4476-4>
- Ahmed, S., Li, Q., Liu, L., & Tsui, A. O. (2012). Maternal deaths averted by contraceptive use: An analysis of 172 countries. *The Lancet*, 380(9837), 111–125. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60478-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60478-4)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). *Laporan kinerja Program Bangga Kencana tahun 2022*. BKKBN.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Blackstone, S. R., Nwaozuru, U., & Iwelunmor, J. (2017). Factors influencing contraceptive use in sub-Saharan Africa: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(5), 1–16. <https://doi.org/10.3390/ijerph14050567>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2012). Contraception and health. *The Lancet*, 380(9837), 149–156. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60609-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60609-6)
- Darroch, J. E., Singh, S., & Weissman, E. (2016). *Adding it up: The costs and benefits of investing in sexual and reproductive health*. Guttmacher Institute.

- Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? *JAMA*, 260(12), 1743–1748. <https://doi.org/10.1001/jama.260.12.1743>
- Ejigu, B. A., Seme, A., Zimmerman, L., & Shiferaw, S. (2022). Trend and determinants of quality of family planning counseling in Ethiopia: Evidence from repeated PMA cross-sectional surveys (2014–2019). *PLOS ONE*, 17(5), e0267944. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267944>
- Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., et al. (2012). Shared decision making: A model for clinical practice. *Journal of General Internal Medicine*, 27(10), 1361–1367. <https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6>
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2003). *Family nursing: Research, theory, and practice* (5th ed.). Prentice Hall.
- Glasier, A., Gülmezoglu, A. M., Schmid, G. P., Moreno, C. G., & Van Look, P. F. A. (2006). Sexual and reproductive health: A matter of life and death. *The Lancet*, 368(9547), 1595–1607. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)69478-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69478-6)
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health program planning: An educational and ecological approach* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan kesehatan reproduksi*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana di fasilitas kesehatan tingkat pertama*. Kemenkes RI.
- Rogers, C. R. (1961). *On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy*. Houghton Mifflin.
- Saifuddin, A. B. (2020). *Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Simaibang, V., et al. (2024). *Konsep dasar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana*.
- Solo, J., et al. (2019). Quality of family planning counseling and its impact on contraceptive continuation. *Global Health: Science and Practice*, 7(3), 1–10. <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-19-00068>
- Starbird, E., Norton, M., & Marcus, R. (2016). Investing in family planning: Key to achieving the Sustainable Development Goals. *Global Health: Science and Practice*, 4(2), 191–210. <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-15-00374>
- Starrs, A. M., et al. (2018). Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all. *The Lancet*, 391(10140), 2642–2692.

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30293-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30293-9)

World Health Organization. (2021). *Family planning: A global handbook for providers* (3rd ed.). WHO Press.

BAB 2

ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM REPRODUKSI SERTA DASAR REGULASI FERTILITAS

CPL Dan CPMK

CPL	CPMK	SUB-CPMK
CPL-1 Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan regulasi dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.	CPMK-1: Menganalisis konsep, tujuan, kebijakan, serta aspek etika–legal keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan. CPMK-3: Mengevaluasi kebutuhan, preferensi, dan hak kesehatan reproduksi klien dengan pendekatan berpusat pada klien. CPMK-4: Merancang dan menerapkan konseling KB efektif (komunikasi, informed choice, skrining kelayakan) serta rencana tindak lanjut. CPMK-7: Mengelola pelayanan KB/kespro (IMS/HIV, logistik, pencatatan-pelaporan, mutu, keselamatan, evaluasi kepuasan) berbasis data.	2.1 Menguraikan anatomi–fisiologi reproduksi dan siklus hormonal 2.2 Menjelaskan regulasi fertilitas dan titik intervensi kontrasepsi
CPL-2 Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi berpusat pada klien/keluarga untuk mendukung pengambilan keputusan kontrasepsi	CPMK-3: Mengevaluasi kebutuhan, preferensi, dan hak kesehatan reproduksi klien dengan pendekatan berpusat pada klien. CPMK-4: Merancang dan menerapkan konseling KB efektif (komunikasi, informed choice, skrining kelayakan) serta rencana tindak lanjut. CPMK-5: Menentukan pilihan metode kontrasepsi yang tepat dan menyusun	

	edukasi penggunaan sesuai kelayakan, kondisi, dan bukti.	
CPL 4 Menganalisis data klinis dan konteks klien untuk pengambilan keputusan berbasis bukti terkait pemilihan dan tindak lanjut kontrasepsi.	CPMK-2: Menganalisis anatomi–fisiologi sistem reproduksi dan regulasi fertilitas sebagai dasar pemilihan metode kontrasepsi. CPMK-3: Mengevaluasi kebutuhan, preferensi, dan hak kesehatan reproduksi klien dengan pendekatan berpusat pada klien. CPMK-5: Menentukan pilihan metode kontrasepsi yang tepat dan menyusun edukasi penggunaan sesuai kelayakan, kondisi, dan bukti. CPMK-6: Menangani efek samping/komplikasi KB, menetapkan tindakan awal, serta menentukan kebutuhan rujukan secara aman.	

Uraian Materi

A. Definisi Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi serta Dasar Regulasi Fertilitas

1. Definisi Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi

Anatomi sistem reproduksi perempuan adalah ilmu yang mempelajari struktur makroskopik dan mikroskopik organ reproduksi internal dan eksternal yang berperan dalam fungsi seksual, menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan persalinan. Fisiologi sistem reproduksi perempuan adalah kajian tentang fungsi dinamis organ-organ tersebut, termasuk interaksi neuroendokrin, imunologis, dan metabolik yang memungkinkan terjadinya siklus menstruasi, ovulasi, implantasi, serta pemeliharaan kehamilan. Literatur mutakhir menekankan bahwa sistem reproduksi perempuan merupakan jaringan terintegrasi antara ovarium, tuba, uterus, serviks, vagina, dan lingkungan mikro imun yang saling berkomunikasi dengan organ lain. Bagi bidan, pemahaman anatomi dan fisiologi ini menjadi dasar untuk menilai fungsi reproduksi normal, mengenali gangguan, dan memberikan konseling KB berbasis kondisi biologis klien (Dai et al., 2023; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Stejskalová et al., 2021; Takada et al., 2023).

Anatomi sistem reproduksi laki-laki mencakup struktur testis, epididimis, vas deferens, vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretralis, penis, dan skrotum yang berfungsi dalam produksi, pematangan, penyimpanan, dan ejakulasi sperma. Fisiologi sistem reproduksi laki-laki berkaitan dengan proses spermatogenesis, transport sperma, sekresi hormon testosteron dan hormon terkait, serta regulasi neuroendokrin dan imunologis yang menjaga kesuburan pria sepanjang siklus hidup. Tinjauan mutakhir menekankan pentingnya pemahaman tentang interaksi antara sistem endokrin, faktor lingkungan, dan mekanisme imun sebagai dasar penilaian fertilitas laki-laki dan pencegahan gangguan reproduksi. Dalam praktik kebidanan, wawasan tentang sistem reproduksi laki-laki diperlukan untuk KIE pasangan, konseling KB pria, dan deteksi dini faktor infertilitas laki-laki yang berdampak pada pilihan metode kontrasepsi (Campion et al., 2012; Cariati et al., 2020; Clavijo & Hsiao, 2018; Foster, 2016; Hedger, 2014; Zhang et al., 2020).

2. Definisi Dasar Regulasi Fertilitas

Dasar regulasi fertilitas perempuan adalah serangkaian mekanisme neuroendokrin, parakrin, dan autokrin yang mengatur perkembangan

folikel, ovulasi, fungsi korpus luteum, serta penerimaan endometrium terhadap embrio. Sistem utama yang mengatur fertilitas adalah sumbu hipotalamus–hipofisis–gonad (HPG), di mana hipotalamus melepaskan gonadotropin-releasing hormone (GnRH) secara pulsatif yang menstimulasi hipofisis anterior untuk mensekresi FSH dan LH, yang selanjutnya mengatur produksi estrogen dan progesteron di ovarium. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa adipokin seperti leptin dan faktor metabolik lain berperan sebagai sensor status energi tubuh dan memodulasi aktivitas sumbu HPG sehingga berpengaruh terhadap ovulasi dan keteraturan siklus haid. Bagi bidan, pemahaman regulasi fertilitas ini penting sebagai landasan pemilihan metode kontrasepsi hormonal, penjelasan mekanisme kerja obat, dan deteksi gangguan ovulasi (Ana-Maria Zagrean, 2020; Christensen et al., 2012; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Salem, 2021).

Dasar regulasi fertilitas laki-laki juga dikendalikan oleh sumbu HPG, di mana GnRH hipotalamus merangsang sekresi LH dan FSH yang mengatur produksi testosteron oleh sel Leydig dan spermatogenesis oleh sel Sertoli. Testosteron dan inhibin B memberikan umpan balik negatif ke hipofisis dan hipotalamus untuk menjaga keseimbangan produksi hormon dan sperma. Kajian mutakhir menyoroti peran faktor lingkungan, zat kimia pengganggu endokrin, serta stres oksidatif dalam mengganggu regulasi hormon dan kualitas sperma, sehingga berdampak pada fertilitas dan kebutuhan akan konseling KB yang mempertimbangkan faktor laki-laki. Dalam konteks kebidanan, pemahaman ini membantu bidan menjelaskan peran suami dalam perencanaan kehamilan dan pemilihan metode kontrasepsi yang melibatkan laki-laki (Campion et al., 2012; Cariati et al., 2020; Christensen et al., 2012; Clavijo & Hsiao, 2018; Foster, 2016; Hedger, 2014; Wang et al., 2020).

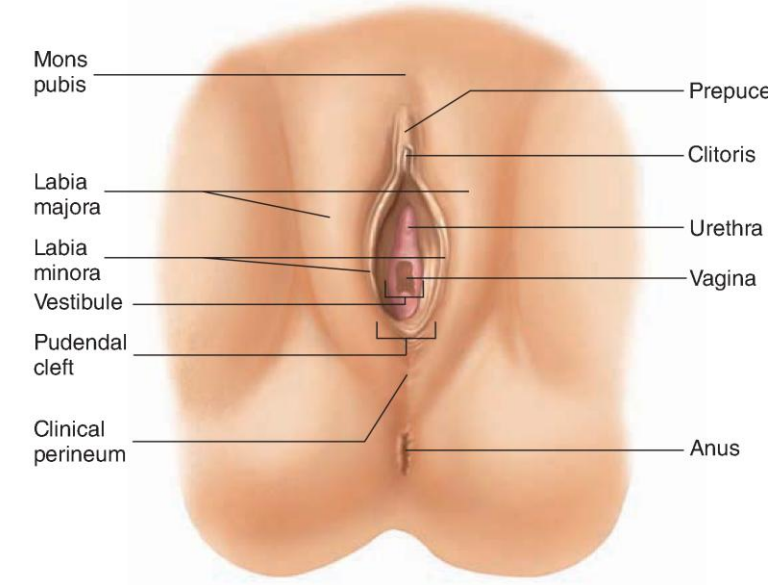
B. Konsep Dasar Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi serta Dasar Regulasi Fertilitas

1. Konsep Dasar Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Perempuan

a. Perempuan – organ eksternal (vulva, klitoris, labia)

Vulva meliputi mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, dan meatus uretra eksterna yang berperan dalam fungsi seksual, perlindungan mekanik, dan pengaliran sekresi genital. Klitoris merupakan struktur erektile dengan kepadatan ujung saraf sensorik tinggi yang berperan utama dalam respon seksual perempuan dan

berhubungan dengan aliran darah lokal, hormon, serta faktor psiko-emosional. Labia mayora dan labia minora melindungi orifisium vagina dan uretra, membantu mempertahankan kelembaban dan pH lokal, serta menjadi bagian penting dalam pemeriksaan fisik kebidanan dan penilaian trauma, infeksi, atau mutilasi genital. Pengenalan anatomi vulva dan variasi normal penting bagi bidan untuk melakukan pemeriksaan, menjelaskan teknik perawatan vulva, dan memberikan konseling kesehatan seksual yang sensitif budaya(Ivell & Anand-Ivell, 2021; Pepe et al., 2018; Wolman, 2014).



Gambar 2.1
Anatom Reproduksi Perempuan - Organ Eksternal (Netter, 2023)

Tabel 2.1
Penjelasan Fungsi Organ-organ Reproduksi Eksternal Perempuan (Gholiof et al., 2022; Wolman, 2014)

Organ	Lokasi anatomi	Struktur utama	Fungsi utama	Keterangan tambahan
Mons pubis	Di atas simfisis pubis, bagian anterior pelvis	Jaringan lemak subkutan, rambut pubis setelah pubertas	Menyerap tekanan mekanik saat aktivitas seksual, melindungi tulang pubis dan jaringan di bawahnya	Bagian dari vulva, dipengaruhi hormon seks sehingga berubah saat pubertas dan kehamilan

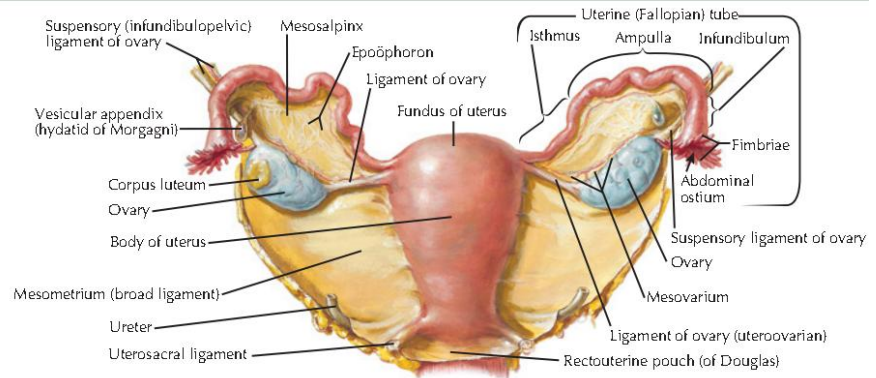
Organ	Lokasi anatomi	Struktur utama	Fungsi utama	Keterangan tambahan
Labia majora	Dua lipatan kulit besar lateral terhadap celah vulva	Kulit dengan rambut, jaringan lemak, kelenjar sebacea dan keringat; homolog dengan skrotum	Melindungi struktur yang lebih dalam (labia minora, klitoris, vestibulum) dari trauma dan kontaminasi mikroba	Berperan dalam menjaga kelembapan dan suhu lokal, sering terlibat pada dermatitis dan infeksi jamur
Labia minora	Lipatan kulit tipis tanpa rambut di medial labia majora	Epitel kaya vaskularisasi dan ujung saraf sensorik, membentuk preputium dan frenulum klitoris	Melindungi orifisium uretra dan vagina, menjaga lingkungan lembap, berperan dalam sensasi seksual	Ukuran dan bentuk sangat bervariasi antar individu; dapat mengalami iritasi bila higiene tidak adekuat
Klitoris	Di komisarura anterior labia minora	Jaringan erektile (korpus kavernosum), glans, batang, preputium; sangat banyak ujung saraf	Pusat sensasi seksual dan orgasme pada perempuan	Homolog dengan penis; tidak terlibat langsung dalam proses fertilisasi namun penting untuk respons seksual
Vestibulum vagina	Ruang antara labia minora, mengelilingi muara uretra dan vagina	Mukosa, orifisium uretra eksterna, orifisium vagina, muara kelenjar Bartholin dan Skene	Jalur keluarnya urin dan darah menstruasi; menerima penis dan semen; ikut menjaga pH dan kelembapan lokal	Perubahan pH dan flora dapat menyebabkan vaginitis, keputihan, dan infeksi menular seksual
Kelenjar Bartholin & Skene	Bartholin: posterolateral introitus	Kelenjar mukosa yang bermuara ke vestibulum	Menghasilkan mukus untuk lubrikasi saat hubungan seksual	Obstruksi dapat menimbulkan kista/abses Bartholin;

Organ	Lokasi anatomi	Struktur utama	Fungsi utama	Keterangan tambahan
	vagina; Skene: sekitar uretra		dan perlindungan mukosa uretra/vestibulum	penting dalam evaluasi nyeri vulva

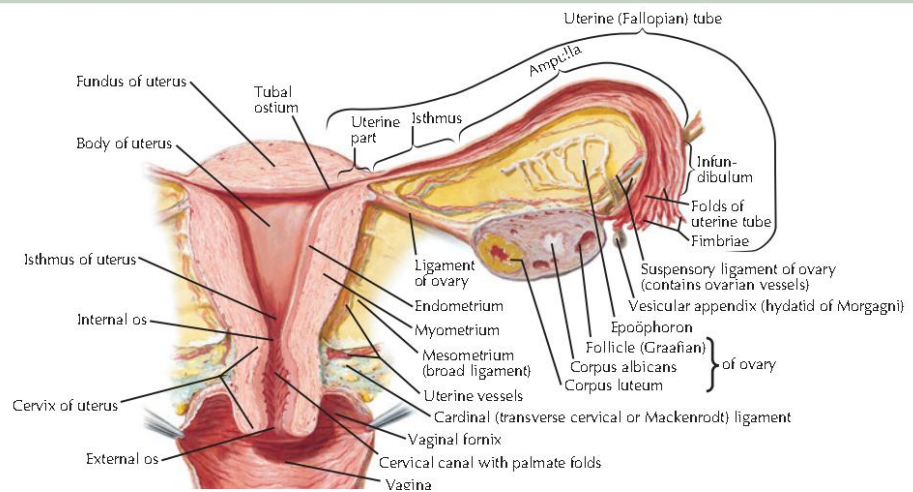
b. Perempuan – organ internal (ovarium, uterus, tuba falopi, vagina)

Ovarium berfungsi sebagai organ gonad yang memproduksi oosit dan hormon steroid (estrogen dan progesteron) melalui proses folikulogenesis yang dikendalikan FSH dan LH. Studi molekuler terbaru menunjukkan bahwa faktor genetik (misalnya ekspresi circRNA, faktor pertumbuhan, dan stanniocalcin-1) serta lingkungan mikro imun dan metabolik mempengaruhi maturasi folikel, kualitas oosit, dan respons terhadap teknologi reproduksi berbantu. Uterus terdiri atas endometrium, miometrium, dan perimetrium, dengan perubahan siklus endometrium yang dipengaruhi estrogen dan progesteron untuk mendukung implantasi dan kehamilan. Tuba falopi berperan dalam menangkap ovum, menjadi tempat fertilisasi, dan mengangkut zigot menuju uterus, di mana matriks ekstraseluler dan pola lipatan mukosa tuba berperan penting dalam transport dan seleksi gamet. Vagina berfungsi sebagai saluran kopulasi, jalan lahir, dan jalur ekskresi darah haid, dengan epitel mukosa dan flora normal yang berperan dalam perlindungan terhadap infeksi, yang keseluruhannya penting bagi keberhasilan konsepsi dan pencegahan penyakit menular seksual (Bishop et al., 2021; Dai et al., 2023; Gao et al., 2021a; Godoy-Guzmán et al., 2018; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Stejskalová et al., 2021; Takada et al., 2023; Tung & Suarez, 2021; Wolman, 2014).

Posterior view



Frontal section



Gambar 2.2

Anatomi Reproduksi Perempuan - Organ Internal (Smith & Netter, 2024)

Tabel 2.2
Penjelasan Fungsi Organ-organ Reproduksi Internal Perempuan (Gholiof et al., 2022; Wolman, 2014)

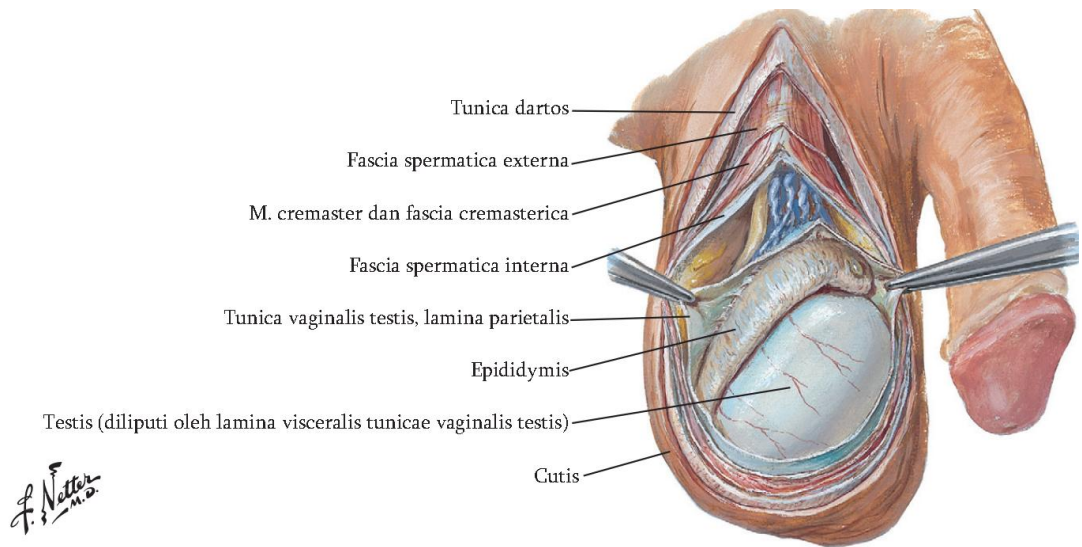
Organ	Lokasi anatomi	Struktur utama	Fungsi utama	Keterangan tambahan
Ovarium	Kanan dan kiri uterus, dalam rongga pelvis	Korteks (folikel, korpus luteum), medula (pembuluh darah, saraf); ditopang ligamentum ovarii dan suspensorium	Gametogenesis (oogenesis, ovulasi) dan fungsi endokrin (sekresi estrogen, progesteron, inhibin)	Organ reproduksi utama; gangguan fungsi menyebabkan anovulasi, infertilitas, dan gangguan siklus haid
Tuba uterina (tuba Fallopii)	Menghubungkan ovarium dengan uterus	Segmen: infundibulum (fimbriae), ampula, isthmus, pars intramuralis; mukosa bersilia dan otot polos	Menangkap oosit, tempat fertilisasi (umumnya di ampula), transport zigot ke uterus melalui gerak silia dan kontraksi	Infeksi atau adhesi tuba meningkatkan risiko kehamilan ektopik dan infertilitas tubal
Uterus	Tengah pelvis, di antara kandung kemih dan rektum	Fundus, korpus, isthmus, serviks; dinding: endometrium, miometrium, perimetrium	Tempat implantasi dan perkembangan janin; kontraksi miometrium saat persalinan dan menstruasi	Endometrium mengalami perubahan siklik oleh hormon; menjadi fokus utama pada infertilitas, endometriosis, dan hiperplasia
Serviks uteri	Segmen bawah uterus yang menonjol ke vagina	Endoserviks (epitel kolumnar, kelenjar mukosa), ektoserviks	Kanal antara uterus dan vagina, sekresi mukus yang mengatur masuknya	Zona transformasi merupakan area rawan neoplasia; basis skrining

Organ	Lokasi anatomi	Struktur utama	Fungsi utama	Keterangan tambahan
		(epitel skuamosa)	sperma dan pertahanan terhadap patogen	Pap smear dan HPV
Vagina	Saluran dari serviks ke introitus vulva	Saluran fibromuskular berlipat (rugae), epitel skuamosa non-keratin dengan glikogen, mikrobiota dominan Lactobacillus	Saluran koitus, saluran lahir, dan jalur keluarnya darah menstruasi; mempertahankan pH asam protektif	Gangguan komposisi mikrobiota (disbiosis) berhubungan dengan vaginosis bakterialis, infeksi, dan gangguan fertilitas

2. Konsep Dasar Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Perempuan

a. Laki-laki – organ eksternal (penis, skrotum)

Penis merupakan organ kopulasi dan ekskresi urine yang terdiri atas korpus kavernosum dan korpus spongiosum dengan jaringan erektile yang merespons rangsangan neurovaskular dan hormonal. Mekanisme ereksi melibatkan vasodilatasi arteri penis, relaksasi otot polos, dan peningkatan aliran darah yang dipengaruhi oleh nitric oxide, prostaglandin, serta status kardiovaskular dan metabolik pria. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis sekitar 2–4 derajat lebih rendah dari suhu tubuh untuk mendukung spermatogenesis, dengan mekanisme adaptif melalui kontraksi otot kremaster dan dartos. Pemahaman anatomi dan fisiologi penis dan skrotum penting dalam edukasi kebersihan genital, pencegahan infeksi menular seksual, serta konseling KB yang melibatkan kondom dan prosedur vasektomi (Clavijo & Hsiao, 2018; Foster, 2016; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Onuoha & Onuoha, 2020).



Gambar 2.3
Anatomi Reproduksi Laki-laki - Organ Eksternal (Smith & Netter, 2024)

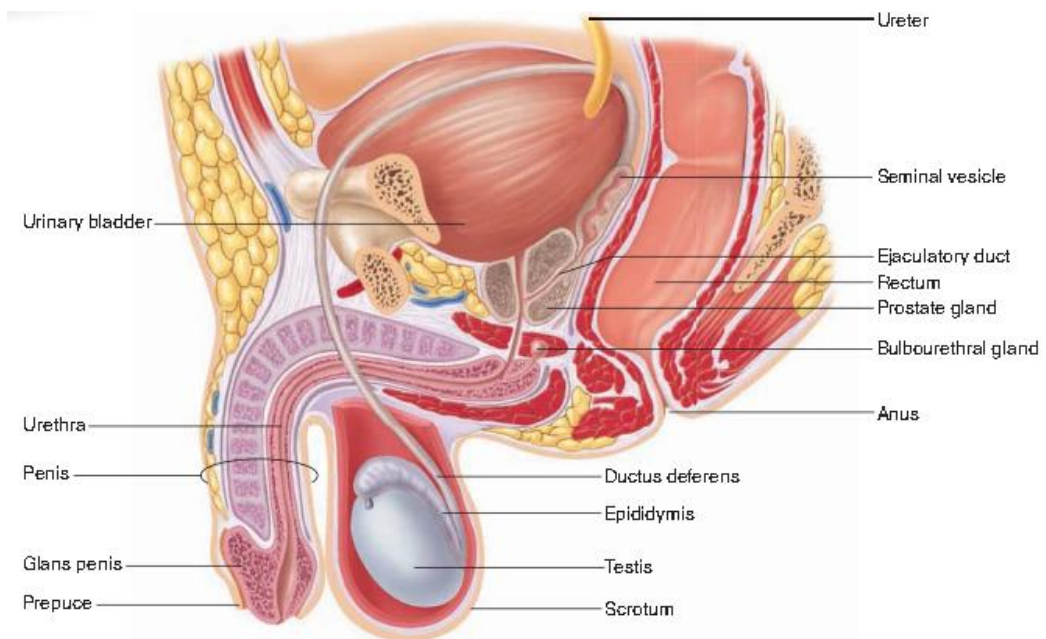
Tabel 2.3
Penjelasan Fungsi Organ-organ Reproduksi Eksternal Laki-laki (Dwyer et al., 2011).

Organ	Lokasi anatomi	Struktur utama	Fungsi utama	Keterangan tambahan
Penis (corpus)	Perineum anterior, menggantung di depan skrotum	Tiga berkas jaringan erektile: dua corpora cavernosa dan satu corpus spongiosum yang mengelilingi uretra; dilapisi tunika albuginea, kulit, dan fascia superfisial	Organ kopulasi, mengantarkan urin dan semen ke luar tubuh melalui uretra	Ereksi terjadi akibat peningkatan aliran darah ke corpora cavernosa; dipersarafi saraf pudendus dan otonom, penting untuk fungsi seksual
Glans penis	Ujung distal penis	Perluasan distal corpus spongiosum; sangat kaya ujung saraf sensoris, dilapisi kulit tipis atau preputium pada yang belum disunat	Pusat sensasi seksual, membantu penetrasi dan arah aliran urin/semen	Sangat sensitif terhadap trauma dan infeksi; area penting dalam edukasi kebersihan genital
Uretra penis (bagian spongiosa)	Berjalan di dalam corpus spongiosum penis	Saluran berlapis epitel yang membawa urin dan semen; bermuara di meatus uretra eksterna pada glans	Saluran ekskresi urin dan semen (fungsi urogenital)	Sfingter internal (di leher vesika) mencegah refluks semen ke kandung kemih saat ejakulasi

Organ	Lokasi anatomi	Struktur utama	Fungsi utama	Keterangan tambahan
Skrotum	Kantong kulit di inferior penis	Kantong kulit dengan raphe, berisi testis dan epididimis; dinding terdiri dari kulit, fasia, dan otot dartos	Menampung dan melindungi testis; mengatur suhu testis (lebih rendah $\pm 2-3^{\circ}\text{C}$ dari suhu tubuh)	Kontraksi otot dartos dan kremaster mengatur jarak testis dari tubuh untuk menjaga suhu ideal spermatogenesis

c. Laki-laki – organ internal (testis, vas deferens, vesikula seminalis)

Testis berfungsi sebagai tempat spermatogenesis dan produksi testosteron, tersusun atas tubulus seminiferus yang mengandung sel germinal dan sel Sertoli, serta jaringan interstisial dengan sel Leydig. Proses spermatogenesis berlangsung melalui tahapan pembelahan mitosis dan meiosis yang sensitif terhadap regulasi hormonal, suhu, stres oksidatif, dan paparan bahan kimia lingkungan. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari epididimis menuju uretra, dengan dinding otot polos yang kuat untuk memfasilitasi ejakulasi; sedangkan vesikula seminalis menghasilkan sebagian besar volume semen yang kaya fruktosa, prostaglandin, dan protein untuk mendukung motilitas dan viabilitas sperma. Studi terkini menunjukkan bahwa lingkungan biokimia cairan semen, termasuk komponen imun dan faktor pertumbuhan, berperan dalam keberhasilan fertilisasi dan dapat berubah akibat paparan toksik atau penyakit sistemik (Cariati et al., 2020; Clavijo & Hsiao, 2018; Foster, 2016; Zhang et al., 2020).



Gambar 2.4
Anatomi Reproduksi Laki-laki - Organ Internal (Cinnamon et al., 2022)

Tabel 2.4
Penjelasan Fungsi Organ-organ Reproduksi Internal Laki-laki (Battistone et al., 2019; Dwyer et al., 2011; Rey, 2021; Ruthig et al., 2016)

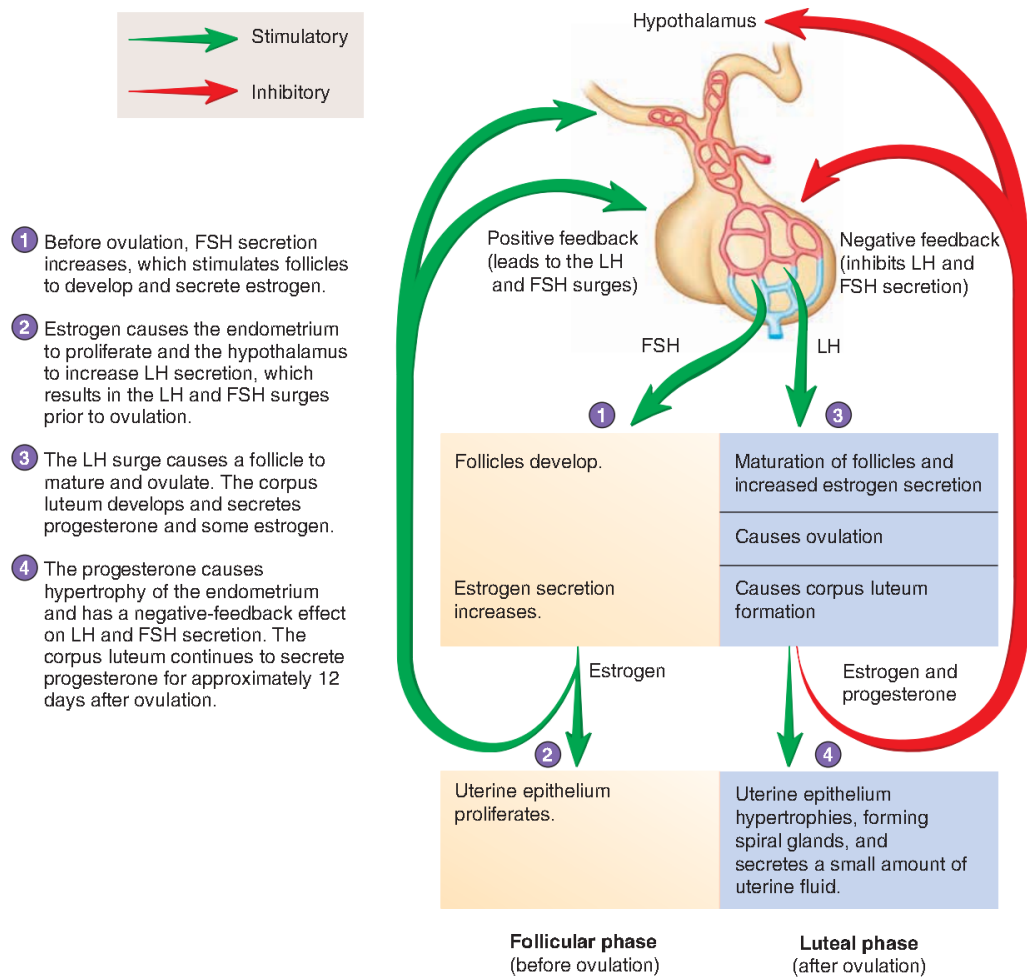
Organ	Lokasi anatomi	Struktur utama	Fungsi utama	Keterangan tambahan
Testis	Di dalam skrotum, kanan dan kiri	Diselubungi tunika vaginalis dan tunika albuginea; berisi lobulus dengan tubulus seminiferus, sel Leydig di interstisium	Produksi sperma (spermatogenesis) dan hormon testosteron serta androgen lain	Androgen penting untuk perkembangan karakter seksual sekunder dan pemeliharaan fungsi organ reproduksi internal–eksternal
Epididimis	Melekat di sisi posterior testis	Kepala, badan, ekor; satu saluran panjang berkelok yang ber dinding epitel dan otot polos	Tempat pematangan, penyimpanan sementara, dan transport sperma dari testis ke vas deferens	Lingkungan epididimis mengatur maturasi fungsional sperma; gangguan di sini terkait infertilitas pria
Vas deferens (ductus deferens)	Dari ekor epididimis menuju vesikula seminalis dan duktus ejakulatorius	Saluran tebal, lumen kecil, dinding otot polos kuat (3 lapis)	Mengangkut sperma saat ejakulasi melalui kontraksi peristaltik kuat menuju duktus ejakulatorius	Segmen ampula vas deferens menjadi tempat penyimpanan sperma tambahan sebelum ejakulasi
Vesikula seminalis	Posterior kandung kemih, superior prostat	Kelenjar berpasangan, saluran berkelok, bermuara ke duktus ejakulatorius	Menghasilkan sekitar 60–70% volume semen: cairan kental kaya fruktosa, prostaglandin,	Fruktosa menjadi sumber energi sperma; prostaglandin memfasilitasi motilitas

Organ	Lokasi anatomi	Struktur utama	Fungsi utama	Keterangan tambahan
			dan protein koagulasi	sperma dan kontraksi traktus genital wanita
Prostat	Inferior kandung kemih, mengelilingi uretra prostatika	Kelenjar fibromuskular berlobus; menghasilkan cairan sekret alkali	Menghasilkan $\pm 20\text{--}30\%$ volume semen, berisi enzim (mis. PSA), sitrat, dan ion yang mendukung viabilitas sperma	Hipertrofi prostat jinak (BPH) dan kanker prostat adalah masalah klinis utama pada pria usia lanjut
Kelenjar bulbouretralis (Cowper)	Di dasar penis, dalam diafragma urogenital	Kelenjar kecil berpasangan, duktusnya bermuara ke uretra spongiosa	Menghasilkan cairan mukoid jernih sebelum ejakulasi (pre-ejakulat) yang melumasi uretra dan menetralkan urin residu asam	Sekret awal ini juga membantu mempersiapkan uretra untuk transport semen
Duktus ejakulatorius	Dari gabungan vas deferens dan duktus vesikula seminalis, menembus prostat	Saluran pendek yang bermuara ke uretra prostatika	Mengalirkan campuran sperma dan sekret vesikula seminalis ke uretra saat ejakulasi	Obstruksi duktus ejakulatorius menyebabkan volume ejakulat rendah dan infertilitas
Uretra prostatika & membranasea	Melintasi prostat dan diafragma urogenital	Saluran yang menerima duktus ejakulatorius dan sekresi prostat	Menjadi jalur semen dari duktus ejakulatorius menuju uretra spongiosa	Sfingter eksternus (membranasea) berperan dalam kontinensia urin; koordinasi penting untuk ejakulasi normal

3. Konsep Dasar Regulasi Fertilitas

a. Regulasi hormonal pada siklus reproduksi Perempuan

Regulasi fertilitas perempuan dikendalikan oleh interaksi sumbu HPG dengan faktor metabolik, imun, dan lingkungan sehingga menghasilkan siklus menstruasi yang teratur. FSH menstimulasi pertumbuhan folikel dan produksi estrogen, sedangkan LH memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum yang memproduksi progesteron untuk mempersiapkan endometrium. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa adipokin seperti leptin dan ghrelin, serta nutrisi dan komposisi tubuh, terlibat dalam mengkoneksikan status energi dengan fungsi reproduksi; malnutrisi atau obesitas dapat mengganggu ovulasi dan menurunkan fertilitas. Selain itu, faktor imunologis dan mikrobiota di traktus genital berperan dalam mempertahankan lingkungan yang mendukung implantasi dan kehamilan, sekaligus melindungi dari infeksi. Konsep ini menjadi dasar bagi bidan untuk menjelaskan mekanisme kerja kontrasepsi hormonal (misalnya pil kombinasi, injeksi, implan) yang umumnya mengganggu ovulasi, memodifikasi lendir serviks, dan mengubah endometrium (Christensen et al., 2012; Dai et al., 2023; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Wolman, 2014)



Gambar 2.5
Regulasi hormonal pada siklus reproduksi perempuan (Cinnamon et al., 2022).

Gambar ini menunjukkan bagaimana otak (hipotalamus dan kelenjar pituitari) berkomunikasi dengan ovarium dan rahim melalui hormon.

Sebagai panduan membaca gambar:

- 1) Panah Hijau: Berarti Stimulasi (merangsang/meningkatkan produksi).
- 2) Panah Merah: Berarti Inhibisi (menghambat/menurunkan produksi).

Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah berdasarkan nomor pada gambar:

1) Pertumbuhan Folikel

Siklus dimulai ketika kelenjar pituitari melepaskan hormon FSH (*Follicle Stimulating Hormone*). Sesuai panah hijau ke bawah, FSH bertugas merangsang folikel (kantong berisi sel telur) di dalam ovarium untuk berkembang. Saat folikel ini berkembang, mereka mulai memproduksi hormon Estrogen.

2) Efek Estrogen dan Umpan Balik Positif Peningkatan kadar Estrogen memiliki dua tugas utama:

- Ke bawah: Merangsang epitel uterus (dinding rahim) untuk menebal atau berproliferasi sebagai persiapan kehamilan.
- Ke atas (Panah Hijau ke Hipotalamus): Memberikan sinyal umpan balik positif ke otak. Tingginya estrogen memicu hipotalamus dan pituitari untuk melepaskan hormon LH (*Luteinizing Hormone*) secara drastis (lonjakan LH) dan sedikit peningkatan FSH tepat sebelum ovulasi.

3) Ovulasi dan Pembentukan Korpus Luteum

Lonjakan hormon LH adalah pemicu utama terjadinya ovulasi (pelepasan sel telur yang sudah matang dari folikel). Setelah sel telur dilepaskan, sisa cangkang folikel tersebut berubah bentuk menjadi struktur yang disebut Korpus Luteum. Korpus luteum ini berfungsi sebagai kelenjar sementara yang memproduksi hormon Progesteron dan sedikit Estrogen.

4) Persiapan Rahim dan Umpan Balik Negatif Hormon dari korpus luteum bekerja dengan cara:

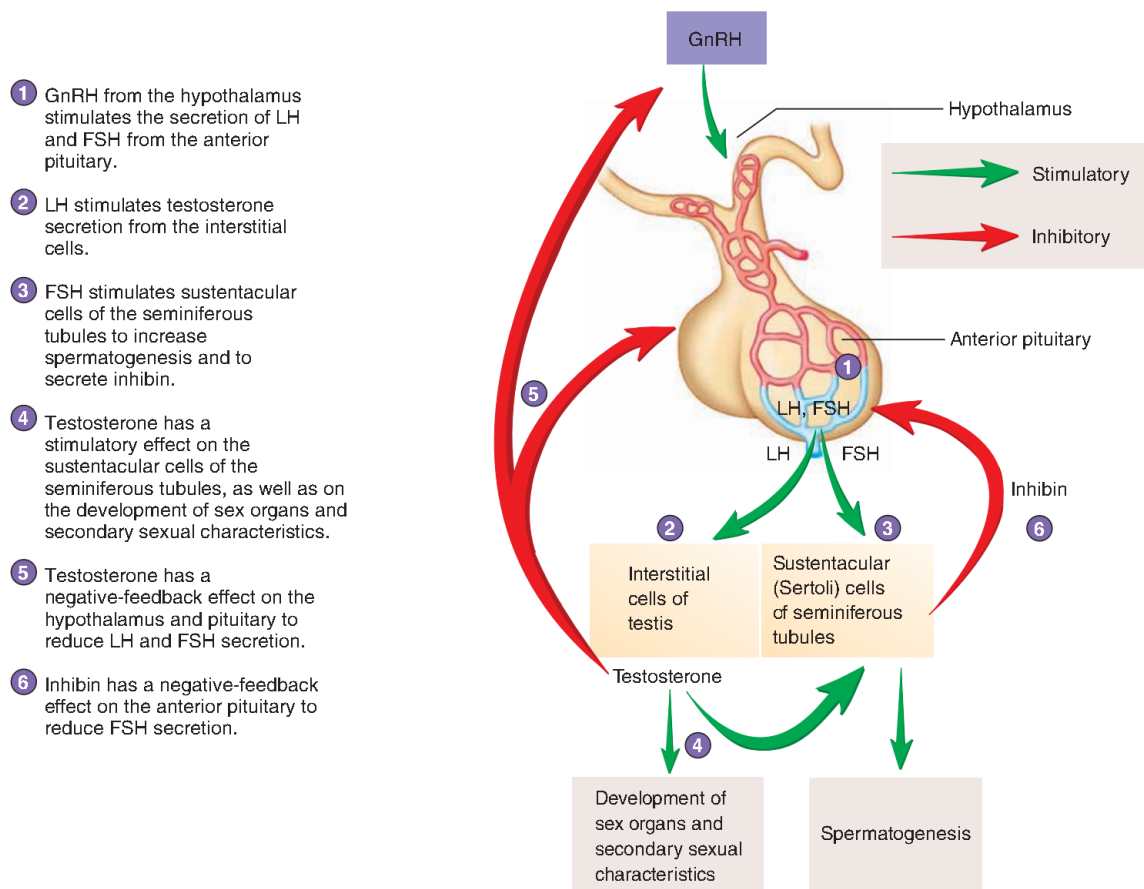
- Ke bawah (Persiapan Rahim): Progesteron menyebabkan dinding rahim mengalami hipertrofi (semakin menebal, kaya pembuluh darah, dan membentuk kelenjar spiral yang mengeluarkan cairan). Ini adalah kondisi ideal jika embrio ingin menempel.

- Ke atas (Panah Merah ke Otak): Kombinasi Estrogen dan Progesteron memberikan sinyal umpan balik negatif kepada hipotalamus dan pituitari. Sinyal ini menghambat (menyetop) produksi hormon FSH dan LH. Tujuannya adalah agar tubuh tidak mematangkan folikel baru saat sedang bersiap untuk kemungkinan kehamilan.

Korpus luteum akan terus memproduksi progesteron selama kurang lebih 12 hari setelah ovulasi. (Jika tidak terjadi kehamilan, korpus luteum akan menyusut, hormon turun, dan terjadilah menstruasi, yang akan mengulang kembali siklus ke langkah 1).

b. 2. Regulasi hormonal pada siklus reproduksi Laki-laki

Pada laki-laki, GnRH hipotalamus merangsang hipofisis untuk mengeluarkan LH dan FSH yang kemudian mengatur produksi testosteron dan spermatogenesis. LH menstimulasi sel Leydig menghasilkan testosteron, sedangkan FSH bersama testosteron menstimulasi sel Sertoli untuk mendukung pembentukan dan maturasi sperma. Inhibin B yang dihasilkan sel Sertoli memberikan umpan balik negatif ke hipofisis untuk mengatur produksi FSH, sementara testosteron menghambat sekresi GnRH dan LH untuk menjaga homeostasis hormonal. Studi terbaru menggarisbawahi peran paparan bahan kimia pengganggu endokrin, stres oksidatif, dan proses inflamasi dalam mengganggu regulasi ini dan menurunkan kualitas sperma. Bagi bidan, pemahaman mekanisme ini bermanfaat untuk memberikan KIE tentang faktor risiko infertilitas laki-laki, pentingnya gaya hidup sehat, dan peluang pengembangan kontrasepsi hormonal pria di masa depan (Campion et al., 2012; Cariati et al., 2020; Clavijo & Hsiao, 2018; Hedger, 2014; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Wang et al., 2020; Zhang et al., 2020).



Gambar 2.6

Regulasi hormonal pada siklus reproduksi laki-laki (Cinnamon et al., 2022).

Gambar ini menjelaskan tentang regulasi hormonal pada sistem reproduksi pria, yang menunjukkan bagaimana otak mengontrol produksi sperma dan hormon testosteron di dalam testis.

Sama seperti gambar sebelumnya, perhatikan panduan warnanya:

- 1) Panah Hijau: Berarti Stimulasi (merangsang/meningkatkan kerja).
- 2) Panah Merah: Berarti Inhibisi (menghambat/memberikan umpan balik negatif untuk menurunkan produksi).

Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah berdasarkan nomor pada gambar:

- 1) Sinyal Awal dari Otak

Siklus dimulai di otak. Hipotalamus melepaskan hormon yang disebut GnRH. Hormon ini turun dan merangsang bagian otak lainnya, yaitu

kelenjar pituitari anterior, untuk melepaskan dua hormon penting: LH (*Luteinizing Hormone*) dan FSH (*Follicle-Stimulating Hormone*).

2) Peran LH (Produksi Testosteron)

Hormon LH bergerak menuju testis dan secara spesifik menstimulasi sel interstitial (juga dikenal sebagai sel Leydig). Sel-sel ini kemudian memproduksi dan melepaskan hormon Testosteron.

3) Peran FSH (Produksi Sperma)

Sementara itu, hormon FSH juga bergerak ke testis tetapi menargetkan sel sustentakular (juga dikenal sebagai sel Sertoli) di dalam tubulus seminiferus. Stimulasi ini bertujuan untuk meningkatkan spermatogenesis (proses pembentukan sperma) dan juga memicu sel tersebut untuk memproduksi hormon Inhibin.

4) Efek Testosteron

Testosteron yang dihasilkan pada langkah 2 memiliki beberapa fungsi penting (ditunjukkan oleh panah hijau ke bawah):

- Membantu sel sustentakular dalam proses pembentukan sperma.
- Merangsang perkembangan organ reproduksi pria.
- Memunculkan karakteristik seksual sekunder (seperti suara yang membesar, pertumbuhan rambut di wajah/tubuh, dan peningkatan massa otot).

5) Umpan Balik Negatif dari Testosteron

Tubuh harus menjaga agar hormon tidak diproduksi berlebihan. Ketika kadar testosteron sudah cukup tinggi di dalam darah, ia akan mengirimkan sinyal umpan balik negatif (panah merah besar yang melengkung ke atas) kembali ke hipotalamus dan kelenjar pituitari. Sinyal ini menyuruh otak untuk "mengerem" atau mengurangi produksi LH dan FSH, sehingga produksi testosteron kembali normal.

6) Umpan Balik Negatif dari Inhibin

Selain testosteron, hormon Inhibin yang dihasilkan pada langkah 3 juga memberikan sinyal umpan balik negatif (panah merah di sebelah kanan). Namun, inhibin secara spesifik hanya menargetkan kelenjar pituitari anterior untuk mengurangi produksi FSH. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar produksi sperma (spermatogenesis) tidak terjadi secara berlebihan.

C. Kebutuhan untuk Pemeliharaan Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi serta Dasar Regulasi Fertilitas

1. Kebutuhan untuk Pemeliharaan Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi

a. Kebutuhan untuk Pemeliharaan Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Perempuan

Pemeliharaan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi perempuan yang sehat membutuhkan keseimbangan hormonal, status nutrisi yang adekuat, lingkungan mikro genital yang seimbang, serta bebas dari infeksi dan paparan toksin. Studi terbaru menekankan peran mikronutrien seperti selenium, vitamin D, dan antioksidan dalam mendukung fungsi ovarium, plasenta, dan mencegah komplikasi kehamilan. Kebutuhan lain mencakup fungsi imun yang seimbang di traktus genital untuk memungkinkan toleransi terhadap sperma dan embrio, namun tetap memberikan pertahanan terhadap patogen. Dari perspektif kebidanan, pemenuhan kebutuhan ini diwujudkan melalui promosi gizi seimbang, pencegahan infeksi menular seksual, imunisasi, dan skrining faktor risiko lingkungan sebelum perencanaan kehamilan dan pemilihan metode KB (Dai et al., 2023; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Kumar et al., 2023; Sadykova & Olina, 2021; Wolman, 2014).

c. Kebutuhan untuk Pemeliharaan Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Laki-laki

Kesehatan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi laki-laki memerlukan testis dengan suhu optimal, suplai vaskular memadai, keseimbangan hormon androgen, serta lingkungan bebas paparan toksin dan stres oksidatif berlebihan. Kajian sistematis menunjukkan bahwa paparan bahan kimia seperti bisphenol A, polibrominated diphenyl ethers, pyrethroid, dan nonylphenol dapat merusak struktur testis, mengganggu spermatogenesis, dan menurunkan kualitas semen. Sebaliknya, intervensi antioksidan seperti N-asetilsistein dan flavonoid tertentu dilaporkan berpotensi memperbaiki fungsi reproduksi pria melalui penurunan stres oksidatif dan perbaikan kualitas sperma. Dalam praktik kebidanan, edukasi kepada pasangan mengenai gaya hidup sehat, penghindaran rokok, alkohol, dan paparan toksik, serta pemantauan keluhan urogenital pria merupakan bagian dari upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi pasangan (Campion et al., 2012; Cariati et al., 2020; Clavijo & Hsiao, 2018;

Ghafari-zadeh et al., 2021; M, 2020; Wang et al., 2020; Ye et al., 2020; Zhang et al., 2020)

2. Kebutuhan Dasar Regulasi Fertilitas

a. Kebutuhan Dasar Regulasi Fertilitas pada Perempuan

Regulasi fertilitas yang optimal membutuhkan integritas sumbu HPG, status gizi memadai, komposisi tubuh sehat, dan keseimbangan antara faktor pro-inflamasi dan anti-inflamasi dalam tubuh. Sistem review terkini menunjukkan bahwa variasi leptin sepanjang siklus menstruasi dan interaksinya dengan hormon gonadotropin mencerminkan hubungan erat antara cadangan energi dan kemampuan reproduksi perempuan. Kebutuhan lain mencakup ritme sirkadian yang baik, aktivitas fisik seimbang, dan minimnya stres kronis, yang semuanya mempengaruhi sekresi GnRH dan fungsi ovarium. Bagi bidan, pemahaman ini menjadi dasar dalam konseling prakonsepsi, penatalaksanaan gangguan siklus haid, serta pemilihan metode KB yang mempertimbangkan keadaan metabolik dan endokrin klien (misalnya PCOS, obesitas, diabetes) (Ana-Maria Zagrean, 2020; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Salem, 2021).

b. Kebutuhan Dasar Regulasi Fertilitas pada Laki-laki

Regulasi fertilitas laki-laki memerlukan sumbu HPG yang utuh, fungsi sel Leydig dan Sertoli yang baik, serta dukungan faktor metabolik dan imunologi yang seimbang. Kajian tentang imunofisiologi reproduksi pria menyoroti bahwa toleransi imun terhadap sperma dan pengaturan respon inflamasi lokal di testis merupakan komponen penting untuk mempertahankan spermatogenesis yang normal. Selain itu, status metabolik seperti obesitas, sindrom metabolik, dan penyakit sistemik dapat memodifikasi kadar testosteron dan kualitas semen sehingga memengaruhi fertilitas. Dalam konteks asuhan kebidanan, pemahaman kebutuhan ini mendasari pentingnya skrining faktor risiko pada suami dalam program KB dan perencanaan kehamilan serta edukasi mengenai pengaruh gaya hidup terhadap fertilitas (Campion et al., 2012; Clavijo & Hsiao, 2018; Hedger, 2014; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Washburn, 2024).

D. Tanda Normal Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi serta Dasar Regulasi Fertilitas

1. Tanda Normal Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi

a. Tanda Normal Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi pada Perempuan

Tanda normal anatomi dan fisiologi sistem reproduksi perempuan meliputi struktur organ genital yang utuh tanpa kelainan bentuk, siklus menstruasi teratur, dan fungsi seksual yang tidak disertai nyeri patologis.

Secara klinis, siklus haid normal berkisar 24–38 hari dengan lama perdarahan 3–8 hari dan jumlah darah yang tidak mengganggu aktivitas harian. Pemeriksaan panggul yang normal menunjukkan ukuran uterus yang sesuai, posisi anatomi wajar, tidak ada massa adneksa, serta tidak ada nyeri tekan signifikan. Fluor albus fisiologis biasanya jernih sampai putih susu, tidak berbau menyengat, tidak menyebabkan gatal, dan berubah sesuai fase siklus menstruasi. Untuk pendidikan kebidanan, pembahasan variasi normal penting agar bidan dapat membedakan antara variasi fisiologis dan tanda awal patologi (Ana-Maria Zagrean, 2020; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Wolman, 2014)

- c. Tanda Normal Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi pada Laki-laki
Pada laki-laki, tanda normal sistem reproduksi mencakup perkembangan genital eksternal sesuai usia, tidak ada keluhan nyeri atau pembengkakan testis, dan fungsi seksual (ereksi dan ejakulasi) yang adekuat. Pemeriksaan fisik menunjukkan testis dengan ukuran dan konsistensi wajar, epididimis tanpa nyeri tekan, dan skrotum simetris tanpa varises atau hernia signifikan. Secara fisiologis, terdapat produksi sperma berkelanjutan dengan parameter semen dalam rentang normal (volume, konsentrasi, motilitas, dan morfologi) sesuai panduan laboratorium. Tidak adanya gejala seperti disuria, sekret uretra patologis, atau nyeri perineum juga termasuk tanda fungsi reproduksi pria yang sehat. Bagi bidan, pemahaman tanda normal ini penting saat melakukan KIE dan rujukan dini bila ditemukan keluhan pada suami (Campion et al., 2012; Clavijo & Hsiao, 2018; Foster, 2016; Ghafarizadeh et al., 2021).

2. Tanda Normal Dasar Regulasi Fertilitas

- a. Tanda Normal Dasar Regulasi Fertilitas pada Perempuan

Regulasi fertilitas yang normal pada perempuan tercermin melalui siklus haid yang teratur, ovulasi yang terjadi secara periodik, dan tanda-tanda kesuburan seperti peningkatan lendir serviks jernih elastis dan sedikit peningkatan suhu basal tubuh sekitar waktu ovulasi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi individu, pola hormon estrogen dan progesteron yang naik-turun secara teratur merupakan indikator utama fungsi ovarium normal. Selain itu, ketiadaan gejala hiperandrogenisme berat, galaktorea, atau amenore berkepanjangan mengindikasikan bahwa sumbu HPG berjalan adekuat. Informasi mengenai tanda kesuburan ini dapat dimanfaatkan dalam metode KB

berbasis kesadaran kesuburan dan konseling perencanaan kehamilan yang diberikan bidan (Ana-Maria Zagrean, 2020; Christensen et al., 2012; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Rojas et al., 2015; Wolman, 2014).

b. Tanda Normal Dasar Regulasi Fertilitas pada Laki-laki

Pada laki-laki, regulasi fertilitas normal ditandai dengan kadar testosteron dalam rentang fisiologis, libido yang adekuat, dan analisis semen yang menunjukkan konsentrasi dan motilitas sperma yang memadai untuk mendukung konsepsi. Tidak adanya gangguan ereksi yang menetap atau gangguan ejakulasi berat juga mencerminkan fungsi neuroendokrin dan vaskular yang baik. Imunofisiologi normal ditandai dengan tidak adanya respon autoimun terhadap sperma yang dapat menurunkan fertilitas. Pengetahuan tentang tanda normal ini penting untuk KIE kepada pasangan mengenai waktu optimal untuk konsepsi dan relevansinya terhadap efektivitas beberapa metode KB (Clavijo & Hsiao, 2018; Ghafarizadeh et al., 2021; Hedger, 2014; Washburn, 2024).

E. Tanda Bahaya Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi serta Dasar Regulasi Fertilitas

1. Tanda Bahaya pada Sistem Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi

a. Tanda Bahaya pada Sistem Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Perempuan

Tanda bahaya anatomi dan fisiologi sistem reproduksi perempuan mencakup perdarahan genital abnormal (di luar pola haid, sangat banyak, pascakoitus), nyeri panggul berat, keputihan berbau menyengat, gatal hebat, dan adanya massa pada panggul. Gejala seperti dispareunia berat, nyeri saat haid yang progresif, dan infertilitas dapat mengindikasikan endometriosis, mioma uteri, atau patologi lain yang memerlukan evaluasi lanjut. Infeksi panggul, kehamilan ektopik, dan torsio ovarium merupakan kondisi gawat darurat yang ditandai nyeri tajam mendadak dan memerlukan rujukan segera. Dalam praktik kebidanan dan KIE KB, bidan perlu menekankan kepada klien bahwa setiap perubahan drastis pada pola haid, nyeri, atau keputihan setelah penggunaan metode kontrasepsi harus segera dilaporkan (Ivell & Anand-Ivell, 2021; Stejskalová et al., 2021; Tung & Suarez, 2021; Wolman, 2014).

b. Tanda Bahaya pada Sistem Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Laki-laki

Pada laki-laki, tanda bahaya sistem reproduksi termasuk nyeri mendadak atau progresif pada testis, pembengkakan skrotum, adanya massa keras, dan perubahan ukuran testis secara cepat. Gejala lain adalah nyeri saat ejakulasi, disuria, sekret uretra purulen, hematuria, atau darah dalam semen yang dapat mengindikasikan infeksi, tumor, atau gangguan lain. Paparan toksin lingkungan yang diikuti penurunan libido, ginekomastia, atau infertilitas juga menjadi peringatan gangguan endokrin dan reproduksi. Bidan perlu mendorong pasangan untuk berkonsultasi ke tenaga kesehatan bila terdapat tanda ini, terutama dalam konteks pelayanan KB dan kesehatan reproduksi pasangan usia subur (Campion et al., 2012; Cariati et al., 2020; Clavijo & Hsiao, 2018; Foster, 2016; Wang et al., 2020; Zhang et al., 2020).

2. Tanda Bahaya Dasar Regulasi Fertilitas

a. Tanda Bahaya Dasar Regulasi Fertilitas pada Perempuan

Gangguan regulasi fertilitas perempuan dapat ditandai amenore sekunder, oligomenore, perdarahan disfungsional, gejala hiperandrogenisme (jerawat berat, hirsutisme), galaktorea, dan perubahan berat badan ekstrem. Kondisi ini dapat mencerminkan gangguan sumbu HPG, seperti PCOS, hiperprolaktinemia, gangguan tiroid, atau insufisiensi ovarium prematur yang memengaruhi kemampuan reproduksi dan respons terhadap kontrasepsi hormonal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa gangguan metabolik, inflamasi kronis, dan faktor genetik turut berperan dalam disfungsi regulasi fertilitas perempuan. Dalam konteks kebidanan, identifikasi dini tanda bahaya ini penting saat skrining calon akseptor KB maupun klien prakonsepsi (Ana-Maria Zagrean, 2020; Dai et al., 2023; Gao et al., 2021b; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Wolman, 2014).

b. Tanda Bahaya Dasar Regulasi Fertilitas pada Laki-laki

Pada laki-laki, tanda bahaya regulasi fertilitas mencakup penurunan libido, disfungsi ereksi menetap, infertilitas, dan gejala hipogonadisme seperti kelelahan, penurunan massa otot, serta perubahan rambut tubuh. Analisis semen yang menunjukkan oligospermia, asthenospermia, atau azoospermia dapat menandakan gangguan regulasi hormonal dan spermatogenesis. Kajian mutakhir menyoroti bahwa paparan kronis bahan kimia pengganggu endokrin dan stres oksidatif menjadi faktor penting dalam disfungsi regulasi fertilitas laki-laki. Dalam praktik kebidanan, bidan dapat berperan dalam KIE kepada pasangan tentang perlunya evaluasi bersama bila terdapat infertilitas yang menetap (Campion et al., 2012; Cariati et al., 2020; Clavijo & Hsiao, 2018; Ghafarizadeh et al., 2021; Wang et al., 2020; Zhang et al., 2020).

F. Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan pada anatomi dan fisiologi sistem reproduksi perempuan mencakup pengkajian menyeluruh (anamnesis, pemeriksaan fisik dan ginekologis), penentuan status reproduksi, dan intervensi promotif-preventif serta kuratif sederhana sesuai kewenangan. Kajian mutakhir menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti, termasuk penggunaan pemeriksaan penunjang (USG, pap smear, tes infeksi) secara rasional untuk deteksi dini kelainan struktur dan fungsi reproduksi. Dalam konteks KB, bidan

bertanggung jawab menilai kesesuaian anatomi dan kondisi ginekologis sebelum pemasangan alat kontrasepsi, misalnya IUD, serta memberikan informasi mengenai perubahan fisiologis yang mungkin terjadi. Asuhan juga mencakup dukungan psikososial, edukasi kebersihan genital, dan rujukan bila ditemukan tanda bahaya atau kelainan anatomi kompleks (Ana-Maria Zagrean, 2020; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Stejskalová et al., 2021; Wolman, 2014).

Asuhan kebidanan pada regulasi fertilitas perempuan mencakup edukasi mengenai siklus haid, tanda kesuburan, dan faktor yang memengaruhi ovulasi, serta pemilihan metode KB yang sesuai kondisi endokrin dan metabolik klien. Pendekatan berbasis bukti menganjurkan skrining faktor risiko seperti obesitas, diabetes, gangguan tiroid, dan hiperprolaktinemia sebelum pemberian kontrasepsi hormonal jangka panjang. Bidan juga berperan dalam manajemen awal gangguan siklus haid yang ringan, misalnya melalui modifikasi gaya hidup dan konseling gizi, serta melakukan rujukan bila dicurigai gangguan sumbu HPG kompleks. Di samping itu, bidan dapat memfasilitasi penggunaan metode KB berbasis kesadaran kesuburan bagi perempuan yang menginginkan metode tanpa obat dan alat (Ana-Maria Zagrean, 2020; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Stejskalová et al., 2021; Wolman, 2014).

Dalam lingkup kebidanan, asuhan terhadap sistem reproduksi laki-laki lebih berfokus pada edukasi, deteksi awal masalah, dan rujukan bila diperlukan. Bidan dapat melakukan pengkajian dasar melalui wawancara tentang riwayat reproduksi, kebiasaan seksual, dan faktor risiko, serta mengobservasi adanya keluhan yang mengarah pada gangguan anatomi atau fisiologi. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam program kesehatan reproduksi dan KB meningkatkan keberhasilan perencanaan kehamilan dan penggunaan kontrasepsi. Oleh karena itu, bidan perlu mengintegrasikan edukasi kesehatan reproduksi laki-laki dalam setiap kontak pelayanan KB dan maternal (Campion et al., 2012; Clavijo & Hsiao, 2018; Ivell & Anand-Ivell, 2021).

Asuhan terhadap regulasi fertilitas laki-laki di tingkat kebidanan berfokus pada KIE mengenai faktor gaya hidup, paparan lingkungan, dan penyakit yang dapat mengganggu produksi hormon dan kualitas sperma. Bidan dapat mengedukasi pasangan tentang pentingnya berhenti merokok, membatasi alkohol, menghindari panas berlebihan di daerah skrotum, dan mengurangi paparan bahan kimia berbahaya. Selain itu, bidan dapat mendorong

pemeriksaan medis pada suami bila terdapat tanda hipogonadisme, gangguan seksual, atau infertilitas yang menetap. Pendekatan asuhan ini mendukung kesetaraan peran dalam perencanaan keluarga dan pengambilan keputusan terkait metode KB (Cariati et al., 2020; Clavijo & Hsiao, 2018; Ghafarizadeh et al., 2021; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Zhang et al., 2020).

G. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

1. KIE untuk Kesehatan Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi

a. KIE untuk Kesehatan Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Perempuan

KIE mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi perempuan bertujuan meningkatkan literasi kesehatan, mengurangi stigma, dan mendukung keputusan sadar terkait KB dan kesehatan reproduksi. Strategi efektif mencakup penggunaan media visual sederhana untuk menjelaskan struktur organ dan siklus haid, bahasa yang sesuai budaya, serta pendekatan partisipatif selama konseling. Penelitian internasional menunjukkan bahwa intervensi edukasi yang terstruktur meningkatkan pemahaman perempuan tentang tanda normal dan bahaya, sehingga mendorong pencarian pertolongan lebih cepat dan kepatuhan terhadap metode kontrasepsi yang dipilih. Dalam pendidikan kebidanan, mahasiswa perlu dilatih keterampilan komunikasi empatik, penggunaan alat bantu gambar, dan teknik menjelaskan konsep biologis kompleks dengan bahasa awam (Ana-Maria Zagrean, 2020; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Wolman, 2014).

b. KIE untuk Kesehatan Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Laki-laki

KIE kepada laki-laki mengenai anatomi dan fisiologi reproduksi penting untuk meningkatkan keterlibatan suami dalam KB dan kesehatan reproduksi pasangan. Edukasi dapat mencakup penjelasan struktur dan fungsi testis, semen, dan faktor yang memengaruhi kesuburan pria, serta meluruskan mitos terkait virilitas dan penggunaan kontrasepsi pria seperti kondom dan vasektomi. Studi menunjukkan bahwa informasi yang jelas dan bebas stigma meningkatkan penerimaan kontrasepsi pria dan dukungan terhadap pasangannya dalam penggunaan kontrasepsi perempuan. Di Indonesia, bidan dapat memanfaatkan momen kunjungan ANC, PNC, dan pelayanan KB untuk memberikan KIE singkat kepada suami yang datang mendampingi (Campion et al., 2012; Clavijo & Hsiao, 2018; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Wolman, 2014).

2. KIE untuk Kesehatan Regulasi Fertilitas

a. KIE untuk Kesehatan Regulasi Fertilitas Perempuan

KIE mengenai regulasi fertilitas perempuan mencakup penjelasan tentang siklus haid, ovulasi, masa subur, dan pengaruh faktor gaya hidup terhadap kesuburan serta efektivitas kontrasepsi. Edukasi berbasis bukti

dapat membantu perempuan memahami bagaimana kontrasepsi hormonal bekerja (misalnya menekan ovulasi atau mengentalkan lendir serviks) dan mengapa kepatuhan penggunaan sangat penting. Program edukasi yang menjelaskan hubungan status gizi, berat badan, dan stres dengan ovulasi terbukti meningkatkan motivasi perempuan untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Bagi mahasiswa kebidanan, keterampilan menjelaskan regulasi fertilitas dengan bahasa sederhana dan analogi visual sangat penting untuk keberhasilan konseling KB (Ana-Maria Zagrean, 2020; Christensen et al., 2012; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Rojas et al., 2015; Salem, 2021; Wolman, 2014).

c. KIE untuk Kesehatan Regulasi Fertilitas Laki-laki

KIE kepada laki-laki mengenai regulasi fertilitas menekankan bahwa kesuburan bukan hanya tanggung jawab perempuan dan bahwa kualitas sperma sangat dipengaruhi gaya hidup dan kondisi kesehatan umum. Penjelasan sederhana tentang bagaimana testis memproduksi sperma dan bagaimana bahan kimia, panas, serta rokok dapat menurunkan kualitas tersebut dapat memotivasi perubahan perilaku. Keterlibatan aktif laki-laki dalam memahami regulasi fertilitas berkontribusi pada dukungan terhadap pasangan dalam penggunaan kontrasepsi dan perencanaan jumlah serta jarak kelahiran. Bidan dapat memanfaatkan media audio-visual dan diskusi kelompok kecil untuk menyampaikan pesan ini kepada pasangan usia subur (Campion et al., 2012; Cariati et al., 2020; Clavijo & Hsiao, 2018; Ghafarizadeh et al., 2021; Ivell & Anand-Ivell, 2021; Wang et al., 2020; Wolman, 2014; Zhang et al., 2020).

H. Dokumentasi

Dokumentasi kebidanan terkait anatomi dan fisiologi sistem reproduksi perempuan meliputi pencatatan data identitas, riwayat haid, riwayat reproduksi, hasil pemeriksaan fisik dan ginekologis, diagnosis kebidanan, serta rencana dan tindakan asuhan. Standar praktik menekankan pentingnya dokumentasi yang akurat, lengkap, dan terstruktur untuk keperluan kontinuitas asuhan, audit klinis, pendidikan, dan aspek legal. Penggunaan format SOAP membantu sistematisasi pencatatan dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pendidikan kebidanan, mahasiswa perlu dilatih menulis dokumentasi yang obyektif, jelas, dan sesuai standar profesi (Ana-Maria Zagrean, 2020; Wolman, 2014)

Dokumentasi regulasi fertilitas perempuan mencakup pencatatan pola siklus haid, keluhan terkait ovulasi, penggunaan kontrasepsi, efek samping, dan respons klien terhadap intervensi. Pencatatan yang sistematis memudahkan evaluasi efektivitas metode KB, identifikasi dini gangguan endokrin, serta perencanaan rujukan ke spesialis bila diperlukan. Dalam konteks pembelajaran, mahasiswa kebidanan perlu dibiasakan menggunakan catatan siklus haid, grafik suhu basal tubuh, atau catatan gejala sebagai bagian dari dokumentasi asuhan (Ana-Maria Zagrean, 2020; Rojas et al., 2015; Wolman, 2014)

Dokumentasi terkait sistem reproduksi laki-laki dalam praktik kebidanan berfokus pada pencatatan riwayat reproduksi suami, penggunaan kontrasepsi, riwayat penyakit urogenital, serta temuan yang relevan dari wawancara dan observasi. Meskipun pemeriksaan fisik detail dan terapi laki-laki biasanya berada di ranah dokter, bidan tetap perlu mencatat keluhan yang diungkapkan klien untuk dasar rujukan dan perencanaan asuhan pasangan. Dokumentasi yang baik mendukung koordinasi antarprofesi dan memastikan bahwa aspek laki-laki tidak diabaikan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (Campion et al., 2012; Clavijo & Hsiao, 2018; Ivell & Anand-Ivell, 2021)

Dokumentasi regulasi fertilitas laki-laki meliputi riwayat kesuburan (jumlah anak, lama infertilitas), penggunaan kontrasepsi, gaya hidup yang berisiko menurunkan kualitas sperma, dan hasil pemeriksaan penunjang bila tersedia. Pencatatan ini penting untuk menilai kebutuhan KIE dan rujukan, serta untuk evaluasi program KB yang melibatkan partisipasi aktif laki-laki. Dalam pendidikan kebidanan, penekanan pada pencatatan aspek laki-laki membantu membentuk perspektif yang lebih holistik dalam asuhan kesehatan reproduksi pasangan (Campion et al., 2012; Clavijo & Hsiao, 2018; Ghafarizadeh et al., 2021; Ivell & Anand-Ivell, 2021)

I. Aktivitas 1

1. Lembar Ujian Tertulis (MCQ/SAQ)

Project Individu

Tulislah nama dan NIM di pojok kanan atas lembar jawaban.

Waktu: 60 menit.

No	Bentuk	Soal	Pilihan Jawaban (jika MCQ)
1	MCQ	Struktur manakah yang merupakan lokasi utama terjadinya fertilisasi pada	A. Infundibulum tuba falopi B. Ampula tuba falopi C. Isthmus tuba falopi

No	Bentuk	Soal	Pilihan Jawaban (jika MCQ)
		sistem reproduksi perempuan normal?	D. Kavum uteri E. Serviks uteri
2	MCQ	Pasangan organ dan fungsi yang PALING tepat adalah:	A. Ovarium – tempat implantasi embrio B. Endometrium – penghasil utama estrogen C. Serviks – barier imun dan pengatur masuknya sperma D. Vagina – lokasi utama spermatogenesis E. Miometrium – penghasil lendir serviks
3	MCQ	Bagian manakah dari sistem reproduksi laki-laki yang berperan utama sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma sebelum ejakulasi?	A. Testis B. Epididimis C. Vesikula seminalis D. Prostat E. Vas deferens
4	MCQ	Pada siklus menstruasi normal, lonjakan hormon manakah yang menjadi pemicu langsung terjadinya ovulasi?	A. FSH B. LH C. Estrogen D. Progesteron E. Prolaktin
5	MCQ	Pil kombinasi estrogen–progesteron mencegah kehamilan terutama melalui mekanisme:	A. Merangsang lonjakan LH sehingga ovulasi lebih cepat B. Menekan sekresi GnRH sehingga menghambat FSH dan LH C. Meningkatkan proliferasi endometrium sehingga implantasi optimal D. Meningkatkan frekuensi pelepasan ovum dalam satu siklus E. Mengurangi kadar progesteron fase luteal
6	MCQ	Implan progestin bekerja MENGUTAMA melalui:	A. Menebalkan lendir serviks dan mengganggu transport sperma B. Meningkatkan produksi FSH sehingga sel telur matang cepat C. Merangsang korpus luteum memproduksi lebih banyak progesteron D. Mengurangi produksi mukus serviks sehingga vagina kering

No	Bentuk	Soal	Pilihan Jawaban (jika MCQ)
			E. Menstimulasi pertumbuhan endometrium
7	SAQ	Seorang perempuan usia 24 tahun dengan siklus haid teratur 28 hari melaporkan keputihan jernih, licin, elastis dan sedikit nyeri perut bawah pada hari ke-14 siklus. a. Jelaskan secara singkat apa yang sedang terjadi pada ovarium dan hormon utama yang berperan pada fase ini. b. Jelaskan dua implikasi klinis temuan ini untuk penentuan masa subur dan pemilihan metode kontrasepsi alamiah.	
8	SAQ	Jelaskan hubungan antara sumbu hipotalamus–hipofisis–gonad (HPG) dengan mekanisme kerja kontrasepsi hormonal kombinasi (pil/patch) dalam tiga kalimat terstruktur.	
9	MCQ	Anatomi organ reproduksi perempuan manakah yang PALING perlu dinilai secara teliti sebelum pemasangan IUD untuk mencegah komplikasi perforasi?	A. Vagina B. Serviks uteri C. Uterus (ukuran, posisi, dan bentuk kavum) D. Tuba falopi E. Ovarium
10	SAQ	Jelaskan hubungan antara fungsi vas deferens dengan tindakan vasektomi sebagai metode kontrasepsi pria dalam 2–3 kalimat.	

Identitas Ujian

Item	Keterangan
Nama Mata Kuliah	Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi: Metode, Konseling, dan Efek Samping
Topik/Bab	Anatomi–Fisiologi Sistem Reproduksi & Regulasi Fertilitas
CPL Terkait	CPL-4: Menganalisis data klinis dan konteks klien untuk pengambilan keputusan berbasis bukti terkait pemilihan dan tindak lanjut kontrasepsi.
Bentuk Ujian	MCQ + SAQ + Concept Map
Nama Mahasiswa	
NIM	
Tanggal Ujian	
Dosen Penguji	

Lembar Penilaian MCQ

Total soal MCQ: 7 (No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9).

Skor: 1 untuk benar, 0 untuk salah (bisa disesuaikan, misal bobot berbeda per soal).

No. Soal	Kunci Jawaban	Jawaban Mhs	Skor (0/1 atau bobot)	Catatan Dosen (bila perlu)
1	B			
2	C			
3	B			
4	B			
5	B			
6	A			
9	C			

- Skor MCQ diperoleh dari jumlah skor benar (atau sesuai bobot yang ditetapkan).
- Rekap:

Komponen	Nilai
Total skor benar MCQ	 / 7
Persentase / Nilai MCQ	 / 100 (jika dikonversi)

Lembar Penilaian SAQ

Total soal SAQ: 3 (No. 7, 8, 10).

Disarankan pakai rubrik 0–4 per soal (atau sesuai kebijakan).

No. Soal	Aspek yang Dinilai (ringkas)	Skor (0–4)	Catatan Dosen
7	a) Ketepatan penjelasan ovulasi & hormon (LH, estrogen, korpus luteum). b) Implikasi klinis: masa subur & penggunaan metode kesadaran kesuburan/barrier.		
8	Hubungan logis HPG axis dengan kerja pil kombinasi: alur GnRH–FSH/LH–ovarium, umpan balik negatif estrogen–progestin, dampak ovulasi, lendir serviks, endometrium.		
10	Keterkaitan fungsi vas deferens dengan vasektomi: jalur sperma, pemotongan/oklusi vas, efek terhadap komposisi ejakulat dan efek kontraseptif.		

Rekap SAQ:

Komponen	Nilai
Total skor SAQ	 / 12
Persentase / Nilai SAQ	 / 100 (jika dikonversi)

Rekap Nilai Ujian Tertulis (MCQ + SAQ)

(Contoh skema, silakan sesuaikan bobot)

Komponen	Skor Perolehan	Skor Maksimal	Bobot	Nilai Akhir Komponen
MCQ		7	%	
SAQ		12	%	
Total nilai ujian tertulis = / 100				

Rekap Akhir (Bila Digabung dengan Concept Map)

Jika ujian tertulis digabung dengan tugas concept map:

Komponen	Nilai (0–100)	Bobot	Nilai Terbobot
Ujian tertulis (MCQ + SAQ)		%	
Concept map		%	
Total Akhir			 / 100

Catatan dosen penguji:

.....
.....

Tanda tangan dosen penguji:

J. Concept Map

Aspek	Uraian Tugas
Judul tugas	Concept map: Anatomi–Fisiologi Sistem Reproduksi, Regulasi Fertilitas, dan Titik Kerja Kontrasepsi
Tujuan	Mahasiswa mampu memetakan hubungan anatomi–fisiologi sistem reproduksi, regulasi hormonal siklus reproduksi, dan titik kerja berbagai metode kontrasepsi.
Instruksi umum	Buatlah peta konsep (concept map) di kertas kosong yang disediakan. Gunakan kotak/lingkaran untuk konsep, dan garis berlabel kata kerja untuk menghubungkan konsep.
Konsep anatomi–fisiologi yang wajib muncul (minimal 5)	Hipotalamus, hipofisis, ovarium, tuba falopi, uterus, serviks, endometrium (boleh ditambah vagina, lendir serviks, korpus luteum, dll.).
Konsep regulasi fertilitas (hormonal & siklus) yang wajib muncul	Hormon: GnRH, FSH, LH, estrogen, progesteron. Fase: fase folikular, ovulasi, fase luteal (boleh ditambah “umpan balik positif/negatif”).
Kelompok metode kontrasepsi yang harus digambarkan	1) Kontrasepsi hormonal kombinasi (pil/patch/injeksi kombinasi); 2) Kontrasepsi progestin saja (implant, pil progestin, injeksi progestin); 3) Kontrasepsi non-hormonal (IUD tembaga, kondom, vasektomi).
Hubungan yang harus terlihat	- Arah stimulasi/inhibisi dalam sumbu HPG (hipotalamus → GnRH → hipofisis → FSH/LH → ovarium → estrogen/progesteron → uterus). - Hubungan fase siklus dengan ovulasi dan perubahan endometrium. - Titik kerja minimal 2 mekanisme untuk tiap kelompok kontrasepsi (misal: supresi GnRH/FSH/LH, pengentalan lendir serviks, perubahan endometrium, gangguan transport sperma, pemotongan vas deferens).
Cara menggambar	- Tulis konsep utama di bagian tengah/atas. - Gunakan garis berarah (→) dengan label kata kerja seperti: “merangsang”, “menghambat”, “menebalkan”, “mengentalkan”, “mencegah ovulasi”, “menghambat implantasi”, “menghambat transport sperma”. - Pastikan peta terbaca rapi dan alur mudah diikuti.
Minimal elemen	≥5 konsep anatomi–fisiologi, ≥4 konsep hormon, ≥3 kelompok metode kontrasepsi dengan masing-masing ≥2 hubungan titik kerja yang jelas.

Aspek	Uraian Tugas
Waktu	20 menit setelah selesai mengerjakan soal ujian tertulis.
Penilaian	Menggunakan rubrik 4 kriteria (ketepatan anatomi–fisiologi, ketepatan regulasi fertilitas, ketepatan hubungan dengan titik kerja kontrasepsi, keterpaduan & kerapian), skor 0–4 per kriteria.

Rubrik Penilaian Concept Map

Kriteria	Skor	Deskripsi Penilaian
Ketepatan konsep anatomi–fisiologi	4	Semua konsep anatomi dan fisiologi utama (≥ 5 konsep: hipotalamus, hipofisis, ovarium, tuba, uterus, serviks, endometrium, dll.) benar, tanpa salah konsep.
	3	Sebagian besar konsep benar, terdapat maksimal 1 salah konsep atau 1 konsep penting hilang.
	2	Beberapa konsep penting benar tetapi terdapat ≥ 2 salah konsep atau beberapa struktur utama tidak dicantumkan.
	1	Banyak kesalahan konsep; peta tidak mencerminkan alur fungsi sistem reproduksi.
	0	Konsep anatomi/fisiologi tidak relevan atau hampir seluruhnya salah.
Ketepatan konsep regulasi fertilitas (HPG dan siklus hormon)	4	Hubungan GnRH–FSH–LH–estrogen–progesteron tepat, fase siklus jelas, arah umpan balik positif/negatif benar.
	3	Alur utama benar tetapi ada 1–2 detail kurang tepat (fase kurang lengkap atau label umpan balik kurang jelas).
	2	Hanya bagian parsial yang benar, siklus hormonal tidak tergambar utuh.
	1	Regulasi hormonal digambarkan sangat terbatas dan banyak salah hubungan.

Kriteria	Skor	Deskripsi Penilaian
	0	Tidak ada konsep regulasi fertilitas yang bermakna.
Ketepatan mengaitkan regulasi fertilitas dengan titik kerja kontrasepsi	4	≥3 kelompok kontrasepsi (kombinasi, progestin, non-hormonal) tercantum dengan ≥2 hubungan titik kerja yang benar untuk tiap kelompok.
	3	Tiga kelompok metode tercantum tetapi ada 1–2 hubungan titik kerja kurang tepat/kurang lengkap.
	2	Hanya 1–2 kelompok yang dihubungkan dengan tepat atau hubungan masih sangat umum.
	1	Sebagian besar hubungan metode–titik kerja salah atau samar.
	0	Tidak ada hubungan kontrasepsi dengan regulasi fertilitas.
Keterpaduan dan kerapian peta konsep	4	Peta sangat jelas, hierarki konsep tampak, garis rapi, hampir semua hubungan berlabel kata kerja, mudah dibaca.
	3	Peta cukup terstruktur, ada beberapa garis tanpa label namun tidak mengganggu pemahaman utama.
	2	Susunan kurang sistematis, hubungan antar konsep sulit diikuti tetapi masih dapat ditafsirkan.
	1	Peta sangat tidak teratur, banyak garis tumpang tindih tanpa label, sulit dipahami.
	0	Peta tidak terbaca atau tidak dikerjakan.

K. Aktivitas 2 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan usia 24 tahun, belum menikah, datang ke puskesmas untuk konseling kesehatan reproduksi. Ia ingin memahami siklus menstruasi dan masa subur karena berencana menikah dalam beberapa bulan ke depan.

Hasil anamnesis: Menarche usia 13 tahun. Siklus menstruasi teratur setiap 28–30 hari. Lama menstruasi 4–5 hari. Tidak ada keluhan nyeri haid berat. Tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Pasien melaporkan bahwa pada pertengahan siklus (sekitar hari ke-14), ia sering mengalami:Keputihan jernih, licin, dan elastis. Sedikit nyeri perut bawah yang hilang sendiri. Peningkatan suhu basal tubuh setelah beberapa hari

Pemeriksaan fisik: Keadaan umum baik. Tanda vital TD: 110/70 mmHg, Suhu: 36,7°C, Nadi: 80 x/menit, RR: 16 x/menit. Tidak ditemukan kelainan organ reproduksi eksternal

Pasien ingin mengetahui apakah kondisi tersebut normal serta bagaimana menentukan masa subur secara ilmiah.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa saja anatomi organ reproduksi perempuan bagian internal dan eksternal yang berperan dalam proses reproduksi?
2. Bagaimana tahapan siklus menstruasi (fase folikular, ovulasi, dan luteal) serta perubahan fisiologis yang terjadi pada ovarium dan endometrium?
3. Bagaimana mekanisme kerja poros hipotalamus–hipofisis–ovarium dalam mengatur siklus menstruasi?
4. Mengapa pasien mengalami mukus serviks yang jernih dan elastis, nyeri perut bawah ringan, serta peningkatan suhu basal tubuh pada pertengahan siklus?
5. Apa yang dimaksud dengan masa subur (fertile window) dan bagaimana cara menentukannya pada siklus menstruasi normal?
6. Bagaimana peran hormon estrogen dan progesteron dalam mempersiapkan endometrium untuk kemungkinan implantasi?
7. Bagaimana cara memberikan edukasi kepada pasien untuk mengenali masa subur secara alami serta faktor apa saja yang dapat memengaruhi keteraturan siklus menstruasi?

Soal OSCE Kebidanan

No	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada Perempuan Usia Reproduksi
3	Kasus	Seorang perempuan usia 24 tahun datang ke puskesmas untuk konseling kesehatan reproduksi. Pasien memiliki siklus menstruasi teratur 28–30 hari. Ia melaporkan keputihan jernih dan elastis pada pertengahan siklus serta peningkatan suhu basal tubuh setelahnya. Pasien ingin mengetahui apakah kondisi tersebut normal dan bagaimana menentukan masa subur. TTV: TD 110/70 mmHg, Nadi 80 x/menit, RR 16 x/menit, Suhu 36,7°C.
4	Tujuan	Mahasiswa mampu melakukan konseling kesehatan reproduksi terkait siklus menstruasi, ovulasi, dan penentuan masa subur secara fisiologis.
5	Kompetensi	1. Menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi perempuan 2. Menjelaskan siklus menstruasi 3. Mengidentifikasi tanda ovulasi 4. Memberikan edukasi masa subur
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	1. Lakukan anamnesis lengkap terkait riwayat menstruasi pasien (menarche, lama dan siklus haid, keluhan saat menstruasi, serta gejala yang muncul di pertengahan siklus). 2. Jelaskan secara ilmiah fase-fase dalam siklus menstruasi (fase menstruasi, folikular, ovulasi, luteal), termasuk perubahan hormonal dan fisiologis yang terjadi pada setiap fase. 3. Edukasikan pasien tentang cara menentukan masa subur menggunakan metode ilmiah seperti kalender menstruasi, pengamatan lendir serviks, dan pengukuran suhu basal tubuh. 4. Berikan konseling pranikah terkait kesehatan reproduksi wanita, termasuk pentingnya menjaga gaya hidup sehat, status gizi, serta pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. 5. Demonstrasikan keterampilan komunikasi yang baik: dengarkan dengan aktif, gunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa istilah medis rumit, dan tunjukkan sikap empatik saat memberikan penjelasan kepada pasien.
7	Instruksi penguji	Instruksi PS: 1. Berperan sebagai perempuan usia 24 tahun, belum menikah. 2. Datang dengan tujuan ingin mengetahui masa subur dan siklus menstruasi. 3. Sampaikan informasi hanya jika ditanya oleh peserta: • Siklus menstruasi 28–30 hari • Lama haid 4–5 hari

No	Komponen	Isi
		• Tidak nyeri haid berat • Tidak ada riwayat penyakit 4. Sampaikan keluhan utama: • "Saya ingin tahu kapan masa subur saya." 5. Jika ditanya lebih lanjut, berikan informasi tambahan: • Mengalami keputihan bening dan elastis di pertengahan siklus • Kadang nyeri ringan di perut bawah • Pernah mencatat suhu basal tubuh meningkat 6. Tunjukkan sikap: • Kooperatif • Sedikit penasaran (ingin tahu) • Tidak cemas berlebihan 7. Ajukan pertanyaan berikut jika peserta tidak menjelaskan: • "Apakah keputihan saya normal?" • "Bagaimana cara mengetahui ovulasi?" • "Kapan waktu terbaik untuk hamil?" Jangan memberikan informasi tambahan di luar skenario.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Nilai kemampuan peserta dalam melakukan konseling kesehatan reproduksi pada perempuan usia reproduksi secara fisiologis. 2. Perhatikan kemampuan peserta dalam: 3. Menggali informasi terkait siklus menstruasi 4. Menjelaskan fase siklus menstruasi secara sistematis 5. Menjelaskan tanda-tanda ovulasi (mukus serviks, nyeri ovulasi, suhu basal tubuh)

No	Komponen	Isi
		- Menentukan masa subur berdasarkan siklus pasien - Memberikan edukasi metode fertility awareness - Nilai aspek komunikasi terapeutik, meliputi: - Salam pembuka dan pengenalan - Bahasa yang mudah dipahami - Sikap empati dan profesional - Nilai ketepatan isi edukasi (ilmiah dan fisiologis) - Tidak diperkenankan memberi bantuan atau arahan kepada peserta selama ujian berlangsung INSTRUKSI TAMBAHAN - Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. - Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
9	Dialog PS	- Bidan: Selamat pagi, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Pasien: Selamat pagi, Bu. Saya ingin konsultasi tentang siklus haid dan masa subur. - Bidan: Baik, boleh diceritakan apa yang ingin Anda ketahui? Pasien: Saya berencana menikah dan ingin tahu kapan masa subur saya. - Bidan: Bagaimana siklus menstruasi Anda selama ini, apakah teratur? Pasien: Ya, biasanya setiap 28 sampai 30 hari. - Bidan: Berapa lama biasanya haid berlangsung? Pasien: Sekitar 4 sampai 5 hari. - Bidan: Apakah ada keluhan seperti nyeri hebat saat haid? Pasien: Tidak, hanya sedikit nyeri ringan saja. - Bidan: Apakah Anda pernah memperhatikan perubahan pada tubuh di pertengahan siklus? Pasien: Iya, saya sering mengalami keputihan yang bening dan licin. - Bidan: Apakah keputihan tersebut seperti lendir putih telur dan elastis? Pasien: Iya, betul seperti itu. - Bidan: Apakah Anda juga merasakan nyeri ringan di perut bagian bawah? Pasien: Iya, kadang ada nyeri sebentar lalu hilang. - Bidan: Apakah Anda pernah mengukur suhu basal tubuh? Pasien: Pernah, dan biasanya naik sedikit setelah beberapa hari.

No	Komponen	Isi
		10. Bidan: Baik, dari tanda-tanda tersebut kemungkinan Anda sedang mengalami ovulasi. Pasien: Oh begitu ya, Bu? Jadi itu normal? 11. Bidan: Ya, itu merupakan tanda fisiologis bahwa tubuh Anda sedang berada pada masa subur. Pasien: Masa subur itu kapan tepatnya, Bu? 12. Bidan: Masa subur biasanya terjadi beberapa hari sebelum dan saat ovulasi, sekitar hari ke-12 sampai 16 pada siklus Anda. Pasien: Berarti peluang hamil paling besar di waktu itu ya? 13. Bidan: Betul, karena sel telur dilepaskan dan siap untuk dibuahi. Pasien: Berapa lama sel telur bisa bertahan? 14. Bidan: Sel telur bertahan sekitar 12–24 jam, sedangkan sperma bisa hidup 3–5 hari di dalam rahim. Pasien: Jadi hubungan sebaiknya kapan, Bu? 15. Bidan: Disarankan berhubungan 2–3 hari sebelum ovulasi dan saat ovulasi. Pasien: Apakah ada cara lain untuk mengetahui masa subur? 16. Bidan: Bisa dengan mencatat siklus haid, mengamati lendir serviks, dan mengukur suhu basal tubuh. Pasien: Apakah stres bisa memengaruhi siklus haid? 17. Bidan: Ya, stres, kelelahan, dan pola hidup tidak sehat dapat memengaruhi hormon. Pasien: Kalau saya ingin menjaga kesuburan, apa yang harus dilakukan? 18. Bidan: Jaga pola makan, olahraga teratur, cukup istirahat, dan hindari rokok serta alkohol. Pasien: Baik, Bu. Apakah saya perlu pemeriksaan khusus? 19. Bidan: Jika siklus Anda teratur dan tidak ada keluhan, pemeriksaan khusus belum diperlukan. Pasien: Terima kasih atas penjelasannya, Bu. 20. Bidan: Sama-sama. Jika ada pertanyaan lain atau keluhan, silakan datang kembali. 21. Pasien: Baik, Bu. Terima kasih banyak.
10	Kebutuhan manikin	Tidak diperlukan manekin, karena stasiun berfokus pada konseling kesehatan reproduksi (non prosedural) Jika diperlukan sebagai pelengkap visual (opsional): Model anatomi organ reproduksi perempuan (alat peraga edukasi)
11	Kebutuhan laboran	1. Menyiapkan ruang OSCE sesuai setting konseling (meja, kursi, alat edukasi). 2. Menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti: 3. Leaflet/flipchart siklus menstruasi

No	Komponen	Isi
		4. Kalender menstruasi 5. Alat tulis 6. Memastikan semua alat dalam kondisi siap pakai sebelum ujian dimulai. 7. Mengatur alur keluar-masuk peserta sesuai jadwal OSCE. 8. Membantu menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian. 9. Mengganti atau merapikan alat setelah digunakan peserta. 10. Menyiapkan ulang stasiun agar siap digunakan oleh peserta berikutnya.
12	Kebutuhan alat	A. Alat Edukasi Utama 1. Leaflet/lembar balik tentang siklus menstruasi 2. Poster/flipchart anatomi sistem reproduksi perempuan 3. Gambar/foto fase siklus menstruasi (folikular, ovulasi, luteal) 4. Kalender menstruasi (untuk simulasi perhitungan masa subur) B. Alat Bantu Konseling 5. Kertas kosong / lembar edukasi 6. Buku catatan siklus menstruasi (contoh) 7. Alat tulis (pulpen, pensil, spidol) 8. Kartu edukasi masa subur C. Alat Monitoring (Simulasi) 9. Termometer digital (untuk penjelasan suhu basal tubuh) 10. Contoh grafik suhu basal tubuh (BBT chart) D. Perlengkapan Setting OSCE 11. Meja dan kursi (untuk bidan dan pasien) 12. Name tag (peserta sebagai bidan & pasien standar) 13. Lembar soal/station card 14. Lembar penilaian OSCE (checklist & global rating) E. Media Pendukung 15. Brosur kesehatan reproduksi 16. Panduan metode fertility awareness 17. Media visual tambahan (print out / slide jika tersedia) F. Alat Kebersihan 18. Hand sanitizer 19. Tisu
13	Penulis	Herlina Puji Angesti S.Tr.Keb., M.Kes.
14	Referensi	(Bull et al., 2019; Duane et al., 2022; Fehring et al., 2006) 1. Bull, J. R., Rowland, S. P., Scherwitzl, E. B., Scherwitzl, R., Danielsson, K. G., & Harper, J. (2019). Real-world menstrual cycle characteristics of more than 600,000 menstrual cycles.

No	Komponen	Isi
		Npj Digital Medicine 2019 2:1, 2(1), 83-. https://doi.org/10.1038/s41746-019-0152-7 2. Duane, M., Stanford, J. B., Porucznik, C. A., & Vigil, P. (2022). Fertility Awareness-Based Methods for Women's Health and Family Planning. <i>Frontiers in Medicine</i>, 9. https://doi.org/10.3389/FMED.2022.858977 3. Fehring, R. J., Schneider, M., & Raviele, K. (2006). Variability in the phases of the menstrual cycle. <i>JOGNN - Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing</i>, 35(3), 376–384. https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2006.00051.x

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada Perempuan Usia Reproduksi

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan Utama Masalah utama yang dirasakan (misal: nyeri haid hebat, siklus tidak teratur, darah terlalu banyak, atau perdarahan di luar jadwal).		
2. Riwayat Menstruasi Saat Ini Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT), durasi haid (berapa hari), dan panjang siklus (jarak dari hari pertama haid bulan lalu ke bulan ini).		
3. Riwayat Pengeluaran Pervaginam Karakteristik darah: Warna, gumpalan, dan jumlah pembalut per hari. Cervical Mucus: Ada tidaknya lendir bening, elastis, dan licin (seperti putih telur mentah) sebagai penanda masa subur.		
4. Tanda Ovulasi (Masa Subur) Adanya nyeri perut bawah di satu sisi (<i>mittelschmerz</i>), peningkatan gairah seksual, atau perubahan suhu basal tubuh (suhu tubuh saat bangun tidur).		
5. Gejala Penyerta (PMS/Dysmenorrhea) Gejala sebelum/saat haid: kram perut, nyeri payudara, perubahan suasana hati (<i>mood swings</i>), atau jerawat hormonal.		
6. Riwayat Ginekologi & Kontrasepsi Riwayat penyakit organ reproduksi (PCOS, kista, miom), penggunaan alat kontrasepsi (hormonal/non-hormonal), dan keteraturan siklus di masa lalu.		
7. Riwayat Kesehatan & Pengobatan Penyakit sistemik (tiroid, diabetes), riwayat operasi panggul, penggunaan obat-obatan jangka panjang, atau suplemen hormonal.		
8. Aktivitas & Gaya Hidup Relevan Tingkat stres, pola tidur, asupan nutrisi (diet ekstrem), perubahan berat badan yang drastis, dan pola olahraga/aktivitas fisik berat.		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.

- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menggali riwayat menstruasi pasien		
b. Menanyakan keteraturan siklus menstruasi		
c. Menanyakan tanda-tanda ovulasi yang dialami		
d. Menjelaskan anatomi sistem reproduksi perempuan		
e. Menjelaskan fase siklus menstruasi		
f. Menjelaskan mekanisme ovulasi		
g. Menjelaskan tanda-tanda masa subur		
h. Menentukan masa subur berdasarkan siklus pasien		
i. Menjelaskan metode fertility awareness		
j. Memberikan edukasi pola hidup yang memengaruhi fertilitas		
k. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami		
l. Menunjukkan komunikasi terapeutik (empati, kontak mata)		
m. Memberikan kesempatan pasien bertanya		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan		
b. Mencatat temuan penting pada partograf/catatan medis/form rujukan		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3=** Jika peserta ujian melakukan **15–19 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2=** Jika peserta melakukan **10–14 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1=** Jika peserta melakukan **1–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.

- **0**= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Membuka komunikasi (salam, pengenalan, membangun hubungan)		
2. Menggali kebutuhan dan pengetahuan awal pasien		
3. Menyampaikan informasi secara jelas, benar, dan sistematis		
4. Menggunakan media/alat bantu edukasi dengan tepat		
5. Memastikan pemahaman pasien (feedback/teach back)		
6. Menutup komunikasi dengan rangkuman dan kesempatan bertanya		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3**= Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2**= Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1**= Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0**= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Berpenampilan rapi, sopan, dan sesuai standar tenaga kesehatan		
2. Menunjukkan sikap empati dan menghargai pasien		
3. Menjaga privasi dan kerahasiaan pasien		
4. Berkomunikasi dengan bahasa yang sopan, jelas, dan mudah dipahami		
5. Menunjukkan sikap profesional (percaya diri, tenang, dan tidak terburu-buru)		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3**= Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2**= Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1**= Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0**= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = $\frac{\text{-----}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Konseling
Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada Perempuan Usia Reproduksi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada Perempuan Usia Reproduksi
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinik dan komunikasi peserta. Penilai mengamati performa peserta secara langsung dan memberikan umpan balik setelah tindakan.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan konseling kepada perempuan usia 24 tahun terkait siklus menstruasi, tanda ovulasi, dan penentuan masa subur.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan konseling kesehatan reproduksi secara sistematis, ilmiah, dan komunikatif.	Mahasiswa dinilai dalam menjelaskan siklus menstruasi, mengenali tanda ovulasi, serta memberikan edukasi masa subur berbasis fisiologi.
Kasus klinik	Kasus diambil dari situasi fisiologis pada perempuan usia reproduksi yang membutuhkan edukasi kesehatan reproduksi.	Seorang perempuan 24 tahun dengan siklus menstruasi teratur, mengalami keputihan jernih elastis di pertengahan siklus dan ingin mengetahui masa subur.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan konseling secara langsung, meliputi anamnesis, edukasi, dan komunikasi.	Mahasiswa memperkenalkan diri, menggali riwayat menstruasi, menjelaskan fase siklus menstruasi, tanda ovulasi, dan menentukan masa subur pasien.
Aspek yang dinilai	Meliputi komunikasi, pemahaman konsep fisiologi, ketepatan edukasi, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan hubungan antara perubahan mukus serviks, ovulasi, dan peningkatan suhu basal tubuh sebagai tanda masa subur.
Fokus observasi pembimbing	Fokus pada performa nyata mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan berbasis edukasi.	Pembimbing memperhatikan kejelasan komunikasi, ketepatan konsep fisiologi, serta kemampuan menjawab pertanyaan pasien.
Umpan balik	Diberikan segera setelah observasi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.	Pembimbing memberikan masukan terkait cara penyampaian, kelengkapan edukasi, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada Perempuan Usia Reproduksi
Keputusan penilaian	Hasil penilaian dikategorikan menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan konseling secara sistematis, benar, dan komunikatif.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik capaian kompetensi mahasiswa pada level praktik nyata (does).	Mahasiswa menunjukkan kemampuan nyata dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi secara langsung kepada pasien.

L. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 2.5
Portofolio pada Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada Perempuan Usia Reproduksi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada Perempuan Usia Reproduksi
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan.	Mahasiswa mengumpulkan bukti kemampuan dalam melakukan konseling siklus menstruasi dan masa subur pada beberapa pasien dengan kondisi fisiologis.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi,	Mahasiswa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada Perempuan Usia Reproduksi
	refleksi, dan perbaikan berkelanjutan.	menjelaskan ovulasi dan masa subur setelah mendapat umpan balik dari pembimbing.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio sebagai bukti keterampilan di laboratorium dan praktik klinik.	OSCE menunjukkan kemampuan komunikasi konseling, sedangkan DOPS menunjukkan performa nyata saat praktik di puskesmas.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus pasien yang ditangani mahasiswa.	Mahasiswa mencatat kasus perempuan 24 tahun dengan siklus teratur dan tanda ovulasi fisiologis.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kesadaran terhadap keselamatan pasien dan pencegahan kesalahan.	Mahasiswa menyadari pentingnya edukasi yang benar untuk mencegah kesalahan persepsi tentang masa subur.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari pembimbing sebagai dasar perbaikan kompetensi.	CI menyarankan mahasiswa meningkatkan kejelasan dalam menjelaskan hormon reproduksi.
Karakteristik penilaian	Penilaian dilakukan secara berulang dan berkesinambungan.	Mahasiswa dinilai dari beberapa kegiatan konseling, bukan hanya satu kali.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan konsistensi performa mahasiswa dari waktu ke waktu.	Mahasiswa konsisten mampu menjelaskan siklus menstruasi dengan benar pada berbagai pasien.
Makna dalam OBE	Bukti autentik capaian pembelajaran berbasis praktik nyata.	Mahasiswa mampu menerapkan teori fisiologi reproduksi dalam konseling langsung.

Tabel 2.6
Case Report pada Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada
Perempuan Usia Reproduksi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada Perempuan Usia Reproduksi
Hakikat case report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus klinik.	Mahasiswa menyusun laporan konseling pada perempuan usia 24 tahun terkait masa subur.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan analisis dan dokumentasi kasus.	Mahasiswa mengintegrasikan data siklus menstruasi dengan konsep ovulasi.
Isi laporan	Identitas, keluhan, data subjektif, objektif, analisis, dan edukasi.	Data mencakup siklus 28–30 hari, mukus serviks elastis, suhu basal meningkat.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, analisis, dan edukasi.	Mahasiswa dinilai dalam menghubungkan tanda ovulasi dengan masa subur.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi ilmiah.	Mahasiswa belajar bahwa tanda fisiologis dapat digunakan untuk menentukan masa subur.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori ke praktik klinik.	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fertilitas secara sistematis.

Tabel 2.7
Refleksi Patient Safety pada Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada
Perempuan Usia Reproduksi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada Perempuan Usia Reproduksi
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi untuk mengenali risiko keselamatan pasien dan pencegahan kesalahan.	Mahasiswa menyadari risiko kesalahan edukasi tentang masa subur.
Tujuan	Meningkatkan kesadaran keselamatan pasien dalam praktik kebidanan.	Mahasiswa memahami pentingnya informasi yang akurat.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, penyebab, dan pencegahan.	Risiko: salah menentukan masa subur → kehamilan tidak direncanakan.
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Edukasi yang tidak tepat, miskonsepsi tentang ovulasi.
Tindakan pencegahan	Langkah untuk mengurangi risiko.	Memberikan edukasi berbasis siklus dan tanda fisiologis.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada Perempuan Usia Reproduksi
Pembelajaran mahasiswa	Insight yang diperoleh dari pengalaman klinik.	Mahasiswa belajar pentingnya komunikasi yang jelas dan ilmiah.
Makna dalam OBE	Bukti perkembangan sikap profesional dan critical thinking.	Mahasiswa mampu mengevaluasi dan meningkatkan praktik konseling.

M. Ringkasan Materi

Memahami sistem reproduksi manusia merupakan landasan krusial dalam praktik kebidanan. Sistem ini bukan sekadar kumpulan organ fisik, melainkan sebuah jaringan terintegrasi yang melibatkan interaksi antara anatomi, fungsi fisiologis yang dinamis, serta pengaturan hormonal yang kompleks untuk memungkinkan terjadinya proses reproduksi.

Sistem reproduksi perempuan terbagi menjadi dua bagian utama. Secara eksternal (vulva), terdapat struktur seperti mons pubis, labia mayora, dan klitoris yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus pusat sensasi. Secara internal, sistem ini melibatkan ovarium sebagai produsen sel telur (oosit) dan hormon utama, yaitu estrogen dan progesteron.

Sel telur yang dilepaskan akan ditangkap oleh fimbriae menuju tuba falopi, tempat di mana fertilisasi biasanya terjadi. Jika pembuahan berhasil, zigot akan bergerak menuju uterus (rahim) untuk melakukan implantasi pada lapisan endometrium yang telah menebal. Vagina melengkapi sistem ini sebagai saluran untuk koitus, jalan lahir, serta saluran pengeluaran darah menstruasi.

Berbeda dengan perempuan, sistem reproduksi laki-laki dirancang untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma. Testis yang terletak di dalam skrotum berperan vital dalam spermatogenesis dan produksi testosteron. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar tetap optimal bagi kualitas sperma. Setelah diproduksi, sperma dimatangkan di epididimis dan disalurkan melalui vas deferens. Selama ejakulasi, sperma bercampur dengan cairan dari kelenjar aksesori (vesikula seminalis, prostat, dan bulbourethralis) yang memberikan nutrisi dan perlindungan bagi sperma agar mampu bertahan hidup di lingkungan vagina yang asam.

Kemampuan reproduksi manusia sangat bergantung pada Sumbu Hipotalamus-Hipofisis-Gonad (HPG). Hipotalamus melepaskan GnRH yang memicu kelenjar hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon FSH dan LH.

Pada perempuan, hormon ini mengatur siklus ovulasi dan pertumbuhan dinding rahim. Pada laki-laki, FSH dan LH mendukung proses pembentukan sperma dan sekresi testosteron. Keseimbangan pada sumbu inilah yang menentukan tingkat fertilitas seseorang.

Bagi seorang tenaga kesehatan, khususnya bidan, penguasaan materi ini sangat penting untuk melakukan penilaian klinis yang akurat. Dengan memahami anatomi dan fisiologi normal, bidan dapat mengenali tanda-tanda gangguan reproduksi secara dini, memberikan edukasi mengenai masa subur, serta memberikan konseling kontrasepsi yang tepat berdasarkan mekanisme kerja hormonal tubuh pasien. Pemahaman yang mendalam terhadap proses-proses biologis ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak secara keseluruhan.

N. Alur asuhan singkat

1. Pengkajian: Cek riwayat menstruasi, gaya hidup, dan pemeriksaan fisik organ reproduksi.
2. Diagnosa: Menentukan status fertilitas (normal atau indikasi gangguan/infertilitas).
3. Intervensi: Edukasi nutrisi (asam folat/Zat Besi), konseling masa subur (KB atau perencanaan kehamilan), dan perbaikan gaya hidup.
4. Evaluasi/Rujukan: Pantau perubahan siklus atau keluhan; rujuk jika ditemukan kelainan anatomis atau hormonal berat.

O. Tabel Red Flags & Eskalasi

Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada Perempuan Usia Reproduksi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Siklus menstruasi tidak teratur (<21 hari atau >35 hari)	Mengarah pada gangguan ovulasi atau ketidakseimbangan hormonal	Lakukan pengkajian lebih lanjut, edukasi terbatas, dan rujuk ke dokter untuk evaluasi hormonal
Tidak haid >3 bulan (amenore)	Kemungkinan gangguan hormonal, kehamilan, atau gangguan endokrin	Anjurkan tes kehamilan, evaluasi lanjutan, rujuk ke fasilitas kesehatan
Perdarahan menstruasi sangat banyak (>7 hari atau ganti pembalut sangat sering)	Curiga menoragia atau gangguan endometrium	Nilai kondisi umum, edukasi awal, rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut
Nyeri haid sangat hebat (dismenore berat)	Kemungkinan endometriosis atau kelainan organ reproduksi	Evaluasi nyeri, berikan edukasi, rujuk bila mengganggu aktivitas
Keputihan abnormal (berbau, berwarna, gatal)	Mengarah pada infeksi saluran reproduksi	Lakukan edukasi kebersihan, hindari diagnosis pasti, rujuk untuk pemeriksaan
Tidak ada tanda ovulasi (tidak ada lendir serviks/subur)	Kemungkinan anovulasi	Edukasi terbatas, anjurkan pemantauan siklus, rujuk bila berlanjut
Perdarahan di luar siklus menstruasi	Dapat mengarah ke gangguan hormonal atau patologi uterus	Lakukan pengkajian, hindari asumsi normal, rujuk segera
Suhu basal tubuh tidak menunjukkan pola ovulasi	Menunjukkan kemungkinan gangguan ovulasi	Edukasi metode pemantauan ulang, rujuk bila menetap
Riwayat infertilitas (>1 tahun tidak hamil)	Mengarah pada gangguan fertilitas	Berikan konseling awal, rujuk ke layanan fertilitas

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab: Konseling Siklus Menstruasi dan Masa Subur pada Perempuan Usia Reproduksi

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Menjelaskan pengertian siklus menstruasi dan mekanismenya pada perempuan usia reproduksi	☐	☐	
2	Menjelaskan fase-fase siklus menstruasi (menstruasi, proliferasi, ovulasi, sekresi)	☐	☐	
3	Menjelaskan perubahan hormonal selama siklus menstruasi (FSH, LH, estrogen, progesteron)	☐	☐	
4	Menjelaskan hubungan antara ovulasi dan masa subur	☐	☐	
5	Menghitung dan menentukan masa subur berdasarkan siklus menstruasi	☐	☐	
6	Menjelaskan tanda dan gejala ovulasi secara klinis	☐	☐	
7	Melakukan anamnesis terarah terkait pola menstruasi dan gangguan haid (polimenorea, oligomenorea, amenorea)	☐	☐	
8	Menilai keteraturan dan lama siklus menstruasi dari data pasien	☐	☐	
9	Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi siklus menstruasi (stres, nutrisi, berat badan, hormon)	☐	☐	
10	Memberikan edukasi tentang cara menentukan masa subur untuk perencanaan/pencegahan kehamilan	☐	☐	
11	Menjelaskan pentingnya pencatatan kalender menstruasi untuk pemantauan kesehatan reproduksi	☐	☐	
12	Melakukan pemeriksaan fisik sederhana terkait keluhan gangguan menstruasi	☐	☐	
13	Mengenali tanda bahaya gangguan siklus menstruasi (perdarahan abnormal, nyeri berat, amenorea >3 bulan)	☐	☐	
14	Menjelaskan indikasi rujukan kasus gangguan menstruasi (misalnya dugaan PCOS atau gangguan hormonal serius)	☐	☐	
15	Memberikan konseling dengan bahasa sederhana tentang pola menstruasi sehat dan masa subur	☐	☐	
16	Mendokumentasikan hasil anamnesis, pemeriksaan, dan edukasi dengan lengkap dan tepat	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
17	Menjaga privasi, keselamatan, dan sikap profesional selama pemeriksaan dan konseling			

Refleksi singkat mahasiswa:

P. Referensi

- Ana-Maria Zagrean, M. P. (2020). MATERNAL-FETAL AND NEONATAL ENDOCRINOLOGY PHYSIOLOGY, PATHOPHYSIOLOGY, AND CLINICAL MANAGEMENT. *Acta Endocrinologica (Bucharest)*, 16(2), 274. <https://doi.org/10.4183/AEB.2020.274>
- Battistone, M. A., Mendelsohn, A. C., Spallanzani, R. G., Brown, D., Nair, A. V., & Breton, S. (2019). Region-specific transcriptomic and functional signatures of mononuclear phagocytes in the epididymis. *Molecular Human Reproduction*, 26(1), 14. <https://doi.org/10.1093/MOLEHR/GAZ059>
- Bishop, A., Cartwright, J. E., & Whitley, G. S. (2021). Stanniocalcin-1 in the female reproductive system and pregnancy. *Human Reproduction Update*, 27(6), 1098–1114. <https://doi.org/10.1093/HUMUPD/DMAB028>
- Bull, J. R., Rowland, S. P., Scherwitzl, E. B., Scherwitzl, R., Danielsson, K. G., & Harper, J. (2019). Real-world menstrual cycle characteristics of more than 600,000 menstrual cycles. *Npj Digital Medicine* 2019 2:1, 2(1), 83-. <https://doi.org/10.1038/s41746-019-0152-7>
- Campion, S., Catlin, N., Heger, N., McDonnell, E. V., Pacheco, S. E., Saffarini, C., Sandrof, M. A., & Boekelheide, K. (2012). Male reprotoxicity and endocrine disruption. *EXS*, 101, 315. https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8340-4_11
- Cariati, F., Carbone, L., Conforti, A., Bagnulo, F., Peluso, S. R., Carotenuto, C., Buonfantino, C., Alviggi, E., Alviggi, C., & Strina, I. (2020). Bisphenol A-Induced Epigenetic Changes and Its Effects on the Male Reproductive System. *Frontiers in Endocrinology*, 11, 544682. <https://doi.org/10.3389/FENDO.2020.00453/TEXT>
- Christensen, A., Bentley, G. E., Cabrera, R., Ortega, H. H., Perfito, N., Wu, T. J., & Micevych, P. (2012). Hormonal Regulation of Female Reproduction. *Hormone and Metabolic Research = Hormon- Und Stoffwechselforschung = Hormones et Metabolisme*, 44(8), 587. <https://doi.org/10.1055/S-0032-1306301>
- Cinnamon, V., Regan, J. L., & Russo, A. F. (2022). *Seeley's Essentials of anatomy & physiology* (11th ed.). McGraw Hill. <https://spclibrary.sanpablocolleges.edu.ph/index.php?p=cite&id=1071&keywords=>

- Clavijo, R. I., & Hsiao, W. (2018). Update on male reproductive endocrinology. *Translational Andrology and Urology*, 7(Suppl 3), S367. <https://doi.org/10.21037/TAU.2018.03.25>
- Dai, M., Xu, Y., Gong, G., & Zhang, Y. (2023). Roles of immune microenvironment in the female reproductive maintenance and regulation: novel insights into the crosstalk of immune cells. *Frontiers in Immunology*, 14, 1109122. <https://doi.org/10.3389/FIMMU.2023.1109122>
- Duane, M., Stanford, J. B., Porucznik, C. A., & Vigil, P. (2022). Fertility Awareness-Based Methods for Women's Health and Family Planning. *Frontiers in Medicine*, 9. <https://doi.org/10.3389/FMED.2022.858977>
- Dwyer, M. E., Salgado, C. J., & Lightner, D. J. (2011). Normal Penile, Scrotal, and Perineal Anatomy with Reconstructive Considerations. *Seminars in Plastic Surgery*, 25(3), 179. <https://doi.org/10.1055/S-0031-1281487>
- Fehring, R. J., Schneider, M., & Raviele, K. (2006). Variability in the phases of the menstrual cycle. *JOGNN - Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing*, 35(3), 376–384. <https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2006.00051.x>
- Foster, R. A. (2016). Male Genital System. *Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals: Volume 3*, 3, 465. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7020-5319-1.00016-5>
- Gao, Q., Wang, T., Pan, L., Qian, C., Wang, J., Xin, Q., Liu, Y., Zhang, Z., Xu, Y., He, X., & Cao, Y. (2021a). Circular RNAs: Novel potential regulators in embryogenesis, female infertility, and pregnancy-related diseases. *Journal of Cellular Physiology*, 236(10), 7223–7241. <https://doi.org/10.1002/JCP.30376;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>
- Gao, Q., Wang, T., Pan, L., Qian, C., Wang, J., Xin, Q., Liu, Y., Zhang, Z., Xu, Y., He, X., & Cao, Y. (2021b). Circular RNAs: Novel potential regulators in embryogenesis, female infertility, and pregnancy-related diseases. *Journal of Cellular Physiology*, 236(10), 7223–7241. <https://doi.org/10.1002/JCP.30376;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>
- Ghafarizadeh, A., Malmir, M., Naderi Noreini, S., & Faraji, T. (2021). Antioxidant effects of N-acetylcysteine on the male reproductive system: A systematic review. *Andrologia*, 53(1), e13898. <https://doi.org/10.1111/AND.13898;CSUBTYPE:STRING:SPECIAL;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>
- Gholiof, M., Adamson-De Luca, E., & Wessels, J. M. (2022). The female reproductive tract microbiotas, inflammation, and gynecological conditions. *Frontiers in Reproductive Health*, 4, 963752. <https://doi.org/10.3389/FRPH.2022.963752>
- Godoy-Guzmán, C., Nuñez, C., Orihuela, P., Campos, A., & Carriel, V. (2018). Distribution of extracellular matrix molecules in human uterine tubes

- during the menstrual cycle: a histological and immunohistochemical analysis. *Journal of Anatomy*, 233(1), 73–85. <https://doi.org/10.1111/JOA.12814>;WGROU:STRING:PUBLICATION
- Hedger, M. P. (2014). The Immunophysiology of Male Reproduction. *Knobil and Neill's Physiology of Reproduction*, 1, 805. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397175-3.00019-3>
- Ivell, R., & Anand-Ivell, R. (2021). The Physiology of Reproduction – Quo vadis? In *Frontiers in Physiology* (Vol. 12). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.650550>
- Kumar, B. S., Manasa, V., Ramesh, H. S., Nandi, S., & Kumar, V. G. (2023). Molecular Targets of Phyto-bioactive Compounds in Female Reproductive System of Mammals: A Review. *Indian Journal of Animal Research*, 57(3), 261–272. <https://doi.org/10.18805/IJAR.B-4288>
- M, M. (2020). A Review on Effect of Para-nonylphenol on Male Reproductive System. *Perceptions in Reproductive Medicine*, 3(5). <https://doi.org/10.31031/PRM.2020.03.000572>
- Netter, F. (2023). *Netter Atlas of Human Anatomy: Classic Regional Approach* (8th ed.). Elsevier. <https://lib.ummetro.ac.id/index.php?p=cite&id=11720&keywords=>
- Onuoha, C. H., & Onuoha, C. H. (2020). Reproductive Physiology of Male Rabbits: A Key Factor in Buck Selection for Breeding (Paper Review). *Advances in Reproductive Sciences*, 8(2), 97–112. <https://doi.org/10.4236/ARSCI.2020.82009>
- Pepe, G., Locati, M., Della Torre, S., Mornata, F., Cignarella, A., Maggi, A., & Vegeto, E. (2018). The estrogen–macrophage interplay in the homeostasis of the female reproductive tract. *Human Reproduction Update*, 24(6), 652–672. <https://doi.org/10.1093/HUMUPD/DMY026>
- Rey, R. A. (2021). The Role of Androgen Signaling in Male Sexual Development at Puberty. *Endocrinology*, 162(2), 1–16. <https://doi.org/10.1210/ENDOCR/BQAA215>
- Rojas, J., Chávez-Castillo, M., Olivar, L. C., Calvo, M., Mejías, J., Rojas, M., Morillo, J., & Bermúdez, V. (2015). Physiologic Course of Female Reproductive Function: A Molecular Look into the Prologue of Life. *Journal of Pregnancy*, 2015, 715735. <https://doi.org/10.1155/2015/715735>
- Ruthig, V. A., Labrash, S., Lozanoff, S., & Ward, M. A. (2016). Macroscopic demonstration of the male urogenital system with evidence of a direct inguinal hernia utilizing room temperature plastination. *Anatomy*, 10(3), 211. <https://doi.org/10.2399/ANA.16.036>
- Sadykova, G. K., & Olina, A. A. (2021). Selenium is a functional component of the female reproductive system. Its role in pregnancy complications. *Russian*

- Journal of Woman and Child Health*, 4(4), 328–332. <https://doi.org/10.32364/2618-8430-2021-4-4-328-332>
- Salem, A. M. (2021). Variation of Leptin During Menstrual Cycle and Its Relation to the Hypothalamic–Pituitary–Gonadal (HPG) Axis: A Systematic Review. *International Journal of Women's Health*, 13, 445–458. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S309299>
- Smith, R. P. ., & Netter, F. H. . (2024). *Netter's obstetrics and gynecology*. 678.
- Stejskalová, A., Vankelecom, H., Sourouni, M., Ho, M. Y., Götte, M., & Almquist, B. D. (2021). In vitro modelling of the physiological and diseased female reproductive system. *Acta Biomaterialia*, 132, 288–312. <https://doi.org/10.1016/J.ACTBIO.2021.04.032>
- Takada, K., Melnikov, V. G., Kobayashi, R., Komine-Aizawa, S., Tsuji, N. M., & Hayakawa, S. (2023). Female reproductive tract-organ axes. *Frontiers in Immunology*, 14, 1110001. <https://doi.org/10.3389/FIMMU.2023.1110001>
- Tung, C. K., & Suarez, S. S. (2021). Co-Adaptation of Physical Attributes of the Mammalian Female Reproductive Tract and Sperm to Facilitate Fertilization. *Cells*, 10(6), 1297. <https://doi.org/10.3390/CELLS10061297>
- Wang, Q., Shen, J. Y., Zhang, R., Hong, J. W., Li, Z., Ding, Z., Wang, H. X., Zhang, J. P., Zhang, M. R., & Xu, L. C. (2020). Effects and mechanisms of pyrethroids on male reproductive system. *Toxicology*, 438, 152460. <https://doi.org/10.1016/J.TOX.2020.152460>
- Washburn, R. L. (2024). Complements from the Male Reproductive Tract: A Scoping Review. *BioMed*, 4(1), 19–38. <https://doi.org/10.3390/biomed4010002>
- Wolman, I. (2014). Berek and Novak's Gynecology 15th Edition. *Journal of Obstetrics and Gynaecology of India*, 64(2), 150. <https://doi.org/10.1007/S13224-014-0538-Z>
- Ye, R. J., Yang, J. M., Hai, D. M., Liu, N., Ma, L., Lan, X. B., Niu, J. G., Zheng, P., & Yu, J. Q. (2020). Interplay between male reproductive system dysfunction and the therapeutic effect of flavonoids. *Fitoterapia*, 147, 104756. <https://doi.org/10.1016/J.FITOTE.2020.104756>
- Zhang, T., Zhou, X., Xu, A., Tian, Y., Wang, Y., Zhang, Y., Gu, Q., Wang, S. Q., & Wang, Z. (2020). Toxicity of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) on rodent male reproductive system: A systematic review and meta-analysis of randomized control studies. *Science of The Total Environment*, 720, 137419. <https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2020.137419>

BAB 3

KEBUTUHAN DAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI: PENDEKATAN BERPUSAT PADA KLIEN

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan regulasi dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.	CPMK-1, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi berpusat pada klien/keluarga untuk mendukung pengambilan keputusan kontrasepsi.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan, pencegahan infeksi, serta perlindungan privasi dan kerahasiaan dalam layanan KB/kespro.	CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-4	Menganalisis data klinis dan konteks klien untuk pengambilan keputusan berbasis bukti terkait pemilihan dan tindak lanjut kontrasepsi.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan layanan KB dan tindak lanjut secara aman, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan klien (metode, edukasi, pemantauan).	CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6
CPL-6	Mengelola layanan KB/kespro melalui pencatatan-pelaporan, logistik, rujukan, evaluasi mutu, dan perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7, CPMK-1

CPL dan CPMK

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep, tujuan, kebijakan, serta aspek etika–legal keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi sistem reproduksi dan regulasi fertilitas sebagai dasar pemilihan metode kontrasepsi.
CPMK-3	Mengevaluasi kebutuhan, preferensi, dan hak kesehatan reproduksi klien dengan pendekatan berpusat pada klien.
CPMK-4	Merancang dan menerapkan konseling KB efektif (komunikasi, informed choice, skrining kelayakan) serta rencana tindak lanjut.
CPMK-5	Menentukan pilihan metode kontrasepsi yang tepat dan menyusun edukasi penggunaan sesuai kelayakan, kondisi, dan bukti.
CPMK-6	Menangani efek samping/komplikasi KB, menetapkan tindakan awal, serta menentukan kebutuhan rujukan secara aman.
CPMK-7	Mengelola pelayanan KB/kespro (IMS/HIV, logistik, pencatatan–pelaporan, mutu, keselamatan, evaluasi kepuasan) berbasis data.

Uraian Materi

Kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang menjamin setiap individu memiliki kebebasan, keamanan, dan martabat dalam menentukan kehidupan reproduksinya. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan fungsi biologis sistem reproduksi, tetapi mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan hak untuk mengambil keputusan secara bebas serta bertanggung jawab (WHO, 2021). Dalam konteks pelayanan kebidanan dan keluarga berencana, pemenuhan kebutuhan dan hak kesehatan reproduksi menjadi fondasi utama dalam praktik profesional yang etis dan berpusat pada klien.

Perkembangan paradigma pelayanan kesehatan global menunjukkan pergeseran dari pendekatan provider-centered menuju client-centered care. Pendekatan berpusat pada klien menempatkan individu sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan layanan kesehatan, bukan sebagai objek intervensi. Teori client-centered care dari Rogers (1961) menekankan pentingnya empati, penerimaan tanpa syarat, dan penghormatan terhadap otonomi klien. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep shared decision making yang menuntut keterlibatan aktif klien dalam menentukan pilihan metode kontrasepsi dan rencana tindak lanjut (Elwyn et al., 2012).

Dalam konteks keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, kebutuhan klien bersifat dinamis sepanjang daur kehidupan. Remaja memiliki kebutuhan edukasi dan perlindungan dari perilaku berisiko. Pasangan usia subur membutuhkan akses terhadap kontrasepsi yang aman dan sesuai kondisi medis. Perempuan pada masa perimenopause memerlukan konseling terkait perubahan hormonal dan risiko kesehatan tertentu. Pendekatan life cycle menegaskan bahwa pelayanan harus disesuaikan dengan tahap kehidupan individu (Friedman et al., 2003).

Hak kesehatan reproduksi mencakup hak atas informasi yang akurat, hak atas akses layanan yang aman, hak atas privasi dan kerahasiaan, hak bebas dari diskriminasi dan paksaan, serta hak untuk menentukan pilihan secara sukarela. Prinsip ini juga diperkuat dalam kerangka etika biomedis yang menekankan otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice (Beauchamp & Childress, 2019). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, bahkan hukum.

Bab ini secara langsung mendukung pencapaian CPMK-3, yaitu kemampuan mahasiswa mengevaluasi kebutuhan, preferensi, dan hak kesehatan reproduksi klien melalui pendekatan berpusat pada klien. Penguatan CPMK-1 tercermin

dalam analisis aspek etika dan regulasi pelayanan. Relevansi terhadap CPMK-4 terlihat pada penerapan konseling efektif, informed choice, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang menghormati hak klien.

Pembahasan dalam bab ini akan menguraikan konsep kebutuhan kesehatan reproduksi sepanjang daur kehidupan, prinsip hak reproduksi, implementasi pendekatan berpusat pada klien dalam praktik pelayanan KB dan kespro, serta tantangan dan strategi penguatan dalam konteks pelayanan kebidanan. Pemahaman komprehensif terhadap aspek kebutuhan dan hak ini menjadi landasan penting dalam membangun praktik kebidanan yang profesional, etis, aman, dan responsif terhadap keberagaman klien.

A. Konsep Kebutuhan Kesehatan Reproduksi Sepanjang Daur Kehidupan

1. Konsep dan Definisi

Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya, serta bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan (WHO, 2022). Definisi ini menegaskan bahwa kesehatan reproduksi memiliki dimensi multidimensional yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan hak asasi manusia.

Kebutuhan kesehatan reproduksi tidak hanya merujuk pada pelayanan klinis, tetapi juga mencakup kebutuhan informasi, akses terhadap layanan yang aman, serta kemampuan individu untuk mengambil keputusan secara bebas dan bertanggung jawab. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan *rights-based* dan *people-centred health services* yang menempatkan individu sebagai subjek aktif dalam sistem pelayanan kesehatan (WHO, 2021).

Pendekatan *life course approach* atau daur kehidupan menekankan bahwa kebutuhan kesehatan reproduksi bersifat dinamis dan berubah sesuai tahap perkembangan individu (UNFPA, 2021). Setiap fase kehidupan memiliki karakteristik risiko, kebutuhan intervensi, dan bentuk pelayanan yang berbeda, antara lain:

- a. Remaja: membutuhkan edukasi kesehatan reproduksi komprehensif, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, pencegahan kehamilan tidak diinginkan, dan layanan ramah remaja.
- b. Usia reproduktif: membutuhkan akses kontrasepsi yang aman, skrining IMS, konseling prakonsepsi, serta perlindungan hak dalam pengambilan keputusan fertilitas.

- c. Kehamilan dan nifas: membutuhkan pelayanan antenatal, persalinan aman, serta integrasi KB pascapersalinan untuk mencegah kehamilan berisiko tinggi.
- d. Perimenopause: membutuhkan konseling perubahan hormonal, manajemen gejala, dan skrining penyakit degeneratif.

Pendekatan daur kehidupan ini mendukung CPMK-3 karena mahasiswa dituntut mampu mengevaluasi kebutuhan klien berdasarkan konteks usia dan fase reproduksi, bukan hanya berdasarkan keluhan klinis saat ini.

2. Kebijakan dan Regulasi Terkini

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) menegaskan bahwa pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan wajib menjamin akses universal, keselamatan pasien, perlindungan privasi, serta penghormatan terhadap hak klien. Regulasi ini mengintegrasikan prinsip mutu layanan, keselamatan pasien, dan non-diskriminasi sebagai standar minimal pelayanan.

WHO (2022) melalui *Family Planning: A Global Handbook for Providers* edisi terbaru menekankan bahwa pelayanan kontrasepsi harus berbasis bukti ilmiah, skrining kelayakan medis yang tepat, serta menjunjung tinggi hak reproduksi. Pendekatan ini juga diperkuat oleh WHO *Consolidated Guideline on Self-Care Interventions* (2021) yang mendorong pemberdayaan klien dalam pengelolaan kesehatan reproduksi secara mandiri dan terinformasi.

Kebijakan nasional dan global tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan kesehatan reproduksi tidak dapat dipisahkan dari kerangka etika dan legal, sehingga memperkuat keterkaitan materi ini dengan CPMK-1.

3. Peran Bidan

Bidan sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab melakukan asesmen kebutuhan kesehatan reproduksi secara komprehensif. Asesmen tersebut meliputi:

- a. Aspek biologis (riwayat menstruasi, riwayat obstetri, kondisi medis)
- b. Aspek psikososial (dukungan pasangan, kondisi ekonomi, literasi kesehatan)
- c. Aspek budaya dan nilai (keyakinan, norma sosial, pengalaman sebelumnya)

Pendekatan ini menuntut keterampilan komunikasi terapeutik dan analisis kontekstual, sehingga relevan dengan penguatan CPMK-4 dalam konseling efektif.

Bidan juga harus memastikan bahwa setiap kebutuhan yang teridentifikasi diterjemahkan dalam rencana pelayanan yang menghormati preferensi klien serta prinsip keselamatan.

4. Contoh Implementasi di Lapangan

Seorang remaja perempuan datang ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi mengenai siklus menstruasi tidak teratur. Pendekatan berpusat pada klien tidak langsung mengarah pada intervensi farmakologis, tetapi dimulai dengan asesmen kebutuhan informasi, pemahaman tentang pubertas, pola hidup, dan kondisi psikososial.

Bidan memberikan edukasi seksual komprehensif tanpa stigma, menjaga kerahasiaan, serta menciptakan ruang konsultasi yang aman. Remaja tersebut merasa dihargai dan bersedia melakukan kunjungan ulang. Praktik ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi bukan hanya tindakan klinis, tetapi juga proses membangun kepercayaan dan keamanan psikologis.

5. Tantangan dan Solusi

Stigma sosial terhadap pembahasan kesehatan reproduksi, khususnya pada remaja, masih menjadi hambatan utama dalam akses layanan. Literasi kesehatan yang rendah dan norma budaya yang membatasi komunikasi terbuka turut memperparah kondisi tersebut.

Strategi penguatan meliputi:

- a. Pengembangan layanan ramah remaja dan ramah perempuan.
- b. Edukasi berbasis komunitas untuk meningkatkan literasi kesehatan reproduksi.
- c. Pelatihan tenaga kesehatan dalam komunikasi sensitif budaya.
- d. Integrasi konseling kespro dalam layanan rutin agar lebih mudah diakses.

Pendekatan sistematis terhadap tantangan ini tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga memperkuat implementasi prinsip hak reproduksi dalam pelayanan sehari-hari.

Subbab ini menegaskan bahwa kebutuhan kesehatan reproduksi harus dipahami secara holistik, dinamis, dan kontekstual. Evaluasi kebutuhan berdasarkan daur kehidupan serta penghormatan terhadap hak individu

menjadi fondasi dalam membangun pelayanan kesehatan reproduksi yang profesional, etis, dan berpusat pada klien.

B. Hak Kesehatan Reproduksi dalam Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

1. Konsep Hak Kesehatan Reproduksi

Hak kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang menjamin setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan reproduksinya secara bertanggung jawab, aman, dan bermartabat. Hak ini mencakup hak memperoleh informasi yang akurat, hak atas akses layanan yang aman dan bermutu, hak atas privasi dan kerahasiaan, hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak untuk membuat keputusan reproduksi tanpa paksaan (WHO, 2022).

Dalam konteks keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, hak tersebut diwujudkan melalui prinsip *informed choice*, *informed consent*, dan *noncoercion*. Pelayanan KB tidak boleh berorientasi pada target program semata, melainkan harus menjamin bahwa keputusan penggunaan kontrasepsi benar-benar berasal dari pilihan klien setelah menerima informasi yang lengkap dan seimbang.

Hak kesehatan reproduksi juga berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan gender. Ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga atau masyarakat dapat membatasi otonomi perempuan dalam menentukan pilihan reproduksi. Pendekatan berbasis hak karena itu tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga sosial dan struktural.

2. Analisis Regulasi Indonesia Terkini

Penguatan hak kesehatan reproduksi dalam pelayanan KB dan kespro di Indonesia didasarkan pada beberapa kerangka regulasi penting:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memperkuat aspek keselamatan pasien, perlindungan data kesehatan, serta standar pelayanan berbasis mutu dan akuntabilitas.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan terkait pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, yang menegaskan kewajiban *informed consent*, perlindungan kerahasiaan, dan penghormatan terhadap hak klien.

d. Program Bangga Kencana (BKKBN, 2023), yang mengintegrasikan prinsip hak reproduksi dan kesetaraan dalam pembangunan keluarga.

Regulasi terbaru menekankan bahwa tenaga kesehatan wajib memberikan informasi yang komprehensif mengenai manfaat, risiko, efek samping, serta alternatif metode kontrasepsi. Dokumentasi persetujuan tindakan menjadi bukti bahwa hak klien telah dihormati secara prosedural dan substantif.

Perlindungan data kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam regulasi terkini. Informasi terkait status reproduksi, penggunaan kontrasepsi, maupun kondisi IMS/HIV termasuk dalam data sensitif yang wajib dijaga kerahasiaannya. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan etik.

3. Integrasi Aspek Etika Klinis

Hak kesehatan reproduksi dalam praktik klinis tidak dapat dilepaskan dari prinsip etika biomedis, yaitu:

- a. Otonomi: Klien berhak menentukan pilihan reproduksi tanpa paksaan.
- b. Beneficence: Tenaga kesehatan wajib memberikan intervensi yang bermanfaat bagi klien.
- c. Non-maleficence: Tindakan tidak boleh menimbulkan bahaya yang tidak perlu.
- d. Justice: Pelayanan harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi.

Dalam praktik KB, konflik etis dapat muncul ketika preferensi klien tidak sepenuhnya sejalan dengan rekomendasi medis. Contohnya, seorang klien dengan riwayat hipertensi tetap ingin menggunakan kontrasepsi kombinasi. Dalam situasi tersebut, bidan wajib menjelaskan risiko secara objektif dan menawarkan alternatif yang lebih aman, tanpa menghilangkan hak klien untuk menentukan keputusan akhir setelah informed choice dilakukan.

Etika klinis juga menuntut perlindungan terhadap kelompok rentan. Remaja, penyandang disabilitas, atau korban kekerasan seksual berhak memperoleh pelayanan tanpa stigma dan tanpa penghakiman moral. Kegagalan menjaga kerahasiaan dapat berdampak psikologis dan sosial yang serius.

4. Peran Bidan dalam Menjamin Hak Reproduksi

Bidan memiliki tanggung jawab profesional untuk:

- a. Menyediakan informasi yang lengkap dan berbasis bukti.
- b. Melaksanakan skrining kelayakan medis sesuai pedoman WHO terbaru.
- c. Memastikan adanya informed consent sebelum tindakan.
- d. Menjaga privasi ruang konseling dan kerahasiaan data.
- e. Menghindari sikap diskriminatif atau bias nilai pribadi.

Pendekatan ini mendukung pencapaian CPMK-3 dalam mengevaluasi dan menerapkan hak klien, serta memperkuat CPMK-1 dalam analisis etika dan regulasi pelayanan.

5. Contoh Implementasi Klinis

Seorang perempuan usia 19 tahun datang untuk meminta kontrasepsi tanpa didampingi orang tua. Secara etis dan legal, bidan harus menilai kapasitas pengambilan keputusan klien, memberikan informasi lengkap, serta menjaga kerahasiaan konsultasi. Penolakan pelayanan semata-mata karena usia tanpa pertimbangan kapasitas dan regulasi dapat melanggar prinsip otonomi dan justice.

Dalam kasus lain, pasangan suami memaksa istrinya memilih metode tertentu. Bidan perlu melakukan konseling individual untuk memastikan keputusan istri benar-benar sukarela. Tindakan ini menunjukkan penerapan prinsip *non-coercion* dalam pelayanan KB.

6. Tantangan dan Strategi Penguatan

Tantangan dalam implementasi hak kesehatan reproduksi meliputi:

- a. Tekanan budaya dan patriarki.
- b. Target program yang berpotensi menggeser fokus dari hak ke capaian angka.
- c. Kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang etika klinis.

Strategi penguatan meliputi:

- a. Pelatihan etika klinis dan komunikasi sensitif budaya.
- b. Audit mutu layanan berbasis indikator hak klien.
- c. Penguatan sistem dokumentasi informed consent.
- d. Integrasi evaluasi kepuasan klien dalam penilaian mutu layanan.

Subbab ini menegaskan bahwa hak kesehatan reproduksi bukan sekadar konsep normatif, melainkan kewajiban profesional yang harus diimplementasikan dalam setiap tahapan pelayanan KB dan kesehatan

reproduksi. Integrasi regulasi nasional, prinsip etika klinis, dan pendekatan berpusat pada klien menjadi fondasi dalam membangun praktik kebidanan yang aman, adil, dan bermartabat.

C. Pendekatan Berpusat pada Klien (Client-Centered Care)

1. Konsep

Pendekatan berpusat pada klien (*client-centered care*) merupakan paradigma pelayanan kesehatan yang menempatkan klien sebagai mitra aktif dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini berakar pada teori humanistik Carl Rogers (1961) yang menekankan empati, penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*), dan keaslian (*genuineness*) dalam relasi profesional. Dalam konteks kesehatan reproduksi, pendekatan ini berarti tenaga kesehatan tidak mendominasi keputusan, melainkan memfasilitasi proses dialog yang menghormati nilai, preferensi, dan konteks kehidupan klien.

Perkembangan literatur mutakhir menegaskan bahwa pelayanan berpusat pada klien meningkatkan kepuasan, kepatuhan, serta keberlanjutan penggunaan kontrasepsi (WHO, 2022). *Client-centered care* juga menjadi bagian dari kerangka *people-centred health services* yang mendorong keterlibatan aktif individu dalam pengelolaan kesehatannya.

Pendekatan ini secara langsung mendukung CPMK-3 karena mahasiswa dituntut mampu mengevaluasi kebutuhan dan preferensi klien, bukan sekadar menyampaikan rekomendasi klinis.

2. Integrasi dengan Konseling KB

Pendekatan berpusat pada klien diimplementasikan dalam praktik melalui konseling terstruktur dan dialog kolaboratif. Model GATHER (Greet, Ask, Tell, Help, Explain, Return) memberikan kerangka sistematis untuk memastikan proses komunikasi berjalan efektif dan komprehensif.

Selain itu, prinsip *shared decision making* memperkuat integrasi *client-centered care* dalam pelayanan KB (Elwyn et al., 2012; update 2020). *Shared decision making* menekankan tiga tahap utama:

- a. penyampaian pilihan yang tersedia,
- b. diskusi risiko dan manfaat berdasarkan bukti ilmiah,
- c. eksplorasi preferensi klien sebelum keputusan diambil.

Dalam praktik keluarga berencana, integrasi ini memastikan bahwa *informed choice* tidak sekadar formalitas, melainkan proses reflektif dan partisipatif.

Pendekatan ini juga mendukung CPMK-4 karena mahasiswa harus mampu menerapkan komunikasi terapeutik, skrining kelayakan medis, serta menyusun rencana tindak lanjut yang sesuai dengan keputusan klien.

3. Peran Bidan

Bidan memiliki peran sentral dalam menerapkan pendekatan berpusat pada klien. Peran tersebut meliputi:

- a. Membangun hubungan terapeutik yang aman dan saling percaya.
- b. Menggali kebutuhan, kekhawatiran, serta pengalaman sebelumnya terkait kontrasepsi.
- c. Menyampaikan informasi berbasis bukti dengan bahasa yang sesuai tingkat literasi kesehatan klien.
- d. Menghindari bias pribadi atau tekanan program dalam merekomendasikan metode.
- e. Mendokumentasikan proses konseling dan keputusan klien secara transparan.

Pendekatan ini menuntut keterampilan komunikasi reflektif, kemampuan mendengarkan aktif, serta sensitivitas terhadap faktor budaya dan gender. Bidan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi informasi, tetapi sebagai fasilitator proses pengambilan keputusan yang aman dan etis.

4. Contoh Praktik

Seorang klien menyatakan keraguan menggunakan kontrasepsi hormonal karena takut mengalami kenaikan berat badan. Pendekatan berpusat pada klien tidak merespons dengan menyangkal kekhawatiran tersebut, melainkan dengan mengakui perasaan klien dan memberikan penjelasan ilmiah mengenai kemungkinan efek samping serta variasi respons individu.

Bidan kemudian menawarkan alternatif metode, seperti IUD atau implan, sambil menjelaskan kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Klien diberi waktu untuk mempertimbangkan pilihan. Keputusan akhir diambil setelah dialog terbuka yang menghormati preferensi klien. Praktik ini mencerminkan penerapan empati, komunikasi dua arah, dan penghormatan terhadap otonomi klien.

5. Tantangan dan Solusi

Pelaksanaan client-centered care menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Waktu pelayanan yang terbatas sehingga komunikasi menjadi terburu-buru.
- b. Tekanan target program yang dapat menggeser fokus dari kebutuhan klien.
- c. Variasi tingkat literasi kesehatan klien.

Strategi penguatan meliputi:

- a. Pengaturan jadwal konseling khusus untuk kasus kompleks.
- b. Pelatihan komunikasi terapeutik berbasis simulasi dan role play.
- c. Penggunaan media edukasi visual untuk membantu pemahaman.
- d. Audit mutu pelayanan berbasis kepuasan dan pengalaman klien.

Pendekatan berpusat pada klien bukan sekadar teknik komunikasi, tetapi paradigma pelayanan yang menjunjung tinggi martabat, otonomi, dan partisipasi aktif individu dalam menentukan keputusan kesehatan reproduksinya. Integrasi pendekatan ini dalam pelayanan KB dan kespro memperkuat profesionalisme bidan sekaligus meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan.

D. Analisis Faktor Penentu Akses dan Kerentanan dalam Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

Pemenuhan kebutuhan dan hak kesehatan reproduksi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan klinis, tetapi juga oleh berbagai faktor struktural dan sosial yang memengaruhi akses. Perspektif determinan sosial kesehatan (social determinants of health) menegaskan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan berperan signifikan dalam menentukan peluang individu untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman dan bermutu (WHO, 2022). Dalam konteks keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, faktor-faktor tersebut dapat memperkuat atau justru menghambat akses terhadap informasi, konseling, dan metode kontrasepsi.

1. Determinan Sosial Kesehatan dalam Akses Layanan Kespro

Determinasi akses terhadap layanan KB dan kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh beberapa dimensi utama:

a. Faktor Sosial dan Budaya

Norma budaya, kepercayaan agama, serta struktur patriarki dapat memengaruhi otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan reproduksi. Di beberapa konteks, keputusan penggunaan kontrasepsi masih didominasi pasangan atau keluarga besar. Norma yang menganggap pembahasan kesehatan reproduksi sebagai hal tabu juga dapat membatasi literasi kesehatan masyarakat.

b. Faktor Ekonomi

Kemampuan ekonomi memengaruhi kemampuan membayar transportasi, biaya layanan, maupun waktu untuk mengakses fasilitas kesehatan. Meskipun banyak layanan KB disubsidi pemerintah, hambatan biaya tidak langsung tetap menjadi faktor pembatas.

c. Faktor Pendidikan dan Literasi Kesehatan

Tingkat pendidikan berkorelasi dengan pemahaman informasi kontrasepsi dan kemampuan melakukan informed choice. Literasi kesehatan yang rendah meningkatkan risiko miskonsepsi, ketakutan terhadap efek samping, serta angka drop out penggunaan kontrasepsi.

d. Faktor Geografis dan Infrastruktur

Wilayah terpencil dengan keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga terlatih memiliki akses yang lebih rendah terhadap metode tertentu seperti IUD atau implan. Distribusi logistik yang tidak merata juga memengaruhi pilihan metode yang tersedia.

Pendekatan determinan sosial ini memperkuat CPMK-3 karena mahasiswa dituntut tidak hanya menilai kondisi klinis, tetapi juga menganalisis konteks sosial yang memengaruhi keputusan reproduksi klien.

2. Perspektif Kesetaraan dan Equity dalam Pelayanan

Konsep equity dalam kesehatan menekankan bahwa setiap individu harus memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya, bukan sekadar perlakuan yang sama (equality). WHO (2022) menegaskan bahwa kelompok rentan memerlukan perhatian khusus agar ketimpangan akses dapat dikurangi.

Kelompok yang sering mengalami kerentanan dalam pelayanan KB dan kespro meliputi:

- a. Remaja dan pasangan muda
- b. Perempuan dengan disabilitas
- c. Perempuan dengan penyakit kronis
- d. Penyintas kekerasan seksual
- e. Perempuan dengan status sosial ekonomi rendah
- f. Kelompok minoritas atau terstigma (misalnya dengan HIV)

Pendekatan equity menuntut penyesuaian layanan agar inklusif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik masing-masing kelompok.

3. Peran Bidan dalam Mengatasi Ketimpangan Akses

Bidan memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi dan mengurangi hambatan akses melalui:

- a. Asesmen sosial dan identifikasi faktor risiko non-medis.
- b. Penyediaan informasi dengan bahasa sederhana dan media visual.
- c. Pelayanan yang tidak diskriminatif dan sensitif budaya.
- d. Rujukan yang tepat dan koordinasi dengan jejaring sosial atau layanan pendukung.
- e. Edukasi komunitas untuk meningkatkan literasi kesehatan reproduksi.

Pendekatan ini juga mendukung CPMK-4 karena kemampuan komunikasi dan konseling efektif menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan akses.

4. Contoh Implementasi di Lapangan

Seorang perempuan dengan disabilitas fisik mengalami kesulitan mengakses ruang pelayanan karena tidak ramah kursi roda. Pendekatan equity mendorong fasilitas kesehatan untuk menyediakan akses fisik yang memadai serta waktu konseling yang cukup.

Dalam kasus lain, remaja dari keluarga konservatif enggan datang ke fasilitas kesehatan karena takut diketahui orang tua. Bidan dapat menyediakan layanan konseling privat dengan menjaga kerahasiaan sesuai regulasi, sehingga hak reproduksi tetap terlindungi.

5. Tantangan dan Strategi Penguatan

Tantangan utama dalam penerapan prinsip kesetaraan meliputi keterbatasan sumber daya, bias tidak sadar tenaga kesehatan, serta kurangnya data terpilah untuk mengidentifikasi kelompok rentan.

Strategi penguatan meliputi:

- a. Pelatihan tenaga kesehatan mengenai pelayanan inklusif dan sensitif gender.
- b. Pengumpulan data berbasis kelompok risiko untuk evaluasi program.
- c. Integrasi indikator equity dalam audit mutu layanan.
- d. Kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi determinan sosial di luar fasilitas kesehatan.

Subbab ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dan hak kesehatan reproduksi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan struktural. Pendekatan berbasis determinan sosial dan kesetaraan layanan memungkinkan bidan memberikan pelayanan yang lebih adil, responsif, dan berpusat pada klien. Integrasi analisis sosial dalam praktik klinis memperkuat kompetensi profesional mahasiswa dalam mengevaluasi kebutuhan klien secara komprehensif dan etis.

E. Integrasi Hak dan Kebutuhan dalam Perencanaan Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi

Integrasi antara kebutuhan kesehatan reproduksi dan hak klien merupakan inti dari pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang profesional. Pendekatan ini menuntut perencanaan layanan yang tidak hanya berbasis data klinis, tetapi juga mempertimbangkan preferensi, nilai, konteks sosial, serta perlindungan hak individu. Integrasi tersebut secara langsung mendukung CPMK-3 sebagai capaian utama, serta memperkuat CPMK-1 dalam aspek etika-legal dan CPMK-4 dalam penerapan konseling dan tindak lanjut.

1. Perencanaan Layanan Berbasis Asesmen Komprehensif

Perencanaan layanan dimulai dari asesmen komprehensif yang mencakup tiga dimensi utama:

a. Dimensi Klinis

Asesmen klinis meliputi riwayat kesehatan reproduksi, riwayat obstetri, penyakit penyerta, penggunaan obat, serta skrining kelayakan medis berdasarkan pedoman WHO Medical Eligibility Criteria (WHO, 2019)

update 2023). Evaluasi ini bertujuan memastikan keamanan metode kontrasepsi yang dipilih.

b. Dimensi Psikososial

Aspek psikososial mencakup dukungan pasangan, kondisi ekonomi, peran gender dalam keluarga, serta tingkat literasi kesehatan. Informasi ini membantu bidan memahami konteks pengambilan keputusan klien.

c. Dimensi Hak dan Preferensi

Evaluasi hak meliputi penghormatan terhadap otonomi, privasi, non-diskriminasi, dan kebebasan dari paksaan. Preferensi klien terhadap metode tertentu harus dihargai selama tidak bertentangan dengan keselamatan medis.

Pendekatan komprehensif ini mencerminkan praktik client-centered care dan memastikan bahwa rencana layanan tidak bersifat seragam, melainkan terpersonalisasi.

2. Penyusunan Rencana Layanan yang Terintegrasi

Rencana layanan KB dan kesehatan reproduksi harus memuat:

- a. Pilihan metode yang sesuai dengan kondisi medis dan preferensi klien
- b. Penjelasan risiko dan manfaat secara seimbang
- c. Rencana tindak lanjut dan jadwal kontrol
- d. Rencana penanganan efek samping atau komplikasi potensial
- e. Mekanisme rujukan bila diperlukan

Penyusunan rencana ini dilakukan melalui proses shared decision making. Keputusan akhir merupakan hasil dialog kolaboratif antara bidan dan klien. Dokumentasi rencana layanan menjadi bukti bahwa prinsip informed choice telah diterapkan.

3. Dokumentasi Profesional dalam Pelayanan Kespro

Dokumentasi merupakan bagian integral dari praktik profesional dan akuntabilitas layanan. Pencatatan harus mencakup:

- a. Hasil asesmen klinis dan sosial
- b. Informasi yang diberikan kepada klien
- c. Pilihan metode yang dipertimbangkan
- d. Persetujuan tindakan (informed consent)
- e. Rencana tindak lanjut dan edukasi lanjutan

Dokumentasi yang lengkap tidak hanya melindungi hak klien, tetapi juga melindungi tenaga kesehatan secara hukum. Undang-Undang Kesehatan terbaru menegaskan pentingnya pencatatan yang akurat,

transparan, dan dapat ditelusuri sebagai bagian dari standar mutu pelayanan.

Selain itu, pencatatan yang baik mendukung evaluasi mutu layanan dan perbaikan berkelanjutan. Data yang terdokumentasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola drop out, efek samping yang sering terjadi, serta hambatan akses yang memerlukan intervensi program.

4. Contoh Implementasi Integratif

Seorang perempuan usia 32 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta, datang untuk memilih metode kontrasepsi. Asesmen menunjukkan riwayat hipertensi ringan dan jadwal kerja yang padat. Klien menyatakan preferensi terhadap metode yang tidak memerlukan kunjungan sering.

Bidan menjelaskan bahwa kontrasepsi kombinasi kurang direkomendasikan karena risiko hipertensi. Alternatif seperti implan atau IUD dijelaskan secara objektif. Setelah diskusi, klien memilih implan karena sesuai dengan kebutuhan mobilitas dan keamanan medis.

Rencana layanan mencakup:

- a. Edukasi mengenai efek samping yang mungkin terjadi
- b. Jadwal kontrol satu bulan dan enam bulan
- c. Nomor kontak fasilitas bila terjadi keluhan
- d. Dokumentasi informed consent

Kasus ini menunjukkan integrasi antara asesmen klinis, preferensi klien, dan perlindungan hak reproduksi dalam satu rencana pelayanan yang komprehensif.

5. Tantangan dan Strategi Penguatan

Tantangan dalam integrasi hak dan kebutuhan meliputi:

- a. Perbedaan antara preferensi klien dan rekomendasi medis
- b. Keterbatasan waktu untuk asesmen mendalam
- c. Dokumentasi yang belum optimal

Strategi penguatan meliputi:

- a. Penggunaan format asesmen terstruktur berbasis checklist
- b. Pelatihan komunikasi berbasis skenario
- c. Digitalisasi pencatatan untuk meningkatkan akurasi dan keterlacakan
- d. Audit mutu layanan berbasis indikator hak klien

Subbab ini menegaskan bahwa perencanaan layanan KB dan kesehatan reproduksi bukan sekadar memilih metode kontrasepsi,

melainkan proses integratif yang menggabungkan asesmen komprehensif, penghormatan hak klien, komunikasi kolaboratif, serta dokumentasi profesional. Pendekatan ini memastikan pelayanan yang aman, bermutu, etis, dan benar-benar berpusat pada klien.

F. Aktivitas 2 — Knows How Mini-Case

Topik: Pelayanan KB Pascapersalinan: Konseling, Pemilihan Metode, dan Rencana Tindak Lanjut

Skenario Kasus (Mini-Case)

Seorang perempuan usia 28 tahun, P3A1, datang ke Posyandu untuk berkonsultasi mengenai kontrasepsi setelah persalinan 6 minggu lalu. Ibu menyusui bayi usia 1,5 bulan.

]

Hasil pengkajian awal:

1. Ibu belum menggunakan kontrasepsi pascapersalinan.
2. Ibu khawatir kontrasepsi hormonal dapat memengaruhi ASI.
3. Suami mendukung penggunaan KB tetapi ingin metode yang mudah dan tidak menyakitkan.
4. Jarak rumah ke Puskesmas ± 5 km.
5. Kader melaporkan ibu kadang melewatkan imunisasi rutin bayi.

Tugas Mahasiswa (Level Knows How)

Mahasiswa diminta untuk menjelaskan dan merencanakan (bukan melakukan tindakan langsung) terkait kasus di atas:

1. Analisis masalah kebidanan dan faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan kontrasepsi.
2. Jelaskan pendekatan konseling berbasis hak (rights-based & client-centered care).
3. Tentukan metode kontrasepsi yang aman, sesuai kondisi menyusui, dan rasional.
4. Jelaskan peran jejaring pelayanan (kader, bidan, Puskesmas).
5. Rancang rencana tindak lanjut berbasis komunitas, termasuk jadwal kontrol dan pemantauan efek samping.
6. Identifikasi potensi risiko (drop out, unmet need, efek samping).

Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	3
2	Judul	Pelayanan KB Pascapersalinan: Konseling, Pemilihan Metode, dan Rencana Tindak Lanjut
3	Kasus	Konseling KB pada ibu pasca persalinan, pemilihan metode kontrasepsi, dan penyusunan rencana tindak lanjut
4	Tujuan	Menilai kemampuan peserta memberikan pelayanan KB pasca persalinan secara komprehensif, termasuk konseling berbasis hak, pemilihan metode sesuai kondisi ibu, dan rencana tindak lanjut untuk keberlanjutan pelayanan
5	Kompetensi	1. Anamnesis pasca persalinan terkait KB 2. Identifikasi kebutuhan KB (unmet need) 3. Skrining kelayakan metode kontrasepsi 4. Pemilihan metode kontrasepsi sesuai kondisi ibu 5. Konseling berbasis hak dan shared decision making 6. Edukasi tentang efek samping dan manfaat metode 7. Perencanaan tindak lanjut dan rujukan 8. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang ibu usia 32 tahun, P2A0, datang kontrol pasca persalinan 6 minggu. Ibu belum menggunakan KB karena khawatir efek samping dan ingin segera menyusui bayi eksklusif. Suami mendukung, tetapi ibu ingin tahu metode yang aman dan sesuai kondisi menyusui. TUGAS 1. Lakukan anamnesis pasca persalinan terkait KB 2. Identifikasi masalah/kebutuhan KB 3. Lakukan skrining kelayakan penggunaan kontrasepsi 4. Tentukan pilihan metode kontrasepsi yang sesuai (misal: implant, IUD, pil, suntik) 5. Berikan konseling berbasis hak dan shared decision making 6. Jelaskan rencana tindak lanjut (kunjungan kontrol, pemantauan efek samping) 7. Jelaskan kemungkinan jejaring/rujukan bila diperlukan
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta sesuai 2. Penilaian berdasarkan checklist (0–3) dan global rating (1–4) 3. Tidak memberikan bantuan 4. Penilaian objektif INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta anamnesis → PS menjawab sesuai scenario 2. Skrining → tidak ada kontraindikasi medis

		3. Diagnosis yang diharapkan: - Ibu pasca persalinan dengan unmet need KB 4. Tindakan yang diharapkan: a. Konseling KB berbasis hak b. Menawarkan metode sesuai kondisi menyusui c. Melibatkan suami dalam shared decision making 5. Edukasi yang diharapkan: a. Meluruskan mitos efek samping b. Menjelaskan manfaat metode untuk kesehatan ibu dan bayi 6. Tindak lanjut: a. Jadwal kunjungan kontrol 1–3 bulan b. Pemantauan efek samping c. Rujukan ke fasilitas kesehatan jika terjadi komplikasi
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. Berperan sebagai ibu pasca persalinan 2. Sedikit cemas terkait metode KB dan efeknya terhadap menyusui 3. Fokus masalah: a. Takut efek samping KB b. Ingin menyusui eksklusif 4. Jika dijelaskan → mulai memahami dan terbuka untuk pilihan metode 5. Akan bertanya: “Bu, kalau pakai KB, nanti menyusui tetap aman kan?”
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi, Bu PS: Pagi, Bu Peserta: Apa yang bisa saya bantu hari ini? PS: Saya ingin KB, tapi takut efek samping dan masih ingin menyusui Peserta: Baik Bu, kita bisa diskusikan pilihan yang aman untuk ibu menyusui PS: Bagaimana kalau pil atau suntik? Peserta: Saya akan jelaskan semua pilihan, manfaat, dan efek sampingnya sehingga ibu bisa menentukan PS: Oke, Bu, saya ingin tahu lebih lanjut
10	Kebutuhan manikin	Tidak wajib (roleplay konseling)
11	Kebutuhan laboran	1. Menyiapkan ruang OSCE 2. Menyiapkan lembar penilaian 3. Mengatur alur peserta
12	Kebutuhan alat	1. Meja dan kursi 2. Lembar status pasien 3. Lembar penilaian 4. Alat tulis

		5. Leaflet KB 6. Buku panduan KIE KB
13	Penulis	(Isi sesuai penulis)
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan RI. (2023). Pedoman pelayanan kontrasepsi. Kemenkes RI. 2. World Health Organization. (2021). Family planning/contraception. WHO. 3. BKKBN. (2022). Pedoman pelayanan KB. BKKBN. 4. Saifuddin, A. B. (2020). Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi. Yayasan Bina Pustaka. 5. Rogers, C. (1961). On becoming a person. Houghton Mifflin. 6. Elwyn, G., et al. (2012). Shared decision making. Journal of General Internal Medicine, 27(10), 1361–1367. 7. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics. Oxford University Press. 8. Haggerty, J. L., et al. (2003). Continuity of care. BMJ, 327(7425), 1219–1221. 9. Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). Health program planning. McGraw-Hill.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 3: Pelayanan KB Pascapersalinan

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif (Anamnesis Pasca Persalinan)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama / kebutuhan KB (unmet need)		
2. Status menyusui dan laktasi		
3. Riwayat penggunaan kontrasepsi sebelumnya		
4. Riwayat obstetri (GPA, persalinan terakhir)		
5. Riwayat penyakit kronis / obat-obatan		
6. Faktor sosial / keluarga (dukungan pasangan, budaya, norma)		
7. Preferensi dan kekhawatiran ibu		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Melakukan semua 7 langkah dengan benar
- 2= Melakukan 4–6 langkah dengan benar
- 1= Melakukan 1–3 langkah dengan benar
- 0= Tidak melakukan

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis dan Perencanaan Layanan KB

1. Persiapan

Komponen	Skoring	Skor
a. Menyapa ibu dengan sopan		
b. Memperkenalkan diri		
c. Menjelaskan tujuan konseling KB		
d. Meminta persetujuan		
e. Menjaga privasi		
f. Hand hygiene		
g. Menyiapkan alat / lembar konseling		

2. Langkah-langkah

Komponen	Skoring	Skor
a. Menilai kondisi umum ibu		
b. Mengidentifikasi unmet need KB		
c. Melakukan skrining kelayakan KB		
d. Mengidentifikasi kontraindikasi medis		
e. Menentukan pilihan metode KB sesuai kebutuhan dan menyusui		
f. Memberikan KIE / konseling berbasis hak		
g. Melibatkan suami atau anggota keluarga sesuai kebutuhan		
h. Menyesuaikan metode dengan preferensi ibu		
i. Menjelaskan cara penggunaan dan efek samping		
j. Menjelaskan tanda bahaya / red flags		
k. Menyusun rencana tindak lanjut / follow-up		

3. Pasca Tindakan

Komponen	Skoring	Skor
a. Menyimpulkan hasil konseling		
b. Melakukan dokumentasi		
c. Merapikan alat / ruang		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Melakukan 15–20 langkah dengan tepat & sistematis
- 2= Melakukan 10–14 langkah cukup tepat
- 1= Melakukan 1–9 langkah
- 0= Tidak melakukan / tidak tepat

KOMPETENSI 3. KIE / Konseling Berbasis Hak

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan kondisi dan kebutuhan ibu		
3. Menjelaskan pilihan metode KB sesuai menyusui		
4. Menjelaskan efek samping & meluruskan mitos		
5. Memberi kesempatan bertanya		
6. Menjawab dengan jelas dan empatik		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= Semua 6 langkah benar
- 2= 4–5 langkah benar
- 1= 1–3 langkah benar
- 0= Tidak melakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sistematis		
2. Menjaga privasi		
3. Empati terhadap ibu		
4. Komunikasi jelas & tenang		
5. Percaya diri		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= 5 langkah benar
- 2= 4 langkah benar
- 1= 1–3 langkah benar
- 0= Tidak melakukan

$$\text{TOTAL SKOR} = (K1 + K2 + K3 + K4) / 3$$

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),.....

.....

Penguji :.....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Topik: Pelayanan KB Pascapersalinan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus KB Pascapersalinan
Metode penilaian	DOPS adalah metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan mahasiswa dalam praktik klinik. Penilai mengamati tindakan nyata mahasiswa, kemudian memberi umpan balik segera. Domain yang dinilai: komunikasi, informed consent, persiapan, keterampilan teknis, keselamatan pasien, profesionalisme.	Pembimbing mengamati mahasiswa saat melakukan konseling KB pascapersalinan di Puskesmas atau Posyandu, skrining kelayakan KB, membantu ibu memilih metode sesuai hak reproduksi dan kondisi menyusui, serta menyiapkan tindak lanjut dan rujukan bila diperlukan.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa memberikan pelayanan KB pascapersalinan yang aman, efektif, dan berpusat pada klien, mempertimbangkan kondisi medis, sosial, dan preferensi keluarga.	Mahasiswa dinilai dari kemampuan melakukan konseling, menjelaskan pilihan metode KB pascapersalinan, mempertimbangkan preferensi ibu dan dukungan pasangan, serta menyusun rencana tindak lanjut berbasis komunitas.
Kasus klinik	Kasus diambil dari situasi nyata atau simulasi klinik pascapersalinan, memungkinkan mahasiswa menunjukkan keterampilan klinik dan manajerial.	Seorang ibu P2A1, berusia 28 tahun, hadir di Posyandu 6 minggu pascapersalinan. Ibu ingin menunda kehamilan berikutnya, sedang menyusui, khawatir efek samping kontrasepsi hormonal, dan ingin berkonsultasi bersama suami.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Observasi dilakukan saat mahasiswa menjalankan tindakan nyata: pengkajian, konseling, skrining, pemilihan metode, edukasi, dan tindak lanjut.	Mahasiswa menyapa ibu, melakukan anamnesis riwayat reproduksi dan menyusui, menilai unmet need, melakukan skrining medis, memberikan edukasi berbasis hak, menyusun rencana kunjungan ulang, serta mendokumentasikan keputusan klien.
Aspek yang dinilai	Kemampuan melakukan anamnesis, ketepatan skrining, pemilihan metode, KIE, keselamatan pasien,	Pembimbing menilai apakah mahasiswa menghubungkan kondisi menyusui, riwayat obstetri, kondisi medis, dan

	profesionalisme, dan kemampuan menghargai keputusan klien (informed choice).	faktor keluarga dengan pilihan KB pascapersalinan, serta memberikan edukasi yang jelas dan empatik.
Fokus observasi pembimbing	Observasi performa nyata mahasiswa, termasuk sistematis, aman, efektif, serta pengambilan keputusan klinis.	Pembimbing mengamati apakah mahasiswa melakukan konseling berbasis hak, melibatkan suami bila perlu, memilih metode KB tepat sesuai menyusui, menjelaskan risiko/efek samping, dan menjaga privasi serta kepercayaan ibu.
Umpan balik	Diberikan segera setelah observasi, mencakup kelebihan dan area perbaikan, spesifik dan konstruktif.	Pembimbing memberi komentar bahwa mahasiswa baik dalam komunikasi, edukasi, dan keterlibatan keluarga, tetapi perlu lebih teliti dalam skrining kontraindikasi medis dan menyusun jadwal tindak lanjut yang jelas.
Keputusan penilaian	Dikategorikan: kompeten, perlu supervisi, atau remedial, berdasarkan ketepatan tindakan, keselamatan, komunikasi, dan pengambilan keputusan.	Mahasiswa kompeten jika mampu melakukan konseling pascapersalinan, memilih metode KB sesuai hak dan kondisi ibu, menyusun tindak lanjut, dan mendokumentasikan keputusan dengan benar. Perlu supervisi jika masih memerlukan arahan. Remedial jika salah memilih metode atau tidak melakukan skrining dengan benar.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mencapai level "does" pada taksonomi Miller. Menilai performa nyata di lapangan.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori KB pascapersalinan, tetapi mampu menerapkan pelayanan, melakukan konseling, mengambil keputusan klinis, dan mengelola tindak lanjut secara berkelanjutan.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 3.1
Portofolio pada Pelayanan KB Pascapersalinan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pelayanan KB Pascapersalinan
Hakikat portofolio	Kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.	Memuat bukti mahasiswa mampu melakukan asesmen kebutuhan KB pascapersalinan, memberikan konseling, membantu ibu memilih metode kontrasepsi aman saat menyusui, serta menyiapkan tindak lanjut dan rujukan bila diperlukan.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik lapangan.	Mahasiswa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memilih metode KB pascapersalinan sesuai kondisi medis, menyusui, dan dukungan keluarga setelah mendapatkan feedback dari CI/dosen.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan performa nyata di lapangan.	OSCE memuat hasil ujian konseling KB pascapersalinan berbasis simulasi, DOPS memuat observasi langsung saat mahasiswa melakukan skrining, edukasi, pemilihan

		metode, dan rencana tindak lanjut klien.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus klien yang ditangani mahasiswa, mencakup data penting, masalah, tindakan, dan hasil.	Mahasiswa menuliskan kasus ibu P2A1, 6 minggu pascapersalinan, yang ingin menunda kehamilan. Mencatat kekhawatiran terkait efek KB, dukungan pasangan, metode KB yang dipilih, dan rencana tindak lanjut monitoring.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien dan mencegah kesalahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya konseling yang jelas, memperhatikan kontraindikasi saat ibu menyusui, dan memastikan ibu memahami efek samping metode KB.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari CI/dosen sebagai bukti pembinaan, menunjukkan kekuatan dan area perlu ditingkatkan.	CI menilai mahasiswa baik dalam komunikasi, edukasi, dan keterlibatan pasangan, tetapi perlu meningkatkan keterampilan menjelaskan metode yang aman saat menyusui.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi bukti yang dikembangkan berulang dan berkesinambungan dengan fokus pada konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa interaksi pelayanan KB pascapersalinan di komunitas, bukan hanya satu kasus, sehingga terlihat konsistensi kemampuan konseling dan monitoring.
Bukti konsistensi kompetensi	Memperlihatkan kemampuan mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan feedback terlihat mahasiswa konsisten mampu memberikan pelayanan KB pascapersalinan yang aman dan berbasis hak klien.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran	Mahasiswa menunjukkan penerapan teori KB

	terlihat dalam performa nyata yang berulang dan berkembang.	pascapersalinan secara konsisten, adaptif terhadap kondisi menyusui, sosial, dan dukungan keluarga.
--	---	---

Tabel 3.2
Case Report pada Pelayanan KB Pascapersalinan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pelayanan KB Pascapersalinan
Hakikat case report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus klien yang ditangani mahasiswa di klinik atau komunitas.	Mahasiswa menyusun laporan tentang ibu P2A1, 6 minggu pascapersalinan, yang ingin menunda kehamilan, termasuk pertimbangan medis, menyusui, dan dukungan pasangan.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengintegrasikan data, analisis masalah, tindakan, dan evaluasi.	Mahasiswa menjelaskan alasan pemilihan metode KB aman untuk ibu menyusui, strategi edukasi klien dan keluarga, serta rencana tindak lanjut monitoring.
Isi laporan	Identitas klien, data subjektif dan objektif, analisis, diagnosis, tindakan, evaluasi.	Data: ibu P2A1, menyusui, ingin menunda kehamilan, khawatir efek samping → analisis → metode KB progestin dipilih → edukasi → rencana tindak lanjut monitoring.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, analisis, dan keputusan klinis.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa memilih metode KB yang sesuai kondisi ibu menyusui, logis secara klinis, dan mempertimbangkan dukungan pasangan.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi.	Mahasiswa belajar bahwa pelayanan KB pascapersalinan harus berbasis bukti, kondisi menyusui, dan komunikasi efektif dengan klien.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori ke praktik nyata.	Mahasiswa mampu menerapkan teori KB pascapersalinan secara sistematis, aman, dan adaptif terhadap konteks lokal.

Tabel 3.3
Refleksi Patient Safety pada Pelayanan KB Pascapersalinan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pelayanan KB Pascapersalinan
Hakikat refleksi	Tulisan yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko dan mencegah kesalahan klinis atau sosial.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memastikan metode KB aman bagi ibu menyusui, mengantisipasi efek samping, dan menyesuaikan edukasi dengan kondisi ibu dan keluarga.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran keselamatan pasien/klien dalam praktik kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa salah konseling atau pemilihan KB dapat menimbulkan risiko kesehatan dan sosial bagi ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.	Risiko: pemahaman ibu rendah, efek samping metode KB, resistensi pasangan → Pencegahan: komunikasi jelas, edukasi berulang, monitoring pasca pemberian KB.
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang membahayakan klien atau komunitas.	Efek samping KB tidak diketahui, salah pilih metode, mitos/kepercayaan yang menghalangi kepatuhan.
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko.	Edukasi berulang, skrining medis, konseling pasangan, pemantauan penggunaan KB pascapersalinan.
Pembelajaran mahasiswa	Apa yang dipelajari dan perbaikan ke depan.	Mahasiswa belajar pentingnya komunikasi efektif, adaptasi kondisi menyusui, keterlibatan keluarga, dan konsistensi monitoring KB pascapersalinan.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis.	Mahasiswa mampu meningkatkan kualitas pelayanan KB pascapersalinan secara aman, berbasis hak, dan berkelanjutan.

G. Rangkuman Materi

1. Kesehatan reproduksi mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta hak individu dalam pengambilan keputusan.
2. Pendekatan life course menegaskan bahwa kebutuhan kesehatan reproduksi berubah sesuai tahap kehidupan.
3. Hak kesehatan reproduksi meliputi hak atas informasi, akses layanan aman, privasi, non-diskriminasi, dan kebebasan dari paksaan.
4. Regulasi nasional Indonesia memperkuat perlindungan hak klien melalui prinsip informed consent dan keselamatan pasien.
5. Client-centered care menempatkan klien sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan melalui komunikasi empatik dan dialog kolaboratif.
6. Determinan sosial kesehatan memengaruhi akses terhadap layanan KB dan kespro, sehingga pendekatan equity diperlukan.
7. Perencanaan layanan harus berbasis asesmen komprehensif yang mencakup aspek klinis, psikososial, dan preferensi klien.
8. Dokumentasi profesional menjadi bagian penting akuntabilitas dan mutu pelayanan.
9. Integrasi kebutuhan dan hak klien memastikan pelayanan KB dan kespro berlangsung etis, aman, dan berpusat pada klien.

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Pelayanan KB Pascapersalinan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perdarahan pervaginam banyak atau berkepanjangan setelah pemasangan atau penggunaan kontrasepsi	Kemungkinan efek samping berat atau gangguan hormonal, termasuk masalah pascapersalinan	Lapor ke pembimbing/dokter, evaluasi kondisi umum ibu, pertimbangkan penghentian metode dan rujukan
Tidak haid disertai tanda kehamilan (mual, payudara tegang)	Kemungkinan kegagalan kontrasepsi atau kehamilan pascapersalinan	Lakukan tes kehamilan, hentikan kontrasepsi sementara, rujuk untuk evaluasi
Nyeri hebat pada perut bawah	Dapat mengarah pada komplikasi pascapersalinan, kehamilan ektopik, atau efek samping kontrasepsi	Segera evaluasi, lakukan rujukan emergensi
Tanda infeksi pada alat kontrasepsi (misal implan, IUD)	Infeksi lokal akibat prosedur atau kondisi pascapersalinan	Lapor ke petugas kesehatan, lakukan perawatan sesuai SOP, pertimbangkan rujukan jika berat
Sakit kepala berat atau gangguan penglihatan	Efek samping serius kontrasepsi hormonal atau kondisi neurologis	Hentikan sementara kontrasepsi, evaluasi medis segera
Peningkatan berat badan yang signifikan dan cepat	Efek samping hormonal atau faktor pascapersalinan lain	Edukasi pola hidup, evaluasi penyebab, pertimbangkan ganti metode KB sesuai kebutuhan
Klien tidak patuh penggunaan kontrasepsi (lupa pil, terlambat suntik)	Risiko kegagalan kontrasepsi meningkat	Edukasi ulang, pilih metode yang lebih sesuai (misal implan atau suntik), lakukan konseling tambahan
Klien ingin menghentikan kontrasepsi karena efek samping atau mitos	Risiko drop out KB pascapersalinan	Konseling ulang, tawarkan alternatif metode, lakukan informed choice dan follow-up
Ditemukan kontraindikasi baru selama penggunaan KB	Risiko keselamatan ibu atau bayi	Hentikan metode, lakukan evaluasi medis, rujuk ke fasilitas kesehatan jika diperlukan
Reaksi alergi atau hipersensitivitas setelah suntikan KB	Efek samping serius yang memerlukan perhatian segera	Hentikan prosedur, berikan pertolongan awal, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab : Pelayanan KB Pascapersalinan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Lapangan Komunitas : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan pelayanan KB pascapersalinan	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan asesmen kebutuhan KB ibu pascapersalinan (usia subur, kependudukan, preferensi)	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menanyakan riwayat persalinan dan penggunaan kontrasepsi sebelumnya	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menanyakan status menyusui dan kondisi pascapersalinan	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menanyakan riwayat penyakit kronis atau obat yang sedang digunakan	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menanyakan preferensi dan kekhawatiran ibu terkait KB	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa melakukan skrining kelayakan metode KB hormonal dan non-hormonal pascapersalinan	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengidentifikasi kontraindikasi penggunaan metode KB tertentu	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menentukan metode KB yang sesuai kondisi dan preferensi ibu pascapersalinan	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa memberikan edukasi mengenai cara kerja, penggunaan, kelebihan, dan kekurangan metode KB	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjelaskan efek samping yang mungkin terjadi dan langkah pencegahannya	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya/red flags yang memerlukan evaluasi atau rujukan	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menyesuaikan metode KB dan edukasi sesuai kondisi medis, sosial, budaya, dan preferensi ibu	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menyusun rencana tindak lanjut dan monitoring penggunaan KB pascapersalinan	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa mendokumentasikan jenis KB, edukasi, dan rencana tindak lanjut secara ringkas dan jelas	☐	☐	_____

16	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama pelayanan KB pascapersalinan	☐	☐	☐
----	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

I. Referensi

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). Laporan kinerja Program Bangga Kencana tahun 2023. BKKBN.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics (8th ed.). Oxford University Press.
- Elwyn, G., Durand, M. A., Song, J., Aarts, J., Barr, P. J., Berger, Z., ... Van der Weijden, T. (2020). A three-talk model for shared decision making: Multistage consultation process. *BMJ*, 359, j4891. <https://doi.org/10.1136/bmj.j4891>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan. Kementerian Kesehatan RI.
- United Nations Population Fund. (2021). State of world population 2021. UNFPA.
- World Health Organization. (2019). Medical eligibility criteria for contraceptive use (5th ed., update 2023). WHO.
- World Health Organization. (2021). WHO consolidated guideline on self-care interventions for health. WHO.
- World Health Organization. (2022). Family planning: A global handbook for providers (3rd ed.). WHO.

BAB 4

KONSELING KB YANG EFEKTIF: KOMUNIKASI, INFORMED CHOICE, DAN SKRINING KELAYAKAN METODE

Capaian Pembelajaran

Bab ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam menganalisis, merancang, dan melaksanakan konseling keluarga berencana (KB) yang efektif, berbasis bukti, serta berorientasi pada keselamatan dan hak klien. Kompetensi ini mencakup kemampuan komunikasi terapeutik, penerapan informed choice, serta skrining kelayakan metode kontrasepsi secara tepat.

Pendahuluan

Pelayanan keluarga berencana merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga. Konseling KB menjadi komponen kunci dalam memastikan bahwa setiap individu atau pasangan mampu mengambil keputusan reproduksi secara sadar dan bertanggung jawab. Konseling yang berkualitas terbukti meningkatkan kepuasan klien, keberlanjutan penggunaan kontrasepsi, serta menurunkan angka kehamilan tidak direncanakan (Upadhyay et al., 2020; Tumlinson et al., 2018).

Dalam praktiknya, konseling KB tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga melibatkan aspek komunikasi, etik, psikologis, serta pertimbangan klinis berbasis kondisi kesehatan klien. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dituntut memiliki kompetensi komprehensif agar mampu memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada klien (WHO, 2022).

A. Konseling KB Sebagai Prosedur Klinis

1. Definisi

Konseling keluarga berencana adalah proses komunikasi terapeutik yang sistematis antara tenaga kesehatan dan klien untuk membantu klien memahami pilihan metode kontrasepsi, mempertimbangkan manfaat dan risiko, serta membuat keputusan secara sukarela sesuai kebutuhan dan kondisi individu (WHO, 2022).

Pendekatan ini menempatkan klien sebagai pusat pelayanan (client-centered care), di mana tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan utama. Hal ini sejalan dengan konsep contraceptive autonomy, yaitu hak individu untuk menentukan pilihan reproduksi tanpa tekanan atau paksaan (Senderowicz, 2020).

2. Tujuan Konseling KB

Konseling KB memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- a. Memberikan informasi yang akurat dan berbasis bukti terkait metode kontrasepsi (WHO, 2018)
- b. Membantu klien memahami kondisi kesehatan reproduksi dan risikonya
- c. Mendukung pengambilan keputusan secara mandiri (informed choice)
- d. Meningkatkan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi (continuation rate) (Upadhyay et al., 2020)
- e. Mencegah komplikasi melalui skrining kelayakan medis (WHO, 2015)

Dengan demikian, konseling KB tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas program kesehatan masyarakat secara luas.

3. Indikasi Konseling KB

Konseling KB diperlukan pada berbagai kondisi, antara lain:

- a. Pasangan usia subur yang ingin merencanakan kehamilan
- b. Ibu pasca persalinan atau pasca keguguran
- c. Klien dengan riwayat efek samping kontrasepsi
- d. Klien dengan penyakit kronis (misalnya hipertensi atau diabetes)
- e. Remaja yang membutuhkan edukasi kesehatan reproduksi

Pemberian konseling pada kelompok tersebut terbukti meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern dan mengurangi angka drop-out (Barden-O'Fallon et al., 2018).

4. Kontraindikasi

Secara umum, tidak terdapat kontraindikasi absolut dalam konseling KB. Namun, terdapat kondisi yang memerlukan penyesuaian pendekatan, seperti:

- a. Kondisi gawat darurat medis
- b. Gangguan komunikasi
- c. Gangguan psikologis berat

Dalam kondisi tersebut, konseling tetap dapat dilakukan dengan pendekatan adaptif dan melibatkan keluarga atau pendamping (WHO, 2022).

5. Alat dan Media

Penggunaan media edukasi dalam konseling terbukti meningkatkan pemahaman dan retensi informasi pada klien (Holt et al., 2020). Alat yang digunakan meliputi:

- a. Leaflet atau booklet kontrasepsi
- b. Flipchart edukasi
- c. Model alat kontrasepsi
- d. Formulir skrining kelayakan (MEC WHO)
- e. Rekam medis

Media visual sangat membantu dalam menjelaskan konsep yang kompleks, terutama pada klien dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah.

6. Persiapan Konseling

Persiapan yang baik akan menentukan keberhasilan konseling.

a. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi klinis dan komunikasi yang baik. Sikap empatik dan non-judgmental sangat penting untuk membangun kepercayaan klien (Kim et al., 2018).

b. Lingkungan

Lingkungan harus menjamin privasi, kenyamanan, dan keamanan sehingga klien merasa bebas menyampaikan informasi pribadi.

c. Klien

Klien perlu dipersiapkan dengan memberikan penjelasan awal mengenai tujuan dan alur konseling.

7. Langkah-Langkah Konseling KB

a. Membangun Hubungan (Rapport Building)

Tahap ini bertujuan menciptakan hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan klien. Hubungan yang baik akan meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan klien (Dehingia et al., 2020).

b. Pengkajian Kebutuhan

Pengkajian dilakukan secara komprehensif meliputi aspek medis, sosial, dan psikologis. Teknik active listening sangat penting dalam tahap ini untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat (Holt et al., 2020).

c. Penyampaian Informasi

Informasi harus diberikan secara lengkap dan seimbang tanpa bias terhadap metode tertentu. Penyampaian yang jelas dan sederhana meningkatkan pemahaman klien (WHO, 2018).

d. Skrining Kelayakan Medis

Skrining menggunakan Medical Eligibility Criteria (MEC) untuk menentukan keamanan metode kontrasepsi. Penggunaan MEC terbukti menurunkan risiko komplikasi (WHO, 2015).

e. Fasilitasi Informed Choice

Informed choice merupakan prinsip utama dalam konseling KB. Klien harus diberikan kebebasan untuk memilih metode berdasarkan informasi yang diberikan (Senderowicz, 2020).

f. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut penting untuk memastikan keberhasilan penggunaan kontrasepsi. Edukasi mengenai efek samping dan tanda bahaya sangat diperlukan (WHO, 2022).

8. Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan KB. Kesalahan dalam pemilihan metode kontrasepsi dapat menyebabkan komplikasi serius (Rosenberg et al., 2019).

Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memastikan:

- a. Skrining dilakukan secara tepat
- b. Informasi yang diberikan akurat
- c. Tidak ada paksaan dalam pengambilan keputusan

9. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas konseling. Metode teach-back dianjurkan untuk menilai pemahaman klien (Holt et al., 2020).

10. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki fungsi klinis dan legal. Catatan yang lengkap akan mendukung continuity of care dan perlindungan hukum tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2020).

B. Mini Case

Kasus:

Ny. B, 35 tahun, memiliki 3 anak, perokok aktif, dengan hipertensi ringan.

Pembahasan:

Pada kasus ini, penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi perlu dihindari karena meningkatkan risiko kardiovaskular pada perokok dengan hipertensi (WHO, 2015). Metode yang lebih aman adalah IUD atau metode non-hormonal.

C. OSCE Konseling KB

OSCE merupakan metode penilaian keterampilan klinis yang objektif dan terstandar.

Penilaian mencakup:

1. Komunikasi terapeutik
2. Ketepatan skrining
3. Keselamatan pasien
4. Pengambilan keputusan klinis

Mahasiswa harus menunjukkan kemampuan secara menyeluruh sesuai standar praktik (Miller, 1990).

DOPS

DOPS digunakan untuk menilai keterampilan di praktik nyata melalui observasi langsung. Metode ini efektif dalam meningkatkan kompetensi klinis karena disertai umpan balik segera (Kim et al., 2018).

Portofolio

Portofolio merupakan bukti pencapaian kompetensi secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan refleksi diri dan pembelajaran sepanjang hayat.

D. Ringkasan BAB

Konseling KB merupakan proses kompleks yang melibatkan komunikasi, pengetahuan klinis, serta pertimbangan etik. Pendekatan yang berpusat pada klien terbukti meningkatkan kualitas pelayanan dan keberhasilan program KB (Upadhyay et al., 2020).

E. Red Flags

Beberapa kondisi yang memerlukan perhatian khusus:

1. Hipertensi berat
2. Perdarahan abnormal
3. Nyeri hebat

4. Riwayat kanker payudara

Identifikasi dini kondisi tersebut sangat penting untuk mencegah komplikasi (WHO, 2015).

Checklist Klinis

Checklist digunakan sebagai panduan standar untuk memastikan setiap langkah konseling dilakukan secara sistematis dan aman.

F. Referensi

- Ali, M., Akin, A., Bahamondes, L., et al. (2019). Extended effectiveness of the etonogestrel-releasing contraceptive implant. *Global Health: Science and Practice*, 7(2), 205–213.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Pedoman pelayanan keluarga berencana*. Jakarta: BKKBN.
- Barden-O’Fallon, J., Speizer, I. S., Calhoun, L. M., & Corroon, M. (2018). Women’s contraceptive discontinuation and switching behavior in urban Senegal. *BMC Women’s Health*, 18(1), 35.
- Dehingia, N., Dixit, A., & Atmavilas, Y. (2020). Role of counseling in modern contraceptive use. *Studies in Family Planning*, 51(3), 235–249.
- Holt, K., Zavala, I., & Quintero, X. (2020). Women’s preferences for contraceptive counseling. *Patient Education and Counseling*, 103(5), 1057–1063.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kim, Y. M., Davila, C., Tellez, C., & Kols, A. (2018). Evaluation of the quality of family planning counseling. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 140(S1), 10–15.
- Rosenberg, M. J., Waugh, M. S., & Long, S. (2019). Unintended pregnancy and contraceptive use. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 220(2), 117–124.
- Senderowicz, L. (2020). Contraceptive autonomy: Conceptualizing a key dimension of reproductive health. *Studies in Family Planning*, 51(2), 161–176.
- Solo, J., & Festin, M. (2019). Provider bias in family planning services. *Global Health: Science and Practice*, 7(3), 371–385.
- Tumlinson, K., Pence, B. W., Curtis, S. L., et al. (2018). Quality of care and contraceptive continuation. *Social Science & Medicine*, 204, 38–45.
- Upadhyay, U. D., et al. (2020). Association between contraceptive counseling and method continuation. *The Lancet Global Health*, 8(2), e243–e251.

- World Health Organization. (2015). Medical eligibility criteria for contraceptive use (5th ed.). Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2018). Ensuring human rights in the provision of contraceptive information and services. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2022). Family planning: A global handbook for providers (3rd ed.). Geneva: WHO.

BAB 5

METODE KONTRASEPSI ALAMIAH DAN BARIER: INDIKASI, CARA PAKAI, DAN KELEBIHAN–KETERBATASAN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan regulasi dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.	CPMK-1, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi berpusat pada klien/keluarga untuk mendukung pengambilan keputusan kontrasepsi.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan, pencegahan infeksi, serta perlindungan privasi dan kerahasiaan dalam layanan KB/kespro.	CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-4	Menganalisis data klinis dan konteks klien untuk pengambilan keputusan berbasis bukti terkait pemilihan dan tindak lanjut kontrasepsi.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan layanan KB dan tindak lanjut secara aman, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan klien (metode, edukasi, pemantauan).	CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6
CPL-6	Mengelola layanan KB/kespro melalui pencatatan-pelaporan, logistik, rujukan, evaluasi mutu, dan perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7, CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep, tujuan, kebijakan, serta aspek etika–legal keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi sistem reproduksi dan regulasi fertilitas sebagai dasar pemilihan metode kontrasepsi.
CPMK-3	Mengevaluasi kebutuhan, preferensi, dan hak kesehatan reproduksi klien dengan pendekatan berpusat pada klien.
CPMK-4	Merancang dan menerapkan konseling KB efektif (komunikasi, informed choice, skrining kelayakan) serta rencana tindak lanjut.
CPMK-5	Menentukan pilihan metode kontrasepsi yang tepat dan menyusun edukasi penggunaan sesuai kelayakan, kondisi, dan bukti.
CPMK-6	Menangani efek samping/komplikasi KB, menetapkan tindakan awal, serta menentukan kebutuhan rujukan secara aman.
CPMK-7	Mengelola pelayanan KB/kespro (IMS/HIV, logistik, pencatatan–pelaporan, mutu, keselamatan, evaluasi kepuasan) berbasis data.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam Pelayanan Kebidanan	1.1 Menganalisis tujuan, manfaat, dan indikator keberhasilan KB/kespro dalam pelayanan	1.2 Menjelaskan kerangka regulasi, etika, dan isu sosial–budaya dalam layanan KB	CPMK-1	CPMK-3; CPMK-7
Bab 2. Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi serta Dasar Regulasi Fertilitas	2.1 Menguraikan anatomi–fisiologi reproduksi dan siklus hormonal	2.2 Menjelaskan regulasi fertilitas dan titik intervensi kontrasepsi	CPMK-2	CPMK-5
Bab 3. Kebutuhan dan Hak Kesehatan Reproduksi: Pendekatan Berpusat pada Klien	3.1 Mengidentifikasi kebutuhan kespro sepanjang daur kehidupan dan faktor penentu akses	3.2 Menerapkan prinsip hak reproduksi pada skenario layanan (autonomi, kerahasiaan, non-diskriminasi)	CPMK-3	CPMK-1; CPMK-4

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Konseling KB yang Efektif: Komunikasi, Informed Choice, dan Skrining Kelayakan Metode	4.1 Mempraktikkan komunikasi terapeutik dan alur konseling terstruktur untuk menggali kebutuhan	4.2 Melakukan informed choice, skrining kelayakan, dan menyusun rencana tindak lanjut	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-2
Bab 5. Metode Kontrasepsi Alamiah dan Barrier: Indikasi, Cara Pakai, dan Kelebihan–Keterbatasan	5.1 Menjelaskan indikasi, cara pakai, efektivitas, dan keterbatasan metode alamiah/barrier	5.2 Menyusun edukasi penggunaan yang benar dan strategi peningkatan kepatuhan serta pencegahan IMS	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-2
Bab 6. Kontrasepsi Hormonal Kombinasi: Pil, Patch/Cincin, Jadwal, dan Penatalaksanaan Keluhan	6.1 Memilih kontrasepsi kombinasi sesuai kelayakan, kontraindikasi, dan interaksi	6.2 Menyusun jadwal penggunaan, tata laksana lupa pakai, dan manajemen keluhan umum	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-4
Bab 7. Kontrasepsi Progestin Saja: Suntik, Pil, dan Implan serta Tatalaksana Efek Samping	7.1 Menentukan pilihan progestin saja berdasarkan kondisi klinis dan preferensi	7.2 Merencanakan pemantauan dan tatalaksana efek samping khas progestin serta kriteria rujukan	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-4
Bab 8. Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD): Seleksi Klien, Prosedur, dan Pencegahan Komplikasi	8.1 Melakukan seleksi klien dan persiapan tindakan AKDR/IUD berbasis keselamatan	8.2 Mengidentifikasi risiko komplikasi, pencegahan, dan tindak lanjut pascatindakan	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-4
Bab 9. Kontrasepsi Pascapersalinan dan Pasca Keguguran: Waktu Pemberian, Laktasi, dan Tindak Lanjut	9.1 Menentukan waktu pemberian kontrasepsi pascapersalinan/pasca keguguran dengan mempertimbangkan laktasi dan risiko	9.2 Menyusun rencana konseling, pemilihan metode, dan follow-up pada periode pasca peristiwa obstetri	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-3; CPMK-6

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 10. Penanganan Efek Samping dan Komplikasi KB: Perdarahan Tidak Teratur, Nyeri, dan Tanda Bahaya	10.1 Membedakan efek samping umum dengan tanda bahaya/komplikasi pada akseptor KB	10.2 Menyusun algoritme penanganan awal, edukasi, dan rujukan pada keluhan prioritas	CPMK-6	CPMK-5; CPMK-4
Bab 11. Kontrasepsi pada Kondisi Khusus: Remaja, Perimenopause, Penyakit Kronis, dan Risiko Tinggi	11.1 Menyesuaikan pilihan kontrasepsi pada kondisi khusus berbasis kelayakan dan risiko	11.2 Merancang konseling dan mitigasi risiko untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-2; CPMK-6
Bab 12. Pencegahan IMS/HIV dalam Pelayanan KB: Skrining Risiko, Edukasi, dan Rujukan	12.1 Melakukan skrining risiko IMS/HIV dan edukasi pencegahan dalam layanan KB	12.2 Menyusun alur rujukan/tes dan kolaborasi layanan sesuai kebijakan setempat	CPMK-7	CPMK-3; CPMK-4
Bab 13. Manajemen Pelayanan KB: Logistik, Pencatatan-Pelaporan, Mutu, dan Keselamatan	13.1 Merancang sistem logistik kontrasepsi (perencanaan, penyimpanan, ketersediaan)	13.2 Menyusun pencatatan-pelaporan, audit mutu, dan penerapan keselamatan layanan	CPMK-7	CPMK-1
Bab 14. Dokumentasi dan Tindak Lanjut KB: Kartu Akseptor, Jadwal Kontrol, dan Evaluasi Kepuasan	14.1 Menghasilkan dokumentasi KB lengkap sesuai standar dan kebutuhan tindak lanjut	14.2 Melakukan evaluasi tindak lanjut dan kepuasan klien serta rencana perbaikan layanan	CPMK-7	CPMK-4; CPMK-3

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Kuis + ujian esai berbasis kasus	Akurasi konsep/istilah; ketepatan argumentasi etika–legal pada kasus	10	Lembar jawaban kuis/ujian; ringkasan analisis kasus
CPMK-2	Ujian tertulis (MCQ/SAQ) + concept map	Ketepatan anatomi–fisiologi; ketepatan mengaitkan regulasi fertilitas dengan titik kerja kontrasepsi	10	Lembar ujian; concept map
CPMK-3	Studi kasus terstruktur + refleksi tertulis	Kelengkapan identifikasi kebutuhan & hambatan akses; konsistensi rencana layanan dengan prinsip hak klien	10	Laporan studi kasus; refleksi
CPMK-4	OSCE/role play konseling + checklist	Skor komunikasi & struktur konseling; kelengkapan informed choice dan skrining kelayakan; rencana tindak lanjut jelas	20	Checklist OSCE; catatan umpan balik
CPMK-5	Ujian kasus klinis terintegrasi + tugas rencana pemilihan metode	Ketepatan pemilihan metode sesuai data klien; kualitas edukasi cara pakai; rencana kontrol dan pencegahan risiko	25	Jawaban kasus; rencana pemilihan metode (format terstruktur)
CPMK-6	Simulasi tatalaksana + ujian berbasis algoritme	Ketepatan membedakan keluhan vs tanda bahaya; ketepatan langkah penanganan awal; ketepatan keputusan rujukan	15	Lembar skenario & jawaban; checklist simulasi
CPMK-7	Proyek manajemen layanan + presentasi + audit dokumen	Kelengkapan desain alur layanan & logistik; akurasi pencatatan–pelaporan; usulan perbaikan mutu dan integrasi IMS/HIV	10	Proposal/proyek; hasil audit; slide presentasi

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)**Rubrik CPMK-1**

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep dan terminologi KB/kespro	Banyak konsep keliru; istilah tidak tepat	Konsep dasar benar namun masih ada kekeliruan penting	Konsep tepat dan konsisten; kekeliruan minor	Konsep sangat tepat, runtut, dan kaya keterkaitan
1.2 Argumentasi etika–legal pada kasus layanan	Tidak merujuk prinsip etika/regulasi; solusi tidak dapat dipertanggungjawabkan	Menyebut prinsip/regulasi namun penerapan belum konsisten	Menerapkan prinsip/regulasi dengan alasan yang logis	Analisis komprehensif; mempertimbangan risiko, hak, dan konteks secara seimbang

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi anatomi–fisiologi dan siklus hormonal	Banyak bagian/mekanisme salah	Benar sebagian; masih ada kekeliruan mekanisme kunci	Benar dan cukup lengkap; penjelasan runtut	Sangat akurat, lengkap, dan mampu menjelaskan implikasi klinis
2.2 Keterkaitan regulasi fertilitas dengan mekanisme kerja kontrasepsi	Tidak mampu mengaitkan	Mengaitkan secara umum tanpa ketepatan titik intervensi	Mengaitkan tepat pada sebagian besar titik intervensi	Mengaitkan sangat tepat dan mampu membandingkan antar-metode dengan alasan ilmiah

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan asesmen kebutuhan, preferensi, dan konteks	Data penting terlewat; asesmen tidak terstruktur	Asesmen dasar ada namun belum menyeluruh	Asesmen lengkap dan terstruktur; mempertimbangkan konteks	Asesmen sangat komprehensif; menangkap faktor sensitif (kerentanan/akses) secara tepat
3.2 Penerapan prinsip hak klien dalam rencana layanan	Mengabaikan hak klien/kerahasiaan	Menyebut hak klien namun belum konsisten dalam rencana	Hak klien terjaga; pilihan klien dihormati	Hak klien menjadi dasar keputusan; inklusif, tidak menghakimi, dan menjaga privasi secara optimal

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Komunikasi terapeutik dan alur konseling terstruktur	Komunikasi tidak empatik; alur tidak jelas	Komunikasi cukup; alur sebagian terikuti	Komunikasi empatik; alur konseling jelas dan efektif	Komunikasi sangat efektif; adaptif, responsif, dan memfasilitasi partisipasi aktif klien
4.2 Informed choice, skrining kelayakan, dan rencana tindak lanjut	Informasi tidak seimbang; skrining/tindak lanjut tidak memadai	Informasi cukup; skrining/tindak lanjut masih ada celah	Informasi seimbang; skrining tepat; tindak lanjut jelas	Informed choice sangat kuat; skrining sangat tepat; tindak lanjut terpersonalisasi dan aman

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan pemilihan metode sesuai data klinis dan preferensi	Pilihan tidak sesuai kondisi/risiko; mengabaikan preferensi	Pilihan cukup sesuai namun belum optimal	Pilihan tepat sesuai kondisi dan preferensi	Pilihan sangat tepat; mempertimbangkan alternatif, risiko, dan keberterimaan secara komprehensif
5.2 Kualitas edukasi penggunaan dan rencana kontrol	Edukasi tidak jelas; kontrol tidak terencana	Edukasi dasar ada; kontrol masih umum	Edukasi jelas; kontrol dan pencegahan risiko terencana	Edukasi sangat jelas dan memberdayakan; kontrol terukur; strategi kepatuhan dan pencegahan risiko sangat kuat

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi efek samping/komplikasi dan tanda bahaya	Salah mengklasifikasi; tanda bahaya terlewat	Mengidentifikasi sebagian; masih ragu pada prioritas	Mengidentifikasi tepat dan memprioritaskan masalah	Identifikasi sangat tepat, cepat, dan berbasis indikator klinis yang kuat
6.2 Ketepatan penanganan awal dan keputusan rujukan	Tindakan tidak aman; rujukan tidak tepat	Tindakan dasar ada; rujukan belum konsisten	Tindakan aman; rujukan tepat sesuai kebutuhan	Tindakan sangat aman dan sistematis; rujukan tepat dengan komunikasi risiko dan tindak lanjut yang jelas

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan dan akurasi pencatatan-pelaporan/logistik	Banyak data hilang; tidak dapat ditelusuri	Cukup lengkap namun masih ada kesalahan/ketidakkonsistenan	Lengkap, akurat, dan dapat ditelusuri	Sangat lengkap, akurat, konsisten; mendukung pengambilan keputusan layanan
7.2 Perencanaan mutu layanan dan integrasi IMS/HIV serta kepuasan	Tidak ada indikator/perbaikan; integrasi tidak jelas	Ada rencana umum; indikator operasional	Rencana jelas; indikator operasional; integrasi dan evaluasi berjalan	Rencana komprehensif berbasis data; indikator kuat; integrasi rujukan efektif; evaluasi kepuasan menghasilkan perbaikan nyata

Uraian materi

A. Konsep Dasar Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan menghambat pertemuan sperma dan ovum atau mencegah implantasi hasil pembuahan .

Metode kontrasepsi secara umum dibagi menjadi:

1. Metode alamiah (tanpa alat)
2. Metode barrier/mekanik (dengan alat)
3. Metode hormonal dan lainnya

B. Metode Kontrasepsi Alamiah

1. Pengertian

Metode kontrasepsi alamiah adalah metode pencegahan kehamilan tanpa alat atau obat, dengan memanfaatkan pemahaman terhadap siklus reproduksi wanita .

2. Jenis Metode Alamiah

- a. Metode kalender (pantang berkala)
- b. Metode suhu basal tubuh
- c. Metode lendir serviks
- d. Metode symptothermal
- e. Metode amenore laktasi (MAL)
- f. Coitus interruptus

3. Indikasi

- a. Pasangan yang menghindari kontrasepsi hormonal/alat
- b. Keyakinan agama atau budaya tertentu
- c. Wanita dengan kontraindikasi terhadap hormon
- d. Masa menyusui (khusus MAL)

4. Cara Pakai

- a. Kondom
 - 1) Dipasang pada penis sebelum penetrasi
 - 2) Digunakan satu kali pakai
 - 3) Dilepas setelah ejakulasi
- b. Diafragma
 - 1) Dimasukkan ke dalam vagina sebelum hubungan
 - 2) Menutup serviks
- c. Spermisida
Dioleskan ke dalam vagina sebelum hubungan seksual

5. Kelebihan
 - a. Tidak ada efek samping hormonal
 - b. Biaya murah/tanpa biaya
 - c. Meningkatkan pemahaman reproduksi pasangan
 - d. Tidak memerlukan alat medis
6. Keterbatasan
 - a. Efektivitas lebih rendah dibanding metode modern
 - b. Membutuhkan kedisiplinan tinggi
 - c. Tidak melindungi dari IMS
 - d. Bergantung pada keteraturan siklus menstruasi

C. Metode Kontrasepsi Barrier

1. Pengertian

Metode kontrasepsi barrier adalah metode yang menggunakan alat untuk menghalangi sperma masuk ke dalam rahim
2. Jenis
 - a. Kondom pria/wanita
 - b. Diafragma
 - c. Spermisida (kimia)
3. Indikasi
 - a. Pasangan yang membutuhkan perlindungan dari IMS
 - b. Kontrasepsi sementara
 - c. Alternatif bagi yang tidak cocok dengan hormon
 - d. Hubungan seksual tidak teratur
4. Cara Pakai
 - a. Kondom
 - 1) Dipasang pada penis sebelum penetrasi
 - 2) Digunakan satu kali pakai
 - 3) Dilepas setelah ejakulasi
 - b. Diafragma
 - 1) Dimasukkan ke dalam vagina sebelum hubungan
 - 2) Menutup serviks
 - c. Spermisida

Dioleskan ke dalam vagina sebelum hubungan seksual
5. Kelebihan
 - a. Melindungi dari IMS (terutama kondom)
 - b. Mudah digunakan
 - c. Tidak mempengaruhi hormon

- d. Dapat digunakan sesuai kebutuhan
- 6. Keterbatasan
 - a. Efektivitas tergantung cara penggunaan
 - b. Harus digunakan setiap kali hubungan
 - c. Risiko alergi (lateks/spermisida)
 - d. Bisa mengganggu spontanitas seksual
- 7. Perbandingan Singkat

Aspek	Alamiah	Barier
Alat	Tidak	Ya
Efektivitas	Lebih rendah	Sedang
Efek samping	Tidak ada	Minimal
Perlindungan IMS	Tidak	Ya (kondom)
Kedisiplinan	Tinggi	Sedang

D. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan, Ny. S, usia 29 tahun, G2P2A0, datang ke praktik bidan bersama suaminya untuk berkonsultasi mengenai metode kontrasepsi. Ia memiliki dua anak berusia 5 tahun dan 2 tahun, dan saat ini belum ingin menambah anak dalam 2–3 tahun ke depan.

Ny. S menyampaikan bahwa ia tidak ingin menggunakan kontrasepsi hormonal karena sebelumnya pernah menggunakan pil KB dan mengalami efek samping berupa mual, peningkatan berat badan, dan sakit kepala. Ia juga merasa khawatir dengan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD.

Riwayat menstruasi Ny. S teratur, dengan siklus 28 hari, lama haid 5 hari, dan tidak ada keluhan nyeri berlebihan. Saat ini ia sudah tidak menyusui. Ia dan suaminya memiliki hubungan yang harmonis dan bersedia bekerja sama dalam penggunaan kontrasepsi.

Pertanyaan Diskusi

1. Kebutuhan kontrasepsi apa yang sesuai dengan kasus diatas?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi diatas?
3. Metode kontrasepsi alamiah dan/atau barier apa yang paling sesuai untuk Ny. S?
4. Berikan alasan ilmiah dan klinis dari pilihan tersebut ?
5. Apa edukasi yang harus diberikan kepada Ny. S dan suami ?
6. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas penggunaan metode yang dipilih?

Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Metode Kontrasepsi Alamiah dan Barrier
3	Kasus	Peran Bidan dalam Konseling Kontrasepsi Alamiah dan Barrier
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat melaksanakan konseling kontrasepsi metode alamiah dan barrier secara komprehensif, efektif, dan profesional sesuai dengan kebutuhan klien.
5	Kompetensi	1. Melakukan Anamnesis Terfokus 2. Mengidentifikasi Kebutuhan dan Masalah Klien 3. Menentukan Metode Kontrasepsi yang Tepat 4. Menjelaskan Indikasi dan Cara Penggunaan 5. Menjelaskan Kelebihan dan Keterbatasan 6. Melakukan Komunikasi dan Konseling Efektif 7. Memberikan Edukasi dan Rencana Tindak Lanjut
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Anda adalah seorang bidan yang bertugas di praktik mandiri. Seorang perempuan, Ny. D, usia 28 tahun, G2P2A0, datang bersama suaminya untuk berkonsultasi mengenai metode kontrasepsi. Ia memiliki dua anak dan ingin menunda kehamilan selama 2–3 tahun ke depan. Ny. D menyampaikan bahwa ia tidak ingin menggunakan kontrasepsi hormonal karena sebelumnya pernah menggunakan suntik KB dan mengalami efek samping berupa peningkatan berat badan dan gangguan siklus haid. Ia juga merasa khawatir menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Hasil anamnesis awal menunjukkan: • Siklus menstruasi teratur (28 hari) • Tidak sedang menyusui • Tidak memiliki riwayat penyakit kronis • Tidak ada riwayat penyakit menular seksual • Suami mendukung penggunaan kontrasepsi • Pasangan bersedia bekerja sama dalam penggunaan metode kontrasepsi Ny. D ingin mengetahui metode kontrasepsi yang aman, tidak memiliki efek samping, dan dapat digunakan tanpa hormon

No.	Komponen	Isi
		TUGAS 1. Lakukan anamnesis terfokus 2. Identifikasi kebutuhan dan masalah klien 3. Tentukan metode kontrasepsi yang sesuai 4. Berikan konseling kontrasepsi 5. Lakukan komunikasi terapeutik 6. Berikan edukasi tambahan 7. Tutup konseling
7	Instruksi penguji	1. Instruksi Umum Penguji diharapkan: a. Membaca dan memahami skenario serta tujuan station sebelum ujian dimulai b. Menilai peserta secara objektif dan konsisten menggunakan checklist yang telah disediakan c. Tidak memberikan bantuan atau petunjuk kepada peserta selama ujian berlangsung, kecuali sesuai ketentuan d. Mengamati seluruh proses, meliputi: - o Komunikasi - o Anamnesis - o Edukasi/konseling - o Sikap profesional e. Menjaga suasana ujian tetap kondusif dan profesional f. Mengikuti waktu yang telah ditentukan (± 10 menit per peserta) g. Tidak mengganggu jalannya interaksi antara peserta dan pasien standar (PS) 2. Instruksi Khusus Penguji harus memperhatikan dan menilai aspek berikut: a. Tahap Pembukaan • Peserta menyapa dan memperkenalkan diri • Menjelaskan tujuan konseling • Membangun hubungan terapeutik b. Anamnesis Terfokus • Menggali riwayat menstruasi • Riwayat kontrasepsi • Jumlah anak dan rencana kehamilan • Dukungan pasangan

No.	Komponen	Isi
		c. Analisis dan Penentuan Metode • Ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan klien • Kesesuaian metode kontrasepsi yang dipilih (alamiah/barier) • Alasan pemilihan metode d. Edukasi/Konseling Peserta harus mampu menjelaskan: • Jenis metode kontrasepsi alamiah dan barier • Indikasi penggunaan • Cara penggunaan yang benar • Kelebihan metode • Keterbatasan dan risiko kegagalan e. Komunikasi • Bahasa jelas dan mudah dipahami • Sikap empatik dan tidak menghakimi • Memberikan kesempatan bertanya • Melibatkan pasangan (jika relevan) f. Penutup • Menyimpulkan hasil konseling • Memastikan pemahaman klien • Memberikan rencana tindak lanjut 3. Instruksi Tambahan - Jika peserta diam lebih dari 30 detik, penguji boleh mengatakan: → <i>"Silakan dilanjutkan"</i> (tanpa memberi petunjuk isi) - Jika peserta bertanya kepada penguji, arahkan untuk bertanya kepada pasien standar (PS) - Jika peserta melakukan kesalahan konsep, penguji tetap: ○ Tidak mengoreksi selama ujian ○ Tetap mencatat dalam penilaian - Jika waktu hampir habis (1 menit terakhir), penguji dapat memberi isyarat: → <i>"Waktu tersisa 1 menit"</i> - Jika peserta menyelesaikan lebih cepat, tetap: ○ Menunggu waktu selesai ○ Tidak memberikan feedback langsung - Penguji tidak diperkenankan: ○ Memberikan ekspresi yang mengarahkan (misalnya: mengangguk/geleng)

No.	Komponen	Isi
		o Memberikan penilaian secara verbal selama ujian berlangsung
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. Perankan sebagai ibu yang ingin KB tanpa metode hormonal 2. Tunjukkan sikap kooperatif dan sedikit cemas di awal 3. Jawab pertanyaan peserta sesuai skenario 4. Tidak memberikan informasi tambahan jika tidak ditanya 5. Ajukan pertanyaan jika penjelasan peserta kurang jelas (misal: "Apakah aman?") 6. Tunjukkan pemahaman jika peserta menjelaskan dengan baik 7. Jaga konsistensi jawaban untuk setiap peserta
9	Dialog PS	Peserta (Bidan): "Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya bidan yang bertugas hari ini. Nama saya ... Boleh saya tahu nama Ibu?" PS: "Pagi, Bu. Nama saya Ny. D." Peserta: "Baik, Bu Ny. D. Ada yang bisa saya bantu hari ini?" PS: "Iya, Bu. Saya mau konsultasi tentang KB." Peserta: "Baik, Ibu. Bisa diceritakan lebih lanjut, Ibu ingin KB seperti apa?" PS: "Saya ingin KB, tapi tidak mau yang hormonal, Bu. Takut efek samping." Peserta: "Baik, Ibu. Memang sebelumnya pernah menggunakan KB hormonal?" PS: "Iya, saya pernah pakai KB suntik." Peserta: "Bagaimana pengalaman Ibu saat menggunakan KB suntik?" PS: "Berat badan saya naik, haid jadi tidak teratur, dan sering pusing." Peserta: "Baik, Ibu. Untuk membantu menentukan metode yang tepat, saya ingin bertanya beberapa hal ya. Bagaimana siklus haid Ibu?" PS: "Haid saya teratur, setiap 28 hari, biasanya 4–5 hari." Peserta: "Baik. Saat ini Ibu sudah memiliki berapa anak?" PS: "Saya sudah punya dua anak." Peserta: "Apakah Ibu masih menyusui?" PS: "Tidak, sudah tidak menyusui." Peserta: "Untuk rencana ke depan, apakah Ibu ingin menambah anak?" PS: "Saya ingin menunda dulu sekitar 2–3 tahun." Peserta: "Bagaimana dengan suami, apakah mendukung penggunaan KB?" PS: "Iya, suami saya mendukung."

No.	Komponen	Isi
		Peserta: "Baik, Bu. Berdasarkan kondisi Ibu yang tidak ingin menggunakan hormon dan memiliki siklus haid teratur, ada beberapa pilihan metode KB yang bisa dipertimbangkan, yaitu metode alamiah dan metode barrier." PS: "Metode alamiah itu seperti apa ya, Bu?" Peserta: "Metode alamiah adalah metode tanpa alat dan tanpa hormon, misalnya: • Metode kalender, yaitu menghitung masa subur • Metode lendir serviks, yaitu melihat perubahan lendir • Metode suhu basal tubuh Metode ini cocok untuk ibu dengan siklus haid teratur seperti Ibu." PS: "Apakah metode itu efektif ya, Bu?" Peserta: "Metode ini cukup efektif jika digunakan dengan benar dan disiplin. Namun, membutuhkan kerja sama dengan suami dan pencatatan yang rutin." Peserta: "Contohnya metode kalender, Ibu harus menghitung masa subur, biasanya sekitar hari ke-12 sampai ke-16 dari siklus haid. Pada masa itu, sebaiknya menghindari hubungan atau menggunakan alat bantu seperti kondom." PS: "Oh begitu, jadi harus dihitung ya?" Peserta: "Iya, betul, Bu. Harus disiplin agar efektif." Peserta: "Selain itu, ada metode barrier seperti kondom dan spermisida." PS: "Kondom itu aman ya, Bu?" Peserta: "Ya, kondom aman digunakan, tidak ada efek samping hormonal, dan juga dapat mencegah penyakit menular seksual." PS: "Apakah tidak mengganggu saat digunakan?" Peserta: "Sebagian pasangan merasa tidak terganggu, apalagi jika sudah terbiasa. Justru ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk dikombinasikan dengan metode alamiah." Peserta: "Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan, Bu. Kelebihan metode alamiah: • Tidak ada efek samping • Biaya murah • Alami Keterbatasannya: • Harus disiplin • Risiko gagal jika salah perhitungan Sedangkan kondom: • Mudah digunakan

No.	Komponen	Isi
		• Melindungi dari penyakit Keterbatasannya: • Harus digunakan setiap hubungan • Bisa gagal jika tidak digunakan dengan benar" PS:"Oh, saya jadi lebih paham sekarang." Peserta:"Menurut Ibu, dari penjelasan tadi, metode mana yang paling sesuai?" PS:"Mungkin saya ingin coba metode alami, tapi juga pakai kondom supaya lebih aman." Peserta:"Itu pilihan yang baik, Bu. Kombinasi metode bisa meningkatkan efektivitas." Peserta:"Nanti saya sarankan Ibu mencatat siklus haid setiap bulan, dan jika ragu, bisa datang kembali untuk konsultasi." PS:"Baik, Bu." Peserta:"Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Bu?" PS:"Sepertinya sudah cukup jelas, Bu." Peserta:"Baik, terima kasih atas kunjungannya. Jika ada pertanyaan atau keluhan, silakan datang kembali." PS:"Terima kasih, Bu Bidan." Catatan 1. Dialog ini mencerminkan: Alur OSCE lengkap (pembukaan–anamnesis–edukasi–penutup) 2. Komunikasi terapeutik 3. Edukasi metode alamiah & barrier secara komprehensif
10	Kebutuhan manikin	Tidak wajib menggunakan manikin, karena fokus station adalah konseling. Namun, jika diperlukan untuk edukasi/visualisasi, dapat disediakan: 1. Model alat reproduksi wanita (phantom uterus/panggul) → Untuk menjelaskan proses ovulasi dan masa subur 2. Model alat reproduksi pria (opsional) → Untuk menjelaskan penggunaan kondom 3. Alat peraga kontrasepsi (bukan manikin utama) → Contoh kondom pria → Diagram siklus menstruasi
11	Kebutuhan laboran	1. Menyiapkan ruangan dan alat sebelum ujian 2. Mengatur waktu pelaksanaan (mulai dan selesai) 3. Mengatur pergantian peserta antar station 4. Memastikan alat tetap lengkap dan berfungsi

No.	Komponen	Isi
		5. Merapikan dan menyiapkan kembali alat setelah ujian
12	Kebutuhan alat	- Alat Edukasi - Leaflet/lembar informasi kontrasepsi - Poster atau diagram siklus menstruasi - Kartu/kalender masa subur - Alat Peraga Kontrasepsi - Kondom pria (contoh/alat peraga) - Spermisida (contoh/ilustrasi) - Alat Tulis - Kertas/lembar catatan - Pulpen/pensil - Perlengkapan Ruangan - Meja dan kursi - Jam/timer - Alat Pendukung (Opsional) - Termometer basal (untuk penjelasan metode suhu) - Flipchart atau papan tulis kecil Catatan - Alat disesuaikan dengan fokus konseling (tidak perlu alat invasif) - Utamakan alat bantu edukasi yang sederhana dan jelas
13	Penulis	Devi Elfita Sari, SST.,Bd.,M.Keb
14	Referensi	BKKBN. (2021). <i>Panduan Pelayanan Kontrasepsi</i>. Jakarta: BKKBN. Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2012). Contraception and health. <i>The Lancet</i>, 380(9837), 149–156. Festin, M. P. R., et al. (2016). Effectiveness of the lactational amenorrhea method. <i>BMJ Sexual & Reproductive Health</i>, 42(2), 101–107. Gloria Leifer. (2019). <i>Introduction to Maternity and Pediatric Nursing</i> (8th ed.). St. Louis: Elsevier. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). <i>Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana</i>. Jakarta: Kemenkes RI. Polis, C. B., Curtis, K. M., & Hannaford, P. C. (2016). Effectiveness of fertility awareness-based methods. <i>Journal of Midwifery & Women's Health</i>, 61(2), 233–241. Trussell, J. (2018). Contraceptive failure in the United States. <i>Contraception Journal</i>, 97(2), 91–97. Varney Helen. (2015). <i>Varney's Midwifery</i> (5th ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.

No.	Komponen	Isi
		Steiner, M. J., et al. (2019). Barrier methods for pregnancy prevention. <i>American Journal of Obstetrics and Gynecology</i> , 221(5), 478–485. World Health Organization. (2018). <i>Family Planning: A Global Handbook for Providers</i> (3rd ed.). Geneva: WHO Press.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Peran Bidan dalam Konseling Kontrasepsi Alamiah dan Barrier

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Menanyakan riwayat menstruasi (siklus, lama, keteraturan)		
2. Menanyakan jumlah anak dan riwayat obstetri		
3. Menanyakan riwayat penggunaan kontrasepsi		
4. Menanyakan rencana kehamilan		
5. Menanyakan dukungan pasangan		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Mengidentifikasi kebutuhan klien dengan tepat		
2. Menentukan metode kontrasepsi yang sesuai		
3. Memberikan alasan pemilihan metode		
4. Menjelaskan langkah penggunaan metode secara sistematis		
5. Menggunakan alat bantu edukasi (jika ada)		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **15–19 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **10–14 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.

- 0= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Menjelaskan jenis metode kontrasepsi (alamiah & barrier)		
2. Menjelaskan indikasi penggunaan		
3. Menjelaskan cara penggunaan		
4. Menjelaskan kelebihan metode		
5. Menjelaskan keterbatasan/risiko		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3**= Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2**= Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1**= Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0**= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Menyapa dan memperkenalkan diri		
2. Bersikap empatik dan sopan		
3. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami		
4. Memberikan kesempatan klien bertanya		
5. Menutup konseling dengan baik		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3**= Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2**= Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1**= Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0**= Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Metode Kontrasepsi Alamiah dan Barrier Indikasi, cara pakai dan kelebihan-keterbatasan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Indikasi, cara pakai dan kelebihan-keterbatasan
Metode penilaian	Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung yang digunakan untuk menilai keterampilan klinis mahasiswa dalam melakukan tindakan atau prosedur secara nyata di hadapan penguji. Pada konteks kebidanan, DOPS digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan konseling kontrasepsi metode alamiah dan barrier secara komprehensif.	Metode penilaian Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) dilakukan dengan mengamati secara langsung kemampuan mahasiswa dalam melakukan konseling metode kontrasepsi alamiah dan barrier meliputi penjelasan indikasi, cara penggunaan, serta kelebihan dan keterbatasannya secara tepat, sistematis, dan profesional.
Tujuan penilaian	Tujuan penilaian adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi kebutuhan klien serta memberikan konseling metode kontrasepsi alamiah dan barrier secara tepat, meliputi indikasi, cara penggunaan, kelebihan, dan keterbatasan secara komprehensif dan profesional.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa dalam menganalisis indikasi penggunaan metode kontrasepsi alamiah dan barrier serta menjelaskan cara pakai, kelebihan, dan keterbatasannya secara tepat dan sesuai dengan kondisi klien.
Kasus klinik	Seorang wanita usia reproduksi datang untuk konsultasi kontrasepsi non-hormonal, sehingga mahasiswa dinilai melalui observasi langsung dalam mengkaji kondisi klien dan memberikan konseling mengenai indikasi, cara pakai, serta kelebihan dan keterbatasan metode kontrasepsi alamiah dan barrier.	Seorang wanita, Ny. D, usia 28 tahun, datang ke praktik bidan untuk berkonsultasi mengenai pemilihan metode kontrasepsi. Ia memiliki dua anak dan ingin menunda kehamilan selama 2–3 tahun. Ny. D tidak ingin menggunakan kontrasepsi hormonal karena sebelumnya mengalami efek samping berupa peningkatan berat badan dan gangguan menstruasi. Siklus haidnya teratur (28 hari), tidak sedang menyusui, dan suami mendukung penggunaan kontrasepsi.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Dalam penilaian DOPS ini, aktivitas mahasiswa yang diamati meliputi kemampuan dalam melakukan pengkajian data subyektif secara	Mahasiswa terlebih dahulu melakukan pengkajian data subyektif, mahasiswa menganalisis kondisi klien, Mahasiswa kemudian

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Indikasi, cara pakai dan kelebihan-keterbatasan
	sistematis (riwayat haid, penggunaan kontrasepsi, rencana kehamilan, dan dukungan pasangan), menganalisis kebutuhan klien, serta memberikan konseling metode kontrasepsi alamiah dan barrier dengan menjelaskan indikasi, cara penggunaan, kelebihan, dan keterbatasannya secara tepat.	menjelaskan indikasi penggunaan, mahasiswa menjelaskan cara pakai, mahasiswa menjelaskan kelebihan metode, Mahasiswa juga menjelaskan keterbatasan metode, mahasiswa dinilai berdasarkan kemampuan komunikasi terapeutik.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai dalam DOPS pada konseling metode kontrasepsi alamiah dan barrier meliputi kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengumpulan data subyektif secara lengkap dan sistematis, menentukan indikasi penggunaan metode yang sesuai dengan kondisi klien, serta menjelaskan cara penggunaan secara benar dan runtut.	Mahasiswa dinilai dalam menentukan indikasi penggunaan metode kontrasepsi, mahasiswa dinilai dalam menjelaskan cara pakai, Mahasiswa juga dinilai dalam menjelaskan kelebihan metode, mahasiswa dinilai dalam menjelaskan keterbatasan metode, mahasiswa dalam menyampaikan informasi secara komunikatif, jelas, dan profesional, sehingga klien dapat memahami dan mengambil keputusan yang tepat.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing dalam DOPS ini adalah menilai secara langsung kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian dan konseling metode kontrasepsi alamiah dan barrier secara komprehensif, meliputi ketepatan dalam menentukan indikasi, kejelasan dalam menjelaskan cara penggunaan, serta kelengkapan dalam menguraikan kelebihan dan keterbatasan metode.	Pembimbing mengamati kemampuan mahasiswa dalam menentukan indikasi penggunaan metode, pembimbing memperhatikan bagaimana mahasiswa menjelaskan cara pakai, Pembimbing juga menilai kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan kelebihan dan keterbatasan metode, Serta pembimbing mengamati sikap profesional mahasiswa, termasuk cara membuka dan menutup konseling, menjaga etika, serta memastikan klien memahami informasi yang telah diberikan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS merupakan proses pemberian evaluasi langsung oleh pembimbing setelah mahasiswa menyelesaikan tindakan atau konseling, yang bertujuan untuk	Setelah mahasiswa menyelesaikan konseling, pembimbing memberikan umpan balik untuk lebih menekankan keseimbangan informasi antara manfaat dan keterbatasan metode serta

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Indikasi, cara pakai dan kelebihan-keterbatasan
	meningkatkan keterampilan klinis dan komunikasi.	meningkatkan keterampilan komunikasi dengan lebih banyak melibatkan klien dalam diskusi."
Keputusan penilaian	Keputusan penilaian dalam DOPS merupakan hasil akhir yang ditetapkan oleh pembimbing berdasarkan observasi langsung terhadap kinerja mahasiswa selama melakukan tindakan atau konseling.	Mahasiswa dinyatakan KOMPETEN , dengan catatan perlu perbaikan pada aspek kelengkapan edukasi, khususnya terkait keterbatasan metode kontrasepsi.
Makna dalam OBE	Melalui DOPS, pembimbing dapat memastikan bahwa mahasiswa benar-benar mampu menerapkan konsep dalam praktik, seperti memberikan konseling kontrasepsi alamiah dan barrier secara tepat, sistematis, dan berpusat pada klien. Selain itu, DOPS mendukung prinsip OBE dengan memberikan umpan balik yang spesifik dan berkelanjutan, sehingga mahasiswa dapat melakukan perbaikan dan mencapai kompetensi yang diharapkan sebelum memasuki praktik klinik yang lebih luas.	DOPS menunjukkan bahwa mahasiswa telah mencapai sebagian besar capaian pembelajaran dalam konseling kontrasepsi, namun masih perlu peningkatan pada aspek kelengkapan edukasi agar sesuai dengan standar Outcome-Based Education (OBE).

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 5.1

Portofolio pada Metode Kontrasepsi Alamiah dan Barrier yang mencakup indikasi, cara pakai, serta kelebihan dan keterbatasan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat portofolio	Hakikat portofolio merupakan kumpulan hasil belajar mahasiswa yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan sebagai bukti pencapaian kompetensi, yang mencerminkan proses, perkembangan, serta hasil belajar dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.	Mahasiswa dapat menunjukkan bahwa ia telah memahami indikasi penggunaan, mampu menjelaskan cara pakai, serta menguraikan kelebihan dan keterbatasan metode secara tepat. Selain itu, mahasiswa juga melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut.
Tujuan portofolio	Tujuan portofolio adalah untuk mendokumentasikan dan menilai secara komprehensif proses serta hasil belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.	Menilai pencapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh serta sebagai sarana refleksi guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap profesional dalam praktik kebidanan
OSCE dan DOPS	Objective Structured Clinical Examination (OSCE) merupakan metode penilaian keterampilan klinis yang dilakukan melalui beberapa station terstruktur, di mana mahasiswa diminta menyelesaikan tugas tertentu seperti anamnesis, pemeriksaan, atau konseling dalam waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) adalah metode penilaian yang dilakukan melalui observasi langsung terhadap	OSCE: Mahasiswa melakukan konseling pada pasien simulasi tentang metode kontrasepsi alamiah dan barrier di station terstruktur dengan penilaian menggunakan checklist. DOPS: Mahasiswa dinilai melalui observasi langsung saat melakukan konseling kontrasepsi alamiah dan barrier kepada pasien dengan penilaian keterampilan, komunikasi, dan profesionalisme.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	mahasiswa saat melakukan tindakan atau prosedur klinis pada pasien nyata atau simulasi.	
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat merupakan ringkasan informasi penting mengenai kondisi klien yang mencakup identitas, keluhan utama, riwayat kesehatan, serta hasil pengkajian yang relevan, yang disusun secara padat dan jelas untuk memudahkan pemahaman serta pengambilan keputusan dalam pemberian asuhan kebidanan.	Catatan kasus singkat: Seorang wanita usia 28 tahun datang untuk konsultasi kontrasepsi non-hormonal dengan riwayat haid teratur dan pernah mengalami efek samping KB suntik, sehingga dipertimbangkan metode kontrasepsi alamiah dan barrier sesuai kondisi dan kebutuhannya.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan proses evaluasi diri yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap praktik pelayanan yang telah dilakukan dengan menekankan pada aspek keselamatan pasien, meliputi identifikasi potensi risiko, kesalahan, atau tindakan yang dapat membahayakan pasien, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan.	Pembimbing menyadari pentingnya memberikan informasi yang lengkap dan memastikan pemahaman klien dalam penggunaan kontrasepsi agar mencegah kesalahan yang dapat membahayakan keselamatan pasien.
Feedback CI/dosen	Penyampaian feedback dilakukan secara jelas, spesifik, dan mendukung agar mahasiswa dapat memahami hasil evaluasi dan termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan.	Mahasiswa sudah mampu melakukan konseling dengan baik, namun perlu meningkatkan kelengkapan penjelasan mengenai keterbatasan metode kontrasepsi agar klien lebih memahami risiko.
Karakteristik penilaian	Karakteristik penilaian adalah kriteria yang digunakan dalam proses evaluasi untuk memastikan penilaian dilakukan secara objektif, valid, reliabel, terukur, dan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.	Karakteristik penilaian dalam OSCE/DOPS ini dilakukan secara objektif, terstruktur, menggunakan checklist yang terstandar, serta berfokus pada pencapaian kompetensi mahasiswa dalam konseling kontrasepsi alamiah dan barrier.
Bukti konsistensi kompetensi	Bukti konsistensi kompetensi adalah bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mempertahankan kinerja dan pencapaian kompetensi secara stabil melalui hasil penilaian yang berulang dan berkelanjutan.	Bukti konsistensi kompetensi ditunjukkan ketika mahasiswa mampu melakukan konseling kontrasepsi alamiah dan barrier dengan hasil yang baik secara

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		berulang pada beberapa penilaian DOPS dan OSCE yang berbeda.
Makna dalam OBE	Makna dalam Outcome-Based Education (OBE) adalah penekanan pada pencapaian capaian pembelajaran yang terukur sebagai bukti bahwa mahasiswa telah menguasai kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditetapkan.	Makna dalam OBE ditunjukkan ketika mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran dengan melakukan konseling kontrasepsi alamiah dan barrier secara tepat, sistematis, dan profesional sebagai bukti kompetensi yang terukur.

Tabel 5.2
Case Report pada Metode Kontrasepsi Alamiah dan Barrier yang mencakup indikasi, cara pakai, serta kelebihan dan keterbatasan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Indikasi, cara pakai dan kelebihan-keterbatasan
Hakikat case report	Hakikat case report adalah laporan ilmiah yang menyajikan satu kasus klinis secara sistematis dan terperinci untuk mendokumentasikan temuan, analisis, serta pembelajaran dari kasus tersebut sebagai bahan rujukan dan pengembangan ilmu.	Hakikat case report pada kasus konseling kontrasepsi alamiah dan barrier adalah laporan terstruktur yang mendokumentasikan kondisi klien, proses pengkajian, intervensi konseling, serta hasil dan pembelajaran yang diperoleh dari penanganan kasus tersebut.
Tujuan	Tujuan case report adalah untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan mengevaluasi penatalaksanaan suatu kasus klinis sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan kompetensi kebidanan.	Mahasiswa mendokumentasikan dan menganalisis asuhan kebidanan pada klien dengan kebutuhan konseling kontrasepsi alamiah dan barrier guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi mahasiswa dalam praktik klinis.
Isi laporan	Isi laporan adalah uraian sistematis yang memuat identitas kasus, hasil pengkajian, analisis, tindakan/intervensi, serta evaluasi yang disusun secara runtut sebagai dasar penarikan kesimpulan dan pembelajaran klinis.	Isi laporan pada case report ini meliputi identitas klien, hasil pengkajian, analisis kebutuhan kontrasepsi, tindakan konseling metode alamiah dan barrier, serta evaluasi hasil konseling yang dilakukan.
Fokus penilaian	Fokus penilaian adalah aspek-aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa, meliputi ketepatan pengkajian,	Fokus penilaian meliputi ketepatan pengkajian, penentuan indikasi, kemampuan menjelaskan cara pakai, serta kelengkapan dalam menguraikan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Indikasi, cara pakai dan kelebihan-keterbatasan
	keterampilan prosedural, kemampuan komunikasi, serta sikap profesional sesuai dengan standar yang ditetapkan.	kelebihan dan keterbatasan metode kontrasepsi alamiah dan barrier.
Nilai edukatif	Nilai edukatif adalah nilai pembelajaran yang diperoleh dari suatu kegiatan atau kasus yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa dalam praktik klinis secara berkelanjutan.	Nilai edukatif dari kasus ini adalah mahasiswa dapat memahami secara lebih mendalam indikasi, cara penggunaan, serta kelebihan dan keterbatasan metode kontrasepsi alamiah dan barrier dalam praktik konseling kebidanan.
Makna dalam OBE	Makna dalam Outcome-Based Education (OBE) adalah penekanan pada pencapaian capaian pembelajaran yang terukur sebagai bukti bahwa mahasiswa telah menguasai kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditetapkan dalam proses pendidikan.	Makna dalam Outcome-Based Education (OBE) pada kasus ini terlihat ketika mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran melalui kemampuan melakukan konseling kontrasepsi alamiah dan barrier secara tepat, sistematis, dan profesional sebagai bukti penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan.

Tabel 5.3

Refleksi Patient Safety pada Kasus Indikasi, cara pakai dan kelebihan-keterbatasan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Indikasi, cara pakai dan kelebihan-keterbatasan
Hakikat refleksi patient safety	Hakikat refleksi patient safety adalah proses evaluasi diri yang berfokus pada identifikasi risiko, analisis potensi kesalahan, dan upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan keselamatan pasien dalam praktik pelayanan kesehatan.	Hakikat refleksi patient safety pada kasus ini adalah mahasiswa menyadari pentingnya memastikan pemahaman klien terhadap penggunaan kontrasepsi alamiah dan barrier untuk mencegah kesalahan yang dapat berdampak pada keselamatan pasien.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa indikasi, cara pakai, serta kelebihan dan keterbatasan metode kontrasepsi alamiah dan barrier dalam memberikan konseling yang tepat kepada klien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi adalah aspek-aspek utama yang menjadi perhatian	Mahasiswa dalam menentukan indikasi, menjelaskan cara pakai,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Indikasi, cara pakai dan kelebihan-keterbatasan
	dalam proses evaluasi diri terhadap pengalaman praktik untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu diperbaiki.	serta menguraikan kelebihan dan keterbatasan metode kontrasepsi alamiah dan barrier secara jelas dan tepat.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali potensi terjadinya kesalahan penggunaan metode kontrasepsi akibat kurangnya pemahaman klien yang dapat menyebabkan kegagalan pencegahan kehamilan atau ketidakefektifan metode.	Klien salah memahami cara penggunaan metode kontrasepsi alamiah dan barrier sehingga meningkatkan risiko kegagalan kontrasepsi.
Tindakan pencegahan	Tindakan pencegahan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi atau menghindari terjadinya risiko atau kesalahan dalam praktik pelayanan guna menjaga keselamatan pasien.	Mahasiswa memberikan edukasi yang jelas dan memastikan klien memahami cara penggunaan metode kontrasepsi alamiah dan barrier dengan meminta klien mengulang kembali informasi yang telah disampaikan.
Pembelajaran mahasiswa	Pembelajaran mahasiswa adalah proses perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi secara bertahap dan berkelanjutan dalam praktik klinis.	Mahasiswa memahami cara menentukan indikasi, menjelaskan cara pakai, serta menguraikan kelebihan dan keterbatasan metode kontrasepsi alamiah dan barrier melalui praktik konseling langsung.
Makna dalam OBE	Makna dalam Outcome-Based Education (OBE) adalah penekanan pada pencapaian capaian pembelajaran yang terukur sebagai bukti bahwa mahasiswa telah menguasai kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditetapkan.	Mahasiswa mampu melakukan konseling kontrasepsi alamiah dan barrier secara tepat, sistematis, dan profesional sebagai bukti tercapainya capaian pembelajaran yang ditetapkan.

E. Ringkasan Materi

Bidan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya dalam konseling kontrasepsi alamiah dan barrier. Peran ini bertujuan untuk membantu klien dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan, serta nilai dan preferensi individu atau pasangan.

Dalam melakukan konseling, bidan berperan sebagai edukator yang memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah dipahami mengenai berbagai metode kontrasepsi alamiah seperti metode kalender, suhu basal, dan lendir serviks, serta metode barrier seperti kondom dan spermisida. Bidan menjelaskan indikasi penggunaan, cara kerja, cara penggunaan yang benar, serta kelebihan dan keterbatasan masing-masing metode agar klien dapat mengambil keputusan yang tepat.

Selain itu, bidan juga berperan sebagai komunikator yang membangun hubungan yang baik dengan klien melalui komunikasi efektif, empati, dan non-judgmental. Bidan harus mampu menggali kebutuhan, kekhawatiran, serta kondisi klien secara menyeluruh agar konseling yang diberikan bersifat individual dan berpusat pada klien (client-centered care).

Peran lain yang tidak kalah penting adalah sebagai konselor yang membantu klien memahami pilihan kontrasepsi secara objektif tanpa memaksakan keputusan. Bidan mendukung klien dalam proses pengambilan keputusan (informed choice) dengan memberikan kesempatan bertanya dan memastikan klien benar-benar memahami informasi yang diberikan.

Dalam aspek pelayanan, bidan juga berperan sebagai fasilitator yang membantu klien dalam menentukan metode yang paling sesuai, termasuk memberikan demonstrasi penggunaan alat kontrasepsi barrier seperti kondom, serta memastikan klien mampu menggunakan metode tersebut dengan benar. Bidan juga melakukan evaluasi terhadap pemahaman klien melalui teknik umpan balik seperti meminta klien mengulang informasi (teach-back method).

Di samping itu, bidan memiliki tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pasien (patient safety) dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak menyesatkan, menghindari kesalahan penggunaan metode, serta memberikan edukasi mengenai tanda-tanda kegagalan kontrasepsi dan langkah yang harus dilakukan jika terjadi masalah.

Secara keseluruhan, peran bidan dalam konseling kontrasepsi alamiah dan barrier mencakup aspek edukasi, komunikasi, konseling, fasilitasi, dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan klien, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta memastikan penggunaan metode kontrasepsi yang aman dan efektif sesuai dengan kebutuhan klien.

F. Alur asuhan singkat

Berikut adalah alur asuhan singkat sebagai peran bidan dalam konseling kontrasepsi alamiah dan barrier:

1. Pengkajian: Bidan mengumpulkan data subjektif dan objektif klien meliputi usia, riwayat kesehatan, pola menstruasi, riwayat penggunaan kontrasepsi, serta kebutuhan dan preferensi klien.
2. Identifikasi masalah/kebutuhan: Bidan menganalisis data untuk menentukan kebutuhan klien terkait pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai.
3. Penjelasan pilihan metode: Bidan memberikan informasi mengenai metode kontrasepsi alamiah dan barrier, termasuk indikasi, cara pakai, kelebihan, dan keterbatasannya.
4. Konseling dan pengambilan keputusan: Bidan membantu klien memilih metode yang paling sesuai melalui komunikasi dua arah dan memastikan informed choice.
5. Demonstrasi dan edukasi: Bidan memberikan contoh atau demonstrasi penggunaan metode, terutama pada kontrasepsi barrier seperti kondom.
6. Evaluasi pemahaman klien: Bidan memastikan klien memahami informasi dengan metode umpan balik seperti teach-back.
7. Tindak lanjut dan dokumentasi: Bidan memberikan rencana kontrol atau tindak lanjut serta mendokumentasikan hasil konseling secara lengkap.

G. Tabel Red Flags & Eskalasi

Peran bidan dalam konseling kontrasepsi alamiah dan barrier:

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Klien tidak memahami cara penggunaan metode	Kegagalan kontrasepsi / kehamilan tidak direncanakan	Ulangi edukasi, gunakan metode teach-back, dan jadwalkan konseling ulang
Siklus menstruasi tidak teratur	Kesulitan menentukan masa subur	Rujuk untuk evaluasi lebih lanjut atau sarankan metode kontrasepsi lain yang lebih sesuai
Riwayat penyakit yang mempengaruhi reproduksi	Ketidakefektifan metode alamiah	Konsultasi/rujukan ke dokter atau tenaga kesehatan terkait
Ketidakpatuhan pasangan dalam mengikuti aturan metode	Penurunan efektivitas metode	Berikan konseling pasangan dan edukasi pentingnya komitmen bersama
Penggunaan kondom tidak benar atau sering gagal	Risiko kehamilan dan infeksi menular seksual	Demonstrasi ulang penggunaan kondom dan evaluasi keterampilan klien

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Alergi terhadap bahan lateks (kondom)	Reaksi alergi	Sarankan alternatif kondom non-lateks atau metode barrier lain
Tidak adanya penggunaan metode tambahan saat masa subur	Peningkatan risiko kehamilan	Edukasi penggunaan metode tambahan atau abstinensi pada masa subur
Klien memiliki risiko tinggi IMS namun tidak menggunakan kondom	Risiko penularan infeksi	Konseling intensif tentang pencegahan IMS dan anjuran penggunaan kondom secara konsisten
Klien menyampaikan keraguan atau kebingungan setelah konseling	Potensi kesalahan penggunaan metode	Lakukan konseling lanjutan dan klarifikasi informasi
Terjadi kegagalan metode (misal kehamilan tidak direncanakan)	Ketidaksesuaian metode	Evaluasi ulang metode kontrasepsi dan rujuk untuk pilihan metode yang lebih efektif

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab : Metode Kontrasepsi Alamiah dan Barrier

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik/Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Keterangan
1	Saya sudah bisa melakukan pengkajian data subjektif dan objektif klien secara lengkap			
2	Saya sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi klien terkait pemilihan kontrasepsi			
3	Saya sudah bisa menjelaskan metode kontrasepsi alamiah dengan tepat			
4	Saya sudah bisa menjelaskan metode kontrasepsi barrier dengan benar			
5	Saya sudah bisa menyampaikan indikasi penggunaan masing-masing metode			
6	Saya sudah bisa menjelaskan cara penggunaan metode kontrasepsi alamiah			
7	Saya sudah bisa menjelaskan cara penggunaan kontrasepsi barrier (kondom/spermisida)			
8	Saya sudah bisa menguraikan kelebihan dan keterbatasan masing-masing metode			
9	Saya sudah bisa melakukan konseling dengan komunikasi efektif dan empatik			
10	Saya sudah bisa membantu klien dalam pengambilan keputusan (informed choice)			
11	Saya sudah bisa melakukan evaluasi pemahaman klien (teach-back method)			
12	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional dan menjaga patient safety			

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Referensi

- Black, K. I., & Fraser, I. S. (2020). *Counselling women about contraception*. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 60(2), 150–158.
- Curtis, K. M., Tepper, N. K., Jatlaoui, T. C., et al. (2021). U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. MMWR Recommendations and Reports, Vol. 70, No. 4, hlm. 1–95.
- Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2012). Contraception and health. The Lancet, 380(9837), 149–156.
- Festin, M. P. R., et al. (2016). Effectiveness of the lactational amenorrhea method. BMJ Sexual & Reproductive Health, 42(2), 101–107.
- Glasier, A., & Gebbie, A. (2021). *Family Planning and Contraception*. Edinburgh: Elsevier, hlm. 78–102.
- Glasier, A., & Gebbie, A. (2020). *Contraception*. The Lancet, 395(10222), 1428–1437.
- Handayani, S. (2024). *Metode Kontrasepsi Sederhana*. Tahta Media, Yogyakarta.
- Agustiawan, A., & Sari, S. N. (2024). Metode Amenore Laktasi sebagai Metode Kontrasepsi: Tinjauan Literatur. Galenical: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh, Vol. 3, No. 4, hlm. 45–52.
- Hall, K. S., & Moreau, C. (2023). *Determinants of contraceptive use*. Journal of Women's Health, 32(5), 567–575.
- Harden, R. M. (2007). Outcome-based education: The future is today. Medical Teacher, 29(7), 625–629.
- Hubacher, D., & Trussell, J. (2020). *A definition of modern contraceptive methods*. Contraception, 101(3), 157–160.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Ningsih, S., Rahmawati, D., & Putri, A. (2023). Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Wanita Usia Subur. Jurnal Pengabdian Masyarakat Aupa (JPM Aupa), Vol. 5, No. 2, hlm. 112–118.
- Norcini, J., & Burch, V. (2007). Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide No. 31. Medical Teacher, 29(9–10), 855–871.
- Polis, C. B., Curtis, K. M., & Hannaford, P. C. (2016). Effectiveness of fertility awareness-based methods. Journal of Midwifery & Women's Health, 61(2), 233–241.
- Polis, C. B., Phillips, S. J., Curtis, K. M., et al. (2022). Effectiveness of Fertility Awareness-Based Methods. American Journal of Obstetrics and Gynecology, Vol. 226, No. 2, hlm. 234–245.

- Pratama, R., & Lestari, D. (2025). Konsep dan Macam-Macam Metode Kontrasepsi Modern. *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 25–33.
- Polis, C. B., Bradley, S. E., Bankole, A., Onda, T., & Croft, T. (2021). *Contraceptive effectiveness*. *Studies in Family Planning*, 52(2), 123–140.
- Sundaram, A., Vaughan, B., Kost, K., et al. (2022). *Contraceptive failure and discontinuation*. *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 54(3), 123–131.
- Steiner, M. J., et al. (2019). Barrier methods for pregnancy prevention. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 221(5), 478–485.
- Trussell, J. (2020). Contraceptive Failure in the United States. *Contraception Journal*, Vol. 101, No. 2, hlm. 89–96.
- Trussell, J. (2021). *Contraceptive failure in the United States*. *Contraception*, 104(2), 1–7.
- Winner, B., Peipert, J. F., Zhao, Q., et al. (2019). *Effectiveness of long-acting reversible contraception*. *New England Journal of Medicine*, 366(21), 1998–2007.
- Wilkinson, J. R., Crossley, J. G., Wragg, A., Mills, P., Cowan, G., & Wade, W. (2008). Implementing workplace-based assessment across the medical specialties in the United Kingdom. *Medical Education*, 42(4), 364–373.
- World Health Organization. (2022). *Family planning: A global handbook for providers*. WHO Publication, 1–200.
- World Health Organization. (2023). *Family Planning: A Global Handbook for Providers (3rd ed.)*. Geneva: WHO Press.

Bab 6

KONTRASEPSI HORMONAL KOMBINASI: PIL, PATCH/CINCIN, JADWAL, DAN PENATALAKSANAAN KELUHAN

Pendahuluan

Pelayanan keluarga berencana merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan reproduksi perempuan. Dalam praktik kebidanan, pemilihan metode kontrasepsi tidak hanya didasarkan pada efektivitas, tetapi juga pada prinsip keamanan, kelayakan medis, hak reproduksi, dan pendekatan berpusat pada klien. Kontrasepsi hormonal kombinasi merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan secara global. Data dari *World Health Organization* menunjukkan bahwa kontrasepsi hormonal berperan penting dalam menurunkan angka kehamilan tidak direncanakan dan komplikasi maternal. Sementara itu, laporan *United Nations Population Fund* (2023) menegaskan bahwa akses terhadap kontrasepsi modern merupakan indikator penting dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target kesehatan ibu dan kesetaraan gender.

Di Indonesia, kebijakan pelayanan keluarga berencana dikoordinasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bidan sebagai tenaga kesehatan lini terdepan memiliki peran strategis dalam memberikan konseling, melakukan skrining kelayakan medis, serta menangani efek samping secara profesional.

Buku ajar ini disusun untuk menjembatani kebutuhan mahasiswa kebidanan dan praktisi dalam memahami kontrasepsi hormonal kombinasi secara ilmiah, sistematis, dan aplikatif.

Tujuan Buku:

Buku ajar ini secara khusus bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kontrasepsi hormonal kombinasi, yang meliputi pil kombinasi, patch transdermal, dan cincin vagina, beserta jadwal penggunaan dan penatalaksanaan keluhan yang mungkin muncul selama pemakaian.

Secara rinci, tujuan buku ini adalah:

- Menjelaskan konsep ilmiah kontrasepsi hormonal kombinasi, termasuk mekanisme kerja estrogen dan progestin dalam menghambat ovulasi, mengubah mukus serviks, serta memodifikasi endometrium.
- Menguraikan jenis-jenis kontrasepsi hormonal kombinasi, yaitu pil kombinasi, patch, dan cincin vagina, termasuk kelebihan, keterbatasan, efektivitas, serta perbandingan klinis antar metode.
- Membekali pembaca dengan kemampuan melakukan skrining kelayakan medis, berdasarkan kriteria *Medical Eligibility Criteria* (MEC) yang direkomendasikan oleh World Health Organization dan pedoman pelayanan kontrasepsi nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Menjelaskan secara sistematis jadwal penggunaan pil, patch, dan cincin, termasuk tata laksana lupa pakai, keterlambatan penggantian, dan kebutuhan kontrasepsi tambahan berdasarkan rekomendasi Centers for Disease Control and Prevention (2024).
- Meningkatkan kompetensi dalam penatalaksanaan keluhan dan efek samping, seperti spotting, mual, nyeri payudara, perubahan tekanan darah, serta identifikasi tanda bahaya (ACHES) yang memerlukan rujukan.
- Mengembangkan kemampuan konseling berbasis informed choice, sehingga mahasiswa dan praktisi mampu memberikan edukasi yang jelas, objektif, serta menghormati hak reproduksi klien.
- Mendukung penerapan praktik kebidanan berbasis bukti (*evidence-based practice*) dalam pelayanan kontrasepsi hormonal kombinasi, sehingga keputusan klinis didasarkan pada data ilmiah mutakhir, keamanan, dan kebutuhan individu klien.

Dengan tujuan tersebut, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber pengetahuan teoritis, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam pengambilan keputusan klinis terkait penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi di pelayanan kebidanan.

Sasaran Pembaca:

Buku ajar ini secara khusus ditujukan bagi pembaca yang membutuhkan pemahaman mendalam dan aplikatif mengenai kontrasepsi hormonal kombinasi, mencakup pil kombinasi, patch transdermal, cincin vagina, jadwal penggunaan, serta penatalaksanaan keluhan dalam praktik klinis.

Secara rinci, sasaran buku ini adalah:

- Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Kebidanan, khususnya yang sedang menempuh mata kuliah Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, agar mampu memahami konsep, mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, serta pengambilan keputusan klinis terkait kontrasepsi hormonal kombinasi.
- Mahasiswa Profesi Bidan, sebagai bekal kompetensi klinis dalam melakukan skrining kelayakan medis, memberikan konseling berbasis informed choice, serta menangani efek samping penggunaan pil, patch, dan cincin secara tepat.
- Bidan praktisi di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di praktik mandiri, puskesmas, klinik, maupun rumah sakit, yang membutuhkan rujukan ilmiah terkini dalam penatalaksanaan keluhan dan evaluasi penggunaan kontrasepsi kombinasi sesuai pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan rekomendasi World Health Organization.
- Dosen dan pendidik kebidanan, sebagai referensi dalam menyusun materi pembelajaran, studi kasus, serta evaluasi berbasis kompetensi terkait kontrasepsi hormonal kombinasi.
- Tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelayanan KB, seperti dokter umum atau perawat, yang memerlukan pemahaman praktis mengenai jadwal penggunaan dan tata laksana lupa pakai berdasarkan rekomendasi Centers for Disease Control and Prevention.

Buku ini disusun dengan kedalaman materi yang sesuai untuk kebutuhan akademik dan praktik klinis, sehingga dapat menjadi panduan pembelajaran sekaligus referensi dalam pengambilan keputusan pelayanan kontrasepsi hormonal kombinasi secara aman, efektif, dan berbasis bukti.

Isi Buku:

Bab ini secara khusus membahas kontrasepsi hormonal kombinasi (Combined *Hormonal Contraceptives/CHC*), yang mencakup pil kombinasi, patch transdermal, dan cincin vagina. Pembahasan disusun secara komprehensif mulai dari dasar teori hingga aplikasi klinis dalam praktik kebidanan.

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam Bab 6 meliputi:

- Konsep Dasar Kontrasepsi Hormonal Kombinasi
- Jenis Kontrasepsi Hormonal Kombinasi
- Skrining dan Kelayakan Medis
- Jadwal Penggunaan dan Tata Laksana Lupa Pakai
- Penatalaksanaan Keluhan dan Efek Samping
- Identifikasi Tanda Bahaya dan Rujukan
- Konseling dan Edukasi Pengguna
- Ringkasan Klinis dan Algoritme Pengambilan Keputusan

Metode Pembelajaran:

Metode pembelajaran pada Bab VI dirancang untuk membantu mahasiswa memahami secara konseptual sekaligus mampu mengaplikasikan kontrasepsi hormonal kombinasi dalam pengambilan keputusan klinis. Pendekatan pembelajaran mengintegrasikan teori, analisis kasus, dan keterampilan praktik berbasis bukti.

Adapun metode yang digunakan meliputi:

- Pembelajaran Berbasis Konsep (Conceptual Learning)
- Pembelajaran Berbasis Kasus (Case-Based Learning)
- Simulasi Konseling (Simulation & Role Play)
- Analisis Algoritme Klinis
- Diskusi Kelompok Terarah
- Evaluasi Formatif dan Sumatif

Pendekatan Pembelajaran:

Pendekatan pembelajaran pada Bab 6 dirancang untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memahami konsep kontrasepsi hormonal kombinasi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik klinis secara aman, rasional, dan berbasis bukti.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

Evidence-Based Learning

Pembelajaran didasarkan pada pedoman ilmiah terkini, antara lain:

- Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use dari World Health Organization
- Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use dari Centers for Disease Control and Prevention
- Pedoman pelayanan kontrasepsi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Mahasiswa dilatih untuk membaca, memahami, dan menginterpretasikan pedoman tersebut dalam konteks kasus nyata, khususnya dalam menentukan kelayakan penggunaan pil, patch, dan cincin vagina.

Clinical Decision-Making Approach

Pendekatan ini menekankan kemampuan mahasiswa dalam:

- Melakukan skrining kelayakan medis
- Menentukan pilihan metode kombinasi yang sesuai
- Mengambil keputusan saat terjadi lupa pakai
- Menangani keluhan seperti spotting, mual, dan nyeri payudara
- Mengidentifikasi tanda bahaya (ACHES) dan menentukan kebutuhan rujukan

Mahasiswa diajak berpikir sistematis melalui algoritme klinis dan skenario kasus.

Student-Centered Learning

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa melalui:

- Diskusi interaktif
- Analisis kasus berbasis vignette
- Refleksi klinis
- Presentasi kelompok

Mahasiswa didorong aktif menganalisis perbedaan penggunaan pil, patch, dan cincin serta mempertimbangkan faktor individu klien.

Problem-Based Learning (PBL)

Mahasiswa diberikan permasalahan nyata, seperti:

- Klien lupa minum pil dua hari berturut-turut
- Klien mengalami spotting pada bulan pertama
- Klien dengan tekanan darah borderline
- Klien dengan migraine tanpa aura

Mahasiswa diminta mengidentifikasi masalah, mencari referensi pedoman, dan menyusun rencana penatalaksanaan yang tepat.

Rights-Based and Client-Centered Approach

Pendekatan ini menekankan:

- Penghormatan terhadap hak reproduksi perempuan
- Prinsip informed choice
- Kerahasiaan dan non-diskriminasi
- Pemberian informasi yang objektif dan seimbang

Pendekatan ini selaras dengan kompetensi inti bidan menurut International Confederation of Midwives.

Reflective Clinical Practice

Mahasiswa diajak melakukan refleksi setelah pembelajaran atau simulasi, dengan mengevaluasi:

- Ketepatan pengambilan keputusan
- Kesesuaian penatalaksanaan dengan pedoman
- Efektivitas komunikasi konseling

Pendekatan reflektif ini memperkuat integrasi teori dan praktik.

Pedoman Penggunaan:

Agar pembelajaran optimal, pembaca disarankan untuk:

- Membaca capaian pembelajaran sebelum memulai materi.
- Memahami konsep dasar mekanisme kerja pil, patch, dan cincin sebelum mempelajari jadwal penggunaan dan tata laksana lupa pakai.
- Menggunakan tabel dan algoritme klinis untuk melatih pengambilan keputusan.
- Mengerjakan studi kasus untuk melatih clinical reasoning.
- Mengaitkan materi dengan praktik klinik, terutama dalam skrining kelayakan, konseling, dan penatalaksanaan keluhan.
- Melakukan refleksi diri untuk memastikan kesiapan praktik dan uji kompetensi.

Daftar Isi:

Konsep Dasar Kontrasepsi Hormonal Kombinasi

- Definisi dan Komponen Hormon
- Mekanisme Kerja Estrogen dan Progestin
- Efektivitas dan Keamanan

Jenis Kontrasepsi Hormonal Kombinasi

- Pil Kombinasi (Combined Oral Contraceptives)
- Patch Transdermal
- Cincin Vagina

Skrining dan Kelayakan Medis

- Anamnesis dan Pemeriksaan Awal
- Indikasi Penggunaan
- Kontraindikasi Berdasarkan WHO MEC

Jadwal Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Kombinasi

- Waktu Memulai Penggunaan
- Regimen Pil (21/7, 24/4, Extended Cycle)
- Jadwal Penggantian Patch
- Durasi dan Siklus Cincin Vagina

Tata Laksana Lupa Pakai

- Lupa Minum Pil
- Patch Terlepas atau Terlambat Diganti
- Cincin Terlepas atau Terlambat Dipasang

Penatalaksanaan Keluhan dan Efek Samping

- Spotting dan Perdarahan Tidak Teratur
- Mual dan Gangguan Gastrointestinal
- Nyeri Payudara dan Sakit Kepala
- Perubahan Tekanan Darah
- Edukasi dan Monitoring Lanjutan

Identifikasi Tanda Bahaya (ACHES) dan Rujukan

Konseling Berbasis Informed Choice

Ringkasan Bab

Latihan Soal dan Studi Kasus

Daftar Pustaka

Tujuan Instruksional dan Capaian Pembelajaran :

Setelah mempelajari Bab 6, mahasiswa mampu menentukan pilihan kontrasepsi hormonal kombinasi (pil, patch, dan cincin vagina), menyusun jadwal penggunaan, serta menangani keluhan secara aman dan berbasis bukti dalam pelayanan kebidanan.

Tujuan Instruksional :

Setelah mengikuti pembelajaran Bab 6, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan mekanisme kerja kontrasepsi hormonal kombinasi berdasarkan regulasi siklus hormonal.
- Mengidentifikasi indikasi, kontraindikasi, dan kriteria kelayakan penggunaan pil kombinasi, patch, dan cincin vagina.
- Membandingkan efektivitas, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing metode.
- Menyusun jadwal penggunaan yang benar (regimen 21/7, 24/4, extended cycle, dan continuous use).
- Menetapkan tata laksana lupa minum pil, keterlambatan pemasangan patch, atau keterlambatan penggunaan cincin vagina.
- Membedakan efek samping umum dengan tanda bahaya (misalnya gejala tromboemboli).
- Menyusun langkah penatalaksanaan keluhan seperti mual, perdarahan bercak, nyeri payudara, dan sakit kepala.
- Menentukan kebutuhan rujukan pada kondisi komplikasi atau kontraindikasi baru.

Capaian Pembelajaran :

CPMK:

CPMK-4: Merancang dan menerapkan konseling KB efektif (komunikasi, informed choice, skrining kelayakan) serta rencana tindak lanjut.

CPMK-5: Menentukan pilihan metode kontrasepsi yang tepat dan menyusun edukasi penggunaan sesuai kelayakan, kondisi, dan bukti.

CPMK-6: Menangani efek samping/komplikasi KB, menetapkan tindakan awal, serta menentukan kebutuhan rujukan secara aman.

- Mahasiswa mampu memilih kontrasepsi hormonal kombinasi sesuai kelayakan medis, kondisi klinis dan preferensi klien (CPMK-5)
- Mahasiswa mampu menyusun jadwal penggunaan serta menangani keluhan dan efek samping secara sistematis dan aman. (CPMK-6, CPMK-4)

Kognitif :

Mahasiswa mampu:

- Menguraikan mekanisme kerja estrogen dan progestin dalam kontrasepsi kombinasi.
- Menjelaskan perbedaan bentuk sediaan pil, patch, dan cincin.
- Menjelaskan prinsip jadwal penggunaan dan tata laksana lupa pakai.
- Menjelaskan penatalaksanaan keluhan dan tanda bahaya.

Psikomotor:

Mahasiswa mampu:

- Melakukan skrining kelayakan medis sebelum pemberian kontrasepsi kombinasi.
- Menentukan pilihan metode sesuai kondisi klien.
- Menyusun edukasi jadwal penggunaan secara jelas dan sistematis.
- Menetapkan penatalaksanaan keluhan secara rasional.
- Mengambil keputusan rujukan bila ditemukan tanda bahaya.

Afektif:

Mahasiswa menunjukkan:

- Sikap profesional dan bertanggung jawab dalam pelayanan KB.
- Penghormatan terhadap hak reproduksi klien.
- Komunikasi yang empatik dan tidak diskriminatif.
- Komitmen terhadap praktik kebidanan berbasis bukti.

A. Konsep Dasar Kontrasepsi Hormonal Kombinasi

1. Definisi dan Komponen Hormon

Kontrasepsi hormonal kombinasi adalah metode pencegahan kehamilan yang mengandung dua hormon sintetis, yaitu estrogen dan progestin, yang bekerja bersama untuk mencegah terjadinya ovulasi dan kehamilan. Kontrasepsi ini tersedia dalam beberapa bentuk, antara lain pil kombinasi oral (COCs), patch transdermal yang ditempelkan pada kulit, dan cincin vagina yang dipasang di dalam vagina. (CDC Control and Prevention, 2024b)

Hormon estrogen yang paling sering digunakan adalah etinil estradiol, sedangkan komponen progestin merupakan turunan sintetis dari hormon alami progesteron. Istilah yang tepat dalam kontrasepsi adalah progestin, bukan progesteron, karena yang digunakan adalah bentuk sintetis yang telah dimodifikasi agar stabil secara oral dan memiliki durasi kerja yang lebih panjang.

Beberapa jenis progestin yang umum digunakan dalam kontrasepsi kombinasi antara lain levonorgestrel, desogestrel, drospirenone, dan norethindrone. Kombinasi estrogen dan progestin ini dirancang untuk meniru kondisi hormonal fase luteal, sehingga tubuh menerima sinyal seolah-olah ovulasi telah terjadi, dan proses pelepasan sel telur dapat dicegah. Kombinasi kedua hormon ini mensimulasikan keadaan hormon luteal, tubuh “mengira” sedang hamil, sehingga ovulasi tidak terjadi. (CDC Control and Prevention, 2024b; WHO, 2025b)

2. Mekanisme Kerja Estrogen dan Progestin

Kontrasepsi hormonal kombinasi bekerja melalui beberapa mekanisme utama yang saling mendukung. (CDC Control and Prevention, 2024b; NICHD, n.d.; WHO, 2025b)

a. Menghambat Ovulasi

Estrogen dan progestin bekerja pada aksis hipotalamus–hipofisis–ovarium. Kombinasi ini menekan sekresi hormon FSH dan LH sehingga tidak terjadi lonjakan LH yang diperlukan untuk ovulasi. Dengan tidak terjadinya ovulasi, sel telur tidak dilepaskan dari ovarium dan kehamilan dapat dicegah.

b. Mengentalkan Lendir Serviks

Progestin menyebabkan lendir serviks menjadi lebih kental dan sulit ditembus oleh sperma. Perubahan ini secara signifikan mengurangi kemungkinan sperma mencapai ovum.

c. Mengubah Endometrium

Paparan hormon kombinasi menyebabkan endometrium menjadi lebih tipis dan kurang reseptif terhadap implantasi. Meskipun mekanisme utama adalah penekanan ovulasi, perubahan endometrium turut memberikan efek kontraseptif tambahan.

d. Memengaruhi Motilitas Tuba

Progestin juga memengaruhi pergerakan tuba falopi sehingga transportasi ovum dan sperma dapat terhambat.

Pendekatan mekanisme kerja ini menunjukkan bahwa kontrasepsi kombinasi tidak hanya menargetkan satu proses reproduksi tetapi beberapa langkah dalam perjalanan fertilisasi, sehingga meningkatkan efektivitas metode ini.

3. Efektivitas dan Keamanan

Efektivitas :

Kontrasepsi hormonal kombinasi termasuk metode kontrasepsi jangka pendek yang cukup efektif bila digunakan dengan benar. Menurut hasil penelitian terkini, efektivitas dengan penggunaan sempurna (*correct use*) menunjukkan hanya sekitar 2 kehamilan per 100 pengguna per tahun, sedangkan dengan penggunaan biasa (*typical use*) berkisar 4–7 kehamilan per 100 pengguna per tahun. Hal ini menunjukkan peran penting kepatuhan pengguna dalam menentukan keberhasilan metodologi.

Efektivitas ini mencakup pil kombinasi oral, patch, dan cincin vagina, yang semuanya merupakan bentuk kombinasi estrogen-progestin. Efektivitas tersebut tergantung pada konsistensi penggunaan dan pemahaman cara menerapkan jadwal yang benar serta tata laksana lupa pakai. (CDC Control and Prevention, 2024b; Teal & Edelman, 2021)

Keamanan :

Dalam hal keamanan, kontrasepsi hormonal kombinasi umumnya aman bagi kebanyakan perempuan usia reproduksi, tetapi tetap memiliki potensi risiko. Estrogen yang terkandung dalam metode ini dapat meningkatkan risiko kejadian seperti:

- a. Pembekuan darah (tromboemboli)
- b. Hipertensi atau peningkatan tekanan darah
- c. Mual, sakit kepala, nyeri payudara dan perubahan mood

Beberapa kondisi medis tertentu seperti merokok pada usia ≥ 35 tahun, riwayat tromboemboli, migraine dengan aura (jenis migrain yang didahului oleh gangguan saraf sementara sebelum nyeri kepala muncul, misalnya melihat

kilatan cahaya, pandangan kabur sebagian, atau kesemutan pada wajah dan tangan) dan penyakit hati berat merupakan kontraindikasi atau memerlukan pertimbangan klinis sebelum penggunaan sesuai pedoman WHO melalui *Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use*. (CDC Control and Prevention, 2024a)

Di Indonesia, pedoman pelayanan KB dari Kementerian Kesehatan dan BKKBN juga menekankan pentingnya anamnesis dan pemeriksaan tekanan darah sebelum pemberian kontrasepsi kombinasi. Dengan skrining yang tepat dan konseling yang adekuat, kontrasepsi hormonal kombinasi merupakan metode yang efektif, aman, dan dapat diterima secara luas dalam pelayanan kebidanan.

B. Jenis Kontrasepsi Hormonal Kombinasi

Kontrasepsi hormonal kombinasi (Combined Hormonal Contraception/CHC) adalah metode kontrasepsi yang mengandung dua hormon sintetis, yaitu estrogen (umumnya etinil estradiol) dan progestin, yang bekerja bersama untuk mencegah ovulasi dan kehamilan. WHO mengelompokkan pil kombinasi, patch transdermal, dan cincin vagina dalam kategori yang sama karena memiliki mekanisme kerja hormonal yang serupa. (WHO, 2015b)

1. Pil Kombinasi (Combined Oral Contraceptives)

Pengertian

Pil kombinasi adalah kontrasepsi oral yang mengandung estrogen dan progestin dalam dosis tertentu untuk digunakan setiap hari. Metode ini bekerja terutama dengan menghambat ovulasi serta mengentalkan lendir serviks. (CDC Control and Prevention, 2024b; WHO, 2015b)

Regimen dan Variasi Fase Pil Kombinasi dalam Pelayanan KB

Pil kombinasi (*Combined Oral Contraceptives/COCs*) merupakan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen (umumnya etinil estradiol) dan progestin. Dalam praktik pelayanan keluarga berencana, pemahaman mengenai regimen penggunaan dan variasi fase hormon sangat penting karena berkaitan dengan kepatuhan klien serta penatalaksanaan efek samping.

Menurut (WHO, 2015b) dan (Kemenkes RI, 2020) , pil kombinasi dapat dibedakan berdasarkan dua aspek utama, yaitu:

- a. Regimen penggunaan (jadwal minum pil)
- b. Variasi dosis hormon dalam satu siklus (fase)

Keduanya merupakan konsep yang berbeda namun saling berkaitan dalam praktik klinis.

a. Regimen Penggunaan Pil Kombinasi

Regimen adalah pola atau jadwal konsumsi pil dalam satu siklus menstruasi. Pedoman pelayanan KB nasional menjelaskan bahwa klien harus minum satu tablet setiap hari pada waktu yang sama untuk menjaga efektivitas metode. Beberapa regimen yang digunakan antara lain:

1) Regimen 21/7

Klien minum 21 tablet aktif selama 21 hari berturut-turut, kemudian tidak minum pil selama 7 hari. Pada masa bebas pil ini biasanya terjadi perdarahan haid.

2) Regimen 24/4

Klien minum 24 tablet aktif dan 4 tablet plasebo tanpa jeda. Pola ini bertujuan meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko lupa memulai siklus baru.

3) Regimen kontinu atau extended cycle

Pil aktif diminum lebih dari 21 atau 24 hari secara berkelanjutan sesuai indikasi medis, sehingga frekuensi menstruasi menjadi lebih jarang.

WHO (2015) menegaskan bahwa semua regimen tersebut aman bagi perempuan yang memenuhi kriteria kelayakan medis. (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2015b)

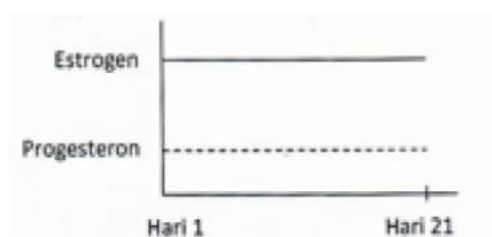
b. Variasi Fase Hormon dalam Pil Kombinasi

Selain regimen, pil kombinasi juga dibedakan berdasarkan variasi dosis hormon dalam satu siklus.

1) Monofasik

Semua tablet aktif mengandung dosis estrogen dan progestin yang sama. Jenis ini paling banyak digunakan dalam pelayanan KB karena lebih sederhana dan memudahkan penatalaksanaan jika terjadi lupa minum pil. Jenis monofasik yang beredar di pasaran yaitu:

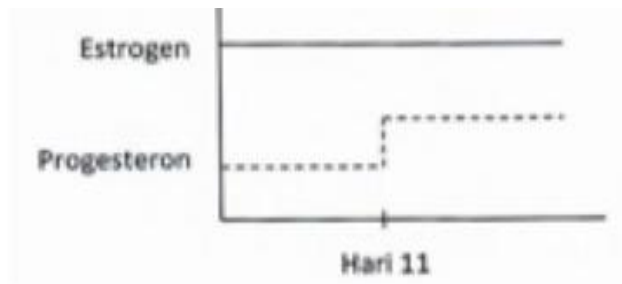
- 21 pil mengandung 20 µg Ethinyl Estradiol (EE)/ 150 µg Levonorgestrel (LNG) dan 7 pil tanpa hormon
- 21 pil mengandung 30 µg EE/ 3000 ug Drospirenone dan 7 pil tanpa hormon
- 24 pil mengandung 30 µg EE/2000 ug Drospirenone dan 4 pil tanpa hormon



Gambar 5.1
Kandungan Hormon Monofasik

2) Bifasik

Pil mengandung hormon aktif estrogen. progestin dalam dua dosis yang berbeda. Jenis pil bifasik yang beredar dipasaran yaitu: 21 pil mengandung 0,02 mm EE/ 0,15 mg Desogestrel, 5 pil mengandung: 0,01 mg EE dan 2 pil tanpa hormon.



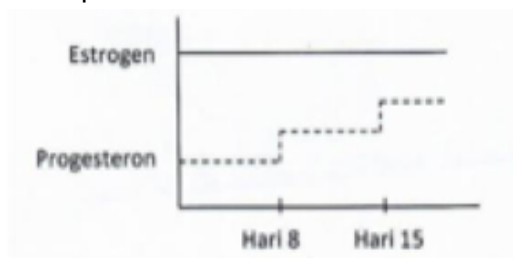
Gambar 5.2
Kandungan Hormon Bifasik

3) Trifasik

Dosis hormon berubah tiga kali dalam satu siklus, dirancang untuk mendekati fluktuasi hormonal alami.

Jenis pil trifasik yang beredar dipasaran

yaitu: 7 pil mengandung 0,035 mg EE/0,5 mg Norethindrone, 7 pil mengandung 0,035 mg EE/0,75 mg Norethindrone, 7 pil mengandung 0,035 mg EE/ 1 mg Norethindrone dan 7 pil tanpa hormon; dan 7 pil mengandung 0,025 mg EE/0,100 mg Desogestrel, 7 pil mengandung 0,025 mg EE/ 0,125 mg Desogestrel, 7 pil mengandung 0,025 mg EE/ 0,150 mg Desogestrel dan 7 pil tanpa hormon.

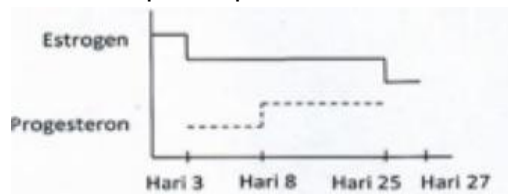


Gambar 5.3
Kandungan Hormon Trifasik

4) Kuadrifasik

Pil mengandung hormon aktif estrogen/ progestin dalam 4 dosis yang berbeda.

Jenis yang beredar di Pasaran antara lain : 2 pil mengandung 3 mg Estradiol Valerat, 5 pil mengandung 2 mg Estradiol Valerat/ 2 mg Dienogest, 17 pil mengandung 2 mg Estradiol Valerate/ 3 mg Dienogest, 2 pil mengandung 1 mg Estradiol Valerate dan 2 pil tanpa hormon.



Gambar 5.4
Kandungan Hormon Kuadrifasik

WHO (2015) tidak membedakan kriteria kelayakan medis berdasarkan jenis fase karena efektivitas dan keamanannya relatif setara. Namun dalam praktik nasional, pil monofasik lebih sering direkomendasikan sebagai pilihan awal karena kemudahan penggunaan ((Kemenkes RI, 2020; WHO, 2015b; Yurissetiowati, 2024).

Cara Kerja dan Penggunaan

Pil ini diminum setiap hari pada waktu yang sama, biasanya selama 21–24 hari aktif hormon, diikuti dengan 4–7 hari tanpa hormon atau pil plasebo, yang menyebabkan terjadinya perdarahan withdrawal seperti menstruasi. Cara penggunaan ini mengikuti rekomendasi dari pedoman penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi. (CDC, 2024; Clinic, 2025)

a. Kelebihan

- 1) Efektivitas tinggi bila digunakan secara konsisten (kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita per tahun jika digunakan dengan sempurna).
- 2) Siklus menstruasi cenderung lebih teratur.
- 3) Dapat memberikan manfaat non-kontrasepsi seperti mengurangi dismenore, perdarahan berlebih, dan gejala sindrom pramenstruasi.

b. Keterbatasan

- 1) Harus diminum setiap hari pada waktu yang sama agar efektif.
- 2) Tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual.
- 3) Diperlukan skrining medis karena estrogen dalam pil kombinasi dapat meningkatkan risiko efek samping pada perempuan dengan kondisi tertentu seperti migrain dengan aura atau hipertensi berat.

2. Patch Transdermal

Pengertian

Patch transdermal adalah plester kontrasepsi yang ditempelkan pada kulit dan secara kontinyu melepaskan hormon estrogen dan progestin yang diserap melalui kulit ke dalam aliran darah untuk mencegah ovulasi dan kehamilan. Ini termasuk pada kelompok *contraceptive patch* dalam kategori *combined hormonal contraceptives*. (CDC Control and Prevention, 2024b).

Setiap patch kontrasepsi transdermal mengandung 6 mg norelgestromin dan 600 µg ethinyl estradiol, dengan pelepasan rata-rata ± 203 µg norelgestromin dan ± 33.9 µg ethinyl estradiol per 24 jam. Beberapa referensi klinis juga menyederhanakan dosis pelepasan sebagai ± 150 µg norelgestromin dan ± 35 µg ethinyl estradiol per hari pada sistem patch kontrasepsi mingguan. (All, n.d.; Patch et al., n.d.)

Cara Penggunaan

Klien menempelkan satu lembar patch pada kulit (misalnya di lengan atas, punggung, atau perut bagian bawah) dan menggantinya setiap minggu selama tiga minggu berturut-turut. Pada minggu keempat, klien tidak menggunakan patch (minggu bebas hormon), dan perdarahan haid biasanya terjadi pada periode tersebut.

Klien dianjurkan untuk:

- a. Mengganti patch pada hari yang sama setiap minggu
- b. Memastikan patch menempel dengan baik
- c. Segera mengganti patch jika terlepas lebih dari 24 jam

Kelebihan

- a. Hanya perlu diganti sekali seminggu, sehingga lebih mudah diingat dibanding pil harian.
- b. Efektivitasnya serupa dengan pil kombinasi bila dipakai dengan benar.

Keterbatasan

- a. Beberapa pengguna melaporkan gejala lokal seperti iritasi kulit pada area tempat patch ditempel.
- b. Pada sebagian wanita dengan berat badan (>90 kg) efektivitasnya dapat sedikit menurun, sehingga pemantauan dan pilihan metode alternatif perlu dipertimbangkan.

(Gallo et al., 2003)

3. Cincin Vagina

Pengertian

Cincin vagina adalah salah satu bentuk kontrasepsi hormonal kombinasi yang dirancang untuk dilekatkan di dalam vagina dan melepaskan hormon estrogen dan progestin secara terus-menerus ke dalam tubuh melalui dinding vagina. Hormon yang dilepaskan mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan mengubah endometrium sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kehamilan. Menurut WHO (2015), cincin vagina termasuk dalam metode hormonal kombinasi yang efektivitasnya setara dengan pil hormonal kombinasi apabila digunakan dengan benar dan konsisten. Kombinasi kedua hormon ini mirip dengan yang terdapat pada pil kombinasi, tetapi dilepaskan langsung melalui permukaan vagina sehingga kadarnya stabil dalam darah tanpa efek pertama di hati (*First-Pass Metabolism*). (CDC, 2024; WHO, 2015b)

Komposisi standar pada 1 cincin vagina kombinasi (misalnya NuvaRing) adalah:

Etonogestrel (progestin): 11,7 mg per ring, Ethinyl estradiol (estrogen): 2,7 mg per ring. Setelah dimasukkan ke vagina, cincin akan melepaskan hormon secara konstan selama ± 3 minggu: Etonogestrel ≈ 120 mikrogram/hari (0,120 mg), Ethinyl estradiol ≈ 15 mikrogram/hari (0,015 mg). (SL, 2020)

Cincin ini adalah cincin fleksibel dari polymer ethylene-vinyl acetate yang berfungsi sebagai reservoir hormon.

Cara Penggunaan

Penggunaan cincin vagina mengikuti pola siklus 28 hari sebagai berikut (CDC, 2024) :

a. Pemasangan Cincin

- 1) Cincin dimasukkan sendiri oleh klien ke dalam vagina.
- 2) Perempuan dapat memasang cincin dalam posisi berdiri, jongkok, atau berbaring.

b. Durasi Pemakaian

Cincin dipakai selama 3 minggu berturut-turut.

c. Minggu Bebas Cincin

- 1) Cincin dilepas dan klien tidak memakai cincin 1 minggu.
- 2) Pada minggu bebas cincin, biasanya terjadi perdarahan "withdrawal".

d. Siklus Selanjutnya

Pada minggu ke-5 (setelah 7 hari tanpa cincin), cincin baru dipasang kembali pada hari yang sama seperti pertama kali dipasang, meskipun perdarahan belum selesai.

Tabel 6.1

Contoh Merek dan Kandungan Hormon Kontrasepsi Hormonal Kombinasi Global

Metode	Contoh Merek (Global)	Kandungan Hormon	Dosis Umum
Pil Kombinasi	Yasmin	Drospirenone + Ethinyl Estradiol	3 mg + 30 µg
	Yaz	Drospirenone + Ethinyl Estradiol	3 mg + 20 µg
	Beyaz	Drospirenone + Ethinyl Estradiol + Levomefolate	3 mg + 20 µg + folate
	Aviane	Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol	0.1 mg + 20 µg
	Sprintec	Norgestimate + Ethinyl Estradiol	0.25 mg + 35 µg
	Apri	Desogestrel + Ethinyl Estradiol	0.15 mg + 30 µg
	Loestrin / Aranelle	Norethindrone + Ethinyl Estradiol	1 mg + 20–30 µg
	Nextstellis	Drospirenone + Estetrol	3 mg + 14.2 mg
	Patch Transdermal	Norelgestromin + Ethinyl Estradiol	±150 µg + 35 µg per hari
		Norelgestromin + Ethinyl Estradiol	±150 µg + 35 µg per hari
		Levonorgestrel + Ethinyl Estradiol	±120 µg + 30 µg per hari
Cincin Vagina	NuvaRing	Etonogestrel + Ethinyl Estradiol	±120 µg + 15 µg per hari
	Annovera	Segesterone acetate + Ethinyl Estradiol	±150 µg + 13 µg per hari

C. Skrining dan Kelayakan Medis

Sebelum memberikan metode kontrasepsi hormonal kombinasi kepada klien, tenaga kesehatan harus melakukan skrining menyeluruh untuk menilai apakah metode ini aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan klien. Skrining dan penilaian medis merupakan langkah penting untuk memastikan keselamatan, efektivitas, dan penerimaan klien terhadap metode kontrasepsi yang dipilih.

1. Anamnesis dan Pemeriksaan Awal

Skrining dimulai dengan anamnesis lengkap dan pemeriksaan awal, yang meliputi:

a. Riwayat kesehatan reproduksi dan sistemik, termasuk:

- 1) Riwayat migrain (dengan atau tanpa aura)
- 2) Riwayat penyakit kardiovaskular
- 3) Riwayat tromboemboli vena (misalnya *deep vein thrombosis*)

- 4) Riwayat hipertensi
- 5) Riwayat penyakit hati
- 6) Riwayat merokok, terutama pada usia ≥ 35 tahun

Informasi ini penting karena kontrasepsi kombinasi mengandung estrogen yang dapat meningkatkan risiko *adverse event* (kejadian tidak diinginkan) tertentu pada klien dengan riwayat penyakit di atas. (WHO, 2025a)

- b. Pemeriksaan tekanan darah, dilakukan pada semua klien sebelum pemberian metode kontrasepsi hormonal kombinasi, karena hipertensi berat menjadi salah satu kondisi yang diklasifikasikan tidak aman untuk penggunaan metode ini menurut WHO MEC. (WHO, 2025a)
- c. Penentuan status kehamilan, dilakukan melalui pertanyaan riwayat menstruasi terakhir atau pemeriksaan tambahan sesuai kebutuhan. Kontrasepsi tidak diberikan pada klien yang sedang hamil. Uraian ini juga sejalan dengan pedoman pelayanan KB nasional di mana pemeriksaan awal merupakan bagian dari prosedur klinis pelayanan kontrasepsi Indikasi Penggunaan. (Kemenkes RI, 2020).

2. Indikasi Berdasarkan WHO MEC

Kontrasepsi hormonal kombinasi (*Combined Hormonal Contraceptives/CHC*), yang meliputi pil kombinasi, patch transdermal, dan cincin vagina, merupakan metode kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progestin. Metode ini diindikasikan bagi perempuan usia reproduksi yang menginginkan pencegahan kehamilan efektif dan tidak memiliki kontraindikasi medis terhadap penggunaan hormon estrogen.

Menurut WHO Medical Eligibility Criteria (2025) dan Pedoman Pelayanan KB Kemenkes RI (2020), indikasi penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi meliputi aspek berikut:

- a. Perempuan Usia Reproduksi yang Membutuhkan Kontrasepsi Efektif
Metode kombinasi diindikasikan pada perempuan yang:
 - 1) Ingin menunda kehamilan (spacing)
 - 2) Ingin membatasi jumlah anak
 - 3) Menginginkan metode yang dapat dihentikan kapan saja dengan cepat kembali subur
 Efektivitas metode ini tinggi apabila digunakan secara konsisten dan benar, dengan tingkat kegagalan sangat rendah pada penggunaan sempurna.
- b. Perempuan Tanpa Faktor Risiko Kardiovaskular atau Tromboemboli
Metode ini diindikasikan pada perempuan yang:
 - 1) Tidak memiliki riwayat tromboemboli vena

- 2) Tidak memiliki riwayat stroke atau penyakit jantung iskemik
- 3) Tidak menderita hipertensi berat
- 4) Tidak mengalami migrain dengan aura
- 5) Tidak memiliki riwayat kanker payudara aktif

Pada perempuan sehat tanpa faktor risiko tersebut, metode kombinasi termasuk kategori 1 atau 2 menurut WHO MEC, sehingga aman digunakan dengan pemantauan rutin.

c. Perempuan dengan Kebutuhan Regulasi Siklus Menstruasi

Kontrasepsi hormonal kombinasi juga diindikasikan pada perempuan dengan gangguan siklus menstruasi, antara lain:

- 1) Siklus menstruasi tidak teratur
- 2) Perdarahan menstruasi berlebihan (menorrhagia)
- 3) Dismenore ringan hingga sedang
- 4) Perdarahan disfungsional

Estrogen dalam metode kombinasi membantu menstabilkan endometrium sehingga siklus menjadi lebih teratur dan jumlah perdarahan berkurang.

d. Perempuan dengan Kondisi Klinis Tertentu yang Mendapatkan Manfaat Non-Kontrasepsi

Beberapa kondisi klinis dapat memperoleh manfaat tambahan dari penggunaan kontrasepsi kombinasi, seperti:

- 1) Sindrom ovarium polikistik (PCOS) untuk regulasi siklus
- 2) Jerawat ringan hingga sedang
- 3) Pencegahan anemia akibat perdarahan menstruasi berlebih

WHO menyatakan bahwa manfaat non-kontrasepsi ini merupakan pertimbangan tambahan dalam pemilihan metode, selama tidak terdapat kontraindikasi medis.

e. Perempuan Postaborsi atau Pascapersalinan (Kondisi Tertentu)

Metode kombinasi dapat diindikasikan pada:

- 1) Perempuan pascaaborsi trimester pertama (dapat langsung dimulai)
- 2) Perempuan pascapersalinan ≥ 21 hari yang tidak menyusui dan tidak memiliki faktor risiko tromboemboli
- 3) Perempuan menyusui setelah 6 bulan postpartum dengan evaluasi kelayakan medis
- 4) Pemilihan waktu inisiasi harus disesuaikan dengan kondisi fisiologis dan risiko tromboemboli.

- f. Perempuan yang menginginkan Metode Non-Invasif dan Reversibel
- Metode kombinasi diindikasikan bagi perempuan yang:
- 1) Tidak menghendaki prosedur invasif seperti pemasangan IUD atau implan
 - 2) Menginginkan kontrol pribadi terhadap penggunaan metode
 - 3) Menginginkan metode yang dapat dihentikan sendiri tanpa prosedur medis
- Pil, patch, dan cincin memberikan fleksibilitas dan kontrol penggunaan kepada klien.

3. Kontraindikasi Berdasarkan WHO MEC

Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (MEC) dari *World Health Organization* edisi terbaru 2025 menjelaskan kriteria kelayakan medis untuk berbagai metode kontrasepsi, termasuk kontrasepsi hormonal kombinasi (yang mencakup pil kombinasi, patch transdermal, dan cincin vagina) berdasarkan kondisi kesehatan dan karakteristik fisiologis individu (WHO, 2025a)

Tabel 6.2
Kategori WHO MEC untuk Kontrasepsi Hormonal Kombinasi

Kategori	Definisi
1	Tidak ada pembatasan untuk penggunaan metode
2	Keuntungan umumnya lebih besar daripada risiko
3	Risiko umumnya lebih besar daripada keuntungan
4	Tidak boleh digunakan (kontraindikasi absolut)

Tabel 6.3
Kondisi Umum dan Kategori untuk Metode Kombinasi

Kondisi Klinis	Kategori WHO MEC	Keterangan Klinis
Usia <35 tahun, tidak merokok	1	Aman digunakan
Usia ≥40 tahun tanpa faktor risiko lain	2	Perlu pemantauan
Merokok <35 tahun	2	Edukasi risiko
Merokok ≥35 tahun (<15 batang/hari)	3	Pertimbangkan metode lain
Merokok ≥35 tahun (≥15 batang/hari)	4	Kontraindikasi
Hipertensi terkontrol	3	Evaluasi berkala
Hipertensi ≥160/100 mmHg	4	Tidak boleh digunakan
Riwayat tromboemboli vena	4	Kontraindikasi absolut
Riwayat stroke atau penyakit jantung iskemik	4	Tidak boleh digunakan
Migrain tanpa aura (<35 tahun)	2	Evaluasi berkala

Kondisi Klinis	Kategori WHO MEC	Keterangan Klinis
Migrain dengan aura	4	Kontraindikasi absolut
Diabetes tanpa komplikasi	2	Aman dengan pemantauan
Diabetes dengan komplikasi vaskular	3/4	Hindari metode kombinasi
Kanker payudara aktif	4	Tidak boleh digunakan
Penyakit hati berat	4	Kontraindikasi

Tabel 6.4
Kondisi Reproduksi

Kondisi	Kategori
Postpartum <21 hari (tanpa menyusui)	4
Postpartum 21–42 hari + faktor risiko trombosis	3
Postpartum >42 hari (tanpa menyusui)	1
Menyusui <6 minggu postpartum	4
Menyusui 6 minggu – <6 bulan	3
Postaborsi trimester I	1

D. Jadwal Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Kombinasi

Jadwal penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi merupakan aspek penting dalam menjamin efektivitas metode kontrasepsi. Ketepatan waktu memulai, keteraturan penggunaan, serta pemahaman klien mengenai regimen yang digunakan akan mempengaruhi keberhasilan metode dalam mencegah kehamilan. Kontrasepsi hormonal kombinasi mengandung estrogen dan progestin, yang bekerja dengan cara menekan ovulasi, mengentalkan mukus serviks, serta mengubah endometrium sehingga tidak mendukung implantasi. Oleh karena itu, penggunaan harus mengikuti pola yang teratur sesuai dengan jenis metode yang dipilih.

1. Waktu Memulai Penggunaan

Menurut *World Health Organization (WHO) Selected Practice Recommendations*, klien dapat memulai kontrasepsi hormonal kombinasi (pil, patch, atau cincin vagina) berdasarkan waktu dalam siklus menstruasi (CDC Control and Prevention, 2024b; WHO, 2025c):

- a. Dalam 5 hari pertama menstruasi (hari pertama haid)
 - 1) COCs, patch, atau CVR dapat dimulai.
 - 2) Tidak perlu kontrasepsi cadangan tambahan karena segera memberikan perlindungan terhadap kehamilan.

- b. Lebih dari 5 hari sejak haid
 - 1) Dapat dimulai bila cukup yakin klien tidak hamil.
 - 2) Klien perlu menggunakan kontrasepsi tambahan (mis. kondom) atau menghindari hubungan seksual selama 7 hari pertama penggunaan.
 - c. Klien amenoreik (tidak haid karena faktor lain)

Metode dapat dimulai kapan saja jika yakin klien tidak hamil, namun kontrasepsi cadangan diperlukan selama 7 hari pertama penggunaan.
 - d. Postpartum atau postaborsi

Pilihan waktu mulai disesuaikan dengan status menyusui dan lamanya sejak persalinan (WHO MEC). Secara umum, CHCs tidak dianjurkan <21 hari postpartum karena risiko tromboemboli, tetapi dapat dipertimbangkan setelah itu dengan pertimbangan medis. Menurut World Health Organization (WHO) Selected Practice Recommendations, klien dapat memulai kontrasepsi hormonal kombinasi (pil, patch, atau cincin vagina) berdasarkan waktu dalam siklus menstruasi (WHO, 2016; CDC, 2024):
2. Regimen Pil (21/7, 24/4, Extended Cycle)
- Regimen pil kombinasi menentukan urutan dan durasi konsumsi tablet aktif dan periode bebas hormon, penting untuk efektivitas metode.
- a. Regimen 21/7
 - 1) Klien minum 21 tablet aktif hormon selama 21 hari berturut-turut.
 - 2) Diikuti oleh 7 hari bebas hormon (selama periode ini biasanya terjadi perdarahan withdrawal).
 - 3) Setelah hari ke-7, siklus baru dimulai dengan pil pertama dari kemasan berikutnya.
 - 4) Ini adalah regimen klasik yang banyak digunakan dalam pelayanan KB.
 - b. Regimen 24/4
 - 1) Klien mengonsumsi 24 tablet aktif hormon diikuti oleh 4 tablet bebas hormon.
 - 2) Interval bebas hormon yang lebih pendek ini dimaksudkan untuk mengurangi gejala perdarahan atau spotting.
 - 3) Efektivitasnya serupa dengan regimen 21/7.
 - c. Extended Cycle
 - 1) Pada regimen ini, pil aktif bisa digunakan lebih dari 24 hari tanpa jeda hormon untuk menunda perdarahan haid.
 - 2) Cocok bagi klien yang ingin mengurangi frekuensi menstruasi.
 - 3) Metode ini aman bila digunakan sesuai pedoman, namun klien harus memahami pola perdarahan yang dapat berubah.

WHO juga mencatat bahwa dosis hormon umumnya diberikan 21–24 hari berturut-turut diikuti oleh 4–7 hari tanpa hormon, tetapi regimen lain dengan hari bebas hormon yang lebih pendek atau tanpa hari bebas hormon juga digunakan secara klinis. (Kemenkes RI dan BKKBN, 2019).

3. Jadwal Penggantian Patch

Patch dapat ditempelkan pada beberapa bagian tubuh seperti lengan atas bagian luar, perut, punggung bagian atas, atau bokong, namun tidak dianjurkan ditempelkan pada payudara. Penting bagi pengguna untuk memastikan patch tetap menempel dengan baik dan menggantinya sesuai jadwal agar efektivitas kontrasepsi tetap terjaga. (Hatcher, R., 2018)

Patch transdermal merupakan metode kombinasi yang ditempel pada kulit dan diganti secara periodik (MSD Manual, 2025) :

- a. Klien menempelkan patch baru setiap minggu pada hari yang sama selama 3 minggu berturut-turut.
- b. Setelah tiga minggu pemakaian, klien berhenti menggunakan patch selama 1 minggu (patch-free week), sehingga terjadi perdarahan withdrawal.
- c. Siklus kemudian diulang dengan patch baru pada hari yang sama di minggu berikutnya.

Perlu ditekankan bahwa patch harus dipakai selama tiga minggu berturut-turut tanpa terlepas lama, dan interval bebas patch tidak boleh lebih dari 7 hari agar efektivitas kontrasepsi tetap tinggi.

4. Durasi dan Siklus Cincin Vagina

Cincin vagina juga mengikuti prinsip regimen kombinasi (MSD Manual, 2025) :

- a. Cincin dimasukkan ke dalam vagina dan dipakai selama 3 minggu (21 hari).
- b. Setelah tiga minggu pemakaian, cincin dilepas selama 1 minggu untuk memungkinkan perdarahan withdrawal.
- c. Pada minggu ke-5, klien memasang cincin baru pada hari yang sama meskipun perdarahan haid belum selesai.
- d. Pola ini memberikan konsistensi hormon yang stabil dan meminimalkan risiko ovulasi.

Jika cincin dilepas atau keluar lebih lama dari periode yang dianjurkan, klien perlu mengikuti rekomendasi klinis untuk memastikan perlindungan kontrasepsi tetap efektif (CDC, 2024).

Jadwal penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi dirancang untuk:

- a. Memastikan perlindungan sejak dini dengan memulai pada waktu yang tepat dalam siklus menstruasi.
- b. Mengatur penggunaan berkala sesuai dengan masing-masing metode (harian untuk pil, mingguan untuk patch, 3-mingguan untuk cincin).
- c. Menjaga efektivitas kontrasepsi melalui kepatuhan jadwal tanpa jeda hormon yang terlalu lama.

Pedoman WHO dan praktik servis KB nasional menjadikan jadwal teratur sebagai bagian penting dari konseling kontrasepsi yang efektif dan aman.

E. Tata Laksana Lupa Pakai

1. Lupa Minum Pil

Langkah awal:

Tentukan jumlah pil yang terlewat dan lamanya keterlambatan.

- a. Terlambat < 24 jam (1 pil terlupa)

Tindakan:

- 1) Minum pil yang terlupa segera setelah ingat.
- 2) Lanjutkan pil berikutnya sesuai jadwal biasa.
- 3) Tidak perlu kontrasepsi tambahan.

Keterangan:

Efektivitas kontrasepsi masih terjaga karena kadar hormon belum menurun secara signifikan.

- b. Terlambat $\geq$ 48 jam ($\geq$ 2 pil terlupa)

Tindakan:

- 1) Minum 1 pil terakhir yang terlupa segera setelah ingat.
- 2) Buang pil yang terlupa sebelumnya.
- 3) Lanjutkan minum pil sesuai jadwal.
- 4) Gunakan metode kontrasepsi tambahan (misalnya kondom) selama 7 hari.

Jika terjadi pada minggu pertama siklus:

- 1) Jika sebelumnya terjadi hubungan seksual tanpa perlindungan → pertimbangkan kontrasepsi darurat.

Jika terjadi pada minggu ketiga:

- 1) Lewati masa bebas pil dan langsung mulai kemasan pil baru.

2. Patch Terlepas atau Terlambat Diganti

a. Patch Lepas <24 jam

- 1) Tempel kembali patch yang sama jika masih dapat menempel.
- 2) Jika tidak dapat menempel, ganti dengan patch baru.
- 3) Jadwal penggantian tetap seperti sebelumnya.
- 4) Tidak perlu kontrasepsi tambahan.

b. Patch Lepas $\geq$ 24 jam atau Patch Terlambat Diganti

- 1) Tempel patch baru segera
- 2) Klien harus menggunakan kontrasepsi cadangan (mis. kondom) selama 7 hari berikutnya
- 3) Hari penggantian selanjutnya tetap dihitung dari patch baru
- 4) Jika ini terjadi pada minggu pertama penggunaan patch pertama kali → pertimbangkan konsultasi untuk evaluasi risiko kehamilan

3. Cincin Terlepas atau Terlambat Dipasang

Penanganan jika cincin keluar, misalnya karena aktivitas fisik atau buang air kecil/besar:

- a. Jika cincin keluar dan kurang dari 3 jam, klien dapat mencuci dengan air bersih dan memasang kembali.
- b. Jika keluar lebih dari 3 jam pada minggu pertama atau kedua, klien perlu menggunakan kontrasepsi tambahan selama 7 hari setelah memasang kembali cincin; pada minggu ketiga harus mempertimbangkan penggantian cincin dan menyesuaikan jadwal.
- c. Kapan harus menghubungi penyedia layanan kesehatan, misalnya jika terjadi nyeri hebat, perdarahan abnormal, atau gejala infeksi. (CDC, 2024; WHO, 2025c)

Prinsip Konseling kepada Klien :

- a. Tenaga kesehatan perlu menekankan beberapa hal berikut kepada pengguna kontrasepsi hormonal kombinasi:
- b. Gunakan kontrasepsi secara teratur dan pada waktu yang sama setiap hari (untuk pil).
- c. Segera lakukan tindakan yang dianjurkan jika terjadi lupa pakai.
- d. Gunakan metode kontrasepsi tambahan apabila terjadi keterlambatan penggunaan.
- e. Pertimbangkan kontrasepsi darurat jika terdapat hubungan seksual tanpa perlindungan setelah kesalahan penggunaan.

- f. Edukasi yang jelas mengenai langkah-langkah tersebut terbukti dapat meningkatkan kepatuhan penggunaan kontrasepsi dan menurunkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan.

F. Penatalaksanaan Keluhan dan Efek Samping

Tabel 6.5
Manajemen Efek Samping Kontrasepsi Hormonal Kombinasi

Keluhan	Patofisiologi	Tatalaksana	Konseling kepada Klien
Spotting / perdarahan tidak teratur	Adaptasi endometrium terhadap perubahan kadar estrogen dan progestin menyebabkan ketidakstabilan pembuluh darah endometrium sehingga terjadi perdarahan bercak.	Anjurkan penggunaan kontrasepsi secara teratur; observasi selama 2–3 siklus; evaluasi kemungkinan infeksi, kehamilan, atau kelainan ginekologis bila perdarahan menetap.	Jelaskan bahwa perdarahan ringan sering terjadi pada awal penggunaan dan biasanya akan membaik setelah beberapa bulan. Anjurkan klien tetap menggunakan kontrasepsi sesuai jadwal.
Mual dan gangguan gastrointestinal	Estrogen memengaruhi pusat muntah di sistem saraf pusat dan meningkatkan sensitivitas mukosa lambung sehingga dapat menimbulkan mual.	Anjurkan konsumsi pil setelah makan atau pada malam hari; pertahankan hidrasi yang cukup; evaluasi jika mual berat atau disertai muntah berulang.	Beritahu klien bahwa mual biasanya terjadi pada awal penggunaan dan umumnya bersifat sementara hingga tubuh beradaptasi dengan hormon.
Nyeri payudara (mastalgia)	Estrogen meningkatkan retensi cairan dan stimulasi jaringan payudara sehingga menimbulkan rasa tegang atau nyeri.	Gunakan bra yang menopang payudara dengan baik; observasi beberapa siklus; evaluasi jika nyeri berat atau menetap.	Jelaskan bahwa keluhan ini umum terjadi pada awal penggunaan dan biasanya berkurang setelah beberapa bulan.
Sakit kepala ringan	Fluktuasi kadar estrogen dapat memengaruhi regulasi neurotransmitter dan tonus vaskular pembuluh darah serebral.	Observasi; anjurkan istirahat yang cukup; berikan analgesik ringan bila diperlukan; evaluasi jika sakit kepala berat atau disertai gejala neurologis.	Informasikan kepada klien untuk segera memeriksakan diri jika sakit kepala berat, terutama jika disertai gangguan penglihatan atau gejala neurologis.

Keluhan	Patofisiologi	Tatalaksana	Konseling kepada Klien
Peningkatan tekanan darah	Estrogen dapat meningkatkan aktivitas sistem renin–angiotensin–aldosteron yang memicu retensi cairan dan vasokonstriksi.	Lakukan pemantauan tekanan darah secara berkala; jika terjadi hipertensi signifikan, pertimbangkan penghentian kontrasepsi kombinasi dan penggunaan metode lain.	Jelaskan pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin selama penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi.
Perubahan pola menstruasi	Pengaruh hormon terhadap endometrium dapat menyebabkan menstruasi lebih ringan, lebih pendek, atau kadang tidak terjadi perdarahan.	Observasi; pastikan kepatuhan penggunaan kontrasepsi; lakukan tes kehamilan jika terdapat kecurigaan kehamilan.	Jelaskan bahwa perubahan pola menstruasi dapat terjadi dan tidak selalu menandakan adanya masalah kesehatan.

(CDC Control and Prevention, 2016; Hatcher, R., 2018; WHO, 2015b, 2025c)

1. Spotting dan Perdarahan Tidak Teratur

Patofisiologi

Perdarahan bercak (spotting) atau perdarahan tidak teratur merupakan efek samping yang paling sering dilaporkan pada pengguna kontrasepsi hormonal kombinasi, terutama pada beberapa siklus pertama penggunaan. Kondisi ini terjadi akibat perubahan stabilitas endometrium yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progestin.

Estrogen berperan dalam merangsang proliferasi endometrium, sedangkan progestin berfungsi menstabilkan lapisan endometrium dan menekan proliferasi yang berlebihan. Pada awal penggunaan kontrasepsi kombinasi, keseimbangan antara kedua hormon tersebut belum sepenuhnya stabil sehingga dapat terjadi ketidakaturan vaskularisasi endometrium. Hal ini menyebabkan fragilitas pembuluh darah endometrium yang kemudian memicu perdarahan ringan atau bercak (Hatcher, R., 2018).

Penatalaksanaan

Dalam sebagian besar kasus, perdarahan ringan ini tidak berbahaya dan akan membaik setelah beberapa siklus penggunaan. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan konseling kepada klien bahwa

kondisi ini bersifat sementara. Klien dianjurkan untuk tetap menggunakan kontrasepsi secara teratur sesuai jadwal.

Apabila perdarahan berlangsung lama atau semakin banyak, tenaga kesehatan perlu melakukan evaluasi untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab lain, seperti infeksi genital, kehamilan, atau kelainan ginekologis lainnya. (WHO, 2025c).

2. Mual dan Gangguan Gastrointestinal

Patofisiologi

Keluhan mual pada pengguna kontrasepsi hormonal kombinasi terutama berkaitan dengan efek hormon estrogen terhadap sistem gastrointestinal. Estrogen dapat memengaruhi pusat muntah di otak serta meningkatkan sensitivitas mukosa lambung, sehingga memicu sensasi mual pada sebagian pengguna.

Selain itu, estrogen juga dapat memengaruhi motilitas gastrointestinal melalui interaksi dengan reseptor hormon pada saluran pencernaan. Perubahan motilitas ini dapat menyebabkan keluhan seperti mual, kembung, atau rasa tidak nyaman pada perut. (Hatcher, R., 2018).

Penatalaksanaan

Penatalaksanaan keluhan ini biasanya bersifat sederhana dan tidak memerlukan penghentian kontrasepsi. Pengguna dapat dianjurkan untuk mengonsumsi pil setelah makan atau pada malam hari untuk mengurangi iritasi pada lambung. Dalam banyak kasus, keluhan mual akan berkurang setelah tubuh beradaptasi terhadap hormon yang diberikan.

Apabila keluhan berlangsung terus-menerus atau disertai muntah berat, tenaga kesehatan perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan tidak terdapat kondisi medis lain yang mendasari keluhan tersebut.

3. Nyeri Payudara dan Sakit Kepala

Patofisiologi

Nyeri payudara (mastalgia) pada pengguna kontrasepsi hormonal kombinasi terjadi akibat pengaruh hormon estrogen terhadap jaringan payudara. Estrogen dapat meningkatkan retensi cairan serta merangsang proliferasi jaringan duktus payudara sehingga menimbulkan sensasi tegang atau nyeri pada payudara.

Sementara itu, sakit kepala dapat terjadi akibat pengaruh fluktuasi hormon estrogen terhadap sistem saraf pusat dan pembuluh darah serebral. Perubahan kadar estrogen dapat memengaruhi regulasi neurotransmitter seperti serotonin serta memicu perubahan tonus vaskular pada pembuluh darah otak.

Penatalaksanaan

Keluhan ini umumnya bersifat ringan dan akan berkurang setelah beberapa siklus penggunaan. Edukasi kepada pengguna sangat penting agar mereka memahami bahwa kondisi ini merupakan efek samping yang umum.

Pengguna dapat dianjurkan untuk menggunakan bra yang nyaman, mengurangi konsumsi kafein, serta melakukan istirahat yang cukup. Namun apabila sakit kepala bersifat berat, terutama yang disertai gangguan penglihatan atau gejala neurologis lain seperti migrain dengan aura, maka penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi perlu dievaluasi karena dapat meningkatkan risiko komplikasi vascular. (CDC Control and Prevention, 2016).

4. Perubahan Tekanan Darah

Patofisiologi

Hormon estrogen dalam kontrasepsi kombinasi dapat memengaruhi sistem kardiovaskular melalui peningkatan aktivitas sistem renin–angiotensin–aldosteron. Aktivasi sistem ini dapat meningkatkan retensi natrium dan cairan sehingga berpotensi menyebabkan peningkatan tekanan darah pada sebagian pengguna.

Selain itu, estrogen juga dapat memengaruhi fungsi endotel pembuluh darah serta meningkatkan sensitivitas terhadap vasokonstriktor. Meskipun peningkatan tekanan darah yang terjadi biasanya ringan, pada perempuan dengan faktor risiko tertentu kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. (WHO, 2015a).

Penatalaksanaan

Sebelum memulai penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi, tenaga kesehatan perlu melakukan skrining tekanan darah sebagai bagian dari pemeriksaan awal. Selama penggunaan kontrasepsi, tekanan darah perlu dipantau secara berkala.

Apabila ditemukan peningkatan tekanan darah yang signifikan atau hipertensi yang tidak terkontrol, penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi perlu dihentikan dan dipertimbangkan metode kontrasepsi lain yang lebih aman.

G. Identifikasi Tanda Bahaya (ACHES) dan Rujukan

Tabel 6.6

Tanda Bahaya Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Kombinasi (ACHES)

Akronim	Gejala Klinis	Kemungkinan Penyebab / Patofisiologi	Tindakan yang Dianjurkan
A – Abdominal pain (nyeri perut hebat)	Nyeri perut bagian bawah atau perut hebat yang muncul tiba-tiba	Dapat berkaitan dengan gangguan hepatic, kista ovarium yang pecah, atau kehamilan ektopik	Hentikan sementara penggunaan kontrasepsi dan segera lakukan evaluasi medis untuk menyingkirkan kondisi ginekologis atau hepatic
C – Chest pain (nyeri dada atau sesak napas)	Nyeri dada mendadak, sesak napas, atau batuk darah	Dapat mengindikasikan emboli paru atau gangguan kardiovaskular akibat pembentukan trombus	Segera rujuk ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan dan penanganan emergensi
H – Headache (sakit kepala hebat)	Sakit kepala berat yang tiba-tiba atau migrain dengan gangguan neurologis	Perubahan tonus vaskular serebral atau risiko stroke akibat trombosis pembuluh darah otak	Hentikan penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi dan lakukan evaluasi neurologis
E – Eye problems (gangguan penglihatan)	Penglihatan kabur, kehilangan penglihatan sementara, atau gangguan visual lainnya	Dapat berkaitan dengan trombosis pembuluh darah retina atau gangguan vaskular serebral	Segera lakukan pemeriksaan medis untuk menilai kemungkinan gangguan vaskular
S – Severe leg pain (nyeri tungkai berat)	Nyeri atau pembengkakan pada tungkai, terutama pada betis	Dapat mengindikasikan deep vein thrombosis akibat peningkatan koagulabilitas darah	Hentikan penggunaan kontrasepsi dan segera lakukan pemeriksaan medis

(CDC Control and Prevention, 2016; Hatcher, R., 2018; Kemenkes RI, 2020; WHO, 2015b)

Tanda bahaya ACHES berkaitan dengan efek hormon estrogen dalam kontrasepsi kombinasi yang dapat memengaruhi sistem koagulasi darah. Estrogen dapat meningkatkan produksi beberapa faktor koagulasi di hati sehingga meningkatkan risiko pembentukan trombus pada individu yang memiliki faktor risiko tertentu. Oleh karena itu, pengguna kontrasepsi hormonal kombinasi perlu

diberikan edukasi mengenai gejala-gejala tersebut agar dapat segera mencari pertolongan medis apabila gejala muncul.

Dalam praktik pelayanan keluarga berencana, tenaga kesehatan perlu menekankan bahwa kejadian komplikasi serius relatif jarang terjadi, namun pengenalan dini terhadap tanda bahaya sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih berat. Edukasi mengenai tanda bahaya ini sebaiknya diberikan pada saat konseling awal serta diulang pada kunjungan ulang.

H. Latihan Soal:

Latihan Kasus:

Berikut Adalah sebuah scenario Latihan kasus untuk memahami Bab di atas.

Kasus:

Seorang perempuan berusia 28 tahun, G1P1A0, datang ke klinik KB untuk kontrol. Ia telah menggunakan pil kontrasepsi hormonal kombinasi regimen 21/7 selama 4 bulan. Pasien mengatakan dalam dua hari terakhir lupa minum pil, dan pada hari ini ia mengalami perdarahan bercak (spotting). Pasien juga mengeluhkan mual ringan pada pagi hari sejak mulai menggunakan pil, namun keluhan tersebut tidak terlalu mengganggu aktivitasnya.

Riwayat kesehatan:

1. Tidak merokok
2. Tekanan darah: 110/70 mmHg
3. Tidak ada riwayat migrain dengan aura
4. Tidak ada riwayat trombosis
5. Pasien mengatakan masih ingin menunda kehamilan selama 3–4 tahun.

Pertanyaan Analisis Kasus :

Mahasiswa diminta menganalisis kasus dengan menjawab pertanyaan berikut:

1. Identifikasi masalah utama pada kasus di atas.
2. Jelaskan patofisiologi terjadinya spotting pada penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi.
3. Berdasarkan pedoman WHO dan BKKBN, bagaimana tata laksana lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut?
4. Apakah pasien perlu menggunakan kontrasepsi tambahan? Jelaskan alasan ilmiahnya.
5. Apa saja konseling yang harus diberikan kepada pasien terkait efek samping yang dialami?

6. Berdasarkan kondisi pasien, apakah metode kontrasepsi hormonal kombinasi masih dapat dilanjutkan? Jelaskan alasan klinisnya.
7. Jika pasien ingin mencoba metode lain dalam kelompok kontrasepsi hormonal kombinasi, metode apa yang dapat direkomendasikan (patch atau cincin vagina)? Jelaskan kelebihan dan kekurangannya.

Tugas Mahasiswa:

Berdasarkan kasus di atas:

Tugas 1 – Analisis Kasus Klinis

Mahasiswa diminta membuat laporan analisis kasus dengan sistematika berikut:

1. Identifikasi masalah klinis
2. Analisis patofisiologi
3. Penatalaksanaan berdasarkan evidence-based guideline
4. Rencana konseling kepada pasien
5. Rencana monitoring dan follow-up

Panjang laporan: 3–4 halaman

Tugas 2 – Pembuatan Algoritma Klinis

Mahasiswa diminta membuat diagram algoritma penatalaksanaan lupa pakai kontrasepsi hormonal kombinasi yang mencakup:

1. Lupa 1 pil
2. Lupa 2 pil
3. Lupa ≥ 3 pil
4. Patch terlambat diganti
5. Cincin vagina terlepas

Algoritma dibuat berdasarkan pedoman:

1. WHO Medical Eligibility Criteria
2. WHO Selected Practice Recommendations
3. Pedoman Pelayanan KB BKKBN

Tugas 3 – Konseling Simulasi

Mahasiswa melakukan simulasi konseling KB berbasis informed choice dengan skenario:

Pasien mengalami efek samping spotting dan mual saat menggunakan pil kombinasi.

Mahasiswa harus menjelaskan:

1. Penyebab keluhan
2. Apakah kondisi tersebut berbahaya atau tidak
3. Cara mengatasi keluhan
4. Tanda bahaya penggunaan kontrasepsi hormonal (ACHES)
5. Kapan pasien harus kembali kontrol

Simulasi dilakukan secara role play bidan–pasien.

Output yang Harus Dikumpulkan Mahasiswa

1. Laporan analisis kasus
2. Algoritma penatalaksanaan
3. Video atau laporan simulasi konseling

Kunci Jawaban:

Kunci Jawaban Latihan Kasus

1. Identifikasi masalah utama

Masalah utama pada kasus ini meliputi:

- a. Lupa minum pil kontrasepsi kombinasi selama 2 hari berturut-turut.
- b. Terjadinya spotting (perdarahan bercak).
- c. Keluhan mual ringan sejak penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi.

Lupa minum pil selama ≥ 2 hari dapat menyebabkan penurunan kadar hormon estrogen dan progestin dalam darah, sehingga supresi ovulasi menjadi tidak optimal dan meningkatkan risiko ovulasi serta kehamilan. Selain itu, fluktuasi hormon juga dapat menyebabkan perdarahan tidak teratur (*breakthrough bleeding/spotting*).

2. Patofisiologi spotting pada penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi

Spotting pada pengguna kontrasepsi hormonal kombinasi umumnya terjadi akibat ketidakseimbangan hormonal pada endometrium.

Secara fisiologis:

- a. Estrogen: Berfungsi menstabilkan proliferasi endometrium.
- b. Progestin: Menyebabkan transformasi sekretorik endometrium dan menekan proliferasi.

Pada penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi, terutama bila pil terlambat atau terlewat, kadar hormon menjadi tidak stabil sehingga terjadi :

- a. Penurunan kadar estrogen sementara
- b. Atrofi endometrium
- c. Fragilitas pembuluh darah endometrium

Akibatnya, lapisan endometrium menjadi tidak stabil dan mudah mengalami perdarahan bercak (*breakthrough bleeding*). Spotting juga sering terjadi pada 3–6 bulan pertama penggunaan kontrasepsi hormonal, karena endometrium masih dalam proses adaptasi terhadap paparan hormon eksogen.

3. Tata laksana lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut

Berdasarkan WHO *Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use*, penatalaksanaan lupa minum pil ≥ 2 hari adalah sebagai berikut:

- a. Segera minum pil terakhir yang terlupa
 - 1) Minum 1 pil yang terakhir terlupa sesegera mungkin.
 - 2) Pil yang terlupa sebelumnya tidak perlu diminum semuanya.
- b. Lanjutkan pil berikutnya sesuai jadwal
Pil berikutnya diminum pada waktu biasa.
- c. Gunakan kontrasepsi tambahan
Gunakan metode kontrasepsi tambahan (misalnya kondom) selama 7 hari berikutnya.
- d. Jika lupa terjadi pada minggu pertama
Pertimbangkan kontrasepsi darurat bila terjadi hubungan seksual tanpa perlindungan dalam 5 hari terakhir.
- e. Jika pil aktif habis
Langsung mulai kemasan baru tanpa jeda 7 hari.

4. Apakah pasien perlu menggunakan kontrasepsi tambahan?

Ya, pasien perlu menggunakan kontrasepsi tambahan selama 7 hari.

Alasannya:

Lupa minum pil selama ≥ 48 jam dapat menyebabkan:

- a. Penurunan kadar hormon
- b. Supresi ovulasi menjadi tidak optimal
- c. Meningkatkan kemungkinan ovulasi

Penggunaan kondom atau abstinensi seksual selama 7 hari diperlukan untuk memastikan kadar hormon kembali cukup untuk menekan ovulasi.

5. Konseling yang harus diberikan kepada pasien

Konseling yang diberikan meliputi:

a. Penjelasan tentang spotting

Pasien perlu dijelaskan bahwa:

- 1) Spotting merupakan efek samping yang sering terjadi
- 2) Umumnya terjadi pada 3–6 bulan pertama penggunaan
- 3) Kondisi ini tidak berbahaya

Pasien dianjurkan untuk tetap melanjutkan penggunaan pil sesuai jadwal.

b. Penanganan mual

Mual merupakan efek samping estrogen yang sering terjadi pada awal penggunaan.

Cara mengurangi mual:

- 1) Minum pil pada malam hari
- 2) Minum pil setelah makan
- 3) Hindari perut kosong saat minum pil

Keluhan biasanya membaik setelah 2–3 bulan penggunaan.

c. Edukasi kepatuhan penggunaan

Pasien perlu diingatkan:

- 1) Minum pil pada waktu yang sama setiap hari
- 2) Gunakan alarm atau pengingat
- 3) Segera minum pil jika terlupa

d. Edukasi tanda bahaya (ACHES)

Pasien harus segera ke fasilitas kesehatan bila mengalami:

Singkatan Tanda Bahaya

- A Abdominal pain berat
- C Chest pain atau sesak napas
- H Headache berat atau migrain dengan aura
- E Eye problems (penglihatan kabur)
- S Severe leg pain (nyeri tungkai/trombosis)

Tanda tersebut dapat menunjukkan komplikasi serius seperti tromboemboli.

e. Apakah metode kontrasepsi ini masih dapat dilanjutkan?

Ya, kontrasepsi hormonal kombinasi masih dapat dilanjutkan.

Alasannya: Pasien tidak memiliki kontraindikasi penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi, yaitu:

- 1) Tidak merokok
- 2) Usia <35 tahun
- 3) Tidak ada riwayat trombosis
- 4) Tidak ada migrain dengan aura

5) Tekanan darah normal

Menurut WHO Medical Eligibility Criteria, kondisi ini termasuk Kategori 1 atau 2, sehingga penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi aman untuk dilanjutkan.

f. Alternatif metode kontrasepsi hormonal kombinasi

Jika pasien ingin mencoba metode lain, dua pilihan yang dapat direkomendasikan adalah:

Patch transdermal:

Patch kontrasepsi ditempelkan pada kulit dan diganti setiap minggu.

Kelebihan:

- 1) Tidak perlu diminum setiap hari
- 2) Kepatuhan penggunaan lebih baik
- 3) Efektivitas tinggi

Kekurangan :

- 1) Dapat menyebabkan iritasi kulit
- 2) Kurang efektif pada wanita dengan berat badan >90 kg
- 3) Patch dapat terlepas

Cincin vagina

Cincin vagina dimasukkan ke dalam vagina selama 3 minggu.

Kelebihan:

- 1) Hormon dilepaskan secara stabil
- 2) Dosis hormon lebih rendah
- 3) Tidak perlu diingat setiap hari

Kekurangan:

- 1) Beberapa wanita merasa tidak nyaman
- 2) Cincin dapat terlepas
- 3) Memerlukan kemampuan memasang sendiri

Latihan Soal:

1. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke klinik untuk konsultasi KB. Ia sudah memiliki satu anak dan tidak ingin hamil dalam waktu dekat. Riwayat kesehatan baik, tidak merokok, tekanan darah 110/70 mmHg. Ia tertarik menggunakan pil KB kombinasi. Bidan menjelaskan mekanisme kerja utama kontrasepsi hormonal kombinasi. Bagaimana mekanisme kerja utama kontrasepsi tersebut?

A. Menghambat implantasi embrio

- B. Menghambat ovulasi melalui supresi hormon FSH dan LH
- C. Menghancurkan sperma dalam uterus
- D. Menebalkan lapisan endometrium
- E. Menghentikan siklus menstruasi

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Kontrasepsi hormonal kombinasi mengandung estrogen dan progestin yang bekerja terutama dengan menghambat ovulasi melalui mekanisme umpan balik negatif pada hipotalamus dan hipofisis. Estrogen menekan sekresi FSH, sedangkan progestin menekan LH surge, sehingga proses pematangan folikel dan pelepasan ovum tidak terjadi. Selain itu, progestin juga menebalkan mukus serviks sehingga menghambat penetrasi sperma dan menyebabkan perubahan endometrium yang kurang reseptif terhadap implantasi. Mekanisme utama tetap supresi ovulasi.

2. Seorang perempuan usia 30 tahun menggunakan pil kombinasi regimen 21/7. Ia lupa minum pil pada hari ke-10 dan baru ingat keesokan harinya. Apakah tindakan yang paling tepat?
- A. Menghentikan pil dan menunggu menstruasi
 - B. Minum dua pil sekaligus dan melanjutkan seperti biasa
 - C. Mengganti metode kontrasepsi
 - D. Menggunakan kontrasepsi darurat
 - E. Menghentikan pil selama 7 hari

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Menurut pedoman pelayanan KB, apabila seorang akseptor lupa minum satu pil kombinasi (<48 jam) maka tindakan yang dianjurkan adalah:

- a. Segera minum pil yang terlupa
- b. Lanjutkan minum pil berikutnya sesuai jadwal
- c. Tidak diperlukan kontrasepsi tambahan

Kadang akseptor harus minum dua pil pada hari yang sama untuk mengganti pil yang terlupa. Metode ini tetap mempertahankan kadar hormon yang cukup untuk menekan ovulasi sehingga efektivitas kontrasepsi tetap terjaga.

3. Seorang perempuan usia 28 tahun menggunakan patch kontrasepsi transdermal. Saat kontrol, ia bertanya kapan patch harus diganti dalam satu siklus penggunaan. Bagaimana jadwal penggunaan patch yang benar?
- A. Diganti setiap hari
 - B. Diganti setiap minggu selama 3 minggu, kemudian 1 minggu tanpa patch
 - C. Diganti setiap 2 minggu
 - D. Dipakai selama 4 minggu tanpa jeda
 - E. Diganti setiap bulan

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Patch kontrasepsi transdermal bekerja dengan melepaskan hormon etinil estradiol dan progestin melalui kulit secara kontinu ke dalam sirkulasi sistemik.

Regimen penggunaan standar adalah:

- a. Patch dipasang selama 3 minggu berturut-turut
- b. Patch diganti setiap minggu
- c. Minggu ke-4 tidak menggunakan patch untuk memungkinkan terjadinya perdarahan withdrawal

Regimen ini menyerupai pola penggunaan pil kombinasi 21/7.

4. Seorang perempuan usia 32 tahun menggunakan kontrasepsi cincin vagina. Ia menanyakan berapa lama cincin harus berada di dalam vagina sebelum dilepas. Jawaban yang tepat adalah:
- A. 1 minggu
 - B. 2 minggu
 - C. 3 minggu
 - D. 4 minggu
 - E. 5 minggu

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Cincin vagina merupakan alat kontrasepsi hormonal yang melepaskan etinil estradiol dan etonogestrel secara perlahan melalui mukosa vagina. Regimen penggunaan standar Adalah :

- a. Cincin dipasang di vagina selama 3 minggu
- b. Setelah itu dilepas selama 1 minggu
- c. Pada minggu bebas cincin terjadi perdarahan withdrawal
- d. Setelah 7 hari, cincin baru dipasang kembali

Metode ini memberikan kadar hormon stabil dan meningkatkan kepatuhan pengguna.

5. Seorang perempuan usia 36 tahun datang ke klinik untuk menggunakan kontrasepsi hormonal kombinasi. Ia memiliki riwayat merokok 20 batang per hari. Apakah keputusan bidan yang paling tepat?
- A. Memberikan pil kombinasi dosis rendah
 - B. Memberikan patch
 - C. Memberikan cincin vagina
 - D. Tidak memberikan kontrasepsi hormonal kombinasi
 - E. Memberikan pil kombinasi siklus panjang

Kunci Jawaban:

D

Pembahasan:

Menurut WHO Medical Eligibility Criteria, wanita yang:

- a. berusia ≥ 35 tahun
 - b. dan merokok ≥ 15 batang per hari
- termasuk kategori 4 (kontraindikasi absolut) untuk kontrasepsi hormonal kombinasi. Estrogen meningkatkan risiko tromboemboli dan penyakit kardiovaskular, yang akan semakin tinggi pada perokok usia lebih dari 35 tahun. Oleh karena itu, metode ini tidak boleh diberikan dan bidan harus menyarankan metode lain seperti IUD, implan, atau kontrasepsi progestin saja.

6. Seorang akseptor pil kombinasi mengeluhkan perdarahan bercak (spotting) pada tiga bulan pertama penggunaan. Bagaimana penjelasan bidan yang paling tepat?
- A. Efek samping normal pada awal penggunaan
 - B. Tanda kegagalan kontrasepsi
 - C. Tanda kehamilan
 - D. Harus segera menghentikan pil
 - E. Efek samping berbahaya

Kunci Jawaban: A

Pembahasan:

Perdarahan bercak atau spotting merupakan efek samping yang sering terjadi pada 3 bulan pertama penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi. Hal ini terjadi karena endometrium sedang beradaptasi terhadap perubahan kadar hormon estrogen dan progestin. Pada sebagian besar kasus, keluhan ini akan

berkurang setelah beberapa siklus penggunaan. Penatalaksanaan utama adalah memberikan konseling dan melanjutkan penggunaan metode kecuali terdapat tanda bahaya.

7. Seorang perempuan menggunakan pil kombinasi dan datang dengan keluhan sakit kepala berat disertai gangguan penglihatan seperti kilatan cahaya. Bagaimana tindakan bidan?
- A. Melanjutkan penggunaan pil
 - B. Mengurangi dosis pil
 - C. Menghentikan kontrasepsi dan merujuk
 - D. Menambahkan obat analgesik
 - E. Menyarankan istirahat

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Sakit kepala berat yang disertai gangguan penglihatan dapat menunjukkan migrain dengan aura. Kondisi ini merupakan kontraindikasi penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi karena meningkatkan risiko stroke iskemik. Oleh karena itu, tindakan yang tepat adalah:

- a. Menghentikan penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi
- b. Melakukan evaluasi medis lebih lanjut atau rujukan

8. Seorang perempuan usia 24 tahun ingin mulai menggunakan pil kombinasi. Ia datang pada hari pertama menstruasi. Kapan pil sebaiknya mulai diminum?
- A. Setelah menstruasi selesai
 - B. Hari pertama menstruasi
 - C. Hari ke-10 siklus
 - D. Setelah ovulasi
 - E. Satu minggu setelah menstruasi

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Metode quick start yang dianjurkan dalam pelayanan KB adalah memulai pil pada hari pertama menstruasi. Cara ini memberikan beberapa keuntungan:

- a. Perlindungan kontrasepsi langsung efektif
- b. Memastikan klien tidak sedang hamil
- c. Mengurangi kemungkinan spotting

9. Seorang akseptor menggunakan cincin vagina, namun cincin tersebut terlepas selama 4 jam. Apakah tindakan yang tepat?
- A. Menghentikan penggunaan
 - B. Mengganti dengan cincin baru
 - C. Membilas dan memasang kembali cincin
 - D. Menggunakan kontrasepsi darurat
 - E. Menunggu menstruasi berikutnya

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Apabila cincin vagina terlepas kurang dari 48 jam, tindakan yang dianjurkan adalah:

- a. Membilas cincin dengan air bersih
- b. Memasang kembali sesegera mungkin

Jika terlepas lebih dari 48 jam, maka diperlukan kontrasepsi tambahan selama 7 hari.

10. Seorang perempuan usia 29 tahun menggunakan patch kontrasepsi. Saat kontrol, tekanan darahnya meningkat menjadi 150/100 mmHg. Apakah tindakan yang paling tepat?
- A. Melanjutkan penggunaan patch
 - B. Mengganti lokasi patch
 - C. Menghentikan kontrasepsi hormonal kombinasi
 - D. Menurunkan dosis hormon
 - E. Mengganti patch setiap 2 minggu

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Kontrasepsi hormonal kombinasi dapat meningkatkan tekanan darah melalui efek estrogen pada sistem renin-angiotensin-aldosteron. Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg merupakan kondisi yang memerlukan evaluasi ulang penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi. Pada hipertensi berat, metode ini harus dihentikan dan diganti dengan metode yang lebih aman seperti IUD atau kontrasepsi progestin saja.

I. Rangkuman Materi

Bab ini membahas secara komprehensif mengenai kontrasepsi hormonal kombinasi yang merupakan metode kontrasepsi modern yang mengandung kombinasi hormon estrogen dan progestin yang bekerja terutama dengan menghambat ovulasi, menebalkan mukus serviks, serta mengubah endometrium sehingga tidak mendukung implantasi. Metode ini tersedia dalam beberapa bentuk sediaan, yaitu pil kombinasi (*combined oral contraceptives*), patch transdermal, dan cincin vagina, yang masing-masing memiliki regimen penggunaan, jadwal pemakaian, serta karakteristik farmakologis yang berbeda. Sebelum penggunaan, tenaga kesehatan perlu melakukan skrining kelayakan medis melalui anamnesis, pemeriksaan tekanan darah, serta penilaian faktor risiko sesuai pedoman *World Health Organization* melalui *Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use*, serta pedoman nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Selain pemahaman tentang jadwal penggunaan dan regimen (seperti 21/7, 24/4, dan extended cycle), tenaga kesehatan juga harus mampu melakukan penatalaksanaan terhadap kondisi lupa pakai, menangani efek samping yang sering muncul seperti spotting, mual, nyeri payudara, atau perubahan tekanan darah, serta mengenali tanda bahaya penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi melalui prinsip ACHES. Pelayanan kontrasepsi hormonal kombinasi juga harus disertai konseling berbasis informed choice, sehingga klien memperoleh informasi yang lengkap mengenai manfaat, risiko, cara penggunaan, dan alternatif metode kontrasepsi lainnya, sehingga keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan reproduksi, dan preferensi pengguna. Pendekatan yang berbasis bukti ilmiah dan konseling yang komprehensif akan meningkatkan keamanan, kepatuhan penggunaan, serta efektivitas metode kontrasepsi hormonal kombinasi dalam mendukung program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

J. Glosarium

ACHES	Akronim dari <i>Abdominal pain, Chest pain, Headache severe, Eye problems, Severe leg pain</i> yang digunakan sebagai tanda bahaya pada pengguna kontrasepsi hormonal kombinasi yang memerlukan evaluasi medis segera.
Anamnesis	Proses pengumpulan informasi riwayat kesehatan klien melalui wawancara untuk menilai kondisi medis sebelum pemberian metode kontrasepsi.
Cincin (Vaginal Ring)	Vagina Metode kontrasepsi hormonal kombinasi berbentuk cincin fleksibel yang dimasukkan ke dalam vagina dan secara kontinu

		melepaskan hormon estrogen dan progestin untuk mencegah ovulasi.
Combined Hormonal Contraception (CHC)		Metode kontrasepsi yang mengandung kombinasi hormon estrogen dan progestin yang bekerja menghambat ovulasi serta mengubah mukus serviks dan endometrium.
Combined Contraceptives (COC)	Oral	Pil kontrasepsi yang mengandung kombinasi estrogen dan progestin yang diminum setiap hari untuk mencegah kehamilan.
Efektivitas Kontrasepsi		Kemampuan suatu metode kontrasepsi dalam mencegah kehamilan selama periode penggunaan tertentu, biasanya dinyatakan sebagai persentase keberhasilan dalam satu tahun penggunaan.
Estrogen		Hormon steroid yang berperan dalam siklus reproduksi perempuan dan dalam kontrasepsi hormonal berfungsi menekan sekresi FSH sehingga mencegah pematangan folikel ovarium.
Extended Cycle		Regimen penggunaan pil kombinasi yang memperpanjang durasi konsumsi hormon aktif hingga 84 hari atau lebih sebelum periode bebas hormon.
Informed Choice		Prinsip pelayanan keluarga berencana yang menekankan hak klien untuk memilih metode kontrasepsi secara sukarela setelah mendapatkan informasi lengkap, objektif, dan mudah dipahami.
Indikasi Penggunaan		Kondisi atau situasi klinis yang memungkinkan seorang perempuan menggunakan metode kontrasepsi tertentu dengan aman dan efektif.
Kontraindikasi		Kondisi medis tertentu yang menyebabkan suatu metode kontrasepsi tidak boleh digunakan karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.
Medical Eligibility Criteria (MEC)	Eligibility	Pedoman yang dikembangkan untuk menilai kelayakan penggunaan metode kontrasepsi berdasarkan kondisi kesehatan individu.
Monofasik		Jenis pil kontrasepsi kombinasi yang memiliki dosis hormon yang sama pada setiap tablet aktif dalam satu siklus penggunaan.
Bifasik		Jenis pil kombinasi yang memiliki dua tingkat dosis hormon berbeda dalam satu siklus untuk meniru perubahan hormonal alami selama siklus menstruasi.
Trifasik		Jenis pil kombinasi yang memiliki tiga variasi dosis hormon dalam satu siklus penggunaan untuk menyesuaikan pola hormon fisiologis siklus menstruasi.

Patch Transdermal	Metode kontrasepsi hormonal kombinasi berbentuk plester yang ditempelkan pada kulit dan melepaskan hormon estrogen dan progestin secara sistemik melalui kulit.
Progestin	Hormon sintetis yang memiliki efek biologis menyerupai progesteron dan digunakan dalam kontrasepsi untuk menghambat ovulasi serta menebalkan mukus serviks.
Regimen 21/7	Pola penggunaan pil kontrasepsi kombinasi yang terdiri dari 21 hari pil aktif dan 7 hari periode bebas hormon.
Regimen 24/4	Pola penggunaan pil kombinasi yang terdiri dari 24 pil aktif dan 4 hari pil tanpa hormon untuk mengurangi fluktuasi hormon.
Skrining Medis	Proses penilaian kondisi kesehatan klien sebelum pemberian kontrasepsi untuk memastikan metode yang dipilih aman digunakan.
Spotting	Perdarahan ringan di luar siklus menstruasi yang sering terjadi pada awal penggunaan kontrasepsi hormonal.
Tekanan Darah	Parameter fisiologis yang perlu dipantau pada pengguna kontrasepsi hormonal kombinasi karena hormon estrogen dapat memengaruhi sistem kardiovaskular.
Trombosis	Pembentukan bekuan darah dalam pembuluh darah yang merupakan salah satu komplikasi serius yang jarang tetapi perlu diwaspadai pada penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi.

K. Referensi

All, E. (n.d.). *About Medicine*. 24–27.

CDC. (2024). *Combined Hormonal Contraceptives* (Vol. 2024, Issue Box 3). https://www.cdc.gov/contraception/hcp/usspr/combined-hormonal-contraceptives.html?utm_source=chatgpt.com

CDC Control and Prevention, U. . D. of H. A. human S. (2016). *U . S . Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use , 2016* (Vol. 65, Issue 4).

CDC Control and Prevention, U. . D. of H. A. human S. (2024a). *U . S . Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use , 2024* (Vol. 73, Issue 4). <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/rr/rr7304a1.htm>

CDC Control and Prevention, U. . D. of H. A. human S. (2024b). *U . S . Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use , 2024* (Vol. 73, Issue 3). US Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/rr/rr7303a1.htm>

Clinic, M. (2025). *Combination birth control pills*. 2–4.

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/combination-birth-control-pills/about/pac-20385282?utm_source=chatgpt.com

Gallo, M. F., Grimes, D. A., & Schulz, K. F. (2003). Skin patch and vaginal ring versus combined oral contraceptives for contraception. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 1, CD003552. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003552>

Hatcher, R., et al. (2018). *Contraceptive Technology* (21st ed). Ayer Company Publishers.

Kemenkes RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana*. <https://repository.kemkes.go.id/book/571>

Kemenkes RI dan BKKBN. (2019). *Rekomendasi Praktik Terpilih Pada Penggunaan Kontrasepsi*.

MSD Manual. (2025). *Hormonal Methods of Contraception*. 1–11. https://www.msmanuals.com/home/women-s-health-issues/family-planning/hormonal-methods-of-contraception?utm_source=chatgpt.com#Contraceptive-Injections_v8951423

NICHD. (n.d.). Contraception and Birth Control. *Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)*. (n.d.), 1–15. <https://www.nichd.nih.gov/health/topics/factsheets/contraception>

Patch, C., Contraception, T., & Evra, O. (n.d.). *Contraceptive Patch*. 8–9.

SL, C. I. (2020). *Application 2020 Etonogestrel/ Ethynilestradiol Vaginal Ring*.

Teal, S., & Edelman, A. (2021). Contraception Selection, Effectiveness, and Adverse Effects: A Review. *JAMA*, 326(24), 2507–2518. <https://doi.org/10.1001/jama.2021.21392>

WHO. (2015a). Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. In *Medical eligibility criteria for contraceptive use* (Fifth, Issue February). WHO. <https://doi.org/10.3109/14647273.2011.602520>

WHO. (2015b). *Medical eligibility criteria for contraceptive use - Executive summary* (5th ed.). WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549158>

WHO. (2025a). *Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use Sixth Edition*. <https://doi.org/10.15585/mmwr.rr6503a1>.

WHO. (2025b). *Oral contraceptives 23*. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/oral-contraceptives#>

WHO. (2025c). *Selected practice recommendations for contraceptive use Fourth Edition*.

Yurissetiowati, dkk. (2024). *Bunga Rampai: Ketrampilan Klinis dalam Praktik*

Kebidanan Untuk D3 Kebidanan (Issue 1). Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta.

BAB 7

KONTRASEPSI PROGESTIN SAJA: SUNTIK, PIL, DAN IMPLAN SERTA TATALAKSANA EFEK SAMPING

Capaian Pembelajaran Lulusan

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan regulasi dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.	CPMK-1, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi berpusat pada klien/keluarga untuk mendukung pengambilan keputusan kontrasepsi.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan, pencegahan infeksi, serta perlindungan privasi dan kerahasiaan dalam layanan KB/kespro.	CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7
CPL-4	Menganalisis data klinis dan konteks klien untuk pengambilan keputusan berbasis bukti terkait pemilihan dan tindak lanjut kontrasepsi.	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-5, CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan layanan KB dan tindak lanjut secara aman, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan klien (metode, edukasi, pemantauan).	CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6
CPL-6	Mengelola layanan KB/kespro melalui pencatatan-pelaporan, logistik, rujukan, evaluasi mutu, dan perbaikan berkelanjutan.	CPMK-7, CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep, tujuan, kebijakan, serta aspek etika–legal keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi sistem reproduksi dan regulasi fertilitas sebagai dasar pemilihan metode kontrasepsi.
CPMK-3	Mengevaluasi kebutuhan, preferensi, dan hak kesehatan reproduksi klien dengan pendekatan berpusat pada klien.
CPMK-4	Merancang dan menerapkan konseling KB efektif (komunikasi, informed choice, skrining kelayakan) serta rencana tindak lanjut.
CPMK-5	Menentukan pilihan metode kontrasepsi yang tepat dan menyusun edukasi penggunaan sesuai kelayakan, kondisi, dan bukti.
CPMK-6	Menangani efek samping/komplikasi KB, menetapkan tindakan awal, serta menentukan kebutuhan rujukan secara aman.
CPMK-7	Mengelola pelayanan KB/kespro (IMS/HIV, logistik, pencatatan–pelaporan, mutu, keselamatan, evaluasi kepuasan) berbasis data.

Uraian Materi

Kontrasepsi merupakan salah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi yang bertujuan membantu pasangan usia subur merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak secara aman dan bertanggung jawab. Penggunaan metode kontrasepsi yang tepat berperan dalam mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mendukung keberhasilan program keluarga berencana. Upaya pengaturan kelahiran melalui kontrasepsi juga berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga (World Health Organization, 2022).

Data global menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi modern terus mengalami peningkatan. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa sekitar 65% perempuan usia reproduksi yang menikah atau hidup bersama pasangan menggunakan metode kontrasepsi modern untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan (World Health Organization, 2022). Metode kontrasepsi hormonal, termasuk pil, suntik, dan implan, merupakan kelompok metode yang banyak digunakan karena memiliki efektivitas tinggi serta relatif mudah digunakan oleh akseptor. Metode kontrasepsi berbasis progestin, terutama kontrasepsi suntik dan implan, menjadi salah satu pilihan utama dalam program keluarga berencana di berbagai negara berkembang (Jacobstein & Polis, 2014).

Kondisi serupa juga terlihat di Indonesia. Data yang dilaporkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan usia subur menggunakan metode kontrasepsi modern sebagai upaya pengaturan kelahiran. Metode kontrasepsi hormonal, khususnya kontrasepsi suntik dan pil, termasuk metode yang paling banyak dipilih oleh akseptor keluarga berencana di Indonesia (BKKBN, 2022). Tingginya penggunaan metode kontrasepsi hormonal menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik, mekanisme kerja, serta keamanan berbagai metode kontrasepsi hormonal dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

Kontrasepsi hormonal secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kontrasepsi kombinasi dan kontrasepsi progestin saja. Kontrasepsi kombinasi mengandung dua jenis hormon, yaitu estrogen dan progestin. Kontrasepsi progestin saja hanya mengandung hormon progestin tanpa kombinasi estrogen. Perbedaan komposisi hormon tersebut menyebabkan perbedaan karakteristik penggunaan, mekanisme kerja, serta indikasi klinis masing-masing metode kontrasepsi (McCann & Potter, 1994).

Kontrasepsi progestin saja dikembangkan sebagai alternatif bagi wanita yang memiliki kontraindikasi terhadap penggunaan estrogen. Metode ini direkomendasikan

bagi wanita dengan kondisi tertentu seperti ibu menyusui, wanita dengan riwayat tromboemboli, hipertensi tertentu, atau migrain dengan aura yang tidak dianjurkan menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen (Żyła et al., 2025). Risiko tromboemboli pada kontrasepsi progestin juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan kontrasepsi hormonal kombinasi yang mengandung estrogen.

Kontrasepsi progestin saja tersedia dalam beberapa bentuk sediaan, antara lain pil progestin saja (progestin-only pill), kontrasepsi suntik progestin, serta kontrasepsi implan yang ditanam di bawah kulit. Setiap metode memiliki karakteristik penggunaan, durasi kerja, serta tingkat efektivitas yang berbeda. Pemilihan metode kontrasepsi perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan, kebutuhan reproduksi, serta preferensi klien sehingga metode yang dipilih dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap kehamilan (Jacobstein & Polis, 2014).

Hormon progestin bekerja melalui beberapa mekanisme dalam mencegah terjadinya kehamilan. Mekanisme tersebut meliputi penghambatan ovulasi melalui penekanan hormon gonadotropin, peningkatan kekentalan mukus serviks yang menghambat penetrasi sperma, serta perubahan pada endometrium yang menyebabkan lingkungan uterus menjadi kurang mendukung proses implantasi embrio (Bastianelli et al., 2020). Efektivitas metode kontrasepsi progestin cukup tinggi apabila digunakan secara benar dan konsisten.

Kontrasepsi progestin saja memiliki peran penting dalam pelayanan keluarga berencana pada ibu menyusui. Penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi yang mengandung estrogen dapat memengaruhi produksi air susu ibu, terutama pada periode awal menyusui. Hormon progestin tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap produksi maupun komposisi air susu ibu sehingga metode ini dianggap aman digunakan selama masa laktasi (Kapp, Curtis, & Nanda, 2010). Organisasi Kesehatan Dunia melalui pedoman Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use menyatakan bahwa metode kontrasepsi progestin saja termasuk metode yang aman digunakan pada ibu menyusui dengan mempertimbangkan waktu pemberian setelah persalinan (World Health Organization, 2015).

Penggunaan kontrasepsi progestin saja juga dapat menimbulkan beberapa efek samping yang perlu dipahami oleh tenaga kesehatan maupun akseptor. Efek samping yang sering dilaporkan antara lain perubahan pola menstruasi, perdarahan tidak teratur, amenore, peningkatan berat badan, serta perubahan suasana hati. Sebagian besar efek samping bersifat ringan dan tidak membahayakan, namun dapat memengaruhi kenyamanan serta kepatuhan penggunaan kontrasepsi apabila tidak diberikan konseling yang tepat (Jacobstein & Polis, 2014).

Pemahaman yang komprehensif mengenai kontrasepsi progestin saja diperlukan oleh tenaga kesehatan dalam pelayanan keluarga berencana untuk menentukan

pilihan metode yang sesuai dengan kondisi klinis dan preferensi klien, serta merencanakan pemantauan dan penatalaksanaan efek samping secara tepat dan aman.

Bab ini membahas secara sistematis mengenai jenis-jenis kontrasepsi progestin saja, mekanisme kerja hormon progestin dalam mencegah kehamilan, pertimbangan klinis dalam pemilihan metode, serta pemantauan dan penatalaksanaan efek samping pada akseptor kontrasepsi progestin saja.

A. Konsep Dasar Kontrasepsi Progestin Saja

Kontrasepsi progestin saja merupakan salah satu metode kontrasepsi hormonal yang hanya mengandung hormon progestin tanpa kombinasi hormon estrogen. Metode ini dikembangkan sebagai alternatif bagi wanita yang memiliki kontraindikasi terhadap penggunaan estrogen atau yang memerlukan metode kontrasepsi hormonal dengan risiko efek samping kardiovaskular yang lebih rendah (McCann & Potter, 1994).

Penggunaan kontrasepsi progestin saja menjadi salah satu pilihan penting dalam pelayanan keluarga berencana karena memiliki tingkat efektivitas yang tinggi serta relatif aman bagi berbagai kelompok wanita dengan kondisi khusus. Metode ini dapat digunakan oleh ibu menyusui, wanita dengan riwayat tromboemboli, atau individu dengan kondisi medis tertentu yang tidak dianjurkan menggunakan kontrasepsi hormonal kombinasi (World Health Organization, 2015).

Kontrasepsi progestin tersedia dalam beberapa bentuk sediaan dengan karakteristik penggunaan yang berbeda. Bentuk kontrasepsi progestin saja yang umum digunakan dalam pelayanan kesehatan reproduksi meliputi:

1. Pil progestin saja (progestin-only pill atau mini pill)
2. Kontrasepsi suntik progestin
3. Kontrasepsi implant

Setiap metode memiliki cara penggunaan, durasi kerja, serta tingkat efektivitas yang berbeda sehingga pemilihan metode harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan, kebutuhan reproduksi, serta preferensi klien (Hatcher et al., 2018).

Kontrasepsi progestin saja termasuk dalam kelompok kontrasepsi hormonal yang bekerja melalui pengaruh hormon terhadap sistem reproduksi wanita. Hormon progestin sintetis dalam metode kontrasepsi ini memiliki aktivitas biologis yang menyerupai hormon progesteron alami yang diproduksi oleh ovarium. Pengaruh hormon tersebut menyebabkan perubahan fisiologis pada sistem reproduksi yang dapat mencegah terjadinya kehamilan (Bastianelli et al., 2020).

Keunggulan utama kontrasepsi progestin saja terletak pada fleksibilitas penggunaannya serta profil keamanan yang relatif baik. Metode ini dapat digunakan pada berbagai kelompok wanita yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi kombinasi yang mengandung estrogen. Penggunaan kontrasepsi progestin juga tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap produksi air susu ibu sehingga metode ini dianggap aman digunakan pada masa menyusui (Kapp, Curtis, & Nanda, 2010). Meskipun demikian, penggunaan kontrasepsi progestin saja juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipahami oleh tenaga kesehatan dan akseptor keluarga berencana. Salah satu efek yang paling sering terjadi adalah perubahan pola menstruasi, seperti perdarahan tidak teratur atau amenore. Kondisi tersebut umumnya tidak berbahaya, namun dapat menimbulkan kekhawatiran bagi akseptor apabila tidak diberikan konseling yang memadai (Jacobstein & Polis, 2014).

Pemahaman yang baik mengenai karakteristik, mekanisme kerja, serta indikasi penggunaan kontrasepsi progestin saja sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas. Tenaga kesehatan perlu mampu membantu klien memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan reproduksi serta memberikan edukasi mengenai penggunaan metode dan kemungkinan efek samping yang dapat terjadi.

B. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Progestin

Kontrasepsi progestin saja bekerja melalui pengaruh hormon progestin terhadap sistem reproduksi wanita sehingga proses yang diperlukan untuk terjadinya kehamilan dapat dihambat. Hormon progestin sintetis yang terkandung dalam kontrasepsi memiliki aktivitas biologis yang menyerupai hormon progesteron alami yang diproduksi oleh korpus luteum setelah ovulasi. Pemberian hormon progestin dalam jumlah tertentu dapat memengaruhi regulasi hormonal pada hipotalamus, hipofisis, dan ovarium sehingga menghambat proses reproduksi yang normal (Hatcher et al., 2018).

Mekanisme kerja kontrasepsi progestin tidak hanya terjadi pada satu titik dalam sistem reproduksi, tetapi melibatkan beberapa perubahan fisiologis yang bekerja secara bersamaan. Mekanisme utama kontrasepsi progestin meliputi penghambatan ovulasi, peningkatan kekentalan mukus serviks, perubahan struktur endometrium, serta perubahan motilitas tuba falopi. Kombinasi dari berbagai mekanisme tersebut menyebabkan lingkungan reproduksi menjadi tidak mendukung terjadinya fertilisasi dan implantasi (Bastianelli, Farris, & Benagiano, 2020).

1. Penghambatan Ovulasi

Salah satu mekanisme utama kontrasepsi progestin adalah penghambatan ovulasi melalui pengaruh terhadap sistem hormonal yang mengatur siklus menstruasi. Hormon progestin bekerja dengan menekan pelepasan hormon gonadotropin dari kelenjar hipofisis anterior, terutama hormon luteinizing hormone (LH). Penekanan lonjakan LH (LH surge) menyebabkan proses pematangan folikel dan pelepasan ovum dari ovarium tidak terjadi (McCann & Potter, 1994).

Penghambatan ovulasi terutama terjadi pada metode kontrasepsi progestin dengan dosis hormon yang relatif tinggi, seperti kontrasepsi suntik dan implan. Pada metode pil progestin dosis rendah, penghambatan ovulasi tidak selalu terjadi secara konsisten sehingga mekanisme lain seperti perubahan mukus serviks memiliki peran yang lebih dominan dalam mencegah kehamilan (Hatcher et al., 2018).

2. Peningkatan Kekentalan Mukus Serviks

Hormon progestin menyebabkan perubahan karakteristik mukus serviks menjadi lebih kental dan viskos. Mukus serviks yang kental membentuk penghalang mekanis yang menghambat pergerakan sperma dari vagina menuju uterus dan tuba falopi. Kondisi tersebut mengurangi kemungkinan sperma mencapai ovum sehingga proses fertilisasi menjadi sulit terjadi (Bastianelli et al., 2020).

Perubahan mukus serviks merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting pada kontrasepsi progestin, terutama pada pil progestin saja. Efek ini dapat terjadi dalam waktu singkat setelah penggunaan kontrasepsi dan berperan besar dalam efektivitas metode kontrasepsi progestin dosis rendah (McCann & Potter, 1994).

3. Perubahan Struktur dan Fungsi Endometrium

Pengaruh hormon progestin juga menyebabkan perubahan pada endometrium atau lapisan dalam rahim. Paparan progestin dalam jangka waktu tertentu menyebabkan endometrium menjadi lebih tipis dan mengalami

perubahan struktural yang menghambat proses implantasi embrio. Endometrium yang mengalami perubahan tersebut menjadi kurang reseptif terhadap penempelan blastokista (Bastianelli et al., 2020).

Perubahan endometrium ini merupakan mekanisme tambahan yang berperan dalam mencegah kehamilan apabila fertilisasi tetap terjadi. Lingkungan endometrium yang tidak optimal menyebabkan embrio sulit untuk berkembang dan melakukan implantasi secara normal.

4. Perubahan Motilitas Tuba Falopi

Kontrasepsi progestin juga dapat memengaruhi motilitas tuba falopi. Hormon progestin menyebabkan perubahan pada kontraksi otot polos tuba falopi sehingga transportasi ovum dan sperma di dalam saluran reproduksi menjadi terganggu. Gangguan transportasi tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pertemuan antara ovum dan sperma (Jacobstein & Polis, 2014).

Perubahan motilitas tuba falopi merupakan mekanisme tambahan yang mendukung efektivitas kontrasepsi progestin. Mekanisme ini bekerja bersama dengan penghambatan ovulasi, perubahan mukus serviks, serta perubahan endometrium dalam mencegah terjadinya kehamilan.

5. Efektivitas Mekanisme Kerja Progestin

Efektivitas kontrasepsi progestin dalam mencegah kehamilan merupakan hasil dari kombinasi berbagai mekanisme yang bekerja secara simultan. Penghambatan ovulasi, peningkatan kekentalan mukus serviks, perubahan endometrium, serta gangguan motilitas tuba falopi saling melengkapi dalam menciptakan kondisi yang tidak mendukung terjadinya fertilisasi dan implantasi.

Tingkat efektivitas kontrasepsi progestin sangat dipengaruhi oleh jenis metode yang digunakan serta kepatuhan pengguna dalam mengikuti aturan penggunaan. Metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan dan suntik memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi karena tidak bergantung pada kepatuhan penggunaan harian oleh akseptor (Hatcher et al., 2018).

Pemahaman mengenai mekanisme kerja kontrasepsi progestin sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan konseling kepada klien. Penjelasan yang jelas mengenai cara kerja metode kontrasepsi dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan akseptor sehingga penggunaan kontrasepsi dapat berlangsung secara konsisten dan efektif.

C. Pil Progestin Saja

Pil progestin saja (progestin-only pill atau POP) merupakan salah satu metode kontrasepsi hormonal yang hanya mengandung hormon progestin tanpa kombinasi

hormon estrogen. Metode ini sering disebut sebagai mini pill karena dosis hormon yang digunakan relatif lebih rendah dibandingkan dengan pil kontrasepsi kombinasi. Pil progestin saja dikembangkan sebagai alternatif kontrasepsi bagi wanita yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen atau yang memerlukan metode kontrasepsi hormonal yang aman selama masa menyusui (McCann & Potter, 1994).

Pil progestin saja bekerja terutama melalui perubahan mukus serviks yang menjadi lebih kental sehingga menghambat penetrasi sperma ke dalam uterus. Selain itu, penggunaan pil progestin juga dapat menimbulkan perubahan pada endometrium yang menyebabkan lingkungan rahim kurang mendukung terjadinya implantasi embrio. Pada sebagian pengguna, pil progestin juga dapat menekan proses ovulasi, meskipun efek ini tidak selalu terjadi secara konsisten seperti pada kontrasepsi hormonal kombinasi (Hatcher et al., 2018).

1. Jenis dan Kandungan Pil Progestin

Pil progestin saja mengandung hormon progestin sintetis dalam dosis rendah. Beberapa jenis progestin yang umum digunakan dalam pil kontrasepsi ini antara lain:

- a. Norethindrone
- b. Levonorgestrel
- c. Desogestrel

Pil yang mengandung desogestrel memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menghambat ovulasi dibandingkan dengan pil progestin generasi sebelumnya. Perbedaan jenis hormon tersebut dapat memengaruhi efektivitas serta profil efek samping yang mungkin terjadi pada pengguna (Hatcher et al., 2018).

2. Cara Penggunaan Pil Progestin

Pil progestin saja digunakan dengan cara diminum setiap hari pada waktu yang sama tanpa masa jeda. Berbeda dengan pil kontrasepsi kombinasi yang memiliki interval bebas hormon, pil progestin harus diminum secara terus-menerus agar efektivitasnya tetap terjaga.

Ketepatan waktu konsumsi pil sangat penting dalam penggunaan metode ini. Keterlambatan minum pil lebih dari tiga jam dapat menurunkan efektivitas kontrasepsi pada beberapa jenis pil progestin. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya ovulasi sehingga kemungkinan kehamilan menjadi lebih besar (World Health Organization, 2022).

Penggunaan pil progestin biasanya dapat dimulai pada hari pertama hingga hari kelima siklus menstruasi. Metode ini juga dapat digunakan segera setelah

persalinan pada ibu menyusui dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan rekomendasi tenaga kesehatan.

3. Keuntungan Pil Progestin Saja

Pil progestin memiliki beberapa keuntungan yang menjadikannya sebagai pilihan kontrasepsi bagi kelompok wanita tertentu. Keuntungan tersebut antara lain:

- a. Tidak mengandung estrogen sehingga cocok bagi wanita dengan kontraindikasi terhadap estrogen.
- b. Aman digunakan oleh ibu menyusui karena tidak memengaruhi produksi air susu ibu.
- c. Risiko tromboemboli lebih rendah dibandingkan kontrasepsi hormonal kombinasi.
- d. Dapat digunakan oleh wanita dengan kondisi medis tertentu seperti hipertensi ringan atau migrain tanpa aura.
- e. Kesuburan dapat kembali dengan cepat setelah penghentian penggunaan.

Keunggulan tersebut menjadikan pil progestin sebagai salah satu metode kontrasepsi yang fleksibel dan aman bagi berbagai kelompok pengguna (Kapp, Curtis, & Nanda, 2010).

4. Keterbatasan Pil Progestin

Meskipun memiliki berbagai keuntungan, penggunaan pil progestin saja juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan utama metode ini adalah ketergantungan terhadap kepatuhan pengguna dalam mengonsumsi pil secara teratur setiap hari.

Efektivitas kontrasepsi dapat menurun apabila pil tidak diminum sesuai jadwal. Beberapa pengguna juga dapat mengalami perubahan pola menstruasi seperti perdarahan tidak teratur atau amenore. Kondisi tersebut sering menjadi alasan penghentian penggunaan pil progestin pada sebagian akseptor (Jacobstein & Polis, 2014). Selain itu, pil progestin tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual sehingga penggunaan kondom tetap dianjurkan pada individu yang memiliki risiko infeksi menular seksual.

5. Efek Samping Pil Progestin

Efek samping yang paling sering dilaporkan pada penggunaan pil progestin berkaitan dengan perubahan pola menstruasi. Beberapa efek samping yang dapat terjadi antara lain:

- a. perdarahan tidak teratur
- b. amenore
- c. sakit kepala
- d. nyeri payudara

e. perubahan suasana hati

Sebagian besar efek samping tersebut bersifat ringan dan dapat berkurang setelah beberapa bulan penggunaan. Konseling yang tepat mengenai kemungkinan efek samping sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan serta keberlanjutan penggunaan metode kontrasepsi ini (Hatcher et al., 2018).

Pemahaman yang baik mengenai karakteristik, cara penggunaan, serta efek samping pil progestin sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi kepada klien. Edukasi yang jelas mengenai cara penggunaan pil dan langkah yang harus dilakukan apabila terjadi keterlambatan minum pil dapat membantu meningkatkan efektivitas kontrasepsi dan mencegah terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan.

D. Kontrasepsi Suntik Progestin

Kontrasepsi suntik progestin merupakan salah satu metode kontrasepsi hormonal yang diberikan melalui injeksi hormon progestin ke dalam tubuh dengan interval waktu tertentu. Metode ini termasuk dalam kelompok kontrasepsi hormonal yang banyak digunakan karena memiliki efektivitas tinggi, praktis, dan tidak memerlukan kepatuhan penggunaan harian seperti pada pil kontrasepsi. Kontrasepsi suntik progestin bekerja dengan melepaskan hormon secara perlahan ke dalam sirkulasi darah sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kehamilan dalam jangka waktu tertentu (Hatcher et al., 2018).

Penggunaan kontrasepsi suntik progestin cukup luas dalam program keluarga berencana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Metode ini menjadi pilihan banyak akseptor karena mudah digunakan, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, serta tidak mengandung estrogen sehingga relatif aman bagi wanita dengan kontraindikasi terhadap hormon tersebut (Jacobstein & Polis, 2014).

1. Jenis Kontrasepsi Suntik Progestin

Beberapa jenis kontrasepsi suntik progestin yang umum digunakan dalam pelayanan keluarga berencana meliputi:

a. Depot Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)

Kontrasepsi suntik jenis ini diberikan setiap tiga bulan (12 minggu) melalui injeksi intramuskular atau subkutan. DMPA merupakan jenis kontrasepsi suntik yang paling banyak digunakan di berbagai negara.

b. Norethisterone Enanthate (NET-EN)

Kontrasepsi suntik jenis ini diberikan setiap dua bulan (8 minggu) melalui injeksi intramuskular. Metode ini memiliki durasi kerja yang lebih pendek dibandingkan DMPA.

Kedua jenis kontrasepsi suntik tersebut bekerja melalui mekanisme hormonal yang serupa, yaitu dengan melepaskan hormon progestin secara bertahap ke dalam sirkulasi darah sehingga dapat mencegah terjadinya kehamilan (World Health Organization, 2022).

2. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Suntik Progestin

Kontrasepsi suntik progestin bekerja melalui beberapa mekanisme fisiologis yang memengaruhi sistem reproduksi wanita. Mekanisme utama metode ini adalah penghambatan ovulasi melalui penekanan sekresi hormon gonadotropin dari kelenjar hipofisis. Penurunan hormon luteinizing hormone (LH) menyebabkan tidak terjadinya lonjakan LH yang diperlukan untuk proses ovulasi (Hatcher et al., 2018).

Selain menghambat ovulasi, kontrasepsi suntik progestin juga menyebabkan peningkatan kekentalan mukus serviks sehingga pergerakan sperma menuju uterus menjadi terhambat. Pengaruh hormon progestin juga menimbulkan perubahan pada endometrium yang menyebabkan lapisan rahim menjadi kurang reseptif terhadap implantasi embrio (Bastianelli et al., 2020).

3. Cara Penggunaan Kontrasepsi Suntik

Kontrasepsi suntik diberikan oleh tenaga kesehatan melalui injeksi intramuskular atau subkutan pada interval waktu tertentu sesuai dengan jenis kontrasepsi yang digunakan. Pemberian suntikan harus dilakukan secara teratur sesuai jadwal untuk mempertahankan efektivitas kontrasepsi.

Pemberian kontrasepsi suntik dapat dimulai pada beberapa kondisi berikut:

- a. pada hari pertama hingga hari ketujuh siklus menstruasi
- b. segera setelah persalinan apabila tidak terdapat kontraindikasi
- c. setelah keguguran atau abortus sesuai dengan pertimbangan klinis

Akseptor yang menggunakan kontrasepsi suntik perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya datang kembali sesuai jadwal untuk mendapatkan suntikan berikutnya.

4. Keuntungan Kontrasepsi Suntik Progestin

Kontrasepsi suntik progestin memiliki beberapa keuntungan yang menjadikannya sebagai salah satu metode kontrasepsi yang banyak digunakan. Keuntungan tersebut antara lain:

- a. Memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam mencegah kehamilan.
- b. Tidak memerlukan kepatuhan penggunaan harian oleh akseptor.
- c. Tidak mengandung hormon estrogen sehingga dapat digunakan pada wanita dengan kontraindikasi terhadap estrogen.
- d. Aman digunakan oleh ibu menyusui setelah periode tertentu pascapersalinan.

- e. Dapat mengurangi nyeri haid dan jumlah perdarahan menstruasi pada sebagian pengguna.

Keunggulan tersebut menjadikan kontrasepsi suntik sebagai metode yang praktis dan efektif bagi wanita yang membutuhkan metode kontrasepsi jangka menengah (Jacobstein & Polis, 2014).

5. Keterbatasan Kontrasepsi Suntik Progestin

Kontrasepsi suntik progestin meskipun memiliki banyak keuntungan, penggunaan kontrasepsi suntik progestin juga memiliki beberapa keterbatasan. Perubahan pola menstruasi merupakan efek yang paling sering terjadi pada pengguna metode ini. Perubahan tersebut dapat berupa perdarahan tidak teratur, bercak (spotting), atau amenore setelah penggunaan dalam jangka waktu tertentu.

Kesuburan juga dapat kembali secara lebih lambat setelah penghentian penggunaan kontrasepsi suntik dibandingkan dengan metode kontrasepsi lainnya. Waktu yang dibutuhkan untuk kembalinya ovulasi dapat mencapai beberapa bulan setelah suntikan terakhir (Hatcher et al., 2018).

Penggunaan kontrasepsi suntik juga tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual sehingga penggunaan kondom tetap dianjurkan bagi individu yang berisiko.

6. Efek Samping Kontrasepsi Suntik Progestin

Efek samping yang sering dilaporkan pada penggunaan kontrasepsi suntik progestin antara lain:

- a. perubahan pola menstruasi
- b. amenore setelah penggunaan jangka panjang
- c. peningkatan berat badan
- d. sakit kepala
- e. perubahan suasana hati

Sebagian besar efek samping tersebut bersifat ringan dan dapat ditangani melalui konseling yang tepat. Tenaga kesehatan perlu memberikan informasi yang jelas kepada akseptor mengenai kemungkinan efek samping serta langkah yang dapat dilakukan apabila keluhan tersebut terjadi (World Health Organization, 2022).

Pemahaman yang baik mengenai indikasi, cara penggunaan, serta efek samping kontrasepsi suntik progestin sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas. Edukasi yang tepat dapat membantu meningkatkan kepatuhan akseptor dalam mengikuti jadwal suntikan serta mencegah terjadinya kegagalan kontrasepsi.

E. Kontrasepsi Implan

Kontrasepsi implan merupakan metode kontrasepsi hormonal jangka panjang yang mengandung hormon progestin dan dipasang di bawah kulit lengan atas. Metode ini termasuk dalam kelompok kontrasepsi jangka panjang yang dapat dibalik (*long-acting reversible contraception/LARC*) karena mampu memberikan perlindungan terhadap kehamilan selama beberapa tahun dan kesuburan dapat kembali setelah alat dilepas. Kontrasepsi implan banyak digunakan dalam pelayanan keluarga berencana karena memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi serta tidak memerlukan kepatuhan penggunaan harian oleh akseptor (Hatcher et al., 2018).

Implan berbentuk batang kecil fleksibel yang mengandung hormon progestin dan ditanam di bawah kulit melalui prosedur medis sederhana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Setelah pemasangan, hormon progestin dilepaskan secara perlahan ke dalam sirkulasi darah sehingga mampu memberikan perlindungan kontrasepsi dalam jangka waktu tertentu (Jacobstein & Polis, 2014).

1. Jenis Kontrasepsi Implan

Beberapa jenis kontrasepsi implan yang umum digunakan dalam pelayanan keluarga berencana meliputi:

a. Implanon atau Nexplanon

Implan jenis ini terdiri dari satu batang yang mengandung hormon etonogestrel dan efektif digunakan hingga tiga tahun.

b. Jadelle

Implan jenis ini terdiri dari dua batang yang mengandung hormon levonorgestrel dan dapat memberikan perlindungan kontrasepsi hingga lima tahun.

Kedua jenis implan tersebut bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu melepaskan hormon progestin secara perlahan ke dalam tubuh sehingga dapat mencegah terjadinya kehamilan dalam jangka panjang (World Health Organization, 2022).

2. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Implan

Kontrasepsi implan bekerja melalui beberapa mekanisme fisiologis yang memengaruhi sistem reproduksi wanita. Mekanisme utama metode ini adalah penghambatan ovulasi melalui penekanan sekresi hormon gonadotropin dari kelenjar hipofisis. Penekanan hormon luteinizing hormone (LH) menyebabkan tidak terjadinya pelepasan sel telur dari ovarium.

Hormon progestin yang dilepaskan dari implan juga menyebabkan peningkatan kekentalan mukus serviks sehingga menghambat pergerakan sperma menuju uterus. Perubahan pada endometrium juga terjadi akibat

pengaruh hormon progestin sehingga lapisan rahim menjadi kurang reseptif terhadap implantasi embrio (Bastianelli, Farris, & Benagiano, 2020).

Kombinasi mekanisme tersebut menyebabkan kemungkinan terjadinya fertilisasi dan implantasi menjadi sangat kecil sehingga implan memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi dalam mencegah kehamilan.

3. Prosedur Pemasangan dan Pelepasan Implan

Pemasangan implan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih melalui prosedur sederhana dengan anestesi lokal. Implan biasanya dipasang pada bagian dalam lengan atas yang tidak dominan. Prosedur pemasangan dilakukan dengan membuat sayatan kecil pada kulit, kemudian batang implan dimasukkan ke bawah kulit menggunakan alat khusus.

Pelepasan implan dilakukan apabila masa penggunaan telah berakhir atau apabila akseptor ingin menghentikan penggunaan metode kontrasepsi tersebut. Prosedur pelepasan dilakukan melalui sayatan kecil pada kulit untuk mengeluarkan batang implan dari jaringan subkutan. Setelah implan dilepas, kadar hormon progestin dalam tubuh akan menurun dengan cepat sehingga kesuburan dapat kembali dalam waktu relatif singkat (Hatcher et al., 2018).

4. Keuntungan Kontrasepsi Implan

Kontrasepsi implan memiliki beberapa keuntungan yang menjadikannya sebagai salah satu metode kontrasepsi yang efektif dan praktis. Keuntungan tersebut antara lain:

- a. Memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi dalam mencegah kehamilan.
- b. Memberikan perlindungan kontrasepsi dalam jangka waktu yang panjang.
- c. Tidak memerlukan kepatuhan penggunaan harian oleh akseptor.
- d. Tidak mengandung hormon estrogen sehingga aman bagi wanita dengan kontraindikasi terhadap estrogen.
- e. Kesuburan dapat kembali dengan cepat setelah implan dilepas.

Keunggulan tersebut menjadikan implan sebagai salah satu metode kontrasepsi yang direkomendasikan dalam program keluarga berencana, terutama bagi wanita yang menginginkan metode kontrasepsi jangka panjang yang efektif (Jacobstein & Polis, 2014).

5. Keterbatasan Kontrasepsi Implan

Meskipun memiliki banyak keuntungan, penggunaan kontrasepsi implan juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Pemasangan dan pelepasan implan memerlukan prosedur medis yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Prosedur tersebut memerlukan peralatan khusus serta keterampilan teknis tertentu.

Perubahan pola menstruasi merupakan efek yang sering terjadi pada pengguna kontrasepsi implan. Perubahan tersebut dapat berupa perdarahan tidak teratur, bercak (spotting), atau amenore. Kondisi tersebut biasanya tidak berbahaya, namun dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pengguna (Hatcher et al., 2018).

Metode kontrasepsi ini juga tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual sehingga penggunaan kondom tetap dianjurkan bagi individu yang memiliki risiko infeksi menular seksual.

6. Efek Samping Kontrasepsi Implan

Beberapa efek samping yang dapat terjadi pada penggunaan kontrasepsi implan antara lain:

- a. perubahan pola menstruasi
- b. amenore
- c. sakit kepala
- d. peningkatan berat badan
- e. nyeri payudara
- f. perubahan suasana hati

Sebagian besar efek samping tersebut bersifat ringan dan tidak membahayakan. Konseling yang tepat sebelum pemasangan implan sangat penting untuk membantu akseptor memahami kemungkinan efek samping serta meningkatkan kepuasan penggunaan metode kontrasepsi ini (World Health Organization, 2022).

Pemahaman yang baik mengenai karakteristik, mekanisme kerja, serta prosedur pemasangan dan pelepasan kontrasepsi implan sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas. Edukasi yang jelas kepada klien mengenai manfaat, cara kerja, serta kemungkinan efek samping dapat membantu klien membuat keputusan kontrasepsi secara sadar dan berdasarkan informasi yang memadai.

F. Efek Samping dan Tatalaksana Kontrasepsi Progestin

Penggunaan kontrasepsi progestin saja dapat menimbulkan beberapa efek samping yang berkaitan dengan perubahan hormonal pada sistem reproduksi wanita. Sebagian besar efek samping tersebut bersifat ringan dan tidak membahayakan kesehatan, namun dapat memengaruhi kenyamanan pengguna serta kepatuhan dalam penggunaan metode kontrasepsi. Tenaga kesehatan perlu memberikan konseling yang memadai mengenai kemungkinan efek samping yang dapat terjadi serta langkah penatalaksanaan yang tepat agar akseptor dapat menggunakan metode kontrasepsi secara optimal (Hatcher et al., 2018).

Efek samping kontrasepsi progestin umumnya berkaitan dengan perubahan pola menstruasi, perubahan metabolik, maupun keluhan sistemik ringan. Pemahaman yang baik mengenai efek samping tersebut sangat penting dalam pelayanan keluarga berencana karena dapat membantu tenaga kesehatan membedakan keluhan yang masih normal dengan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut atau rujukan (World Health Organization, 2022).

1. Perubahan Pola Menstruasi

Perubahan pola menstruasi merupakan efek samping yang paling sering terjadi pada penggunaan kontrasepsi progestin. Perubahan tersebut dapat berupa perdarahan tidak teratur, bercak (spotting), perdarahan yang lebih ringan, atau bahkan tidak terjadi menstruasi sama sekali (amenore). Kondisi ini terjadi akibat pengaruh hormon progestin terhadap endometrium yang menyebabkan lapisan rahim menjadi lebih tipis dan tidak stabil (Bastianelli, Farris, & Benagiano, 2020).

Tatalaksana perubahan pola menstruasi meliputi pemberian konseling kepada akseptor bahwa kondisi tersebut merupakan efek yang umum terjadi dan biasanya tidak berbahaya. Pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan apabila perdarahan berlangsung lama, sangat banyak, atau disertai keluhan lain yang mencurigakan.

2. Amenore

Amenore merupakan kondisi tidak terjadinya menstruasi selama beberapa siklus setelah penggunaan kontrasepsi progestin. Kondisi ini sering terjadi terutama pada pengguna kontrasepsi suntik progestin setelah penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Amenore terjadi akibat penipisan endometrium sehingga tidak terjadi peluruhan lapisan rahim selama siklus menstruasi (Hatcher et al., 2018).

Tatalaksana amenore meliputi pemberian penjelasan kepada akseptor bahwa kondisi tersebut tidak berbahaya dan tidak menandakan gangguan kesehatan. Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan apabila terdapat kemungkinan terjadinya kehamilan atau apabila akseptor merasa khawatir.

3. Peningkatan Berat Badan

Sebagian pengguna kontrasepsi progestin melaporkan peningkatan berat badan selama penggunaan metode kontrasepsi. Peningkatan berat badan dapat berkaitan dengan perubahan metabolisme, peningkatan nafsu makan, atau retensi cairan dalam tubuh.

Tatalaksana kondisi ini meliputi edukasi mengenai pola makan sehat, peningkatan aktivitas fisik, serta pemantauan berat badan secara berkala. Evaluasi metode kontrasepsi dapat dipertimbangkan apabila peningkatan berat badan dirasakan mengganggu oleh akseptor.

4. Sakit Kepala dan Perubahan Suasana Hati

Penggunaan kontrasepsi progestin juga dapat menimbulkan keluhan sistemik seperti sakit kepala, kelelahan, atau perubahan suasana hati. Keluhan tersebut biasanya bersifat ringan dan dapat berkurang setelah tubuh beradaptasi dengan perubahan hormonal.

Penatalaksanaan keluhan tersebut meliputi observasi, pemberian analgesik ringan apabila diperlukan, serta konseling kepada akseptor mengenai kemungkinan efek samping yang dapat terjadi selama penggunaan kontrasepsi hormonal.

5. Nyeri Payudara

Nyeri atau rasa tidak nyaman pada payudara dapat terjadi pada sebagian pengguna kontrasepsi progestin akibat perubahan hormonal yang memengaruhi jaringan payudara. Keluhan ini biasanya bersifat sementara dan dapat berkurang setelah beberapa waktu penggunaan.

Penatalaksanaan nyeri payudara meliputi pemberian edukasi kepada akseptor mengenai sifat sementara dari keluhan tersebut serta anjuran penggunaan penyangga payudara yang nyaman.

6. Tanda Bahaya dan Indikasi Rujukan

Meskipun sebagian besar efek samping kontrasepsi progestin bersifat ringan, tenaga kesehatan perlu mengenali tanda bahaya yang memerlukan evaluasi lebih lanjut atau rujukan. Beberapa kondisi yang memerlukan perhatian khusus antara lain:

- a. perdarahan vagina yang sangat banyak atau berlangsung lama
- b. nyeri kepala berat yang muncul secara mendadak
- c. nyeri dada atau sesak napas
- d. nyeri perut hebat yang tidak diketahui penyebabnya

Kondisi tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan tidak terdapat komplikasi serius yang memerlukan penanganan medis lanjutan.

Pemantauan berkala terhadap pengguna kontrasepsi progestin merupakan bagian penting dari pelayanan keluarga berencana. Tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi kepada akseptor mengenai kemungkinan efek samping, langkah yang perlu dilakukan apabila keluhan muncul, serta kapan harus mencari pertolongan medis. Pendekatan tersebut dapat membantu meningkatkan keamanan penggunaan kontrasepsi serta kepuasan akseptor terhadap pelayanan keluarga berencana.

Tabel 7.1
Perbandingan Pil Progestin, Suntik, dan Implan

Aspek	Pil Progestin Saja	Suntik Progestin	Implan
Jenis metode	Kontrasepsi hormonal oral	Kontrasepsi hormonal injeksi	Kontrasepsi hormonal subdermal
Kandungan hormon	Progestin dosis rendah	Progestin dosis sedang	Progestin dilepaskan perlahan
Cara penggunaan	Diminum setiap hari pada waktu yang sama	Disuntik setiap 2 atau 3 bulan	Dipasang di bawah kulit lengan
Durasi efektivitas	24 jam	2–3 bulan	3–5 tahun
Mekanisme utama	Mengentalkan mukus serviks, sebagian menghambat ovulasi	Menghambat ovulasi dan mengentalkan mukus serviks	Menghambat ovulasi dan mengentalkan mukus serviks
Efektivitas	Tinggi jika digunakan konsisten	Sangat tinggi	Sangat tinggi
Ketergantungan kepatuhan pengguna	Tinggi	Sedang	Rendah
Kembalinya kesuburan	Cepat setelah berhenti	Dapat tertunda beberapa bulan	Cepat setelah implan dilepas
Efek samping utama	Perdarahan tidak teratur	Amenore, peningkatan berat badan	Perdarahan tidak teratur
Perlindungan IMS	Tidak	Tidak	Tidak

Tabel 7.2
Indikasi dan Kontraindikasi Kontrasepsi Progestin

Indikasi	Penjelasan
Ibu menyusui	Progestin tidak memengaruhi produksi ASI
Wanita dengan kontraindikasi estrogen	Misalnya riwayat tromboemboli
Wanita dengan migrain tanpa aura	Progestin lebih aman dibanding kontrasepsi kombinasi
Wanita dengan hipertensi ringan	Tidak meningkatkan risiko seperti estrogen
Wanita yang membutuhkan kontrasepsi jangka Panjang	Implan dan suntik efektif untuk jangka panjang

Kontraindikasi

Kontraindikasi	Penjelasan
Kehamilan	Kontrasepsi tidak diperlukan pada kondisi ini
Perdarahan uterus yang belum diketahui penyebabnya	Perlu evaluasi lebih lanjut sebelum penggunaan
Kanker payudara aktif	Progestin dapat memengaruhi pertumbuhan sel tumor
Penyakit hati berat	Metabolisme hormon dapat terganggu

Tabel 7.3
Clinical Decision Table Pemilihan Metode Progestin

Kondisi Klien	Metode yang Direkomendasikan	Alasan Klinis
Ibu menyusui	Pil progestin / implan / suntik	Aman untuk laktasi
Klien sering lupa minum obat	Implan atau suntik	Tidak bergantung pada kepatuhan harian
Klien ingin kontrasepsi jangka panjang	Implan	Efektivitas tinggi hingga beberapa tahun
Klien ingin kontrasepsi sementara	Pil progestin	Mudah dihentikan kapan saja
Klien menginginkan metode praktis	Suntik	Tidak perlu penggunaan harian
Klien ingin kesuburan cepat kembali	Pil atau implan	Kesuburan kembali lebih cepat dibanding suntik

G. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case

Seorang wanita usia 28 tahun, P1A0, datang ke Praktik Mandiri Bidan (PMB) dengan keinginan menggunakan kontrasepsi. Ibu sedang menyusui bayi usia 3 bulan secara eksklusif. Riwayat kesehatan umum baik, tidak memiliki riwayat hipertensi, diabetes, maupun penyakit kronis lainnya.

Ibu menyampaikan kekhawatiran terkait penggunaan kontrasepsi, yaitu takut mengalami peningkatan berat badan serta tidak menginginkan gangguan siklus menstruasi.

Pertanyaan Diskusi:

1. Metode kontrasepsi apa yang paling sesuai untuk kasus ini? Jelaskan pilihan utama dan alternatifnya.
2. Apa dasar pertimbangan klinis dalam pemilihan metode tersebut? (kaitkan dengan kondisi menyusui dan preferensi klien)
3. Apa efek samping yang mungkin terjadi dari metode yang dipilih? Mana yang termasuk normal dan mana yang perlu diwaspadai?
4. Bagaimana rencana edukasi (KIE) yang harus diberikan kepada klien agar penggunaan kontrasepsi optimal?
5. Kapan klien harus melakukan kontrol ulang dan dalam kondisi apa harus segera kembali ke fasilitas kesehatan?

Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Pelayanan Kontrasepsi Progestin pada Ibu Menyusui
3	Kasus	Konseling dan pemilihan kontrasepsi pada ibu menyusui 3 bulan dengan kekhawatiran efek samping
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta mampu menunjukkan kompetensi sebagai calon bidan dalam pelayanan KB berbasis klien
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 28 tahun, P1A0, datang ke PMB ingin menggunakan kontrasepsi. Ibu sedang menyusui bayi usia 3 bulan secara eksklusif. Hasil anamnesis: a. Tidak ada riwayat penyakit kronis b. Tidak menggunakan kontrasepsi sebelumnya c. Mengeluh takut gemuk d. Tidak ingin mengalami gangguan menstruasi e. Keadaan umum baik, tanda vital dalam batas normal. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus 2. Lakukan skrining kelayakan penggunaan kontrasepsi 3. Tentukan diagnosis/masalah kebidanan 4. Tentukan metode kontrasepsi yang tepat 5. Berikan KIE/konseling kepada klien 6. Lakukan dokumentasi singkat
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta sesuai 2. Berikan penilaian berdasarkan: a. Checklist (0–3) b. Global rating (1–4) 3. Tidak diperbolehkan memberi bantuan kepada peserta 4. Penilaian dilakukan objektif sesuai performa. INSTRUKSI KHUSUS

		1. Jika peserta melakukan anamnesis → PS menjawab sesuai skenario 2. Jika peserta melakukan skrining → penguji memberi data: a. Tidak ada kontraindikasi hormonal b. Ibu menyusui eksklusif 3. Diagnosis yang diharapkan: Akseptor KB dengan kebutuhan kontrasepsi progestin 4. Tindakan yang diharapkan: a. Menentukan kontrasepsi progestin (implan/suntik/pil) b. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan c. Menyesuaikan dengan preferensi klien 5. Edukasi yang diharapkan: a. Efek samping (amenore, spotting) b. Tidak mengganggu ASI c. Jadwal kontrol 6. Dokumentasi: a. Jenis kontrasepsi b. Edukasi c. Rencana tindak lanjut
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu menyusui 2. Tampak cemas ringan 3. Fokus pada kekhawatiran: a. takut gemuk b. takut haid terganggu 4. Jika diberi penjelasan → kooperatif 5. Jika dijelaskan metode → bertanya: "Apakah nanti saya bisa gemuk, Bu?"
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi, Bu PS: Pagi, Bu Peserta: Apa tujuan ibu datang hari ini? PS: Saya mau pakai KB, Bu Peserta: Apakah ibu sedang menyusui? PS: Iya, bayi saya 3 bulan Peserta: Apakah ibu punya kekhawatiran? PS: Saya takut gemuk dan tidak mau haid saya terganggu Peserta: Baik Bu, saya akan membantu memilihkan KB yang sesuai PS: Iya, Bu.
10	Kebutuhan manikin	Tidak wajib (roleplay konseling)

11	Kebutuhan laboran	1. Menyiapkan ruang OSCE 2. Menyiapkan lembar penilaian 3. Mengatur alur peserta
12	Kebutuhan alat	1. Meja dan kursi 2. Lembar status pasien 3. Lembar penilaian 4. Alat tulis 5. Leaflet KB (opsional) 6. Handrub
13	Penulis	Bdn. Erma Puspita Sari, SST., M.Kes.
14	Referensi	1. World Health Organization. (2022). Family planning: A global handbook for providers (3rd ed.). World Health Organization. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi bidan Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). Pedoman pelayanan keluarga berencana. BKKBN. 4. Hatcher, R. A., Nelson, A. L., Trussell, J., Cwiak, C., Policar, M. S., Edelman, A., Aiken, A. R. A., Marrazzo, J., & Kowal, D. (2018). Contraceptive technology (21st ed.). Ayer Company Publishers.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Pelayanan Kontrasepsi Progestin pada Ibu Menyusui

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif (Anamnesis)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama (keinginan menggunakan KB)		
2. Status menyusui (eksklusif/tidak, usia bayi)		
3. Riwayat penggunaan kontrasepsi sebelumnya		
4. Riwayat menstruasi (teratur/tidak, keluhan)		
5. Riwayat obstetri (GPA, persalinan terakhir)		
6. Riwayat penyakit (hipertensi, DM, tromboemboli)		
7. Riwayat penggunaan obat/hormonal		
8. Preferensi dan kekhawatiran klien (takut gemuk, haid terganggu)		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3= Melakukan semua 8 langkah dengan benar
- 2= Melakukan 5–7 langkah dengan benar
- 1= Melakukan 1–4 langkah dengan benar
- 0= Tidak melakukan

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

1. Persiapan

Komponen	Skoring	Skor
a. Menyapa klien dengan sopan		
b. Memperkenalkan diri		
c. Menjelaskan tujuan tindakan		
d. Meminta persetujuan		
e. Menjaga privasi		
f. Hand hygiene		
g. Menyiapkan alat/lembar konseling		

2. Langkah-langkah

Komponen	Skoring	Skor
a. Menilai kondisi umum klien		
b. Mengidentifikasi status menyusui		
c. Melakukan skrining kelayakan KB hormonal		
d. Mengidentifikasi kontraindikasi estrogen		
e. Menentukan kebutuhan KB klien		
f. Menentukan pilihan kontrasepsi progestin		
g. Menjelaskan pilihan metode (pil/suntik/implan)		
h. Menyesuaikan metode dengan kondisi & preferensi klien		
i. Menjelaskan cara kerja kontrasepsi		
j. Menjelaskan cara penggunaan		
k. Menjelaskan efek samping		
l. Menjelaskan tanda bahaya		

m. Menyusun rencana tindak lanjut/kontrol		
---	--	--

3. Pasca Tindakan

Komponen	Skoring	Skor
a. Menyimpulkan hasil konseling		
b. Melakukan dokumentasi		
c. Merapikan alat		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3= Melakukan 15–20 langkah dengan tepat & sistematis
- 2= Melakukan 10–14 langkah dengan cukup tepat
- 1= Melakukan 1–9 langkah
- 0= Tidak melakukan / tidak tepat

KOMPETENSI 3. KIE / Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan kondisi klien		
3. Menjelaskan pilihan kontrasepsi		
4. Menjelaskan efek samping & mitos (gemuk, haid)		
5. Memberi kesempatan bertanya		
6. Menjawab dengan jelas dan empatik		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3= 6 langkah benar
- 2= 4–5 langkah benar
- 1= 1–3 langkah benar
- 0= Tidak melakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sistematis		
2. Menjaga privasi		
3. Empati terhadap klien		
4. Komunikasi jelas & tenang		
5. Percaya diri		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3= 5 langkah benar
- 2= 4 langkah benar
- 1= 1–3 langkah benar
- 0= Tidak melakukan

TOTAL SKOR = (K1 + K2 + K3 + K4) / 3

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),.....

.....

Penguji :

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Pada Pelayanan Kontrasepsi Progestin pada Ibu Menyusui

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kontrasepsi Progestin
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam praktik klinik. Penilai mengamati secara langsung tindakan yang dilakukan mahasiswa pada pasien nyata atau simulasi, kemudian memberikan umpan balik segera setelah tindakan selesai. Domain yang dinilai mencakup komunikasi, informed consent, persiapan, keterampilan teknis, keselamatan pasien, serta profesionalisme.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan konseling KB pada ibu menyusui, melakukan skrining kelayakan kontrasepsi hormonal, menentukan metode kontrasepsi progestin yang tepat, serta memberikan edukasi penggunaan dan efek samping kepada klien.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam memberikan pelayanan kontrasepsi yang aman, efektif, dan berpusat pada klien (client-centered care), dengan mempertimbangkan kondisi klinis, kebutuhan reproduksi, serta preferensi klien. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pelayanan KB berbasis evidence-based practice dan penghormatan terhadap hak reproduksi.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pemahaman teori kontrasepsi progestin, tetapi juga dari kemampuannya melakukan konseling, menentukan metode yang sesuai untuk ibu menyusui, menjelaskan efek samping, serta menyusun rencana tindak lanjut secara tepat.
Kasus klinik	Kasus dalam DOPS dipilih dari situasi nyata yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya dalam pelayanan keluarga berencana pada kelompok khusus seperti ibu menyusui. Kasus harus memungkinkan mahasiswa menunjukkan keterampilan klinik secara langsung.	Seorang perempuan usia 28 tahun, P1A0, datang ke PMB untuk menggunakan kontrasepsi. Ibu menyusui bayi usia 3 bulan dan khawatir akan efek samping berupa peningkatan berat badan dan gangguan menstruasi.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Dalam DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan tindakan nyata, bukan hanya diskusi kasus. Aktivitas meliputi komunikasi awal, anamnesis terarah, skrining kelayakan, penentuan metode kontrasepsi, serta edukasi kepada klien. Keterampilan ini mencerminkan integrasi	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan anamnesis, mengidentifikasi bahwa klien menyusui, melakukan skrining kontraindikasi estrogen, menentukan kontrasepsi progestin sebagai pilihan, menjelaskan jenis metode (pil,

	pengetahuan, keterampilan klinis, dan komunikasi.	suntik, implan), serta memberikan edukasi efek samping dan jadwal kontrol.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi: kemampuan melakukan anamnesis, ketepatan skrining kelayakan, pemilihan metode kontrasepsi, kemampuan komunikasi (KIE), keselamatan pasien, serta profesionalisme. Penilaian juga mencakup kemampuan mahasiswa dalam menghargai preferensi klien dan memberikan informed choice.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kondisi menyusui dengan pilihan kontrasepsi progestin, menjelaskan bahwa metode tersebut aman untuk ASI, serta mampu mengklarifikasi kekhawatiran klien terkait kenaikan berat badan dan perubahan siklus menstruasi.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi adalah performa nyata mahasiswa saat memberikan pelayanan KB. Pembimbing menilai apakah mahasiswa bekerja secara sistematis, aman, dan efektif, serta mampu mengambil keputusan klinis yang tepat.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu melakukan konseling secara empatik, memilih metode yang tepat, menjelaskan dengan bahasa sederhana, serta menjaga kenyamanan dan kepercayaan klien.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan selesai, mencakup kelebihan dan area yang perlu diperbaiki. Umpan balik harus spesifik, konstruktif, dan mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, tetapi perlu meningkatkan ketepatan dalam menjelaskan efek samping atau memperdalam skrining kelayakan sebelum menentukan metode.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS dikategorikan menjadi: kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Penilaian didasarkan pada ketepatan tindakan, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan pengambilan keputusan klinis.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan konseling dan pemilihan metode secara tepat dan aman. Perlu supervisi jika masih membutuhkan arahan. Remedial jika salah menentukan metode atau tidak melakukan skrining dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran pada level "does" dalam taksonomi Miller. Penilaian berbasis observasi langsung ini sangat sesuai dengan pendekatan Outcome-Based Education karena menilai performa nyata mahasiswa dalam praktik klinik.	Pada kasus kontrasepsi progestin, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan pelayanan KB secara langsung, melakukan konseling efektif, dan mengambil keputusan klinis yang tepat sesuai kondisi klien.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 7.4
Portofolio pada Pelayanan Kontrasepsi Progestin pada Ibu Menyusui

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kontrasepsi Progestin
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya satu kali ujian.	Pada topik kontrasepsi progestin, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan konseling KB, melakukan skrining kelayakan, menentukan metode kontrasepsi yang tepat, serta memberikan edukasi kepada klien secara berulang dan konsisten.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, serta tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah memberikan pelayanan KB, tetapi juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memilih metode yang tepat dan mengatasi kekhawatiran klien setelah mendapatkan umpan balik dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS merupakan bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik.	OSCE memuat hasil ujian konseling KB dan pemilihan metode kontrasepsi. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pelayanan KB pada ibu menyusui, termasuk skrining dan edukasi.

Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang ditangani mahasiswa, meliputi data penting, masalah kebidanan, tindakan, dan hasil.	Mahasiswa menuliskan kasus ibu usia 28 tahun, menyusui bayi 3 bulan, ingin KB tetapi takut gemuk dan haid terganggu, kemudian dilakukan konseling dan dipilih metode kontrasepsi progestin yang sesuai.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, serta merencanakan tindakan pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya pemilihan kontrasepsi yang aman pada ibu menyusui, menghindari penggunaan estrogen, serta memastikan klien memahami efek samping agar tidak terjadi penghentian penggunaan secara tidak tepat.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari CI/dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	CI menilai mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, tetapi perlu meningkatkan ketelitian dalam skrining kelayakan dan memperjelas edukasi terkait efek samping kontrasepsi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dikembangkan secara berulang dan berkesinambungan dengan fokus pada konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman pelayanan KB, bukan hanya satu kasus, sehingga terlihat konsistensi dalam kemampuan konseling dan pengambilan keputusan klinis.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan feedback, terlihat mahasiswa konsisten mampu memilih kontrasepsi progestin yang tepat dan memberikan edukasi secara benar.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi tampak dalam performa nyata yang berulang dan berkembang.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami teori kontrasepsi, tetapi mampu menerapkannya secara konsisten dalam pelayanan KB di praktik klinik.

Tabel 7.5
Case Report pada Pelayanan Kontrasepsi Progestin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kontrasepsi Progestin
-----------------	------------------	--

Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, ini menjadi bukti kemampuan analisis klinis mahasiswa.	Mahasiswa menyusun laporan tentang ibu menyusui yang membutuhkan kontrasepsi dengan pertimbangan klinis tertentu.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data, analisis masalah, tindakan, dan evaluasi.	Mahasiswa menjelaskan alasan pemilihan kontrasepsi progestin berdasarkan kondisi menyusui dan preferensi klien.
Isi laporan	Identitas pasien, data subjektif dan objektif, analisis, diagnosis, tindakan, evaluasi.	Data: ibu menyusui, takut gemuk, tidak ingin haid terganggu → analisis → pilihan KB progestin → edukasi → rencana kontrol.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, analisis, dan keputusan klinis.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa memilih metode yang tepat dan logis.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi.	Mahasiswa belajar bahwa pemilihan KB harus berbasis kondisi klien.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori ke praktik nyata.	Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori kontrasepsi secara sistematis.

Tabel 7.6
Refleksi Patient Safety pada Pelayanan Kontrasepsi Progestin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kontrasepsi Progestin
Hakikat refleksi	Refleksi patient safety adalah tulisan yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko dan mencegah kesalahan klinis.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya pemilihan kontrasepsi yang aman pada ibu menyusui.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran keselamatan pasien dalam praktik kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa salah memilih KB dapat berdampak pada ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.	Risiko: salah pilih KB (estrogen), efek samping tidak dijelaskan, drop out KB.
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang membahayakan pasien.	Gangguan ASI, efek samping tidak dipahami, ketidakpatuhan klien.
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko.	Skrining ketat, edukasi lengkap, informed choice.
Pembelajaran mahasiswa	Apa yang dipelajari dan perbaikan ke depan.	Mahasiswa belajar pentingnya konseling yang jelas dan berbasis bukti.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis.	Mahasiswa mampu meningkatkan kualitas

		pelayanan KB secara berkelanjutan.
--	--	------------------------------------

H. Rangkuman Materi

Kontrasepsi progestin saja merupakan salah satu metode kontrasepsi hormonal yang hanya mengandung hormon progestin tanpa kombinasi hormon estrogen. Metode ini dikembangkan sebagai alternatif kontrasepsi bagi wanita yang memiliki kontraindikasi terhadap estrogen atau yang membutuhkan metode kontrasepsi hormonal yang aman pada kondisi tertentu, seperti masa menyusui. Kontrasepsi progestin memiliki efektivitas tinggi dalam mencegah kehamilan apabila digunakan dengan benar dan konsisten.

Kontrasepsi progestin tersedia dalam beberapa bentuk sediaan yang memiliki karakteristik penggunaan yang berbeda, yaitu pil progestin saja, kontrasepsi suntik progestin, dan kontrasepsi implan. Pil progestin saja digunakan setiap hari pada waktu yang sama tanpa interval bebas hormon. Kontrasepsi suntik progestin diberikan melalui injeksi secara berkala, umumnya setiap dua atau tiga bulan tergantung jenis preparat yang digunakan. Kontrasepsi implan merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang dipasang di bawah kulit dan dapat memberikan perlindungan terhadap kehamilan selama beberapa tahun.

Hormon progestin dalam kontrasepsi bekerja melalui beberapa mekanisme untuk mencegah kehamilan. Mekanisme tersebut meliputi penghambatan ovulasi melalui penekanan hormon gonadotropin, peningkatan kekentalan mukus serviks yang menghambat penetrasi sperma, perubahan pada endometrium yang menyebabkan lingkungan rahim kurang mendukung implantasi, serta perubahan motilitas tuba falopi yang memengaruhi transportasi ovum dan sperma.

Kontrasepsi progestin memiliki beberapa keuntungan, antara lain tidak mengandung estrogen sehingga dapat digunakan oleh wanita dengan kontraindikasi terhadap estrogen, aman bagi ibu menyusui karena tidak memengaruhi produksi air susu ibu secara signifikan, serta memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan dan suntik juga tidak memerlukan kepatuhan penggunaan harian sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan kontrasepsi.

Penggunaan kontrasepsi progestin juga dapat menimbulkan beberapa efek samping. Efek samping yang paling sering terjadi adalah perubahan pola menstruasi, seperti perdarahan tidak teratur, bercak, atau amenore. Efek samping lain yang dapat muncul meliputi sakit kepala, nyeri payudara, peningkatan berat badan, serta perubahan suasana hati. Sebagian besar efek samping tersebut bersifat ringan dan tidak berbahaya.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam pelayanan kontrasepsi progestin. Peran tersebut meliputi membantu klien memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan reproduksi, memberikan edukasi mengenai cara penggunaan metode kontrasepsi, serta melakukan pemantauan terhadap kemungkinan efek samping yang muncul selama penggunaan kontrasepsi. Penatalaksanaan efek samping yang tepat serta pemberian konseling yang memadai dapat meningkatkan kepuasan dan keberlanjutan penggunaan metode kontrasepsi oleh akseptor keluarga berencana.

I. Tabel Red Flags & Eskalasi

Pelayanan Kontrasepsi Progestin pada Ibu Menyusui

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perdarahan pervaginam banyak atau berkepanjangan setelah penggunaan KB progestin	Kemungkinan efek samping berat atau gangguan hormonal yang memerlukan evaluasi lebih lanjut	Lapor ke pembimbing/dokter, evaluasi kondisi umum, pertimbangkan penghentian metode dan rujukan
Tidak haid disertai tanda kehamilan (mual, payudara tegang)	Kemungkinan kegagalan kontrasepsi dan kehamilan	Lakukan tes kehamilan, hentikan kontrasepsi sementara, rujuk untuk evaluasi
Nyeri hebat pada perut bawah	Dapat mengarah pada kehamilan ektopik atau komplikasi lain	Segera evaluasi, lakukan rujukan emergensi
Tanda infeksi pada area pemasangan implan (kemerahan, nyeri, bengkak, keluar cairan)	Infeksi lokal akibat prosedur	Lapor, lakukan perawatan luka, pertimbangkan rujukan jika berat
Sakit kepala berat atau gangguan penglihatan	Kemungkinan efek samping serius atau kondisi neurologis	Hentikan sementara penggunaan, evaluasi medis segera
Peningkatan berat badan yang signifikan dan cepat	Efek samping hormonal atau faktor lain yang perlu dikaji	Edukasi, evaluasi pola hidup, pertimbangkan ganti metode
Klien tidak patuh penggunaan (lupa minum pil, terlambat suntik)	Risiko kegagalan kontrasepsi meningkat	Edukasi ulang, pilih metode yang lebih sesuai (misal implan), lakukan konseling
Klien ingin menghentikan kontrasepsi karena efek samping	Risiko drop out KB	Konseling ulang, tawarkan alternatif metode, lakukan informed choice
Ditemukan kontraindikasi baru selama penggunaan	Risiko keselamatan pasien	Hentikan metode, lakukan evaluasi dan rujukan jika diperlukan

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab : Pelayanan Kontrasepsi Progestin pada Ibu Menyusui

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan konsultasi kontrasepsi progestin pada ibu menyusui	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah (keluhan utama, status menyusui, usia bayi)	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menanyakan riwayat penggunaan kontrasepsi sebelumnya	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menanyakan riwayat menstruasi dan keluhan terkait haid	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menanyakan riwayat obstetri (GPA, persalinan terakhir)	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menanyakan riwayat penyakit kronis dan obat/hormon yang digunakan	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menanyakan preferensi dan kekhawatiran klien (takut gemuk, haid terganggu)	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa melakukan skrining kelayakan kontrasepsi hormonal	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa mengidentifikasi kontraindikasi penggunaan estrogen	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menentukan metode kontrasepsi progestin yang sesuai (pil/suntik/implan)	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjelaskan cara kerja, cara penggunaan, kelebihan dan kekurangan metode	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan efek samping yang mungkin terjadi (normal dan perlu diwaspadai)	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa memberikan edukasi mengenai tanda bahaya/red flags	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menyesuaikan metode dan edukasi dengan preferensi klien	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menyusun rencana kontrol dan tindak lanjut	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa mendokumentasikan jenis kontrasepsi, edukasi, dan rencana tindak lanjut secara ringkas	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama konseling	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

J. Referensi

- Bastianelli, C., Farris, M., & Benagiano, G. (2020). Effects of progestin-only contraceptives on the endometrium. *Expert Review of Clinical Pharmacology*, 13(8), 895–903. <https://doi.org/10.1080/17512433.2020.1796637>
- Hatcher, R. A., Nelson, A. L., Trussell, J., Cwiak, C., Cason, P., Policar, M., Edelman, A., Aiken, A., Marrazzo, J., & Kowal, D. (2018). *Contraceptive technology* (21st ed.). Ayer Company Publishers.
- Jacobstein, R., & Polis, C. B. (2014). Progestin-only contraception: Injectables and implants. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 28(6), 795–806. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2014.05.003>
- Kapp, N., Curtis, K. M., & Nanda, K. (2010). Progestogen-only contraceptive use among breastfeeding women: A systematic review. *Contraception*, 82(1), 17–37. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2010.02.002>
- McCann, M. F., & Potter, L. S. (1994). Progestin-only oral contraception: A comprehensive review. *Contraception*, 50(6), S1–S195. [https://doi.org/10.1016/0010-7824\(94\)90002-7](https://doi.org/10.1016/0010-7824(94)90002-7)
- World Health Organization. (2015). *Medical eligibility criteria for contraceptive use* (5th ed.). World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549158>
- World Health Organization. (2022). *Family planning: A global handbook for providers* (3rd ed.). World Health Organization & Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). *Laporan kinerja program keluarga berencana nasional. BKKBN.PROFIL PENULIS*

PROFIL PENULIS



Wiwiek Elsada Nainggolan, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb., merupakan dosen tetap dan Ketua Program Studi D3 Kebidanan Universitas Satya Terra Bhinneka. Penulis adalah bidan profesional dengan minat pada bidang kesehatan reproduksi dan kehamilan. Lahir di Sibolga pada 28 Agustus 1997, penulis menyelesaikan pendidikan DIV Kebidanan tahun 2019 dan Magister Terapan Kebidanan tahun 2022. Dalam kegiatan akademik, penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan serta Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Fokus penelitian meliputi upaya promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak, khususnya kesehatan reproduksi perempuan. Email: wiwiekelsada4@gmail.com



Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes., merupakan dosen tetap dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kader Bangsa Palembang. Penulis adalah bidan profesional yang memiliki kepakaran di bidang kesehatan reproduksi dan pelayanan kebidanan komunitas. Lahir di Palembang pada 1 Agustus 1988, Penulis menyelesaikan pendidikan DIV Kebidanan pada tahun 2010, meraih gelar Magister Kesehatan pada tahun 2015, dan menuntaskan program profesi bidan pada tahun 2023. Dalam aktivitas akademiknya, Penullis mengampu mata kuliah Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi, Asuhan Kebidanan Komunitas, serta Asuhan Kebidanan Perempuan dan Anak dalam Kondisi Rentan. Fokus risetnya mencakup upaya preventif dan promotif kesehatan ibu dan anak, dengan penekanan pada kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kontrasepsi. Kontak korespondensi dapat dilakukan melalui email: ramdhanilist@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes., Lahir di Grobogan, 05 Maret 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan Poltekkes Tasikmalaya dan lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan ke jenjang D4 Program Studi Sarjana Sains Terapan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta dan lulus tahun 2007. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Respati Indonesia pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan penulis dimulai setelah lulus D3 sebagai bidan praktik di berbagai fasilitas kesehatan dasar, kemudian bergabung sebagai tenaga pengajar di institusi pendidikan kesehatan. Saat ini penulis menjabat sebagai Rektor sekaligus dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana (Kespro & KB), Kesehatan Dasar Pada Kehamilan (KDPK), serta Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan Al-Islam Kemuhammadiyah. Penulis telah menghasilkan berbagai penelitian di bidang kesehatan reproduksi remaja dan anemia gizi besi, serta aktif melakukan pengabdian masyarakat melalui edukasi kesehatan di sekolah-sekolah dan komunitas. Selain itu, penulis rutin mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi, serta menulis buku dan modul pembelajaran untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: slimusfiroh052@gmail.com

Motto: "Menjadi manusia yang berguna untuk orang lain"



Lely Khulafa'ur Rosidah, S.ST., M.Kes., Lahir pada 4 Maret 1985 di Nganjuk, Jawa Timur. Riwayat Pendidikan: Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri (2006), DIV Bidan Pendidik Universitas Padjadjaran (2008), S2 Magister Kedokteran Keluarga (2014). Riwayat Pekerjaan :Dosen di Akbid Dharma Husada Kediri (2006-2024), Dosen di Universitas Strada Indonesia (2024-sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lelykhulafaur.strada@gmail.com. Motto : "Baiti Jannati".

PROFIL PENULIS



Bdn. Erma Puspita Sari, SST., M.Kes., adalah dosen tetap sekaligus Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Kader Bangsa Palembang. Ia merupakan bidan profesional yang menekuni bidang kesehatan reproduksi dan KB serta pelayanan pasca persalinan. Lahir di Sekayu pada 16 Januari 1988, ia menyelesaikan pendidikan DIV Kebidanan pada tahun 2010, meraih gelar magister kesehatan pada tahun 2012, dan menuntaskan program profesi bidan pada tahun 2022. Ia aktif mengajar mata kuliah KB dan Pelayanan, Asuhan Kebidanan Nifas, serta Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Fokus risetnya mencakup upaya meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang, dengan penekanan pada kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kontrasepsi.

Penulis dapat dihubungi melalui email: ermapuspitasari88@gmail.com.

Sinopsis

Buku ajar “Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi: Metode, Konseling, dan Efek Samping” disusun sebagai sumber pembelajaran yang membahas konsep, prinsip, dan praktik pelayanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi dalam lingkup kebidanan. Buku ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya pelayanan KB yang aman, bermutu, beretika, dan berpusat pada kebutuhan klien.

Materi dalam buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan kebidanan. Pembaca diperkenalkan pada peran bidan dalam memberikan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada pemilihan metode kontrasepsi, tetapi juga pada pemenuhan hak kesehatan reproduksi, pemberian informasi yang tepat, serta dukungan terhadap pengambilan keputusan klien secara sadar dan bertanggung jawab.

Buku ini juga menguraikan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi serta dasar regulasi fertilitas sebagai landasan penting dalam memahami cara kerja berbagai metode kontrasepsi. Pemahaman ini menjadi dasar bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam menjelaskan proses reproduksi, masa subur, mekanisme pencegahan kehamilan, serta prinsip penggunaan kontrasepsi secara tepat.

Pembahasan selanjutnya menekankan pentingnya pendekatan berpusat pada klien dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Buku ini membahas kebutuhan dan hak kesehatan reproduksi, termasuk hak memperoleh informasi, hak memilih metode kontrasepsi, hak mendapatkan pelayanan yang aman, serta hak untuk dihargai tanpa diskriminasi. Pendekatan ini menjadi dasar dalam membangun hubungan pelayanan yang komunikatif, empatik, dan menghormati keputusan klien.

Aspek konseling keluarga berencana dibahas secara khusus melalui materi komunikasi efektif, informed choice, dan skrining kelayakan metode kontrasepsi. Melalui pembahasan ini, pembaca diharapkan mampu memahami tahapan konseling, menggali kebutuhan klien, memberikan informasi secara objektif, serta membantu klien memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan, dan preferensinya.

Buku ajar ini turut membahas berbagai metode kontrasepsi, mulai dari metode kontrasepsi alamiah dan barrier, kontrasepsi hormonal kombinasi, hingga kontrasepsi progestin saja. Setiap metode dijelaskan berdasarkan indikasi, cara penggunaan, kelebihan, keterbatasan, jadwal pemakaian, serta penatalaksanaan keluhan dan efek samping yang mungkin terjadi. Pembahasan mengenai pil, patch, cincin, suntik, pil progestin, dan implan disajikan untuk membantu pembaca memahami pilihan kontrasepsi secara komprehensif dan aplikatif.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, dan tenaga kesehatan dalam memahami serta menerapkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara profesional. Dengan penyajian materi yang sistematis, buku ini mendukung pengembangan pengetahuan, keterampilan konseling, kemampuan skrining, serta sikap menghargai hak dan kebutuhan klien dalam pelayanan kebidanan.

Buku ajar “Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi: Metode, Konseling, dan Efek Samping” disusun sebagai sumber pembelajaran yang membahas konsep, prinsip, dan praktik pelayanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi dalam lingkup kebidanan. Buku ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya pelayanan KB yang aman, bermutu, beretika, dan berpusat pada kebutuhan klien. Materi dalam buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam pelayanan kebidanan. Pembaca diperkenalkan pada peran bidan dalam memberikan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada pemilihan metode kontrasepsi, tetapi juga pada pemenuhan hak kesehatan reproduksi, pemberian informasi yang tepat, serta dukungan terhadap pengambilan keputusan klien secara sadar dan bertanggung jawab.

Buku ini juga menguraikan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi serta dasar regulasi fertilitas sebagai landasan penting dalam memahami cara kerja berbagai metode kontrasepsi. Pemahaman ini menjadi dasar bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam menjelaskan proses reproduksi, masa subur, mekanisme pencegahan kehamilan, serta prinsip penggunaan kontrasepsi secara tepat.

Pembahasan selanjutnya menekankan pentingnya pendekatan berpusat pada klien dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Buku ini membahas kebutuhan dan hak kesehatan reproduksi, termasuk hak memperoleh informasi, hak memilih metode kontrasepsi, hak mendapatkan pelayanan yang aman, serta hak untuk dihargai tanpa diskriminasi. Pendekatan ini menjadi dasar dalam membangun hubungan pelayanan yang komunikatif, empatik, dan menghormati keputusan klien.

Aspek konseling keluarga berencana dibahas secara khusus melalui materi komunikasi efektif, informed choice, dan skrining kelayakan metode kontrasepsi. Melalui pembahasan ini, pembaca diharapkan mampu memahami tahapan konseling, menggali kebutuhan klien, memberikan informasi secara objektif, serta membantu klien memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan, dan preferensinya.

Buku ajar ini turut membahas berbagai metode kontrasepsi, mulai dari metode kontrasepsi alamiah dan barier, kontrasepsi hormonal kombinasi, hingga kontrasepsi progestin saja. Setiap metode dijelaskan berdasarkan indikasi, cara penggunaan, kelebihan, keterbatasan, jadwal pemakaian, serta penatalaksanaan keluhan dan efek samping yang mungkin terjadi. Pembahasan mengenai pil, patch, cincin, suntik, pil progestin, dan implan disajikan untuk membantu pembaca memahami pilihan kontrasepsi secara komprehensif dan aplikatif.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, dan tenaga kesehatan dalam memahami serta menerapkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara profesional. Dengan penyajian materi yang sistematis, buku ini mendukung pengembangan pengetahuan, keterampilan konseling, kemampuan skrining, serta sikap menghargai hak dan kebutuhan klien dalam pelayanan kebidanan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-21-7 (PDF)



9

786347

927217